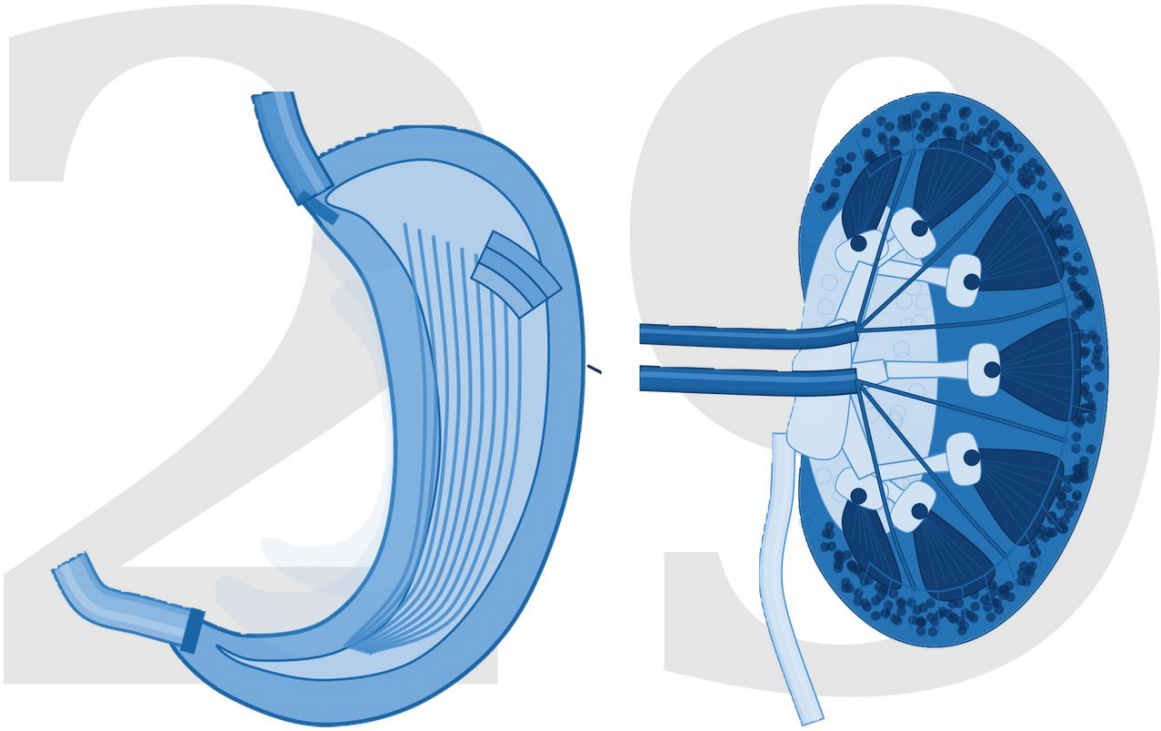
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 29

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Terminologie médicale

Medical terminology: Greek and Latin roots, prefixes and suffixes, and the reading of medical reports

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 29

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Terminologie médicale

Medical terminology: Greek and Latin roots, prefixes and suffixes, and the reading of medical reports

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1, C2.2 et C2.6 · C3 (détail en 29.1)

MOTS-CLÉS

terminologie médicale
étymologie
préfixe
suffixe
racine
doublet
sigle
compte rendu d'hospitalisation
diagnostic diététique
dénutrition

KEYWORDS

medical terminology
etymology
prefixes
suffixes
Greek and Latin roots
medical abbreviations
discharge report
nutrition diagnosis
malnutrition criteria
IDDSI

RÉSUMÉ

Contexte. Le diététicien lit chaque jour des comptes rendus d'hospitalisation, des observations, des résultats d'examens et des prescriptions, et il écrit lui-même dans le dossier patient. Ces documents emploient un vocabulaire savant, formé pour l'essentiel de racines grecques et latines, et de nombreux sigles. Une erreur de lecture (iléon pour os iliaque, -tomie pour -stomie, -émie pour -urie) conduit à des conseils inadaptés ; une erreur d'écriture engage la responsabilité de son auteur.

Objectif. Maîtriser la méthode de décomposition et de construction des termes médicaux ; connaître la liste indicative du guide d'accompagnement 2025 (53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines) avec leur origine, leur sens et des exemples ; appliquer ce vocabulaire aux organes, aux signes, aux examens, aux actes et aux pathologies ; lire un compte rendu médical et en extraire les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED.

Contenu. Anatomie d'un mot médical ; méthode en cinq étapes ; doublets grec et latin ; éponymes, sigles, termes historiques ; orthographe ; préfixes de position, de quantité, de nombre, de couleur, de temps, de vitesse et de qualité ; suffixes des maladies, des signes, des hémorragies, des examens, des actes et des traitements ; racines des appareils digestif, respiratoire, cardiovasculaire, urinaire, endocrinien, nerveux, cutané, locomoteur et génital et du sang ; vocabulaire de la démarche clinique ; repères anatomiques ; compte rendu d'hospitalisation et sigles ; nutrition clinique (voies d'alimentation, textures IDDSI, dénutrition, sarcopénie, diagnostic diététique PES) ; vocabulaire de l'épidémiologie et de la recherche.

Conclusion. La terminologie médicale est combinatoire : une centaine d'éléments permet de comprendre des milliers de termes. Le suffixe donne la nature, la racine l'organe, le préfixe la position, la quantité ou le temps. Lire un terme de la fin vers le début, vérifier sa cohérence avec le contexte, reformuler sans trahir le sens et écrire avec exactitude sont des compétences transversales, mobilisées dans tous les chapitres de physiopathologie et de diététique thérapeutique.

ABSTRACT

Medical vocabulary is largely built from Greek and Latin elements combined according to stable rules: a prefix indicating position, quantity, time or negation, one or more roots naming an organ, a substance or a function, a linking vowel and a suffix stating the nature of the process (disease, sign, investigation, procedure or treatment). This review presents a five-step method to decompose and define an unknown term and to build a term from its definition, Greek and Latin doublets, eponyms, acronyms and historical terms, and spelling rules. It covers the complete

indicative list of the French national guide for dietetics students (53 prefixes, 49 suffixes and 135 roots), with origin, meaning and examples, applied to the digestive, respiratory, cardiovascular, urinary, endocrine, nervous, integumentary, musculoskeletal and reproductive systems and to blood. It then describes the vocabulary of clinical reasoning and epidemiology, anatomical landmarks, the structure of hospital discharge reports and their abbreviations, and the terminology of clinical nutrition: routes of feeding, IDDSI texture levels, malnutrition criteria (French guidelines of 2019 and 2021, GLIM), sarcopenia, cachexia, refeeding syndrome and the problem-etiology-signs format of the nutrition diagnosis.

Points clés · Highlights

- Un terme médical se lit de la fin vers le début : le **suffixe** donne la nature (maladie, signe, examen, acte), la **racine** l'organe ou la substance, le **préfixe** la position, la quantité, le temps ou la négation ; la voyelle de liaison -o- relie les éléments.
- La liste indicative du guide 2025 comprend **53 préfixes**, **49 suffixes** et **135 racines** ; les doublets grec et latin (néphr- / rén-, pneum- / pulmon-) se répartissent entre noms de maladies et d'actes (grec) et adjectifs anatomiques (latin).
- Les suffixes proches doivent être distingués : -ite (inflammation) / -ose (état dégénératif) ; -tomie (inciser) / -ectomie (enlever) / -stomie (aboucher) ; -émie (sang) / -urie (urine) ; -graphie (technique) / -gramme (document).
- Le vocabulaire de la démarche clinique distingue symptôme (ressenti) et signe (constaté), étiologie et pathogénie, diagnostic et pronostic, prévalence et incidence, aigu et chronique, bénin et malin.
- Lire un compte rendu, c'est en repérer le plan, développer les sigles, décomposer les termes, puis trier les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle ; écrire dans le dossier exige exactitude, chiffres et format PES pour le diagnostic diététique.
- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED, dont les imprécisions (sens de a- et de dys-, de -ite, de -scopie, de macrosomie, signe et symptôme, néoglucogenèse) ont été corrigées.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

29.1 Compétences mobilisées....5
29.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
29.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
29.3 Cours....8
29.3.1 Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes....8
29.3.2 Les préfixes....17
29.3.3 Les suffixes....24
29.3.4 Les racines, appareil par appareil....33
29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique....48
29.3.6 Le vocabulaire des documents médicaux et de la nutrition clinique....52
Exercice de synthèse – la lithiase biliaire en chirurgie digestive....56
Exercice de synthèse – lire le bilan biologique d'un résident déshydraté....57
Exercice de synthèse – un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann....58
Exercice de synthèse – une décompensation cardiaque....59
Exercice de synthèse – une maladie rénale chronique d'origine diabétique....60
Exercice de synthèse – la découverte d'un diabète de type 1....62
Exercice de synthèse – construire et décomposer vingt termes....63
Exercice de synthèse – les pièges de la terminologie....63
Exercice de synthèse – une BPCO et une dénutrition....64
29.4 Approfondissements....65
29.4.1 Lire et rédiger dans le dossier patient....65
29.4.2 La terminologie de la nutrition clinique....67
29.4.3 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche....69
29.4.4 Sens courant et sens médical....70
29.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....71
29.5.1 Classifications et terminologies normalisées : CIM, CCAM, SNOMED CT....71
29.5.2 La nomenclature anatomique internationale....71
29.5.3 Une brève histoire de la langue médicale....71
29.5.4 La fabrique des néologismes....72
29.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....72
29.7 L'essentiel du chapitre....72
29.8 Fiches de synthèse....74
29.9 Valeurs de référence et conversions à associer aux termes....74
29.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....75
29.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....76
29.11.1 Schémas à réaliser et à légender....76
29.11.2 Applications d'entraînement corrigées....78
29.11.3 QCM....84
29.11.4 Questions de réflexion corrigées....86
29.11.5 Étude de cas – Mme R., 45 ans, une chirurgie bariatrique....87
29.11.6 Étude de cas – M. F., 68 ans, une cirrhose décompensée....87
29.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée....88
29.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage....90
29.11.9 Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition....91
29.12 Glossaire du chapitre....92
29.13 Bibliographie du chapitre....93

29.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

La **terminologie médicale** est la langue des soignants. Un compte rendu d'hospitalisation, une prescription diététique, une lettre de liaison, un résultat de biologie ou un article scientifique emploient des centaines de mots savants : **cholécystectomie**, **dysphagie**, **hypoalbuminémie**, **hépatosplénomégalie**, **pollakiurie**, **gastroparésie**… Ces mots paraissent difficiles, mais ils sont presque tous construits de la même façon, à partir d'un petit nombre d'éléments **grecs** ou **latins** : un **préfixe** qui précise le sens, une ou plusieurs **racines** qui désignent l'organe, le tissu ou la substance, et un **suffixe** qui indique s'il s'agit d'une maladie, d'un symptôme, d'un examen ou d'un geste. Quelques centaines d'éléments suffisent pour comprendre plusieurs milliers de termes.

Pour le diététicien nutritionniste, cette langue est un **outil de travail quotidien**. À l'hôpital, il lit le dossier du patient avant chaque consultation et doit y repérer en quelques minutes les antécédents, le motif d'hospitalisation, les examens et leurs résultats, les actes chirurgicaux et les consignes alimentaires. Il rédige lui-même ses **transmissions** et son **diagnostic diététique** dans le dossier partagé, avec une terminologie que le médecin, l'infirmier et l'orthophoniste comprennent sans ambiguïté. En restauration collective, il traduit une prescription (« texture mixée lisse, épaississement de niveau 2 pour dysphagie ») en menus ; dans l'industrie, il lit des allégations et des études cliniques ; en santé publique, il comprend les indicateurs (incidence, prévalence, morbidité, mortalité). À l'inverse, il doit savoir **reformuler** ces termes en langage courant pour un patient : on ne dit pas « hypokaliémie » à une personne âgée, on lui explique que son sang manque de potassium.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui place la « Terminologie médicale » en tête de la troisième partie du bloc, « **Physiopathologie appliquée à la diététique** », sans détailler de contenu. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 100) en précise l'objectif : « **maîtriser le vocabulaire scientifique et médical utile aux compétences mises en œuvre dans les trois blocs** » ; il recommande d'« intégrer les principaux termes médicaux au fur et à mesure de l'étude des appareils et systèmes puis des pathologies » et donne une **liste indicative** de **53 préfixes**, **49 suffixes** et **135 racines**. Ce cours présente **tous** ces éléments, classés par sens et par appareil, avec leur origine, leur signification exacte et des exemples tirés de la pratique diététique ; il les complète par le vocabulaire de la démarche clinique (séquence 1 du CNED « Bases physiopathologiques »), de la chirurgie (séquence 5) et des documents médicaux. Les pathologies elles-mêmes sont étudiées aux chapitres 31 à 41 : ici, on apprend à **lire** leurs noms.

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir un préfixe, une racine, un suffixe, une voyelle de liaison ; donner le sens de chaque élément de la liste du guide 2025 ; définir symptôme, signe, syndrome, diagnostic, pronostic, étiologie, physiopathologie, sémiologie, épidémiologie

E2 – Analyser et interpréter des données — Décomposer un terme inconnu et en reconstruire la définition ; lire un compte rendu d'hospitalisation, un bilan biologique, une prescription ; situer une valeur par rapport à la normale (hypo-, normo-, hyper-)

E2 – Argumenter, esprit critique — Repérer les pièges (racines voisines, sens courant et sens médical, éponymes) ; vérifier la cohérence d'un terme avec le contexte clinique ; choisir le terme exact

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient le vocabulaire médical dans une copie, une transmission ou un diagnostic diététique ; orthographier correctement les termes (rr de -rragie, -rrhée, -rraphie ; y de dys-, poly-, hypo-)

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Extraire du dossier médical les données utiles (antécédents, motif, examens, traitements, actes) ; formuler un diagnostic diététique avec une terminologie professionnelle (problème, étiologie, signes et symptômes)

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Traduire une prescription (textures, voies d'alimentation, régimes) en conseils et en menus ; comprendre les termes chirurgicaux (gastrectomie, colostomie, anastomose) et leurs conséquences nutritionnelles

C1.5 – Éducation thérapeutique — Reformuler un terme médical en langage courant, adapté au patient, sans le déformer

C2.1 / C2.2 / C2.6 – Restauration collective — Lire une prescription de régime ou de texture en établissement de santé ou médico-social ; communiquer avec l'équipe soignante et la cuisine

C3 – Prévention, santé publique, recherche — Comprendre les indicateurs épidémiologiques et le vocabulaire d'un article scientifique ou d'un rapport de santé publique

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. La terminologie est un **outil transversal**. Elle s'appuie sur les chapitres de physiologie des volumes 1 et 2, dont elle reprend les organes (chapitres 11 à 19 : cellule,

tissus, sang, système endocrinien, système nerveux, cœur et vaisseaux, respiration, digestion, rein, immunité) et les régulations (chapitres 21 à 28 : glycémie, équilibre phosphocalcique et hydrominéral, faim et soif, grossesse, xénobiotiques). Les planches d'organes de ce chapitre sont celles des chapitres 12 à 18, dont les légendes ont été remplacées par les racines : **réviser l'anatomie et apprendre le vocabulaire se font ensemble**. Elle prépare tous les chapitres de physiopathologie : **examens paracliniques** (chapitre 30 : -scopie, -graphie, -métrie), **cancers** (chapitre 31 : -ome, carcinome, métastase, -plasie), **tube digestif** (chapitre 32 : dysphagie, -ectomie, -stomie), **foie, voies biliaires et pancréas** (chapitre 33 : hépatite, cholécystite, stéatose, cirrhose), **rein** (chapitre 34 : néphropathie, -urie, dialyse, lithiase), **cœur et vaisseaux** (chapitre 35 : athérosclérose, ischémie, infarctus, -sténose), **endocrinologie et métabolisme** (chapitre 36 : -émie, hyper-, hypo-), **système nerveux** (chapitre 37 : -plégie, aphasie, dysphagie), **maladies génétiques**, **allergies**, **TCA** et **dénutrition** (chapitres 38 à 41 : -orexie, -phagie, cachexie, sarcopénie). Elle sert enfin au **bloc 1** (bilan et diagnostic diététiques), au **bloc 2** (prescriptions de textures et de régimes en restauration collective) et au **bloc 3** (lecture d'études et d'indicateurs).

29.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau reprend la ligne « Terminologie médicale » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et les précisions du guide d'accompagnement pédagogique (2025, partie « Précisions sur les notions de physiopathologie et liens disciplinaires », p. 99-100). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité.

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Terminologie médicale (partie « Physiopathologie appliquée à la diététique ») — *Précisions du guide 2025 :* Maîtriser le vocabulaire scientifique et médical utile aux compétences des trois blocs ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Comprendre et employer les termes médicaux ; les décomposer pour en retrouver le sens ; *Où dans ce cours :* 29.3.1 : structure d'un terme, méthode de décomposition, origines grecque et latine, doublets, voyelle de liaison, orthographe

(Préfixes) — *Précisions du guide 2025 :* Liste indicative de 53 préfixes : a, acro, allo, anté, anti, auto, bio, brady, caryo, copro, cyano… xéno ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Donner le sens d'un préfixe et l'illustrer par un exemple ; *Où dans ce cours :* 29.3.2 : préfixes de position, de quantité, de nombre, de temps, de vitesse, de couleur, de qualité ; tableau complet des 53 préfixes du guide

(Suffixes) — *Précisions du guide 2025 :* Liste indicative de 49 suffixes : algie, blast, centèse, cide, claste, cyte… urie ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Donner le sens d'un suffixe et l'illustrer par un exemple ; *Où dans ce cours :* 29.3.3 : suffixes des maladies, des signes, des écoulements, des examens, des actes, des traitements, des cellules ; tableau complet des 49 suffixes du guide

(Racines) — *Précisions du guide 2025 :* Liste indicative de 135 racines : adéno, adipo, andr(o)… vascul(o) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Associer une racine à un organe, un tissu, une substance ou une fonction ; *Où dans ce cours :* 29.3.4 : racines appareil par appareil (planches d'organes), doublets grec/latin ; tableau alphabétique complet des racines du guide

(Intégration progressive) — *Précisions du guide 2025 :* Intégrer les principaux termes au fur et à mesure de l'étude des appareils, systèmes et pathologies ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Réinvestir le vocabulaire dans les chapitres de physiopathologie ; *Où dans ce cours :* 29.3.4 (renvois aux chapitres d'organes) ; 29.3.5 (vocabulaire des pathologies) ; renvois aux chapitres 30 à 41

(Démarche d'étude des pathologies) — *Précisions du guide 2025 :* Définition, épidémiologie, étiologie et facteurs de risque, mécanismes physiopathologiques, diagnostic et examens, conséquences et complications, traitements ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Employer le vocabulaire de cette démarche ; *Où dans ce cours :* 29.3.5 : sémiologie, symptôme, signe, syndrome, diagnostic, pronostic, étiologie, épidémiologie (incidence, prévalence), qualificatifs d'une maladie

(Lien avec le bloc 1) — *Précisions du guide 2025 :* Rédaction d'un diagnostic diététique avec une terminologie professionnelle (référentiel, C1.2) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Lire un dossier médical ; rédiger une transmission ; *Où dans ce cours :* 29.3.6 : compte rendu, abréviations, repérage sur le corps, voies d'alimentation, terminologie du processus de soin nutritionnel ; 29.4

Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre

Ce qui est attendu à l'examen : **décomposer** un terme médical en ses éléments et en **donner la définition** ; **donner le sens** des préfixes, suffixes et racines de la liste du guide ; **construire** le terme correspondant à une définition (« ablation de la vésicule biliaire » → cholécystectomie) ; **distinguer** des termes voisins (dysphagie, dysphasie ; hématémèse, hémoptysie ; arthrite, arthrose ; -tomie, -ectomie, -stomie) ; **lire** un document médical (compte rendu, bilan) et en extraire les informations utiles à la prise en charge diététique ; **employer** le vocabulaire exact dans une réponse rédigée.

Ce qui n'est pas attendu : connaître l'étymologie grecque ou latine exacte de chaque élément (elle est donnée ici pour aider la mémoire), les règles savantes de formation des mots, les classifications internationales de maladies et d'actes (CIM-11,

CCAM), la terminologie anatomique internationale. Ces notions sont placées en Licence 3 (29.5).

29.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED ne consacre pas de séquence entière à la terminologie : elle est introduite dans le cours « **Bases physiopathologiques de la diététique** » (réf. 3-2023), module 1 « Introduction à la physiopathologie », **séquence 1 « Examen clinique »** (§ 1 « Quelques notions d'étymologie » : préfixes et suffixes ; § 2 « Quelques définitions à bien connaître » ; § 3 et 4 : interrogatoire et examen clinique) et **séquence 5 « Acte chirurgical et conséquences nutritionnelles »** (§ 1 « Terminologie chirurgicale utile ») ; la **séquence 2** (« Examens paracliniques ») et la séquence « **Imagerie médicale** » du cours de physiologie de 2e année (4524, S2) en emploient le vocabulaire, développé au chapitre 30. Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces séquences, puis contrôlé avec les dictionnaires de référence (Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, Garnier-Delamare, Littré, Bailly pour le grec, Gaffiot pour le latin). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

3-2023 M1 S1 § 1.1 – Préfixes — *Contenu CNED :* a ou an, dys, poly, mono, micro, macro, péri, anti, intra ou endo, exo ou extra, brady, tachy ; *Où dans ce cours :* 29.3.2 (tous, avec sens corrigés) et tableau complet

M1 S1 § 1.2 – Suffixes — *Contenu CNED :* -ite, -graphie, -logie, -scopie, -émie, -urie ; *Où dans ce cours :* 29.3.3 (tous) et tableau complet

M1 S1 § 2 – Définitions — *Contenu CNED :* signes ou symptômes, pathologie, physiopathologie, étiologie, épidémiologie, étiopathogénie, sémiologie ; *Où dans ce cours :* 29.3.5 (définitions précisées : symptôme et signe distingués)

M1 S1 § 3 – Interrogatoire — *Contenu CNED :* anamnèse ; état civil, motif, antécédents personnels et hérédo-collatéraux, histoire de la maladie ; *Où dans ce cours :* 29.3.5 (démarche clinique) ; 29.3.6 (compte rendu, ATCD)

M1 S1 § 4 – Examen clinique — *Contenu CNED :* signes généraux, fonctionnels, physiques ; inspection, palpation, percussion, auscultation ; état général ; diagnostic positif et différentiel ; *Où dans ce cours :* 29.3.5 (examen clinique, types de signes, diagnostic)

M1 S2 – Examens paracliniques ; 4524 S2 – Imagerie médicale — *Contenu CNED :* signes paracliniques ; examens biochimiques, cytologiques, immunologiques, microbiologiques ; enregistrements graphiques (ECG, EEG, EFR) ; imagerie : radiographie, échographie, scanner (tomodensitométrie), IRM, scintigraphie, endoscopie ; *Où dans ce cours :* 29.3.3 (suffixes des examens : -graphie, -scopie, tomo-, écho-, scinti-) ; 29.3.5 (signes paracliniques) ; détail au chapitre 30

M1 S5 § 1 – Terminologie chirurgicale — *Contenu CNED :* voie d'abord, endoscopie, cœlioscopie, laparotomie, -tomie, -ectomie, anastomose (termino-terminale, termino-latérale), -stomie (gastrostomie, colostomie), suture, ablation, exérèse, ponction, cathétérisme, endoprothèse, greffe ; *Où dans ce cours :* 29.3.3 (suffixes des actes, planche des gestes) ; 29.3.6 (voies d'alimentation)

Attention

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine ; Garnier-Delamare, Dictionnaire illustré des termes de médecine ; Bailly ; Gaffiot) :

1. **a-, an-** (S1 § 1.1) : le préfixe signifie « **absence, privation** » (privatif) ; « carence » est un cas particulier. L'exemple « asthénie : fatigue » est juste, mais il faut le décomposer : a- + **sthén-** (gr. *sthenos*, force) = « absence de force ».

2. **dys-** : le sens est « **difficulté, anomalie, trouble** » (gr. *dus-*, mal, difficilement) et non « anormale » seulement ; dysphagie = **difficulté** à avaler.

3. **macro-** : « macrosomie » ne signifie pas « taille anormale » mais **grande taille du corps** (gr. *makros*, grand, et *sôma*, corps) ; en obstétrique, un nouveau-né macrosome pèse 4 000 g ou plus, ou plus que le 90e percentile pour le terme (CNGOF).

4. **anti-** : « antibiotique : contre la vie » est la traduction littérale ; le sens médical est « **substance qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication** ». Une traduction littérale doit toujours être reformulée.

5. **brady-** et **tachy-** : brady- signifie « **lent** » et tachy- « **rapide** » (gr. *bradus*, *takhus*), et non « ralentissement » et « augmentation » ; la tachycardie est une fréquence cardiaque **trop rapide** (> 100 battements par minute au repos chez l'adulte), la bradycardie une fréquence **trop lente** (< 60 par minute, ou < 50 selon les auteurs).

6. **-ite** (S1 § 1.2) : le suffixe désigne une **inflammation**, qui n'est pas toujours infectieuse : la pancréatite alcoolique, la thyroïdite auto-immune ou la mucite radique sont des inflammations sans microbe. « Infection » ne doit pas être donné comme synonyme.

7. **-scopie** : le suffixe signifie « **examen visuel, observation** » (gr. *skopein*, examiner) ; ce n'est pas un « examen d'imagerie » au sens radiologique :

l'endoscopie est une observation directe par un tube optique. Inversement, la radioscopie est une observation en direct sous rayons X.

8. **-graphie** : « **écrire, enregistrer, produire une image** » ; on distingue la technique (-graphie : électrocardiographie) et le document obtenu (-gramme : électrocardiogramme).

9. **-émie** : « présence **dans le sang** » d'une substance, et, par extension, sa **concentration** (glycémie). Attention : **anémie** n'est pas une concentration mais une **diminution de l'hémoglobine** (an- + -émie, « manque de sang »), et **leucémie** est un cancer des cellules de la moelle (« sang blanc »).

10. **Signes et symptômes** (S1 § 2) : les deux mots ne sont pas synonymes. Le **symptôme** est ressenti et rapporté par le patient (douleur, nausée, asthénie) : il est **subjectif** ; le **signe** est constaté par le soignant à l'examen (œdème, ictère, souffle) ou par un examen paraclinique : il est **objectif**. Dans l'usage, on parle de « signes fonctionnels » (symptômes) et de « signes physiques ».

11. **Percussion** (S1 § 4, « ce qu'il faut retenir ») : on percute le **thorax** et l'**abdomen** (avec les doigts, pour apprécier la sonorité) ; la recherche des **réflexes ostéotendineux** au marteau n'est pas une percussion au sens de l'examen clinique, mais un temps de l'examen neurologique.

12. **Cœlioscopie** (S5 § 1) : ce n'est pas une « incision de la paroi », mais l'**exploration** ou l'intervention dans la cavité abdominale (gr. *koilia*, ventre, cavité) à l'aide d'un **endoscope** introduit par de **petites incisions** (« chirurgie mini-invasive », synonyme : laparoscopie) ; elle s'oppose à la **laparotomie** (ouverture large de la paroi). Le terme « néoglycogenèse » (S5 § 2) est à remplacer par **néoglucogenèse** (synthèse de **glucose**, et non de glycogène).

13. **Gastrostomie** (S5 § 1) : aujourd'hui, la gastrostomie est le plus souvent posée par **voie endoscopique** (gastrostomie percutanée endoscopique, **GPE**) ou radiologique, sans laparotomie ; la voie chirurgicale est réservée aux cas où l'endoscopie est impossible.

29.3 COURS

29.3.1 Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes

Module · *Référentiel : « Terminologie médicale : racines, préfixes, suffixes » · Guide 2025 p. 99-100 : liste indicative des préfixes, suffixes et racines à connaître · CNED : 3-2023 M1 S1 §1 (étymologie)*

Définitions

Terminologie médicale : ensemble des termes employés par les professionnels de santé pour désigner les organes, les fonctions, les maladies, les signes, les examens et les traitements, avec un **sens précis et partagé**.

Terme savant : mot formé à partir d'éléments **grecs** ou **latins** (« hépatite », « néphrectomie ») ; il s'oppose au mot **courant** (« jaunisse », « ablation du rein »), plus vague.

Étymologie : origine d'un mot et histoire de sa formation (gr. *etumos*, vrai, et *logos*, discours) ; connaître l'étymologie d'un élément permet de **deviner** le sens des mots qui le contiennent.

Pourquoi la médecine emploie-t-elle des mots aussi compliqués ? D'abord pour des raisons **historiques**. La médecine savante occidentale est née en **Grèce** : la collection hippocratique (V^{e}-IVe siècle avant notre ère) et les traités de **Galien** (IIe siècle) ont fixé les noms de nombreux organes et maladies (*kardia*, *hêpar*, *nephros*, *arthritis*, *diarrhoia*). Les médecins romains, puis toute l'Europe savante jusqu'au XVIIIe siècle, ont écrit en **latin**, qui a fourni les noms anatomiques (*ventriculus*, *vesica*, *renes*, *pulmo*). Quand la médecine moderne a eu besoin de mots nouveaux, aux XVIIIe et XIXe siècles (découverte de la cellule, des microbes, de la biochimie, des techniques d'imagerie), elle les a **fabriqués** avec ces éléments anciens : « leucocyte », « hématocrite », « électrocardiogramme », « échographie » n'ont jamais existé en grec ancien, mais ils sont construits avec des mots grecs.

Ensuite pour des raisons de **précision**. Le mot courant « mal au ventre » ne dit ni où, ni comment ; « épigastralgie » désigne une douleur de la région située **au-dessus de l'estomac**. « Jaunisse » décrit une couleur ; « ictère cholestatique » précise que la bile ne s'écoule plus. Un terme savant a **un seul sens**, le même pour tous les soignants, à Paris comme à Montréal, et il se traduit presque mot pour

mot dans les autres langues (anglais *gastrectomy*, espagnol *gastrectomía*, italien *gastrectomia*). Enfin pour des raisons d'**économie** : un mot composé remplace une phrase entière (« hépatosplénomégalie » = « augmentation du volume du foie et de la rate »).

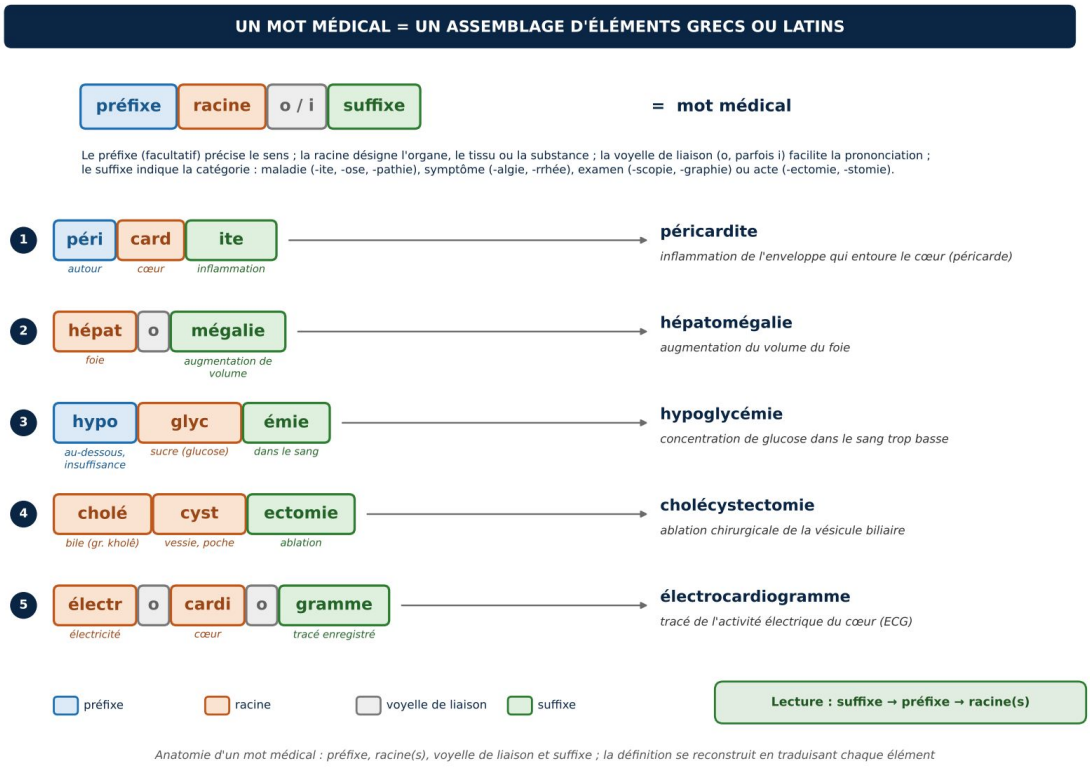
À RETENIR

Un terme médical n'est pas à **apprendre par cœur** comme un mot isolé : il se **comprend** en le décomposant. Environ **300 éléments** (préfixes, racines, suffixes) permettent de lire la grande majorité des termes rencontrés dans un dossier médical.

Le diététicien doit savoir faire les **deux opérations** : **décomposer** (du terme vers la définition) et **construire** (de la définition vers le terme).

L'anatomie d'un mot médical

Un terme médical composé comprend au plus quatre types d'éléments, toujours dans le même ordre. Le **préfixe**, placé au début, est facultatif ; il précise le sens (position, quantité, temps, vitesse, absence, anomalie). La **racine** (ou radical) porte le sens principal : elle désigne en général l'**organe**, le tissu, le liquide ou la substance concernés ; un terme peut contenir **plusieurs racines** (hépato-spléno-mégalie, gastro-entéro-logie). La **voyelle de liaison**, le plus souvent **o** (parfois **i**), relie deux racines ou une racine et un suffixe commençant par une consonne. Le **suffixe**, placé à la fin, indique la **catégorie** du mot : maladie (-ite, -ose, -pathie), symptôme (-algie, -rrhée), examen (-scopie, -graphie), acte chirurgical (-ectomie, -stomie), traitement (-thérapie), cellule (-cyte).



Anatomie d'un mot médical : préfixe, racine(s), voyelle de liaison et suffixe ; la définition se reconstruit en traduisant chaque élément

Fig. 29.1. Anatomie d'un mot médical : préfixe, racine(s), voyelle de liaison et suffixe ; cinq termes décomposés

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.1

Le bandeau du haut donne la **formule** d'un terme : préfixe (bleu, facultatif) + racine (orange) + voyelle de liaison (gris) + suffixe (vert). Chaque ligne numérotée décompose un mot réel : **1. péricardite** = péri- (autour) + card- (cœur) + -ite (inflammation) : inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur, le **péricarde** ; **2. hépatomégalie** = hépat- (foie) + o + -mégalie (augmentation de volume) ; **3. hypoglycémie** = hypo- (insuffisance) + glyc- (sucre, glucose) + -émie (dans le sang) ; **4. cholécystectomie** : deux racines (cholé-, bile ; cyst-, poche) + -ectomie (ablation) : ablation de la **vésicule biliaire** ; **5. électrocardiogramme** : deux racines reliées par deux voyelles de liaison + -gramme (tracé enregistré).

La consigne « **lecture : suffixe → préfixe → racine(s)** » rappelle que la définition se reconstruit **en commençant par la fin du mot** : on dit d'abord **ce que c'est** (une inflammation, une ablation, un tracé), puis **où** et **comment**.

Définitions

Préfixe : élément placé **avant** la racine, qui en modifie ou en précise le sens ; il ne peut pas former un mot seul (hyper-, péri-, dys-).

Racine (radical) : élément qui porte le **sens principal** du terme (organe, tissu, substance, fonction) ; elle peut se combiner à un préfixe, à un suffixe ou à une autre racine (gastr-, néphr-, glyc-).

Voyelle de liaison : voyelle (o, plus rarement i) insérée entre deux éléments pour faciliter la prononciation ; elle **disparaît** devant un élément qui commence par une voyelle (gastr-**ite** et non « gastro-ite »).

Suffixe : élément placé **après** la racine, qui indique la **catégorie** du terme (maladie, signe, examen, acte, traitement) ou en fait un adjectif (-al, -ique, -aire).

La voyelle de liaison en pratique. On l'ajoute entre deux consonnes : gastr + scopie → gastr**o**scopie ; cardi + logie → cardi**o**logie ; néphr + lithiase → néphr**o**lithiase. On ne l'ajoute **pas** si le suffixe commence par une voyelle : gastr + ite → gastrite ; néphr + ectomie → néphrectomie ; hépat + ome → hépatome ; arthr + algie → arthralgie. La voyelle **i** se rencontre surtout avec des éléments latins : insectic**i**de, vermifuge, ovipare, carnivore. Quand deux voyelles se rencontrent, la langue courante les garde parfois avec un **trait d'union** ou un tréma pour éviter une mauvaise prononciation : gastro-entérite, oto-rhino-laryngologie, auto-immun, néo-urètre ; les dictionnaires récents écrivent de plus en plus les mots soudés (gastroentérologie, autoimmunité), les deux graphies sont acceptées.

Les suffixes adjectivaux. Beaucoup de termes ne sont pas des noms mais des **adjectifs** formés sur une racine : -al, -ale (rénal), -ique (gastrique, hépatique), -aque (cardiaque), -aire (pulmonaire), -eux (osseux), -é (cutané). Ils signifient « **relatif à** » : insuffisance **rénale** (du rein), ulcère **duodénal**, nutrition **entérale** (par l'intestin), nutrition **parentérale** (« à côté de » l'intestin, c'est-à-dire par voie veineuse), régime **hyposodé** (pauvre en sel). Les adjectifs en -oïde signifient « **qui ressemble à** » (gr. *eidos*, forme) : sigmoïde (en forme de sigma), thyroïde (en forme de bouclier), lymphoïde, androïde (obésité de répartition masculine) et gynoïde (de répartition féminine).

S'entraîner – application

Repérez le préfixe, la ou les racines, la voyelle de liaison et le suffixe des termes suivants, puis définissez-les : **a)** gastroscopie ; **b)** polyurie ; **c)** néphrolithiase ; **d)** hypercholestérolémie ; **e)** endocardite.

Corrigé

a) gastr- (estomac) + o + -scopie (examen visuel) : **examen visuel de l'intérieur de l'estomac** à l'aide d'un endoscope.

b) poly- (nombreux, beaucoup) + -urie (urine) : **émission d'un volume d'urine excessif** (plus de 3 L par 24 h chez l'adulte).

c) néphr- (rein) + o + lith- (pierre) + -iase (état, maladie) : **présence de calculs dans le rein** (lithiase rénale).

d) hyper- (excès) + cholestérol- (cholé-, bile, et *stereos*, solide) + -émie (dans le sang) : **concentration de cholestérol trop élevée dans le sang** ; trois éléments se suivent sans voyelle de liaison car cholestérol est déjà un mot.

e) endo- (à l'intérieur) + card- (cœur) + -ite (inflammation) : **inflammation de l'endocarde**, la tunique interne du cœur qui tapisse les cavités et les valves.

La méthode pour décomposer et définir un terme

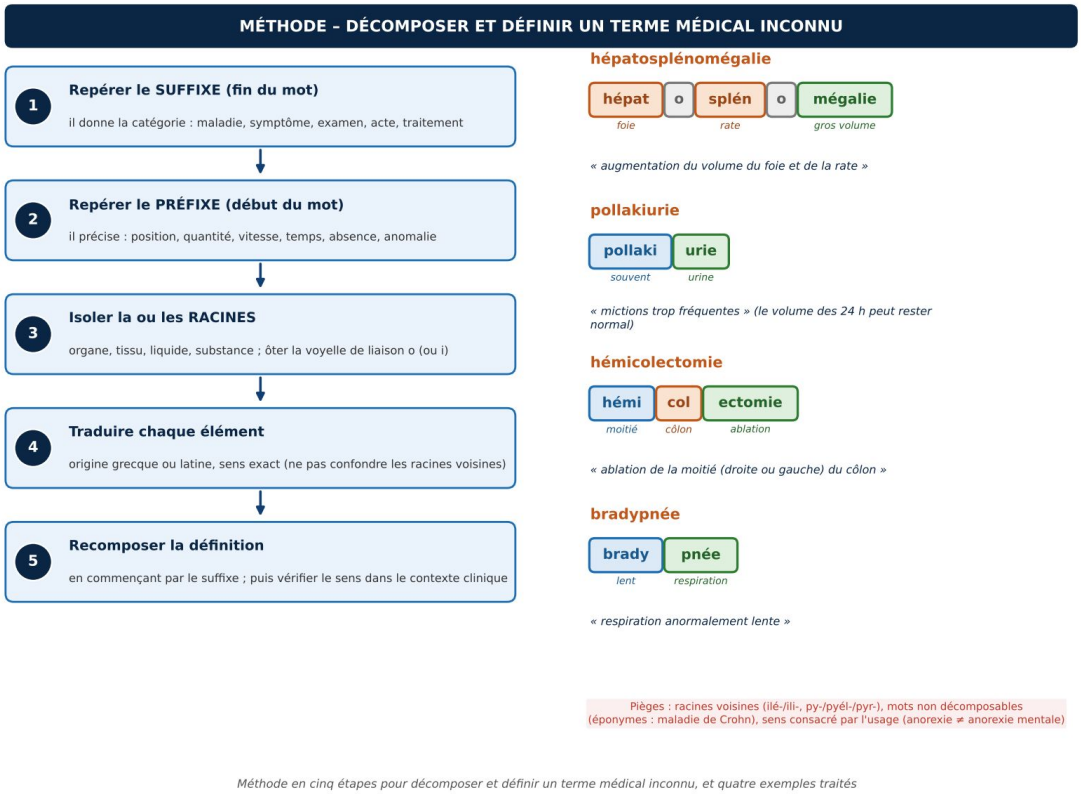
Devant un terme inconnu, il faut éviter deux erreurs : **deviner** son sens d'après une ressemblance vague, ou **renoncer**. La méthode suivante, en cinq étapes, permet de retrouver la définition de la plupart des termes ; elle est attendue à l'examen sous la forme « décomposez le terme et donnez sa définition ».

Comprendre le schéma – figure 29.2

La colonne de gauche donne les **cinq étapes** : **1.** repérer le **suffixe**, à la fin du mot : il donne la

catégorie (maladie, symptôme, examen, acte, traitement) ; **2.** repérer le **préfixe**, au début : il précise la position, la quantité, la vitesse, le temps, l'absence ou l'anomalie ; **3.** isoler la ou les **racines** (organe, tissu, liquide, substance) en ôtant les voyelles de liaison ; **4. traduire** chaque élément avec son sens exact ; **5. recomposer** la définition en commençant par le suffixe, puis vérifier qu'elle a un sens dans le contexte clinique.

La colonne de droite applique la méthode à quatre termes. **Hépatosplénomégalie** : deux racines (hépat-, foie ; splén-, rate) et -mégalie : augmentation du volume du foie et de la rate. **Pollakiurie** : pollaki- (souvent) + -urie : mictions **trop fréquentes**, alors que le volume des 24 heures peut rester normal (à ne pas confondre avec la polyurie, où c'est le **volume** qui est excessif). **Hémicolectomie** : hémi- (moitié) + col- (côlon) + -ectomie : ablation de la moitié droite ou gauche du côlon. **Bradypnée** : brady- (lent) + -pnée (respiration) : respiration anormalement lente. L'encadré rouge rappelle les **pièges** : racines voisines, mots qui ne se décomposent pas (éponymes) et sens consacré par l'usage.



Méthode en cinq étapes pour décomposer et définir un terme médical inconnu, et quatre exemples traités

Fig. 29.2. Méthode en cinq étapes pour décomposer et définir un terme médical inconnu, et quatre exemples traités

Méthode

Rédiger une définition à l'examen. 1) Écrire la **décomposition** avec un trait ou un tiret entre les éléments et le sens de chacun entre parenthèses : « cholécystectomie : cholé- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ectomie (ablation) ». 2) Donner la **définition** en une phrase complète, en langage médical correct : « ablation chirurgicale de la vésicule biliaire ». 3) Si la question le demande, ajouter le **contexte** : « réalisée le plus souvent par cœlioscopie en cas de lithiase biliaire symptomatique ».

Vérifier la cohérence. Une décomposition littérale peut être **trompeuse** : « anorexie » signifie littéralement « absence d'appétit », mais l'**anorexie mentale** est un trouble du comportement alimentaire où l'appétit est longtemps conservé et la restriction volontaire ; « antibiotique » signifie littéralement « contre la vie », mais désigne une substance active contre les bactéries ; « diabète » vient du grec *diabainein*, « passer à travers » (l'eau semble traverser le corps : polyurie), et ne se décompose pas en éléments utiles. On reformule toujours la traduction littérale en définition médicale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Construisez le terme médical correspondant à chaque définition : **a)** inflammation du foie ; **b)** ablation de l'estomac ; **c)** douleur d'une articulation ; **d)** concentration de sodium trop basse dans le sang ; **e)** abouchement du côlon à la peau ; **f)** examen visuel de l'intérieur du côlon ; **g)** paralysie partielle de l'estomac ; **h)** respiration difficile.

CORRIGÉ

a) hépat- + -ite → **hépatite** ; **b)** gastr- + -ectomie → **gastrectomie** ; **c)** arthr- + -algie → **arthralgie** ; **d)** hypo- + natr- + -émie → **hyponatrémie** ; **e)** col- + o + -stomie → **colostomie** ; **f)** col- + o + -scopie → **coloscopie** ; **g)** gastr- + o + -parésie → **gastroparésie** ; **h)** dys- + -pnée → **dyspnée**.

Les doublets grec et latin

Pour beaucoup d'organes, il existe **deux racines** : une **grecque** et une **latine**. Ce n'est pas un hasard : le latin a donné le français courant et l'anatomie descriptive, le grec a fourni les mots savants de la pathologie. La tendance générale est la suivante : la **racine grecque** forme surtout les **noms de maladies, d'examens et d'actes** (néphrite, néphrectomie, néphrologie), la **racine latine** forme les **adjectifs** anatomiques et les mots courants (rénal, surrénale, insuffisance rénale). Connaître les deux formes est indispensable pour reconnaître qu'il s'agit du même organe.

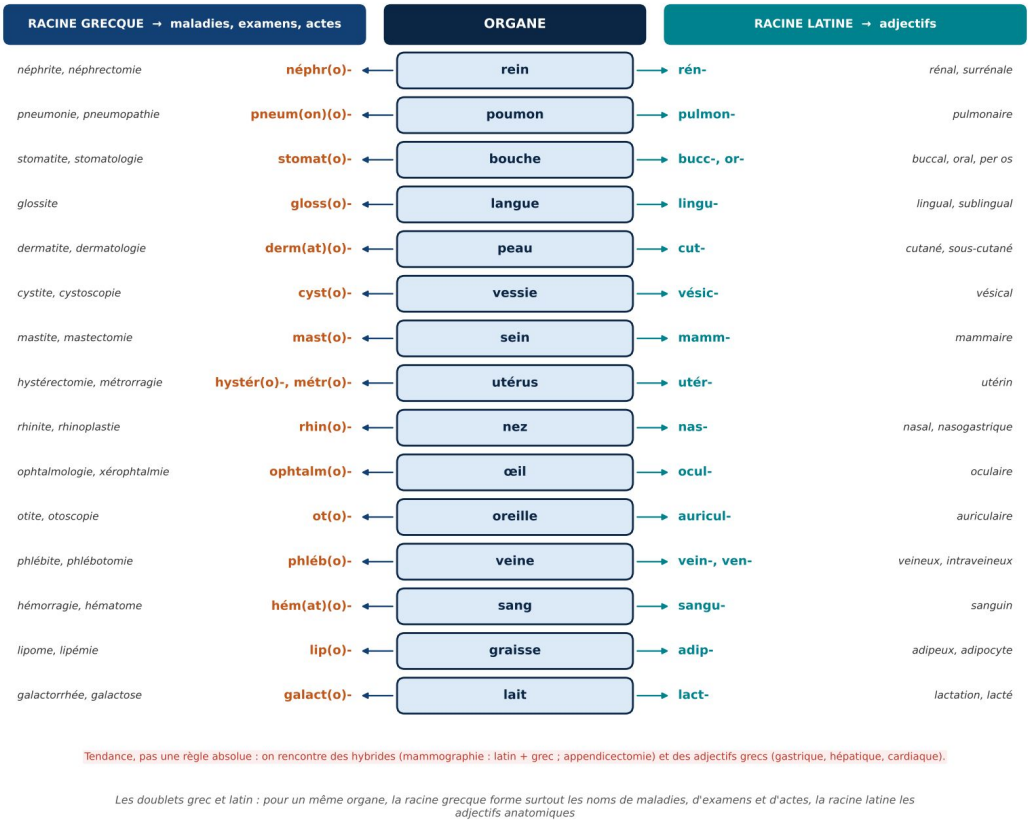


Fig. 29.3. Les doublets grec et latin : pour un même organe, la racine grecque forme surtout les noms de maladies, d'examens et d'actes, la racine latine les adjectifs anatomiques

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.3

Au centre, quinze **organes** ; à gauche, la **racine grecque** (en orange) et deux termes qu'elle forme (maladie, examen ou acte) ; à droite, la **racine latine** (en bleu-vert) et les adjectifs correspondants. Rein : **néphr(o)-** (néphrite, néphrectomie) et **rén-** (rénal, surrénale) ; poumon : **pneum(on)(o)-** (pneumonie) et **pulmon-** (pulmonaire) ; bouche : **stomat(o)-** (stomatite) et **bucc-, or-** (buccal, oral, *per os*) ; langue : **gloss(o)-** et **lingu-** ; peau : **derm(at)(o)-** et **cut-** (cutané, sous-cutané) ; vessie : **cyst(o)-** et **vésic-** ; sein : **mast(o)-** et **mamm-** ; utérus : **hystér(o)-, métr(o)-** et **utér-** ; nez : **rhin(o)-** et **nas-** (sonde nasogastrique) ; œil : **ophtalm(o)-** et **ocul-** ; oreille

: **ot(o)-** et **auricul-** ; veine : **phléb(o)-** et **vein-, ven-** (intraveineux) ; sang : **hém(at)(o)-** et **sangu-** ; graisse : **lip(o)-** et **adip-** ; lait : **galact(o)-** et **lact-**.

La note rouge précise qu'il s'agit d'une **tendance**, pas d'une règle : il existe des **hybrides** (mammographie : latin + grec ; appendicectomie : latin + grec ; hypertension : grec + latin) et des adjectifs formés sur le grec (gastrique, hépatique, cardiaque, pneumatique).

Organe ou notion · Racine grecque · Exemples · Racine latine · Exemples

estomac — *Racine grecque :* gastr(o)- ; *Exemples :* gastrite, gastrectomie ; *Racine latine :* stomac- (rare) ; *Exemples :* stomacal

intestin — *Racine grecque :* entér(o)- ; *Exemples :* entérite, entéral ; *Racine latine :* intestin- ; *Exemples :* intestinal

foie — *Racine grecque :* hépat(o)- ; *Exemples :* hépatite, hépatocyte ; *Racine latine :* jecor- (inusité) ; *Exemples :* « hépatique » sert d'adjectif

cœur — *Racine grecque :* cardi(o)- ; *Exemples :* cardiopathie, cardiaque ; *Racine latine :* cord-, cœur ; *Exemples :* cordial (rare en médecine)

vaisseau — *Racine grecque :* angi(o)- ; *Exemples :* angiographie, angioplastie ; *Racine latine :* vas(o)-, vascul(o)- ; *Exemples :* vasodilatation, vasculaire

artère — *Racine grecque :* artéri(o)- ; *Exemples :* artérite, artériographie ; *Racine latine :* arter- ; *Exemples :* artériel

os — *Racine grecque :* osté(o)- ; *Exemples :* ostéoporose, ostéite ; *Racine latine :* oss- ; *Exemples :* osseux, ossification

muscle — *Racine grecque :* my(o)- ; *Exemples :* myalgie, myocarde ; *Racine latine :* muscul- ; *Exemples :* musculaire

nerf — *Racine grecque :* neur(o)-, névr(o)- ; *Exemples :* neuropathie, névralgie ; *Racine latine :* nerv- ; *Exemples :* nerveux

tête — *Racine grecque :* céphal(o)- ; *Exemples :* céphalée ; *Racine latine :* capit- ; *Exemples :* capital, décapitation

dent — *Racine grecque :* odont(o)- ; *Exemples :* odontologie ; *Racine latine :* dent- ; *Exemples :* dentaire, dentition

femme — *Racine grecque :* gynéc(o)- ; *Exemples :* gynécologie ; *Racine latine :* femin- ; *Exemples :* féminin

enfant — *Racine grecque :* pédi- (*pais*) ; *Exemples :* pédiatrie ; *Racine latine :* infant- ; *Exemples :* infantile

pied — *Racine grecque :* pod(o)- ; *Exemples :* podologue ; *Racine latine :* péd- (*pes*) ; *Exemples :* pédieux, pédicure

main — *Racine grecque :* chir(o)- ; *Exemples :* chirurgie ; *Racine latine :* man- ; *Exemples :* manuel

vie — *Racine grecque :* bi(o)- ; *Exemples :* biologie, biopsie ; *Racine latine :* vit- ; *Exemples :* vital, vitamine

mort — *Racine grecque :* nécr(o)-, thanat(o)- ; *Exemples :* nécrose ; *Racine latine :* mort- ; *Exemples :* mortalité

sucre — *Racine grecque :* glyc(o)-, gluc(o)- ; *Exemples :* glycémie, glucose ; *Racine latine :* sacchar- (lat. *saccharum*) ; *Exemples :* saccharose

eau — *Racine grecque :* hydr(o)- ; *Exemples :* hydrique, déshydratation ; *Racine latine :* aqu- ; *Exemples :* aqueux

rein — *Racine grecque :* néphr(o)- ; *Exemples :* néphropathie ; *Racine latine :* rén- ; *Exemples :* rénal

Les familles de mots. Une racine ou un suffixe connu ouvre l'accès à des dizaines de termes. C'est la façon la plus efficace d'apprendre : on ne mémorise pas des mots isolés, mais des **éléments** qui se combinent. La figure suivante en donne deux exemples ; les tableaux des parties 29.3.2 à 29.3.4 sont construits sur le même principe.

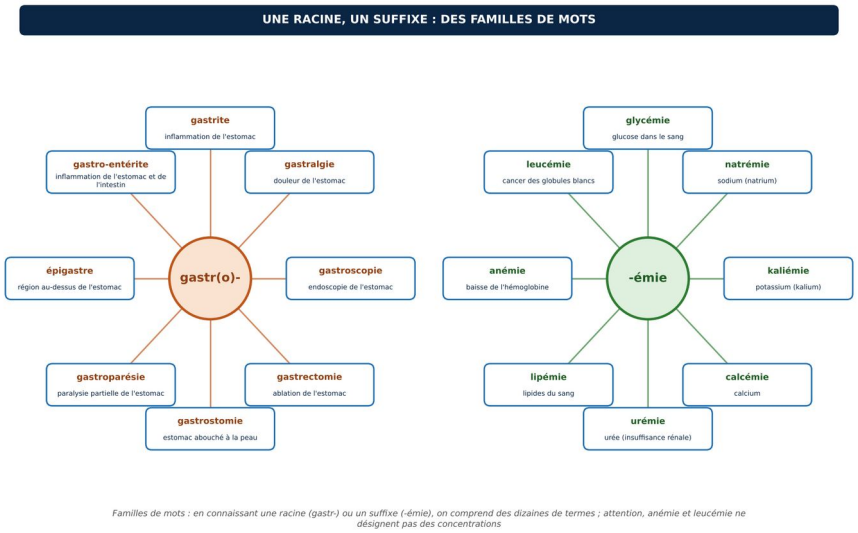


Fig. 29.4. Familles de mots : en connaissant une racine (gastr-) ou un suffixe (-émie), on comprend des dizaines de termes ; attention, anémie et leucémie ne désignent pas des concentrations

Comprendre le schéma – figure 29.4

À gauche, la racine **gastr(o)-** combinée à huit éléments : -ite (gastrite), -algie (gastralgie), -scopie (gastroscopie), -ectomie (gastrectomie), -stomie (gastrostomie), -parésie (gastroparésie, paralysie partielle de l'estomac, fréquente au cours du diabète ancien), le préfixe épi- (épigastre, la région de l'abdomen située au-dessus de l'estomac) et une seconde racine (gastro-entérite). À droite, le suffixe **-émie** combiné à huit racines : glyc- (glucose), natr- (sodium, lat. *natrium*), kali- (potassium, lat. *kalium*), calc- (calcium), ur- (urée), lip- (lipides) ; deux termes font exception : l'**anémie** (an- + -émie) est une **diminution de l'hémoglobine** et la **leucémie** (« sang blanc ») un **cancer** des cellules souches de la moelle osseuse qui produisent les globules blancs : ni l'une ni l'autre ne désigne une concentration.

Les termes non décomposables : éponymes, sigles, termes historiques

Tous les termes médicaux ne se décomposent pas. Il faut en connaître quatre catégories.

1. Les éponymes sont des maladies, des signes, des structures ou des interventions qui portent le **nom d'une personne** (souvent le médecin qui les a décrits) ou d'un lieu. Ils ne contiennent aucun indice sur l'organe ou le mécanisme : il faut les apprendre. Les plus utiles au diététicien figurent dans le tableau ci-dessous ; on les retrouve dans les chapitres de physiopathologie. La tendance actuelle est de les remplacer par des termes descriptifs (« thyroïdite auto-immune » plutôt que « maladie de Hashimoto ») ; les deux formes coexistent dans les dossiers.

Éponyme · Définition · Terme descriptif · Chapitre

maladie de Crohn — *Définition :* maladie inflammatoire chronique pouvant toucher tout le tube digestif ; *Terme descriptif :* MICI (maladie inflammatoire chronique de l'intestin) ; *Chapitre :* 32

maladie de Basedow (Graves) — *Définition :* hyperthyroïdie auto-immune par anticorps stimulant le récepteur de la TSH ; *Terme descriptif :* hyperthyroïdie auto-immune ; *Chapitre :* 13, 36

maladie de Hashimoto — *Définition :* thyroïdite auto-immune évoluant souvent vers une hypothyroïdie ; *Terme descriptif :* thyroïdite chronique auto-immune ; *Chapitre :* 13, 36

maladie d'Addison — *Définition :* insuffisance de la corticosurrénale d'origine surrénalienne ; *Terme descriptif :* insuffisance surrénale primaire ; *Chapitre :* 13, 23

syndrome de Cushing — *Définition :* excès chronique de cortisol ; *Terme descriptif :* hypercorticisme ; *Chapitre :* 13, 23

maladie d'Alzheimer — *Définition :* maladie neuroévolutive avec atteinte de la mémoire et des fonctions cognitives ; *Terme descriptif :* maladie neurodégénérative ; *Chapitre :* 37

maladie de Parkinson — *Définition :* maladie neuroévolutive par perte des neurones dopaminergiques ; *Terme descriptif :* syndrome parkinsonien ; *Chapitre :* 37

encéphalopathie de Gayet-Wernicke — *Définition :* atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine (vitamine B1) ; *Terme descriptif :* encéphalopathie carentielle ; *Chapitre :* 37, 41

maladie de Charcot — *Définition :* atteinte des neurones moteurs centraux et périphériques ; *Terme descriptif :* sclérose latérale amyotrophique (SLA) ; *Chapitre :* 37

maladie de Biermer — *Définition :* carence en vitamine B12 par gastrite auto-immune (absence de facteur intrinsèque) ; *Terme descriptif :* anémie pernicieuse ; *Chapitre :* 12, 32

îlots de Langerhans — *Définition :* amas de cellules endocrines du pancréas (insuline, glucagon) ; *Terme descriptif :* îlots pancréatiques ; *Chapitre :* 13, 21

valvule de Bauhin — *Définition :* valvule entre l'iléon et le cæcum ; *Terme descriptif :* valvule iléocæcale ; *Chapitre :* 17

intervention de Whipple — *Définition :* ablation de la tête du pancréas et du duodénum ; *Terme descriptif :* duodénopancréatectomie céphalique ; *Chapitre :* 33

test de Schilling (ancien) — *Définition :* mesure de l'absorption de la vitamine B12 ; *Terme descriptif :* test d'absorption de la B12 ; *Chapitre :* 30

2. Les sigles et les acronymes abrègent un groupe de mots par ses initiales : **HTA** (hypertension artérielle), **DT2** (diabète de type 2), **IMC** (indice de masse corporelle), **AVC** (accident vasculaire cérébral), **NFS** (numération formule sanguine), **IRM** (imagerie par résonance magnétique). Un **acronyme** se prononce comme un mot (SIDA, IDDSI) ; un **sigle** se prononce lettre par lettre (HTA). Ils sont très nombreux dans les dossiers : un tableau des abréviations usuelles est donné en 29.3.6. Règle d'écriture : à la première occurrence dans un document destiné à d'autres, on écrit le terme en entier suivi du sigle entre parenthèses.

3. Les mots hérités du langage courant ou de l'histoire : scorbut (carence en vitamine C), béribéri (carence en thiamine), pellagre (carence en niacine, de l'italien *pelle agra*, peau rugueuse), rachitisme (du grec *rhakhis*, colonne, car il déforme le squelette), goitre (latin *guttur*, gorge), ictère, angine, grippe, rougeole. Certains se décomposent en partie, d'autres non.

4. Les emprunts à l'anglais, de plus en plus nombreux : *stent* (endoprothèse vasculaire), *by-*

pass (dérivation, contournement chirurgical, comme le « bypass gastrique » ou court-circuit gastrique), *scanner* (tomodensitomètre), *screening* (dépistage), *burn-out* (épuisement professionnel), *binge eating* (hyperphagie boulimique). Les recommandations françaises proposent un équivalent français ; dans un écrit professionnel, on privilégie le terme français et on peut ajouter l'anglais entre parenthèses.

L'orthographe et les termes voisins

Une seule lettre peut changer le sens d'un terme : **hypo**kaliémie et **hyper**kaliémie ont des conséquences opposées sur le cœur, **ilé**on et **ili**on désignent l'intestin et l'os. L'orthographe exacte fait donc partie de la compétence attendue. Quelques règles reviennent sans cesse, car elles transcrivent en français des lettres grecques.

Graphie · Origine · Exemples · Erreur fréquente

ph = son « f » — *Origine :* lettre grecque phi (φ) ; *Exemples :* œsophage, lymphe, phlébite, dysphagie, néphron ; *Erreur fréquente :* « dysfagie », « néfrite »

th = son « t » — *Origine :* lettre grecque thêta (θ) ; *Exemples :* thrombose, thérapie, athérome, thyroïde ; *Erreur fréquente :* « trombose »

ch = son « k » — *Origine :* lettre grecque khi (χ) ; *Exemples :* cholestérol, chondrocyte, chirurgie, chimiothérapie, bronche (son « ch » par exception) ; *Erreur fréquente :* prononcer « cholé » comme « chaud »

y — *Origine :* lettre grecque upsilon (υ) ; *Exemples :* dys-, hypo-, hyper-, poly-, cyto-, glycémie, lymphe, myocarde ; *Erreur fréquente :* « dis- », « hipo- », « glicémie »

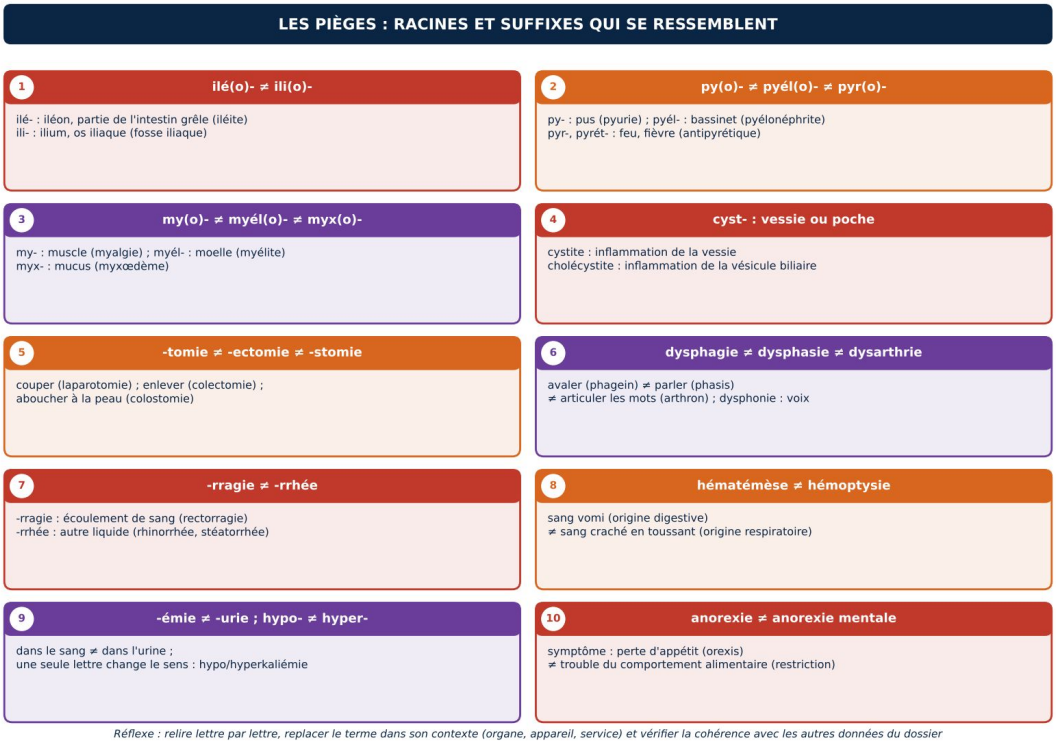
rh et **rr** — *Origine :* esprit rude du grec (ῥ) ; *Exemples :* rhinite, rhumatisme ; diarrhée, hémorragie, -rraphie ; *Erreur fréquente :* « diarhée », « hémoragie »

œ, **æ** — *Origine :* diphtongues grecques et latines ; *Exemples :* œsophage, œdème, fœtus, cæcum, hématie ; *Erreur fréquente :* « oesophage » accepté, « ésophage » faux

pn, **ps**, **pt** — *Origine :* groupes de consonnes grecs ; *Exemples :* pneumonie, apnée, psychiatrie, hémoptysie ; *Erreur fréquente :* oublier le p

-émie et **-urie** — *Origine :* grec *haima* et *ouron* ; *Exemples :* glycémie, glycosurie ; *Erreur fréquente :* « glycémi », « glycosuri »

Pluriels et accords. Les termes savants français prennent un -s au pluriel comme les autres noms (des cholécystectomies, des stomies). Les mots latins restés tels quels gardent parfois leur pluriel latin dans les écrits savants (un *foramen*, des *foramina* ; un *corpus*, des *corpora*) mais l'usage français admet le -s. Les adjectifs en -al font -aux au masculin pluriel (rénal, rénaux ; duodénal, duodénaux), et le féminin s'accorde avec le nom (insuffisance rénale, nutrition entérale). Les noms de maladies ne prennent pas de majuscule (diabète, cirrhose), sauf le nom propre d'un éponyme (maladie de Crohn).



Les principaux pièges de la terminologie : racines voisines, suffixes proches et termes dont le sens courant diffère du sens médical

Fig. 29.5. Les principaux pièges de la terminologie : racines voisines, suffixes proches et termes dont le sens courant diffère du sens médical

Comprendre le schéma – figure 29.5

Les dix cartes regroupent les confusions les plus fréquentes dans les copies et les transmissions. **1. ilé(o)- ≠ ili(o)-** : l'**iléon** est la dernière partie de l'intestin grêle (iléite, iléostomie) ; l'**ilion** est la partie supérieure de l'os coxal (fosse iliaque, crête iliaque). **2. py(o)- ≠ pyél(o)- ≠ pyr(o)-** : pus (pyurie), bassinet du rein (pyélonéphrite), feu ou fièvre (antipyrétique). **3. my(o)- ≠ myél(o)- ≠ myx(o)-** : muscle (myalgie), moelle (myélite, myélome), mucus (myxœdème, l'infiltration de la peau dans l'hypothyroïdie). **4. cyst-** désigne la vessie **ou** toute poche : cystite (vessie) mais cholécystite (vésicule biliaire). **5. -tomie ≠ -ectomie ≠ -stomie** : couper, enlever, aboucher. **6. dysphagie ≠ dysphasie ≠ dysarthrie** : avaler, parler (langage), articuler ; la dysphonie concerne la voix. **7. -rragie ≠ -rrhée** : écoulement de sang, écoulement d'un autre liquide. **8. hématémèse ≠ hémoptysie** : sang vomi (origine digestive), sang craché en toussant (origine respiratoire). **9. -émie ≠ -urie** et **hypo- ≠ hyper-** : dans le sang ou dans l'urine ; au-dessous ou au-dessus. **10. anorexie ≠ anorexie mentale** : le symptôme (perte d'appétit, fréquente au cours des cancers et des infections) et le trouble du comportement alimentaire.

La phrase du bas donne le **réflexe** à acquérir : relire le terme lettre par lettre, le replacer dans son **contexte** (organe, appareil, service) et vérifier sa cohérence avec les autres données du dossier.

Termes voisins · Sens du premier · Sens du second · Moyen mnémotechnique

hémi- / hémo- — *Sens du premier :* moitié (hémiplégie) ; *Sens du second :* sang (hémorragie) ; *Moyen mnémotechnique :* hémi = moitié comme demi

ana- / an- — *Sens du premier :* vers le haut, de nouveau (anabolisme, anamnèse) ; *Sens du second :* privatif (anémie, anurie) ; *Moyen mnémotechnique :* regarder si le mot continue par une voyelle (an-urie) ou par « a » (ana-bolisme)

anti- / anté- — *Sens du premier :* contre (antiémétique) ; *Sens du second :* avant (antépartum) ; *Moyen mnémotechnique :* anté comme « antérieur »

hypo- / hyper- — *Sens du premier :* au-dessous, insuffisance ; *Sens du second :* au-dessus, excès ; *Moyen mnémotechnique :* o comme « en dessous », er comme « supérieur »

inter- / intra- — *Sens du premier :* entre (intercostal) ; *Sens du second :* à l'intérieur (intraveineux) ; *Moyen mnémotechnique :* intra = dedans

-phagie / -phasie — *Sens du premier :* manger, avaler ; *Sens du second :* parler ; *Moyen mnémotechnique :* phag- comme « œsophage »

-ite / -ose — *Sens du premier :* inflammation ; *Sens du second :* maladie non inflammatoire, dégénérative ou chronique ; *Moyen mnémotechnique :* arthrite (aiguë) / arthrose (usure)

prostate / prostration — *Sens du premier :* glande masculine ; *Sens du second :* abattement extrême ; *Moyen mnémotechnique :* sans rapport

urètre / uretère — *Sens du premier :* conduit de la vessie vers l'extérieur ; *Sens du second :* conduit du rein vers la vessie ; *Moyen mnémotechnique :* uretère : deux, plus long ; urètre : un seul

iléon / ilion — *Sens du premier :* partie terminale de l'intestin grêle ; *Sens du second :* partie supérieure de l'os iliaque ; *Moyen mnémotechnique :* iléon : é comme entér-

malléole / malléable — *Sens du premier :* saillie osseuse de la cheville ; *Sens du second :* qui se déforme ; *Moyen mnémotechnique :* sans rapport

angine / angi(o)- — *Sens du premier :* inflammation de la gorge (lat. *angere*, serrer) ; *Sens du second :* vaisseau (gr. *angeion*) ; *Moyen mnémotechnique :* l'angine de poitrine est une douleur constrictive, pas une maladie des vaisseaux de la gorge

S'entraîner – application

Corrigez les erreurs de terminologie de cette transmission rédigée par un stagiaire : « Patiente de 78 ans, admise pour **hématémèse** (crachats sanglants au cours d'une pneumopathie). Antécédents d'**iliostomie** pour cancer du rectum et d'**arthrite** de la hanche (usure du cartilage). Présente une **dysphasie** aux liquides justifiant une eau gélifiée. Kaliémie à 3,1 mmol/L : **hyperkaliémie**. »

Corrigé

hématémèse → hémoptysie : le sang est **craché en toussant** et vient des voies respiratoires (pneumopathie) ; l'hématémèse est un vomissement de sang d'origine digestive.

iliostomie → iléostomie (ou colostomie) : l'abouchement à la peau concerne l'**iléon** (ilé-), pas l'os iliaque ; après amputation du rectum, on réalise plutôt une colostomie définitive ou une iléostomie de protection.

arthrite → arthrose (coxarthrose) : l'usure dégénérative du cartilage est une arthrose (-ose) ; l'arthrite est une inflammation de l'articulation.

dysphasie → dysphagie : la difficulté concerne la **déglutition** (-phagie) des liquides, ce qui justifie l'eau gélifiée ; la dysphasie est un trouble du langage.

hyperkaliémie → hypokaliémie : 3,1 mmol/L est **au-dessous** de l'intervalle de référence (3,5 à 5,0 mmol/L).

29.3.2 Les préfixes

Module · *Guide 2025 p. 99-100 : 53 préfixes · CNED : 3-2023 M1 S1 §1*

Le préfixe est l'élément le plus facile à repérer : il se trouve au **début** du mot et appartient à une liste assez courte. Il ne désigne jamais l'organe, mais il **modifie** le sens de la racine : il la **situe** (épi-, sous-, péri-), la **quantifie** (hypo-, hyper-, oligo-, poly-), la **date** (pré-, post-), en indique la **vitesse** (brady-, tachy-), la **qualité** (eu-, dys-, mal-) ou la **négation** (a-, an-, anti-). Un même préfixe garde le même sens dans tous les mots où il apparaît : connaître **hypo-** permet de comprendre hypoglycémie, hypokaliémie, hypotension, hypothyroïdie, hypoderme, hypophyse et hypothalamus.

Les préfixes viennent du **grec** ou du **latin**, et beaucoup vont **par paires** de même sens : épi- (gr.) et supra- (lat.), hypo- (gr.) et sub- (lat.), endo- (gr.) et intra- (lat.), exo- (gr.) et extra- (lat.), hémi- (gr.) et semi- (lat.), poly- (gr.) et multi- (lat.), péri- (gr.) et circum- (lat.). En principe, on associe un préfixe grec à une racine grecque (hypoglycémie) et un préfixe latin à une racine latine (sublingual), mais les hybrides sont fréquents (hypertension : préfixe grec et racine latine ; à l'inverse, intraveineux est entièrement latin et hypodermique entièrement grec).

Les préfixes de position et de direction

Les préfixes de **position** situent une structure **par rapport à un organe** ou à un point de repère : au-dessus, au-dessous, autour, à côté, devant, derrière, entre, dedans, dehors, à travers. Ils sont très nombreux en **anatomie** (épigastre, hypoderme, péricarde, parathyroïde) et dans les noms des **voies d'administration** (sublingual, intraveineux, sous-cutané, transdermique, percutané).

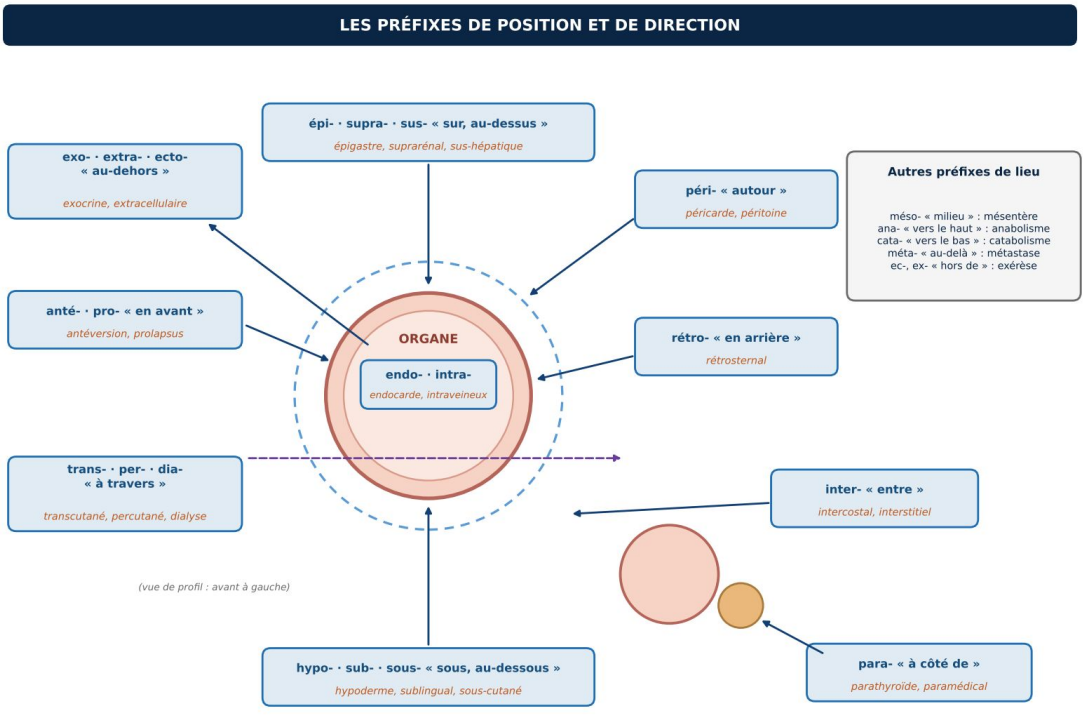


Fig. 29.6. Les préfixes de position et de direction situent une structure par rapport à un organe ; flèche violette : traverser (trans-, per-, dia-) ; exemples en italique

Comprendre le schéma – figure 29.6

L'organe est représenté au centre par un disque (paroi et cavité) entouré d'un cercle pointillé (son voisinage). **endo-, intra-** désignent l'**intérieur**

(endocarde, la tunique interne du cœur ; intraveineux, dans une veine) ; **exo-, extra-, ecto-** l'**extérieur** (glande exocrine, dont la sécrétion est déversée à l'extérieur du milieu intérieur, dans un conduit ; liquide extracellulaire) ; **épi-, supra-, sus-** le **dessus** (épigastre ; suprarénal, synonyme de surrénal ; veines sus-hépatiques) ; **hypo-, sub-, sous-** le **dessous** (hypoderme, sous le derme ; sublingual, sous la langue ; sous-cutané) ; **péri-** le **pourtour** (péricarde, l'enveloppe du cœur ; péritoine, la séreuse qui enveloppe les viscères abdominaux) ; **anté-, pro-** l'**avant** (antéversion de l'utérus ; prolapsus, « chute en avant » d'un organe) ; **rétro-** l'**arrière** (douleur rétrosternale, derrière le sternum) ; **inter-** l'intervalle **entre** deux structures (espace intercostal ; tissu interstitiel) ; **para-** la position **à côté** (parathyroïdes, à côté de la thyroïde). La flèche violette traverse l'organe : **trans-, per-, dia-** signifient « **à travers** » (transcutané, percutané, dialyse : passage à travers une membrane).

L'encadré gris ajoute cinq préfixes de lieu ou de mouvement : **méso-** (milieu : mésentère, le repli du péritoine qui suspend l'intestin), **ana-** (vers le haut : anabolisme, synthèse), **cata-** (vers le bas : catabolisme, dégradation), **méta-** (au-delà, changement : métastase, « déplacement » d'un cancer), **ec-, ex-** (hors de : exérèse, ablation chirurgicale ; ectopie).

Préfixe · Sens · Exemples de la pratique diététique

endo- (gr.), intra- (lat.) — *Sens :* à l'intérieur ; *Exemples de la pratique diététique :* endoscopie (voir l'intérieur), endocrine, endogène ; intracellulaire, intraveineux (IV), intramusculaire (IM)

exo- (gr.), extra- (lat.), ecto- (gr.) — *Sens :* à l'extérieur ; *Exemples de la pratique diététique :* exocrine, exogène (apporté de l'extérieur : alimentation), exocytose ; extracellulaire, extrarénal ; ectopie

épi- (gr.), supra- (lat.), sus- — *Sens :* sur, au-dessus ; *Exemples de la pratique diététique :* épigastre, épiderme, épiglotte, épiphyse ; suprarénal ; sus-hépatique, sus-ombilical

hypo- (gr.), sub- (lat.), sous- — *Sens :* sous, au-dessous ; *Exemples de la pratique diététique :* hypoderme, hypophyse, hypothalamus, hypocondre ; sublingual, subclaviculaire ; sous-cutané (SC)

péri- (gr.), circum- (lat.) — *Sens :* autour ; *Exemples de la pratique diététique :* péricarde, péritoine, périnatal, périombilical ; circoncision

para- (gr.) — *Sens :* à côté de ; *Exemples de la pratique diététique :* parathyroïde, paramédical, parentéral (à côté de l'intestin)

anté- (lat.), pro- (gr. et lat.) — *Sens :* devant, en avant ; *Exemples de la pratique diététique :* antérieur, antéversion ; prolapsus, procidence

rétro- (lat.) — *Sens :* en arrière ; *Exemples de la pratique diététique :* rétrosternal, rétropéritonéal (organes situés derrière le péritoine : reins, pancréas)

inter- (lat.) — *Sens :* entre ; *Exemples de la pratique diététique :* intercostal, interstitiel, intervertébral, interventriculaire

trans- (lat.), per- (lat.), dia- (gr.) — *Sens :* à travers ; *Exemples de la pratique diététique :* transcutané, transmural ; percutané, *per os* (par la bouche) ; dialyse, diarrhée (écoulement à travers)

méso- (gr.) — *Sens :* au milieu ; *Exemples de la pratique diététique :* mésentère, mésoderme, mésogastre (région ombilicale)

ec-, ex- (gr. et lat.) — *Sens :* hors de ; *Exemples de la pratique diététique :* exérèse, excision, exophtalmie (œil saillant hors de l'orbite)

ana- (gr.) / cata- (gr.) — *Sens :* vers le haut / vers le bas ; *Exemples de la pratique diététique :* anabolisme (synthèse) / catabolisme (dégradation) ; hypercatabolisme du patient agressé

méta- (gr.) — *Sens :* au-delà, après, changement ; *Exemples de la pratique diététique :* métastase, métabolisme (transformation), métaplasie (changement de type de tissu)

Lien avec la diététique

Les voies d'administration se nomment avec ces préfixes : *per os* (PO, par la bouche), **sublinguale** (sous la langue : absorption directe sans premier passage hépatique), **entérale** (par le tube digestif, en particulier par sonde), **parentérale** (en dehors du tube digestif : en pratique **intraveineuse**), **intramusculaire**, **sous-cutanée** (insuline), **transdermique** ou **transcutanée** (patch). En nutrition clinique, l'opposition **entérale / parentérale** est fondamentale : la nutrition entérale utilise le tube digestif et doit être préférée dès qu'il est fonctionnel (règle « *if the gut works, use it* ») ; la nutrition parentérale apporte les nutriments par une veine (voir 29.3.6).

Les préfixes de quantité et de mesure

Les préfixes de **quantité** et d'**intensité** sont les plus importants pour le diététicien, car ils servent à qualifier un **résultat** : une glycémie, une natrémie, une diurèse, une fréquence cardiaque. Chacun situe la valeur **sous**, **dans** ou **au-dessus** de l'intervalle de référence. Le préfixe ne donne pas le **seuil** : il faut connaître les valeurs normales, présentées dans la fiche « Valeurs de référence » (29.9) et détaillées au chapitre 30.

Comprendre le schéma – figure 29.7

Chaque bande horizontale représente une grandeur mesurée chez l'adulte ; la zone verte correspond à l'**intervalle de référence**, les zones bleues aux valeurs basses (préfixe **hypo-**, **brady-**, **oligo-**, **an-**), les zones rouges aux valeurs élevées (**hyper-**, **tachy-**, **poly-**). **Glycémie à jeun** : hypoglycémie

au-dessous de 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ; normoglycémie de 0,70 à 1,10 g/L ; **hyperglycémie modérée à jeun** de 1,10 à 1,25 g/L ; **diabète** à partir de 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises. **Fréquence cardiaque de repos** : bradycardie au-dessous de 60 par minute, tachycardie au-dessus de 100. **Fréquence respiratoire** : bradypnée au-dessous de 12 cycles par minute, eupnée de 12 à 20, tachypnée (ou polypnée) au-dessus de 20. **Diurèse des 24 heures** : anurie au-dessous de 100 mL, oligurie au-dessous de 500 mL, polyurie au-dessus de 3 L. **Natrémie** : hyponatrémie au-dessous de 135 mmol/L, hypernatrémie au-dessus de 145 mmol/L. **Température centrale** : hypothermie au-dessous de 35 °C, état subfébrile de 37,5 à 38 °C, fièvre à partir de 38 °C.

Le cadre de droite regroupe les préfixes et suffixes de quantité : a-, an- (absence : anurie, aphagie) ; oligo- (peu : oligurie, oligoélément) ; hypo- (insuffisance : hypokaliémie) ; normo-, eu- (normal : normocalcémie, euthyroïdie) ; iso- (égal : isotonique) ; hyper- (excès : hypercholestérolémie) ; poly-, multi- (nombreux : polydipsie, multipare) ; pan- (tout : pancytopénie, la baisse des trois lignées sanguines) ; micro-, macro- (petit, grand : microcytose, macrocytose) ; méga- et -mégalie (très grand : mégacôlon, splénomégalie) ; -pénie (manque : thrombopénie, sarcopénie) ; -émie (dans le sang : urémie, lipémie).

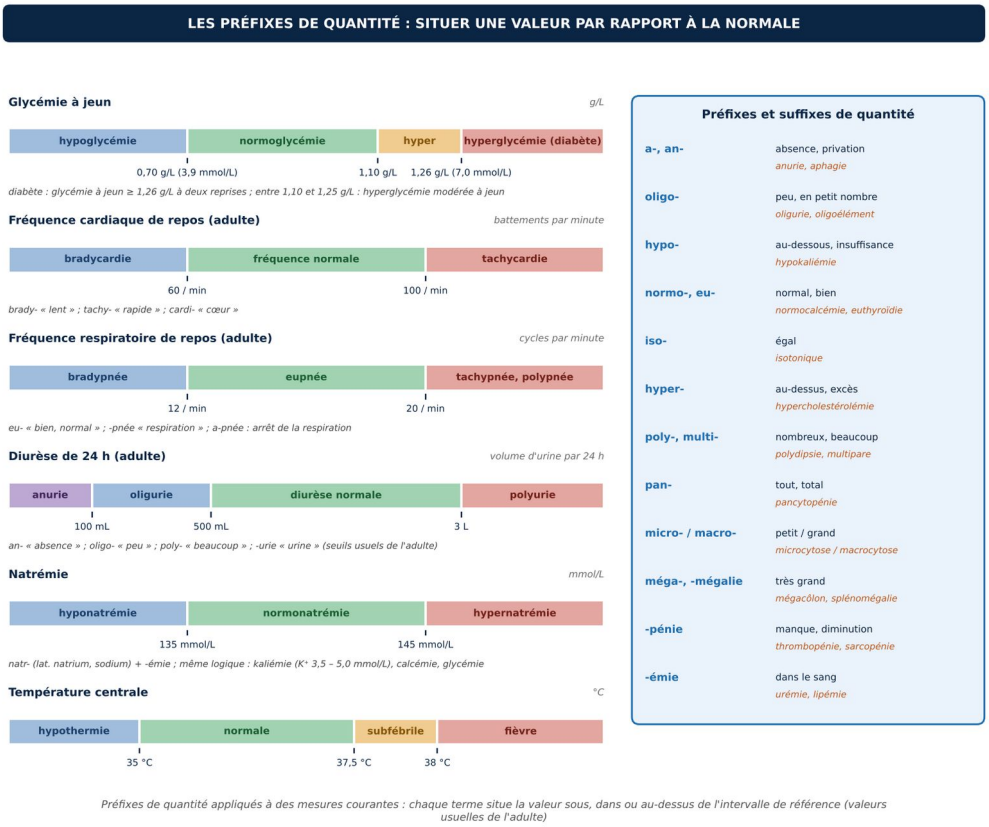


Fig. 29.7. Préfixes de quantité appliqués à des mesures courantes : chaque terme situe la valeur sous, dans ou au-dessus de l'intervalle de référence (valeurs usuelles de l'adulte)

Préfixe · Sens · Exemples · Contraire

a-, an- — *Sens :* absence, privation ; *Exemples :* anurie, aphagie, apnée, amnésie, aménorrhée, asthénie, anémie ; *Contraire :* —

oligo- — *Sens :* peu, en petite quantité ; *Exemples :* oligurie, oligoélément, oligoamnios, oligospermie ; *Contraire :* poly-

hypo- — *Sens :* insuffisance, au-dessous de la normale ; *Exemples :* hypoglycémie, hypokaliémie, hypotension, hypothyroïdie, hypoprotidémie ; *Contraire :* hyper-

normo-, eu- — *Sens :* normal ; *Exemples :* normoglycémie, normocalcémie ; eupnée, euthyroïdie, euvolémie ; *Contraire :* dys-

hyper- — *Sens :* excès, au-dessus de la normale ; *Exemples :* hyperglycémie, hypertension, hyperthyroïdie, hypercatabolisme ; *Contraire :* hypo-

poly-, multi- — *Sens :* nombreux, beaucoup ; *Exemples :* polyurie, polydipsie, polyphagie, polyarthrite, polyneuropathie ; multifactoriel ; *Contraire :* oligo-, mono-

pan- — *Sens :* tout, en totalité ; *Exemples :* pancytopénie, pandémie, panhypopituitarisme ; *Contraire :* —

micro- / macro- — *Sens :* petit / grand ; *Exemples :* microcytose, micronutriment, microalbuminurie / macrocytose, macronutriment, macrosomie ; *Contraire :* l'un l'autre

méga-, mégalo- — *Sens :* très grand ; *Exemples :* mégacôlon, mégaloblaste (anémie mégaloblastique par carence en B9 ou B12) ; *Contraire :* micro-

iso- — *Sens :* égal ; *Exemples :* isotonique (même osmolarité que le plasma), isocalorique, isoprotidique ; *Contraire :* hétéro-

hémi-, semi- — *Sens :* moitié ; *Exemples :* hémiplégie, hémicolectomie ; semi-liquide, semi-perméable ; *Contraire :* —

ATTENTION

Hypo- et hyper- se rapportent à une valeur de référence, qui dépend de l'âge, du sexe, de l'état physiologique et du laboratoire. La référence change selon le **moment** : une glycémie de 1,30 g/L est une hyperglycémie si elle est mesurée à jeun, mais une valeur habituelle une heure après un repas chez un sujet non diabétique. Une créatininémie de 90 µmol/L est normale chez un homme jeune et musclé, mais peut traduire une insuffisance rénale chez une femme âgée dénutrie de 45 kg (masse musculaire faible). Il faut donc **toujours** comparer un résultat à l'intervalle du laboratoire et au contexte.

Ne pas confondre la quantité dans le sang (-émie) et la quantité totale dans l'organisme : une **hyponatrémie** est souvent due à un **excès d'eau** (dilution) et non à un manque de sodium ; une **hypokaliémie** peut coexister avec un stock de potassium normal (transfert dans les cellules sous insuline). Le préfixe décrit la **concentration mesurée**, pas la cause (chapitre 25).

Les préfixes de nombre et les racines de couleur

Les préfixes **numériques** viennent par paires grecques et latines : on les retrouve en anatomie (biceps, triceps, quadriceps), en obstétrique (primipare, multipare), en neurologie (hémiplégie, tétraplégie) et en biochimie (disaccharide, triglycéride, tétrahydrofolate). Les racines de **couleur** décrivent l'aspect d'une peau, d'un tissu, d'une cellule ou d'une sécrétion : elles sont à l'origine de noms de cellules (érythrocyte, leucocyte, mélanocyte), de signes (cyanose, érythème, ictère) et de maladies (mélanome, leucémie, xanthome).



Les racines de couleur (à gauche) et les préfixes numériques (à droite) ; le grec et le latin fournissent souvent deux formes de même sens

Fig. 29.8. Les racines de couleur (à gauche) et les préfixes numériques (à droite) ; le grec et le latin fournissent souvent deux formes de même sens

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.8

Couleurs : **érythr(o)-** (rouge : érythrocyte, le globule rouge ; érythème, la rougeur de la peau qui s'efface à la pression) ; **leuc(o)-** (blanc : leucocyte, leucopénie) ; **mélan(o)-** (noir : mélanine, mélanome, méléna, les selles noires dues à du sang digéré) ; **cyan(o)-** (bleu sombre : cyanose, la coloration bleutée de la peau et des lèvres par excès d'hémoglobine désoxygénée) ; **xanth(o)-** (jaune : xanthome et xanthélasma, dépôts jaunes de cholestérol sous la peau ou les paupières, signes d'hypercholestérolémie) ; **ictère** (jaunisse : coloration jaune de la peau et des muqueuses par la bilirubine ; le **subictère** n'est visible qu'aux

conjonctives) ; **chlor(o)-** (vert : chlorophylle) ; **poli(o)-** (gris : poliomyélite, atteinte de la **substance grise** de la moelle) ; **purpur-** (pourpre : purpura, taches rouges ou violacées qui ne s'effacent pas à la pression, dues à du sang sorti des vaisseaux) ; **alb-** (blanc, lat. : albumine, albinisme).

Nombres : **hémi-, semi-** (½ : hémiplégie, paralysie d'une moitié du corps) ; **mono-, uni-** (1 : monocyte, cellule à noyau unique ; unilatéral) ; **di-, bi-** (2 : disaccharide, bilatéral) ; **tri-** (3 : triglycéride, valve tricuspide) ; **tétra-, quadri-** (4 : tétraplégie, quadriceps) ; **nulli-** (0 : nullipare, femme n'ayant jamais accouché) ; **oligo-** (peu) ; **poly-, multi-** (beaucoup) ; **pan-** (tout) ; **prim(i)-, prot(o)-** (premier : primipare ; protéine, du grec *prôteios*, « de premier rang »).

Les préfixes de temps

Les préfixes de **temps** situent un événement **avant**, **pendant** (ou autour) et **après** un repère : une intervention chirurgicale, un repas, une naissance, un accouchement, la ménopause. Ils sont omniprésents dans les prescriptions diététiques : « bilan nutritionnel **pré**opératoire », « réalimentation **post**opératoire précoce », « glycémie **post**prandiale », « supplémentation en fer **anté**natale », « diabète **post**-greffe ».



Fig. 29.9. Les préfixes de temps situent un événement avant, pendant (ou autour) et après une référence : intervention, repas, naissance, accouchement, ménopause, maladie

Comprendre le schéma – figure 29.9

La flèche du temps sépare trois colonnes : **AVANT** (anté-, pré-, pro-), **PENDANT / AUTOUR** (per-, intra-, péri-), **APRÈS** (post-, méta-). Chaque ligne applique ces préfixes à un repère : **chirurgie** (préopératoire, peropératoire, postopératoire) ; **repas** (préprandial, prandial, postprandial ; la glycémie postprandiale se mesure 2 heures après le début du repas, du latin *prandium*, repas) ; **naissance** (prénatal ou anténatal, périnatal, postnatal ; **néonatal** concerne le nouveau-né, de néo-, nouveau, et *natus*, né) ; **accouchement** (antepartum, perpartum, post-partum, du latin *partus*, accouchement) ; **ménopause** (préménopause, périménopause, postménopause ; méno-, mois, et pause, arrêt) ; **maladie** (prodromes, signes avant-coureurs ; phase d'état ; séquelles et convalescence).

Préfixe · Sens · Exemples
anté-, pré- (lat.) — *Sens :* avant ; *Exemples :* anténatal, antépartum ; préopératoire, préprandial, prédiabète, prématuré
pro- (gr.) — *Sens :* avant, en avant ; *Exemples :* prodrome, pronostic (connaître à l'avance), prophylaxie (prévention)
per-, intra- — *Sens :* pendant ; *Exemples :* peropératoire, perpartum ; intrapartum
péri- — *Sens :* autour de (avant et après) ; *Exemples :* périnatal (de la 22e semaine de grossesse au 7e jour de vie selon l'OMS), périopératoire, périménopause
post- (lat.) — *Sens :* après ; *Exemples :* postopératoire, postprandial, post-partum, postménopausique

néo- (gr.) — *Sens :* nouveau, récent ; *Exemples :* néonatal, néoglucogenèse, néoplasie (« formation nouvelle » : tumeur)

ré- (lat.) — *Sens :* de nouveau ; *Exemples :* récidive, rechute, réalimentation, renutrition

Les préfixes de vitesse, de qualité et de relation

Une troisième famille de préfixes qualifie la **manière** dont une fonction s'accomplit : vite ou lentement, souvent, bien ou mal, droit, normalement ou non. Ils forment les noms de très nombreux **symptômes**.

Préfixe · Sens · Exemples · Remarque

brady- (gr.) — *Sens :* lent ; *Exemples :* bradycardie, bradypnée, bradykinésie (lenteur des mouvements, maladie de Parkinson) ; *Remarque :* opposé à tachy-

tachy- (gr.) — *Sens :* rapide ; *Exemples :* tachycardie, tachypnée, tachyarythmie ; *Remarque :* la tachypnée accompagne fièvre, acidose, insuffisance respiratoire

pollaki- (gr.) — *Sens :* souvent ; *Exemples :* pollakiurie (mictions fréquentes) ; *Remarque :* fréquence des mictions, pas volume (≠ polyurie)

eu- (gr.) — *Sens :* bien, normal ; *Exemples :* eupnée, euthyroïdie, eutocie (accouchement normal), eupeptique ; *Remarque :* opposé à dys-

dys- (gr.) — *Sens :* difficulté, trouble, anomalie ; *Exemples :* dysphagie, dyspnée, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose, dysplasie, dysurie ; *Remarque :* un des plus fréquents en diététique

mal- (lat.) — *Sens :* mal, insuffisamment ; *Exemples :* malabsorption, malnutrition, malformation, maldigestion ; *Remarque :* malnutrition : dénutrition et surnutrition

ortho- (gr.) — *Sens :* droit, correct ; *Exemples :* orthostatique (en position debout), orthopnée (dyspnée en position couchée, soulagée assis), orthophonie, orthorexie ; *Remarque :* l'orthopnée oriente vers une insuffisance cardiaque

para- (gr.) — *Sens :* anormal, à côté ; *Exemples :* paresthésie (sensation anormale : fourmillements), paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs) ; *Remarque :* para- a aussi un sens de position

a-, an- (gr.) — *Sens :* absence ; *Exemples :* aphagie, aphasie, apyrexie (absence de fièvre), anorexie, asthénie ; *Remarque :* devant une voyelle : an-

anti- (gr.) — *Sens :* contre ; *Exemples :* antiémétique, antipyrétique, antidiabétique, antioxydant, anticoagulant ; *Remarque :* ne pas confondre avec anté-

Les préfixes de **relation** comparent deux éléments : identiques ou différents, appartenant à soi ou à un autre. On les rencontre en immunologie, en génétique, en transplantation et en toxicologie.

Préfixe · Sens · Exemples

auto- (gr.) — *Sens :* soi-même ; *Exemples :* auto-immunité (réaction du système immunitaire contre ses propres constituants : diabète de type 1, maladie cœliaque), autogreffe, autolyse

allo- (gr.) — *Sens :* autre (de la même espèce) ; *Exemples :* allogreffe (greffe d'un donneur), allergie (réaction « autre », exagérée), allergène

xéno- (gr.) — *Sens :* étranger (autre espèce ou substance étrangère) ; *Exemples :* xénogreffe (valve cardiaque de porc), xénobiotique (chapitre 28)

homo-, homéo- (gr.) — *Sens :* semblable, même ; *Exemples :* homozygote, homolatéral, homéostasie (maintien d'un état stable)

hétéro- (gr.) — *Sens :* différent ; *Exemples :* hétérozygote, hétérogène, controlatéral (synonyme latin d'hétérolatéral)

iso- (gr.) — *Sens :* égal ; *Exemples :* isotonique, isotope, iso-osmotique

syn-, sym- (gr.) — *Sens :* avec, ensemble ; *Exemples :* syndrome (signes qui courent ensemble), synthèse, symbiose, syndactylie

Enfin, quelques préfixes de la liste du guide ont un sens **concret** et se comportent presque comme des racines : **acro-** (extrémités : acromégalie, augmentation de volume des mains, des pieds et du visage par excès d'hormone de croissance ; acrocyanose), **bio-** (vie : biologie, biopsie, prélèvement d'un fragment de tissu vivant ; biodisponibilité), **caryo-** (noyau : caryotype, l'ensemble des chromosomes d'une cellule ; caryolyse, destruction du noyau d'une cellule qui meurt), **copro-** (selles : coproculture, la culture des selles à la recherche de bactéries pathogènes ; coprologie, l'étude des selles), **cyano-** (bleu : cyanose), **étio-** (cause : étiologie), **méno-** (mois, règles : ménopause, ménorragie) et **odyno-** (douleur : **odynophagie**, douleur ressentie lors de la déglutition, fréquente au cours des mucites de la chimiothérapie et de la radiothérapie, chapitre 31).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Donnez le sens du préfixe et définissez : **a)** oligurie ; **b)** euthyroïdie ; **c)** odynophagie ; **d)** pancytopénie ; **e)** paresthésie ; **f)** rétrosternal ; **g)** intercostal ; **h)** orthopnée ; **i)** xénogreffe ; **j)** périnatal.

CORRIGÉ

a) oligo- (peu) : diurèse **inférieure à 500 mL par 24 h** chez l'adulte (insuffisance rénale aiguë, déshydratation). **b)** eu- (normal) : fonctionnement **normal** de la thyroïde (TSH, T4 dans les normes). **c)** odyno- (douleur) + phag- (avaler) : **douleur à la déglutition**. **d)** pan- (tout) + cyt- (cellule) + -pénie (manque) : **diminution des trois lignées sanguines** (hématies, leucocytes, plaquettes). **e)** para- (anormal) + -esthésie (sensibilité) : **sensation anormale** non douloureuse (fourmillements,

picotements), par exemple dans une neuropathie diabétique ou une carence en B12.

f) rétro- (en arrière) : **situé derrière le sternum** (douleur rétrosternale de l'infarctus, brûlure rétrosternale du reflux gastro-œsophagien). **g)** inter- (entre) + cost- (côte) : **situé entre deux côtes** (muscles, espace intercostal). **h)** ortho- (droit) + -pnée (respiration) : **gêne respiratoire en position couchée**, soulagée en position assise ou debout. **i)** xéno- (étranger) : **greffe d'un tissu provenant d'une autre espèce**. **j)** péri- (autour) + nat- (naissance) : **période qui entoure la naissance**.

Tableau complet des préfixes du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique, les **53 préfixes** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025, avec leur origine, leur sens et des exemples. Il sert de **référence** pour les révisions ; les préfixes y sont rangés comme dans le guide (tétra- après trans-).

Préfixe · Origine · Sens · Exemples

a-, an- — *Origine :* gr. *a-* privatif ; *Sens :* absence, privation ; *Exemples :* aphagie, anurie, asthénie, apnée, anorexie

acro- — *Origine :* gr. *akros*, extrême ; *Sens :* extrémités du corps ; *Exemples :* acromégalie, acrocyanose

allo- — *Origine :* gr. *allos*, autre ; *Sens :* autre, différent ; *Exemples :* allogreffe, allergie, allogénique

anté- — *Origine :* lat. *ante*, avant ; *Sens :* avant (dans le temps ou l'espace) ; *Exemples :* antépartum, antérieur, antéversion

anti- — *Origine :* gr. *anti*, contre ; *Sens :* contre, opposé à ; *Exemples :* antibiotique, antiémétique, antioxydant, anticorps

auto- — *Origine :* gr. *autos*, soi-même ; *Sens :* soi-même ; *Exemples :* auto-immunité, autogreffe, autolyse

bio- — *Origine :* gr. *bios*, vie ; *Sens :* vie, vivant ; *Exemples :* biologie, biopsie, biodisponibilité

brady- — *Origine :* gr. *bradus*, lent ; *Sens :* lent ; *Exemples :* bradycardie, bradypnée, bradykinésie

caryo- — *Origine :* gr. *karuon*, noix ; *Sens :* noyau de la cellule ; *Exemples :* caryotype, caryolyse

copro- — *Origine :* gr. *kopros*, excrément ; *Sens :* selles, matières fécales ; *Exemples :* coproculture, coprologie, coprolithe

cyano- — *Origine :* gr. *kuanos*, bleu sombre ; *Sens :* bleu ; *Exemples :* cyanose, acrocyanose

dys- — *Origine :* gr. *dus-*, mal, difficilement ; *Sens :* difficulté, trouble, anomalie ; *Exemples :* dysphagie, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose

ecto- — *Origine :* gr. *ektos*, au-dehors ; *Sens :* à l'extérieur ; *Exemples :* ectoderme, ectopie (organe hors de sa place)

en- — *Origine :* gr. *en*, dans ; *Sens :* dans, à l'intérieur ; *Exemples :* encéphale (dans la tête), encéphalite

endo- — *Origine :* gr. *endon*, dedans ; *Sens :* à l'intérieur ; *Exemples :* endoscopie, endocrine, endocarde, endomètre

épi- — *Origine :* gr. *epi*, sur ; *Sens :* sur, au-dessus ; *Exemples :* épigastre, épiderme, épiglotte, épiphyse

étio- — *Origine :* gr. *aitia*, cause ; *Sens :* cause ; *Exemples :* étiologie, étiopathogénie

eu- — *Origine :* gr. *eu*, bien ; *Sens :* bien, normal ; *Exemples :* eupnée, euthyroïdie, eutocie

exo- — *Origine :* gr. *exô*, au-dehors ; *Sens :* à l'extérieur, vers l'extérieur ; *Exemples :* exocrine, exocytose, exogène

extra- — *Origine :* lat. *extra*, en dehors ; *Sens :* en dehors de ; *Exemples :* extracellulaire, extrasystole

hémi- — *Origine :* gr. *hêmi-*, à moitié ; *Sens :* moitié ; *Exemples :* hémiplégie, hémicolectomie, hémiparésie

hétéro- — *Origine :* gr. *heteros*, autre ; *Sens :* différent ; *Exemples :* hétérozygote, hétérogène

homo- — *Origine :* gr. *homos*, semblable ; *Sens :* semblable, même ; *Exemples :* homozygote, homolatéral, homéostasie

hyper- — *Origine :* gr. *huper*, au-dessus ; *Sens :* excès, au-dessus de la normale ; *Exemples :* hyperglycémie, hypertension, hypertrophie

hypo- — *Origine :* gr. *hupo*, au-dessous ; *Sens :* insuffisance ; au-dessous ; *Exemples :* hypoglycémie, hypokaliémie ; hypoderme, hypophyse

inter- — *Origine :* lat. *inter*, entre ; *Sens :* entre ; *Exemples :* intercostal, interstitiel, intervertébral

intra- — *Origine :* lat. *intra*, à l'intérieur ; *Sens :* à l'intérieur de ; *Exemples :* intraveineux, intracellulaire, intramusculaire

iso- — *Origine :* gr. *isos*, égal ; *Sens :* égal ; *Exemples :* isotonique, isocalorique, isotope

macro- — *Origine :* gr. *makros*, grand, long ; *Sens :* grand ; *Exemples :* macrocytose, macrosomie, macronutriment, macrophage

mal- — *Origine :* lat. *male*, mal ; *Sens :* mal, insuffisamment ; *Exemples :* malabsorption, malnutrition, malformation

méga- — *Origine :* gr. *megas*, grand ; *Sens :* très grand ; *Exemples :* mégacôlon, mégacœsophage

méno- — *Origine :* gr. *mên, mênos*, mois ; *Sens :* règles (menstruations) ; *Exemples :* ménopause, ménorragie, aménorrhée

micro- — *Origine :* gr. *mikros*, petit ; *Sens :* petit ; *Exemples :* microcytose, micronutriment, microbiote, microalbuminurie

mono- — *Origine :* gr. *monos*, seul ; *Sens :* un seul ; *Exemples :* monocyte, monothérapie, mononucléose

multi- — *Origine :* lat. *multus*, nombreux ; *Sens :* plusieurs, nombreux ; *Exemples :* multipare, multifactoriel

néo- — *Origine :* gr. *neos*, nouveau ; *Sens :* nouveau ; *Exemples :* néoglucogenèse, néonatal, néoplasie

odyno- — *Origine :* gr. *odunê*, douleur ; *Sens :* douleur ; *Exemples :* odynophagie (douleur à la déglutition)

oligo- — *Origine :* gr. *oligos*, peu nombreux ; *Sens :* peu, insuffisant ; *Exemples :* oligurie, oligoélément, oligospermie

ortho- — *Origine :* gr. *orthos*, droit ; *Sens :* droit, correct ; *Exemples :* orthopédie, orthophonie, orthostatique, orthopnée

pan- — *Origine :* gr. *pan, pantos*, tout ; *Sens :* tout, en totalité ; *Exemples :* pancytopénie, pandémie, pancréas

para- — *Origine :* gr. *para*, à côté de ; *Sens :* à côté de ; en marge, anormal ; *Exemples :* parathyroïde, paramédical, parentéral ; paresthésie

per- — *Origine :* lat. *per*, à travers, pendant ; *Sens :* à travers ; pendant ; *Exemples :* percutané, per os ; peropératoire

péri- — *Origine :* gr. *peri*, autour ; *Sens :* autour ; *Exemples :* péricarde, péritoine, périnatal

pollaki- — *Origine :* gr. *pollakis*, souvent ; *Sens :* souvent, fréquent ; *Exemples :* pollakiurie

poly- — *Origine :* gr. *polus*, nombreux ; *Sens :* nombreux, beaucoup ; *Exemples :* polyurie, polydipsie, polyphagie, polynucléaire

post- — *Origine :* lat. *post*, après ; *Sens :* après, derrière ; *Exemples :* postprandial, postopératoire, post-partum

rétro- — *Origine :* lat. *retro*, en arrière ; *Sens :* en arrière ; *Exemples :* rétrosternal, rétropéritonéal, rétrograde

sub- — *Origine :* lat. *sub*, sous ; *Sens :* sous ; presque ; *Exemples :* sublingual, sous-cutané ; subictère, subfébrile

supra- — *Origine :* lat. *supra*, au-dessus ; *Sens :* au-dessus ; *Exemples :* suprarénal (surrénal), supraventriculaire

tachy- — *Origine :* gr. *takhus*, rapide ; *Sens :* rapide ; *Exemples :* tachycardie, tachypnée

trans- — *Origine :* lat. *trans*, au-delà ; *Sens :* à travers, au-delà ; *Exemples :* transcutané, transfusion, transaminase

tétra- — *Origine :* gr. *tetra-*, quatre ; *Sens :* quatre ; *Exemples :* tétraplégie, tétrahydrofolate

xéno- — *Origine :* gr. *xenos*, étranger ; *Sens :* étranger ; *Exemples :* xénobiotique, xénogreffe

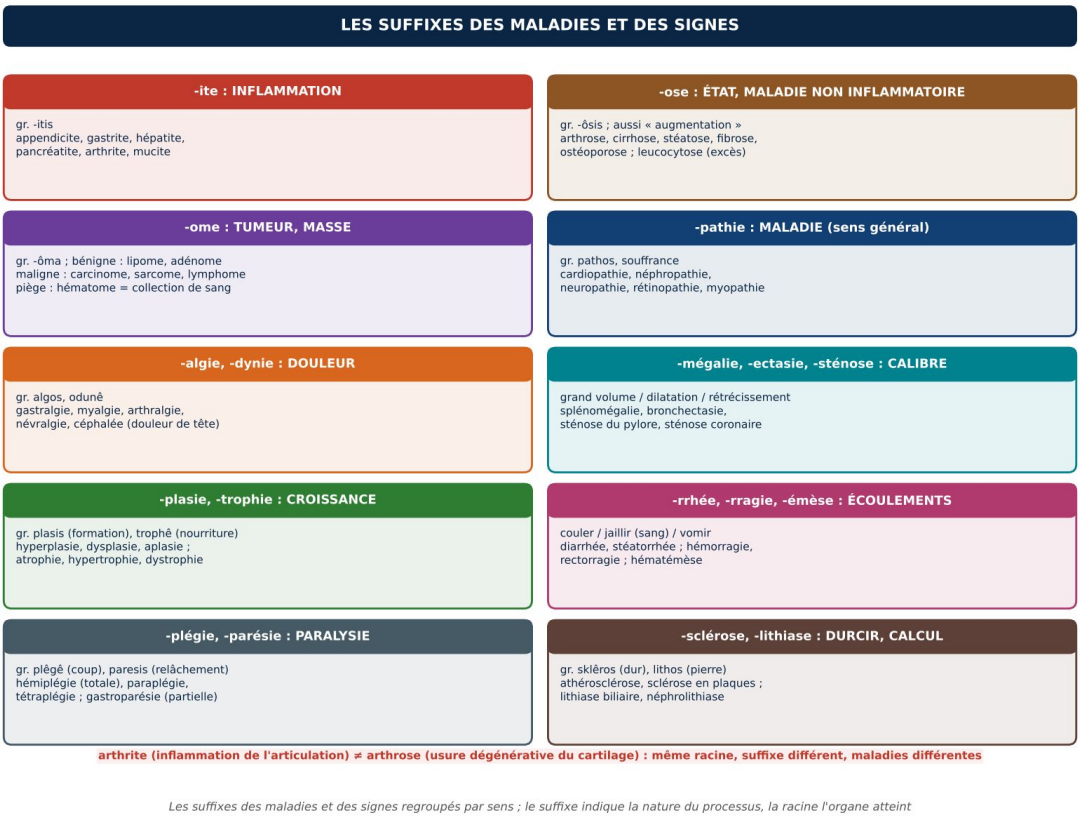
29.3.3 Les suffixes

Module • *Guide 2025 p. 99-100 : 49 suffixes · CNED : 3-2023 M1 S1 §1, S2 (examens), S5 (terminologie chirurgicale)*

Le suffixe est l'élément **décisif** : c'est lui qui dit **ce qu'est** la chose nommée. Hépat-**ite**, hépat-**ome**, hépat-**ocyte**, hépat-**ectomie**, hépato-**mégalie** et hépato-**logie** désignent respectivement une maladie inflammatoire, une tumeur, une cellule, un acte chirurgical, un signe d'examen et une spécialité médicale, alors qu'ils partagent la même racine. Pour lire un terme, on commence donc toujours par la fin. On peut ranger les suffixes en sept familles : les **maladies**, les **signes et symptômes**, les **écoulements**, les **examens**, les **actes chirurgicaux**, les **traitements** et les **cellules ou processus biologiques**.

Les suffixes des maladies

Les suffixes de maladies précisent la **nature du processus** pathologique : inflammation, dégénérescence, tumeur, augmentation de volume, rétrécissement, trouble de croissance, paralysie, durcissement ou calcul. Ce sont eux qui permettent de distinguer des maladies très différentes d'un même organe.



Les suffixes des maladies et des signes regroupés par sens ; le suffixe indique la nature du processus, la racine l'organe atteint

Fig. 29.10. Les suffixes des maladies et des signes regroupés par sens ; le suffixe indique la nature du processus, la racine l'organe atteint

Comprendre le schéma – figure 29.10

Les dix cartes regroupent les suffixes par sens. **-ite** : inflammation (gr. *-itis*) : appendicite, gastrite, hépatite, pancréatite, arthrite, mucite (inflammation des muqueuses, complication des chimiothérapies). **-ose** : état chronique, maladie **non inflammatoire** ou dégénérative (arthrose, cirrhose, stéatose, fibrose, ostéoporose) ; appliqué à une cellule, il signifie aussi « **augmentation** » (leucocytose, excès de leucocytes). **-ome** : **tumeur** ou masse (lipome et adénome sont bénins ; carcinome, sarcome et lymphome sont malins) ; piège : l'**hématome** est une collection de sang, pas une tumeur. **-pathie** : maladie au sens général, sans préciser le mécanisme (cardiopathie, néphropathie, neuropathie, rétinopathie, myopathie). **-algie, -dynie** : douleur (gastralgie, myalgie, arthralgie, névralgie ; la céphalée est la douleur de tête). **-mégalie, -ectasie, -sténose** : calibre ou volume (splénomégalie ; bronchectasie, dilatation des bronches ; sténose du pylore, sténose coronaire). **-plasie, -trophie** : croissance et développement (hyperplasie, dysplasie, aplasie ; atrophie, hypertrophie, dystrophie). **-rrhée, -rragie, -émèse** : écoulements (diarrhée, stéatorrhée ; hémorragie, rectorragie ; hématémèse). **-plégie, -parésie** : paralysie complète ou partielle (hémiplégie, paraplégie, tétraplégie ; gastroparésie). **-sclérose, -lithiase** : durcissement ou calcul (athérosclérose, sclérose en plaques ; lithiase biliaire, néphrolithiase).

La ligne rouge du bas résume le piège le plus classique : **arthrite** (inflammation de l'articulation, souvent aiguë, avec chaleur, rougeur, gonflement) **≠ arthrose** (usure dégénérative du cartilage, chronique) : même racine, suffixe différent, maladies différentes.

Suffixe · Sens · Exemples · Pour le diététicien

-ite — *Sens :* inflammation (infectieuse ou non) ; *Exemples :* hépatite, pancréatite, gastrite, œsophagite, colite, cholécystite, diverticulite, mucite ; *Pour le diététicien :* pancréatite aiguë : jeûne puis réalimentation précoce ; mucite : textures adaptées

-ose — *Sens :* état chronique, dégénératif, non inflammatoire ; excès de cellules ; *Exemples :* stéatose, cirrhose, arthrose, ostéoporose, athérosclérose, fibrose ; leucocytose, thrombocytose ; *Pour le diététicien :* stéatose : perte de poids, réduction des sucres ajoutés et de l'alcool

-iase — *Sens :* état pathologique, souvent dû à un corps étranger ou à un parasite ; *Exemples :* lithiase (calculs), candidose ou candidiase, giardiase ; *Pour le diététicien :* lithiase oxalocalcique : boissons abondantes

-ome — *Sens :* tumeur ou masse ; *Exemples :* adénome, lipome, carcinome, sarcome, lymphome, mélanome, myélome ; *Pour le diététicien :* voir le tableau des tumeurs ci-dessous

-pathie — *Sens :* maladie (sens général) ; *Exemples :* néphropathie diabétique, cardiopathie ischémique, neuropathie, rétinopathie, entéropathie ; *Pour le diététicien :* néphropathie : adaptation des apports en protéines, sel, potassium

-mégalie — *Sens :* augmentation de volume d'un organe ; *Exemples :* hépatomégalie, splénomégalie, cardiomégalie, acromégalie ; *Pour le diététicien :* hépatomégalie stéatosique

-ectasie — *Sens :* dilatation ; *Exemples :* bronchectasie, télangiectasie (dilatation de petits vaisseaux cutanés) ; *Pour le diététicien :* bronchectasies de la mucoviscidose (chapitre 38)

-sténose — *Sens :* rétrécissement d'un conduit ; *Exemples :* sténose œsophagienne, sténose pylorique, sténose de l'intestin (Crohn), sténose coronaire ; *Pour le diététicien :* sténose digestive : textures, régime pauvre en fibres

-plasie — *Sens :* formation d'un tissu ; *Exemples :* hyperplasie (cellules plus nombreuses), dysplasie (anomalie précancéreuse), aplasie (absence de production), néoplasie (tumeur) ; *Pour le diététicien :* aplasie médullaire de la chimiothérapie : hygiène alimentaire

-trophie — *Sens :* développement, nutrition d'un tissu ; *Exemples :* atrophie (diminution de volume), hypertrophie (augmentation du volume des cellules), dystrophie ; *Pour le diététicien :* atrophie villositaire de la maladie cœliaque

-plégie / -parésie — *Sens :* paralysie complète / partielle ; *Exemples :* hémiplégie, paraplégie, tétraplégie / hémiparésie, gastroparésie ; *Pour le diététicien :* gastroparésie diabétique : repas fractionnés, pauvres en graisses et fibres

-sclérose — *Sens :* durcissement ; *Exemples :* athérosclérose, artériosclérose, sclérose en plaques ; *Pour le diététicien :* prévention cardiovasculaire (chapitre 35)

-malacie — *Sens :* ramollissement (gr. *malakos*, mou) ; *Exemples :* ostéomalacie (défaut de minéralisation de l'os adulte) ; *Pour le diététicien :* carence en vitamine D (chapitre 24)

-porose — *Sens :* présence de pores, de cavités ; *Exemples :* ostéoporose (diminution de la masse et de la microarchitecture osseuses) ; *Pour le diététicien :* apports en calcium, vitamine D, protéines

Les noms des tumeurs suivent une règle précise, qu'il faut connaître avant le chapitre 31 (pathologies cancéreuses). Le suffixe **-ome** seul, ajouté au nom du tissu, désigne en général une tumeur **bénigne** : adénome (tissu glandulaire), lipome (tissu adipeux), fibrome (tissu fibreux), léiomyome (muscle lisse), chondrome (cartilage), ostéome (os), angiome (vaisseaux). Une tumeur **maligne** d'origine **épithéliale** (revêtements et glandes) est un **carcinome** (gr. *karkinos*, crabe) : adénocarcinome (épithélium glandulaire : côlon, estomac, pancréas, sein, prostate), carcinome épidermoïde (épithélium malpighien : œsophage,

peau, voies aérodigestives supérieures), carcinome hépatocellulaire. Une tumeur maligne d'origine **conjonctive** (tissus de soutien) est un **sarcome** (gr. *sarx*, chair) : liposarcome, léiomyosarcome, ostéosarcome. Les tumeurs malignes des tissus **lymphoïdes** sont des **lymphomes**, celles des plasmocytes de la moelle des **myélomes**, celles des mélanocytes des **mélanomes** ; ces trois termes en -ome désignent, malgré leur forme, des tumeurs **malignes**.

Tissu d'origine · Tumeur bénigne · Tumeur maligne · Exemple de localisation

épithélium glandulaire — *Tumeur bénigne :* adénome ; *Tumeur maligne :* adénocarcinome ; *Exemple de localisation :* polype adénomateux du côlon → adénocarcinome colique

épithélium de revêtement malpighien — *Tumeur bénigne :* papillome ; *Tumeur maligne :* carcinome épidermoïde ; *Exemple de localisation :* œsophage, cavité buccale, peau

tissu adipeux — *Tumeur bénigne :* lipome ; *Tumeur maligne :* liposarcome ; *Exemple de localisation :* tissus mous

muscle lisse — *Tumeur bénigne :* léiomyome (fibrome utérin) ; *Tumeur maligne :* léiomyosarcome ; *Exemple de localisation :* utérus, tube digestif

os / cartilage — *Tumeur bénigne :* ostéome / chondrome ; *Tumeur maligne :* ostéosarcome / chondrosarcome ; *Exemple de localisation :* squelette

vaisseaux — *Tumeur bénigne :* angiome ; *Tumeur maligne :* angiosarcome ; *Exemple de localisation :* foie, peau

tissu lymphoïde — *Tumeur bénigne :* — ; *Tumeur maligne :* lymphome ; *Exemple de localisation :* ganglions, intestin (lymphome de la maladie cœliaque)

mélanocytes — *Tumeur bénigne :* nævus (grain de beauté) ; *Tumeur maligne :* mélanome ; *Exemple de localisation :* peau

plasmocytes — *Tumeur bénigne :* — ; *Tumeur maligne :* myélome ; *Exemple de localisation :* moelle osseuse

cellules sanguines immatures — *Tumeur bénigne :* — ; *Tumeur maligne :* leucémie (pas de suffixe -ome) ; *Exemple de localisation :* moelle et sang

Attention

Tous les mots en -ome ne sont pas des tumeurs : l'**hématome** est une collection de sang dans un tissu ; l'**athérome** est le dépôt lipidique de la paroi artérielle ; le **granulome** est un amas de cellules inflammatoires ; le **xanthome** est un dépôt de cholestérol sous la peau ; le **glaucome** est une maladie de l'œil ; le **fécalome** est une masse de selles durcies dans le rectum (complication de la constipation chez la personne âgée alitée) ; le **trachome** est une infection de l'œil. Inversement, **néoplasme** et **néoplasie** (formation nouvelle) sont des synonymes savants de « tumeur » et désignent souvent un cancer dans les comptes rendus (« néoplasie colique »).

Les suffixes des signes et des symptômes

Les suffixes de **signes et symptômes** décrivent ce que ressent le patient ou ce que constate le soignant : une douleur, une sensation anormale, un trouble de la parole, de la mémoire ou de la respiration, une anomalie de la quantité d'un liquide ou d'une substance. Plusieurs concernent directement l'**alimentation** et la **digestion** : ils reviennent dans chaque bilan diététique.

Suffixe · Sens · Exemples

-algie, -dynie — *Sens :* douleur ; *Exemples :* gastralgie, épigastralgie, myalgie, arthralgie, lombalgie, névralgie ; pleurodynie ; mastodynie

-esthésie — *Sens :* sensibilité ; *Exemples :* anesthésie (perte de la sensibilité), hypoesthésie, hyperesthésie, paresthésie (fourmillements)

-phasie — *Sens :* parole, langage ; *Exemples :* aphasie (perte du langage après un AVC), dysphasie

-phonie — *Sens :* voix ; *Exemples :* dysphonie (voix modifiée), aphonie (extinction de voix)

-mnésie — *Sens :* mémoire ; *Exemples :* amnésie ; anamnèse (rappel des antécédents à l'interrogatoire)

-phobie — *Sens :* peur, aversion ; *Exemples :* néophobie alimentaire du jeune enfant ; phobie alimentaire ; hydrophobe (qui repousse l'eau)

-pnée — *Sens :* respiration ; *Exemples :* dyspnée (difficulté à respirer), apnée, tachypnée, bradypnée, orthopnée

-urie — *Sens :* urine ; substance dans l'urine ; *Exemples :* polyurie, oligurie, anurie, nycturie (urines nocturnes), dysurie ; glycosurie, protéinurie, hématurie, cétonurie

-émie — *Sens :* substance dans le sang ; *Exemples :* glycémie, natrémie, kaliémie, calcémie, urémie, lipémie, cholestérolémie, albuminémie, cétonémie, lactatémie

-pénie — *Sens :* diminution, manque ; *Exemples :* leucopénie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie, sarcopénie, ostéopénie, sidéropénie

-cytose — *Sens :* augmentation du nombre de cellules ; *Exemples :* leucocytose, hyperleucocytose, thrombocytose ; microcytose et macrocytose (taille des hématies)

-oxie, -oxémie — *Sens :* oxygène dans les tissus ; dans le sang ; *Exemples :* hypoxie, anoxie ; hypoxémie (baisse de l'oxygène du sang artériel)

Comprendre le schéma – figure 29.11

Dix cartes regroupent les suffixes et racines des signes **digestifs et nutritionnels**. **-phagie** (manger, avaler) : **dysphagie** (difficulté à avaler, qui impose une adaptation des textures), **aphagie** (impossibilité d'avaler), **odynophagie** (déglutition douloureuse), **polyphagie** et **hyperphagie** (ingestion excessive), **aérophagie** (déglutition

d'air). **-orexie** (appétit) : l'**anorexie** est la perte d'appétit (symptôme) ; l'**anorexie mentale** est un trouble du comportement alimentaire (chapitre 40) ; **orexigène** : qui stimule l'appétit. **-pepsie** (digestion) : **dyspepsie**, inconfort digestif haut (pesanteur, satiété précoce, brûlures) ; la **pepsine** est l'enzyme gastrique. **-dipsie** (soif) : **polydipsie** (soif excessive du diabète déséquilibré), **adipsie** (absence de soif, fréquente chez la personne âgée : risque de déshydratation). **-émèse** (vomissement) : hématémèse, **hyperémèse gravidique** (vomissements graves de la grossesse), **antiémétique**. **-rrhée** (écoulement) : diarrhée, **stéatorrhée** (graisses dans les selles, signe de malabsorption des lipides), **créatorrhée** (fibres musculaires non digérées dans les selles, signe d'insuffisance pancréatique). **copr(o)-, féc-** (selles) : coproculture, coprolithe, **fécalome**. **-stase** (arrêt) : **cholestase** (arrêt de l'écoulement de la bile), hémostase. **-lyse** (dégradation) : lipolyse, protéolyse, glycogénolyse, hémolyse. **troph(o)-** (nourriture) : atrophie, dystrophie ; **cachexie** (gr. *kakos*, mauvais, et *hexis*, état) : amaigrissement extrême avec fonte musculaire, au cours des cancers et des maladies chroniques.

La ligne rouge du bas rappelle qu'**une syllabe change l'organe et la fonction** : dysphagie (avaler) ≠ dyspepsie (digérer) ≠ dysphasie (parler).



Le vocabulaire des signes digestifs et nutritionnels : il revient dans chaque bilan diététique (chapitres 32, 33, 40 et 41)

Fig. 29.11. Le vocabulaire des signes digestifs et nutritionnels : il revient dans chaque bilan diététique (chapitres 32, 33, 40 et 41)

Le vocabulaire des hémorragies

Le vocabulaire des **hémorragies** combine une racine d'organe et un suffixe d'écoulement ; il permet de localiser l'origine d'un saignement, information essentielle pour comprendre la prise en charge (jeûne, endoscopie, transfusion, supplémentation en fer). Le suffixe **-rragie** (gr. *rhêgnunai*, briser, jaillir) désigne un écoulement abondant de **sang** ; le suffixe **-rrhée** (gr. *rhein*, couler) un écoulement d'un **autre liquide**. Quelques termes ne suivent pas cette règle : **épistaxis**, **hématémèse**, **méléna**, **hémoptysie**, **hématurie**.

Comprendre le schéma – figure 29.12

La silhouette porte onze points de saignement numérotés. **1. otorragie** : saignement par l'oreille (ot-, oreille) ; **2. épistaxis** : saignement de nez (gr. *epistazein*, couler goutte à goutte) ; **3. hématémèse** : vomissement de sang (hémat- + -émèse), d'origine digestive haute (œsophage, estomac, duodénum) ; **4. méléna** : émission par l'anus de selles **noires**, poisseuses et malodorantes, faites de sang **digéré** ; il traduit un saignement

digestif **haut** (ici l'estomac ; gr. *melaina*, noire) ; **5. hématurie** : sang dans les urines ; **6. purpura, pétéchies** : petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression, dues à une sortie de sang hors des capillaires (anomalie des plaquettes ou des vaisseaux, carence en vitamine C dans le scorbut) ; **7. gingivorragie** : saignement des gencives (lat. *gingiva*), fréquent dans le scorbut et sous anticoagulants ; **8. hémoptysie** : rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de **toux**, venant des voies respiratoires (gr. *ptusis*, crachat) ; **9. hématome, ecchymose** : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau (« bleu ») ; **10. ménorragie / métrorragie** : règles trop abondantes / saignement de l'utérus en dehors des règles ; **11. rectorragie** : émission de sang **rouge** par l'anus, traduisant un saignement digestif **bas** (côlon, rectum, anus).

La légende du bas définit les deux suffixes d'écoulement : **-rragie** pour le sang, **-rrhée** pour un autre liquide (diarrhée, rhinorrhée). La version muette de cette figure est proposée en 29.11.1.

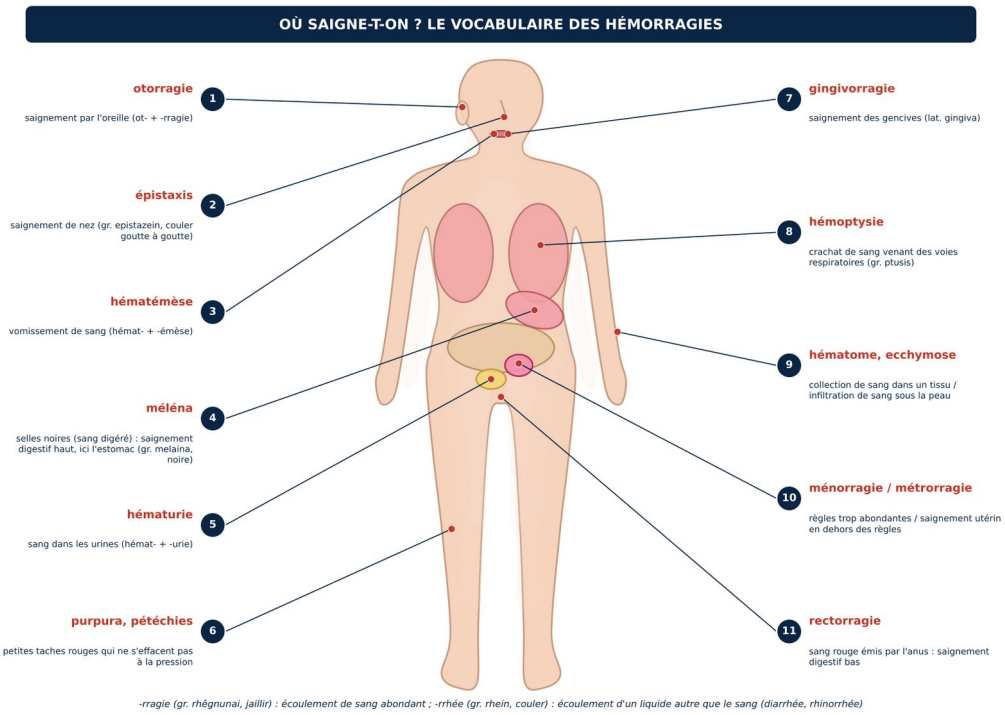


Fig. 29.12. Où saigne-t-on ? Le vocabulaire des hémorragies, de la tête aux pieds

Lien avec la diététique

Hémorragies et diététique. Une hémorragie **aiguë** impose souvent un **jeûne** temporaire (avant une endoscopie digestive) puis une réalimentation progressive ; une hémorragie **chronique** et occulte (ulcère, cancer du côlon, règles abondantes) provoque une **anémie ferriprive** : le diététicien augmente les apports en fer héminique (viandes, poissons, boudin) et en vitamine C au cours du repas, et signale tout signe de saignement. Un méléna chez un patient sous anti-inflammatoires ou anticoagulants est une **urgence**. Les **pétéchies** et les **gingivorragies** chez une personne âgée qui ne mange ni fruits ni légumes doivent faire évoquer un **scorbut**.

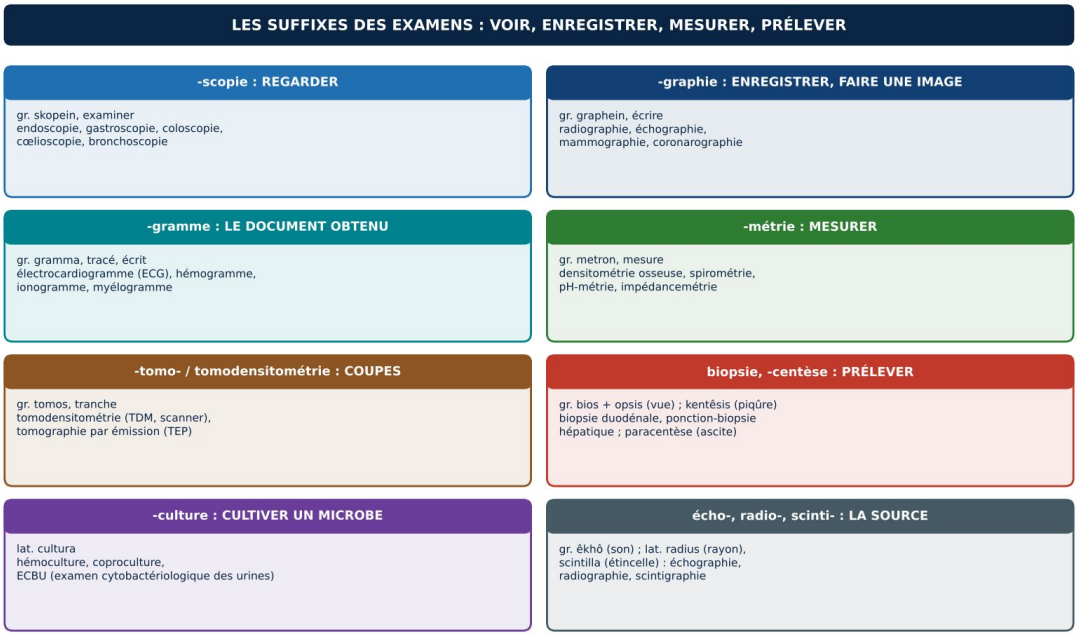
Les suffixes des examens complémentaires

Le nom d'un **examen complémentaire** indique ce que l'on fait : **regarder** (-scopie), **enregistrer** ou **produire une image** (-graphie), obtenir un **document** (-gramme), **mesurer** (-métrie), **prélever** (biopsie, ponction, -centèse) ou **cultiver** un microbe (-culture). La racine indique l'organe examiné ou la technique employée (radio-, écho-, scinti-, tomo-). Les examens eux-mêmes sont étudiés au chapitre 30 ; on apprend ici à **lire leurs noms**.

Comprendre le schéma – figure 29.13

Huit cartes associent un suffixe ou une racine à une action. **-scopie** (gr. *skopein*, examiner) : **regarder** directement l'intérieur d'un organe creux ou d'une

cavité avec un endoscope (endoscopie, gastroscopie, coloscopie, cœlioscopie, bronchoscopie). **-graphie** (gr. *graphein*, écrire) : **enregistrer** un signal ou **produire une image** (radiographie, échographie, mammographie, coronarographie). **-gramme** (gr. *gramma*, tracé) : le **document** obtenu ou le **résultat** écrit (électrocardiogramme ou ECG, hémogramme, ionogramme, myélogramme). **-métrie** (gr. *metron*, mesure) : **mesurer** une grandeur (densitométrie osseuse, spirométrie, pH-métrie œsophagienne, impédancemétrie). **tomo-** (gr. *tomos*, tranche) : images en **coupes** (tomodensitométrie ou TDM, appelée couramment « scanner » ; tomographie par émission de positons, TEP). **biopsie, -centèse** : **prélever** un fragment de tissu (bios, vie, et *opsis*, vue : biopsie duodénale) ou un liquide par ponction (*kentêsis*, piqûre : paracentèse, la ponction d'une ascite). **-culture** : faire **pousser** un microbe pour l'identifier (hémoculture, coproculture, ECBU, l'examen cytobactériologique des urines). **écho-, radio-, scinti-** : la **source** du signal (ultrasons : gr. *êkhô*, son ; rayons X : lat. *radius*, rayon ; rayonnement d'un traceur radioactif : lat. *scintilla*, étincelle).



Les suffixes et racines des examens complémentaires : le nom d'un examen indique ce que l'on fait (regarder, enregistrer, mesurer, prélever) ; détails au chapitre 30

Fig. 29.13. Les suffixes et racines des examens complémentaires : le nom d'un examen indique ce que l'on fait (regarder, enregistrer, mesurer, prélever) ; détails au chapitre 30

Élément · Sens · Technique (-graphie, -scopie, -métrie) · Document ou résultat (-gramme)

électro-cardio- — *Sens :* activité électrique du cœur ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* électrocardiographie ; *Document ou résultat (-gramme) :* électrocardiogramme (ECG)

électro-encéphalo- — *Sens :* activité électrique du cerveau ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* électroencéphalographie ; *Document ou résultat (-gramme) :* électroencéphalogramme (EEG)

échographie — *Sens :* images par ultrasons ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* échographie abdominale, échocardiographie ; *Document ou résultat (-gramme) :* compte rendu d'échographie

hémo- — *Sens :* sang ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* numération formule sanguine (NFS) ; *Document ou résultat (-gramme) :* hémogramme

iono- — *Sens :* ions ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* dosage des électrolytes ; *Document ou résultat (-gramme) :* ionogramme sanguin, urinaire

myélo- — *Sens :* moelle osseuse ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* ponction de moelle ; *Document ou résultat (-gramme) :* myélogramme

mammo- — *Sens :* sein ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* mammographie ; *Document ou résultat (-gramme) :* clichés de mammographie

coronaro- — *Sens :* artères coronaires ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* coronarographie ; *Document ou résultat (-gramme) :* images des coronaires

densito- — *Sens :* densité (osseuse) ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* densitométrie osseuse (DXA) ; *Document ou résultat (-gramme) :* T-score

spiro- — *Sens :* respiration ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* spirométrie ; *Document ou résultat (-gramme) :* courbe débit-volume, VEMS

gastro-, colo-, broncho- — *Sens :* estomac, côlon, bronches ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie ; *Document ou résultat (-gramme) :* compte rendu, biopsies

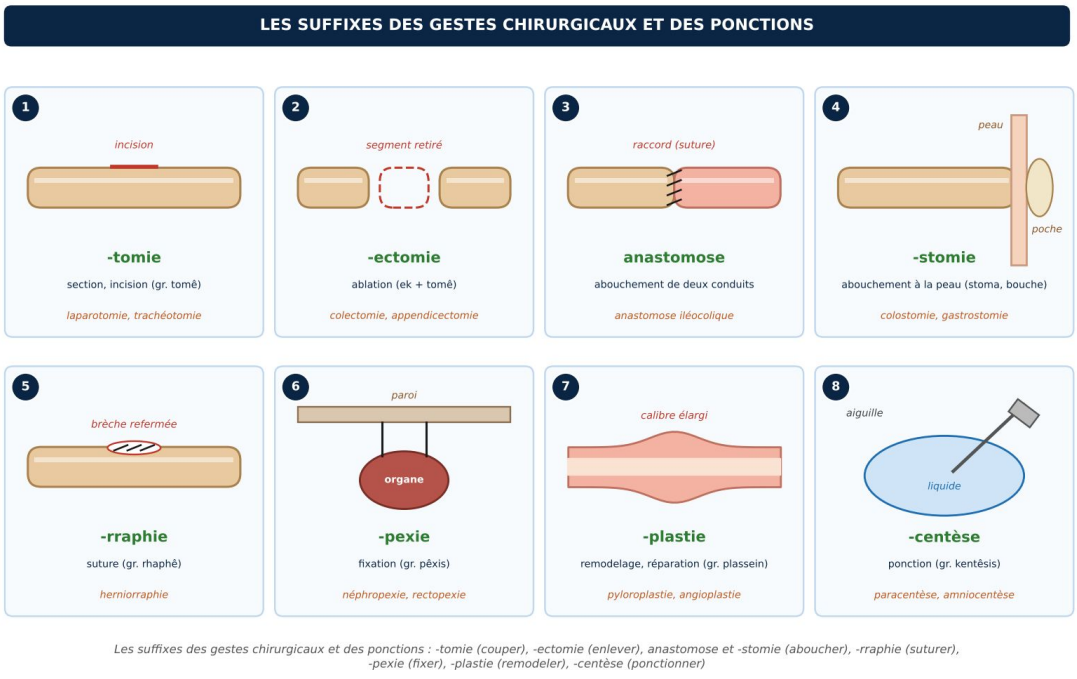
cœlio-, laparo- — *Sens :* cavité abdominale, paroi ; *Technique (-graphie, -scopie, -métrie) :* cœlioscopie, laparoscopie (synonymes) ; *Document ou résultat (-gramme) :* compte rendu opératoire

Attention

-graphie ≠ -gramme ; -scopie ≠ -graphie. On réalise une électrocardio**graphie** et on obtient un électrocardio**gramme** ; dans l'usage, « ECG » désigne les deux. Une gastro**scopie** est une **observation directe** de l'estomac par une caméra ; un « transit œso-gastro-duodénal » est une radio**graphie** après ingestion d'un produit de contraste. L'abréviation **FOGD** (fibroscopie œso-gastro-duodénale) désigne la gastroscopie : *fibro-* rappelle les fibres optiques des premiers endoscopes.

Les suffixes des actes chirurgicaux

La chirurgie a son propre vocabulaire, que le CNED présente dans la séquence « Acte chirurgical et conséquences nutritionnelles ». Toute intervention commence par une **voie d'abord** : soit les **voies naturelles** (endoscopie digestive : le chirurgien ou le gastro-entérologue passe par la bouche ou l'anus), soit une **incision** de la paroi. L'ouverture large de l'abdomen est une **laparotomie** (gr. *lapara*, flanc, et *-tomie*) ; l'intervention réalisée à l'aide d'un endoscope introduit par de petites incisions, l'abdomen étant gonflé de gaz, est une **cœlioscopie** (gr. *koilia*, cavité abdominale), ou **laparoscopie** : elle réduit la douleur, la durée d'hospitalisation et le délai de reprise de l'alimentation. Le geste lui-même est désigné par un suffixe.



Les suffixes des gestes chirurgicaux et des ponctions : -tomie (couper), -ectomie (enlever), anastomose et -stomie (aboucher), -rraphie (suturer), -pexie (fixer), -plastie (remodeler), -centèse (ponctionner)

Fig. 29.14. Les suffixes des gestes chirurgicaux et des ponctions : -tomie (couper), -ectomie (enlever), anastomose et -stomie (aboucher), -rraphie (suturer), -pexie (fixer), -plastie (remodeler), -centèse (ponctionner)

Comprendre le schéma – figure 29.14

Les huit vignettes représentent un segment d'organe creux (beige) et le geste correspondant. **1. -tomie** : section ou **incision** (gr. *tomê*) : laparotomie (ouverture de la paroi abdominale), trachéotomie (incision de la trachée), sphinctérotomie. **2. -ectomie** : **ablation** (gr. *ek*, hors de, et *tomê*) d'un organe ou d'une partie d'organe ; le segment retiré est en pointillés rouges : colectomie, appendicectomie, gastrectomie, cholécystectomie. **3. anastomose** : **abouchement de deux conduits** (raccord suturé) pour rétablir la continuité après une ectomie : anastomose iléocolique ; elle peut être **termino-terminale** (bout à bout) ou **termino-latérale** (le bout d'un segment sur le côté de l'autre). **4. -stomie**

: **abouchement d'un organe creux à la peau** (gr. *stoma*, bouche), avec une poche collectrice ou une sonde : colostomie, iléostomie, gastrostomie, jéjunostomie, trachéostomie. **5. -rraphie** : **suture** (gr. *rhaphê*, couture) : herniorraphie. **6. -pexie** : **fixation** d'un organe mobile à une paroi (gr. *pêxis*) : rectopexie (contre un prolapsus du rectum), néphropexie. **7. -plastie** : **remodelage**, réparation ou élargissement (gr. *plassein*, modeler) : pyloroplastie, angioplastie (dilatation d'une artère rétrécie, souvent avec un stent). **8. -centèse** : **ponction** à l'aiguille d'une cavité contenant du liquide (gr. *kentêsis*, piqûre) : paracentèse (ponction d'ascite), amniocentèse, thoracentèse. La version muette de cette figure est proposée en 29.11.1.

Terme · Définition · Exemple et conséquence nutritionnelle

exérèse, résection — *Définition :* ablation chirurgicale d'un tissu ou d'une partie d'organe (synonymes larges d'-ectomie) ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* résection iléale étendue : malabsorption de la vitamine B12 et des sels biliaires

gastrectomie (partielle ou totale) — *Définition :* ablation de l'estomac ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* petits repas fractionnés, risque de syndrome de chasse (*dumping syndrome*), carences en B12, fer, calcium

sleeve gastrectomie — *Définition :* gastrectomie longitudinale (réduction du volume de l'estomac) en chirurgie bariatrique ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* progression des textures, apports protéiques, suppléments

bypass (court-circuit) gastrique — *Définition :* petite poche gastrique anastomosée à une anse jéjunale : restriction et malabsorption ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* supplémentation vitaminique à vie (chapitre 32)

colectomie, hémicolectomie — *Définition :* ablation du côlon, d'une moitié du côlon ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* reprise progressive, adaptation des fibres

colostomie, iléostomie — *Définition :* abouchement du côlon, de l'iléon à la peau ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* iléostomie : pertes en eau et en sodium, risque de déshydratation

gastrostomie (GPE), jéjunostomie — *Définition :* sonde posée dans l'estomac ou le jéjunum à travers la paroi ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* nutrition entérale prolongée

cholécystectomie — *Définition :* ablation de la vésicule biliaire ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* alimentation normale le plus souvent ; parfois diarrhée biliaire

duodénopancréatectomie céphalique — *Définition :* ablation de la tête du pancréas, du duodénum et de la voie biliaire principale ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* insuffisance pancréatique exocrine (extraits pancréatiques), diabète possible

angioplastie — *Définition :* dilatation d'une artère rétrécie par un ballonnet, avec pose d'un stent ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* prévention secondaire cardiovasculaire

pontage — *Définition :* dérivation contournant une artère obstruée par un vaisseau greffé ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* pontage aorto-coronarien

greffe, transplantation — *Définition :* introduction d'un organe ou d'un tissu venant d'un donneur ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* immunosuppresseurs : hygiène alimentaire, diabète post-greffe, interactions (pamplemousse)

cathétérisme — *Définition :* introduction d'un tube fin et souple (cathéter) dans un vaisseau ou une cavité ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* cathéter veineux central de nutrition parentérale

endoprothèse (stent) — *Définition :* tube maillé maintenant ouvert un conduit rétréci ; *Exemple et conséquence nutritionnelle :* stent œsophagien : textures adaptées

À RETENIR

-tomie = couper (on ouvre, on incise) ; **-ectomie = couper et enlever** ; **-stomie = créer une bouche** (aboucher à la peau ou à un autre organe) ; **anastomose = raccorder** deux conduits. Une intervention digestive associe souvent les trois : laparotomie (voie d'abord), colectomie (ablation), anastomose colorectale (rétablissement de la continuité) ou colostomie (si l'anastomose est impossible ou doit être protégée).

Les suffixes des traitements

Les suffixes de **traitement** et de **spécialité** se reconnaissent facilement. **-thérapie** (gr. *therapeia*, soin) désigne un traitement : chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, insulinothérapie, oxygénothérapie, diétothérapie (traitement par l'alimentation), kinésithérapie, psychothérapie. **-logie** désigne une science ou une spécialité et **-logue** le spécialiste : cardiologie et cardiologue, néphrologie, endocrinologie, gastroentérologie, oncologie, diabétologie, nutrition ; **-iatrie** (gr. *iatros*, médecin) désigne aussi une spécialité médicale : pédiatrie (enfant), gériatrie (gr. *gerôn*, vieillard), psychiatrie, phoniatrie ; **iatrogène** signifie « **provoqué par un soin** ». **-cide** (lat. *caedere*, tuer) qualifie ce qui tue (bactéricide, fongicide), **-statique** ce qui arrête la multiplication (bactériostatique), **anti-** ce qui s'oppose (antibiotique, antiémétique, antalgique, anti-inflammatoire, antipyrétique), **-lytique** ce qui dissout (thrombolytique, mucolytique), **-gène** ce qui produit (pathogène, cancérogène, tératogène, orexigène), **-trope** ce qui agit sur (psychotrope, hormones hypophysaires gonadotropes, thyréotropes).

Les suffixes **cellulaires et biologiques** viennent de l'histologie et de la biochimie (volume 1). **-cyte** (cellule) : érythrocyte, leucocyte, lymphocyte, monocyte, thrombocyte, hépatocyte, adipocyte, entérocyte, ostéocyte, chondrocyte. **-blaste** (cellule jeune, qui forme) : ostéoblaste (forme l'os), fibroblaste, érythroblaste, mégaloblaste. **-claste** (qui détruit) : ostéoclaste (résorbe l'os). **-poïèse** (production de cellules) : hématopoïèse, érythropoïèse (stimulée par l'érythropoïétine, EPO, produite par le rein). **-genèse** (formation) : lipogenèse, glycogenèse, néoglucogenèse, cétogenèse, cancérogenèse, ovogenèse. **-lyse** (dégradation) : glycolyse, lipolyse, protéolyse, glycogénolyse, hémolyse. **-phile** (affinité) : hydrophile, lipophile, neutrophile, éosinophile, basophile (affinité pour des colorants). **-crine** (sécrétion) : endocrine, exocrine, paracrine. **-ule**, **-ole**, **-ille** (diminutifs latins) : lobule, veinule, artériole, bronchiole, ovule, globule, papille, villosité (lat. *villus*, poil).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Donnez le sens du suffixe et définissez : **a)** hépatocyte ; **b)** érythropoïèse ; **c)** ostéoclaste ; **d)** iatrogène ; **e)** stéatorrhée ; **f)** nycturie ; **g)** pyloroplastie ; **h)** paracentèse ; **i)** splénomégalie ; **j)** dyspepsie.

CORRIGÉ

a) -cyte (cellule) : **cellule du foie**. **b)** -poïèse (production) : **production des hématies** dans la moelle osseuse. **c)** -claste (qui détruit) : **cellule qui résorbe l'os**. **d)** -gène (qui produit) : **provoqué par un soin** (médicament, examen, intervention). **e)** -rrhée (écoulement) : **présence excessive de graisses dans les selles** (plus de 6 g par 24 h lors d'un apport de 100 g de lipides par jour), signe de malabsorption ou de maldigestion des lipides.

f) -urie (urine) + nyct- (nuit) : **émission d'urines la nuit**, obligeant à se lever. **g)** -plastie (remodelage) : **élargissement chirurgical du pylore**. **h)** -centèse (ponction) + para- : **ponction de la cavité péritonéale** pour évacuer une ascite. **i)** -mégalie (augmentation de volume) : **augmentation du volume de la rate**. **j)** -pepsie (digestion) + dys- : **trouble de la digestion haute** (inconfort, pesanteur, satiété précoce).

Tableau complet des suffixes du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique et sans le tiret initial du guide, les **49 suffixes** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025, avec leur origine, leur sens et des exemples.

Suffixe · Origine · Sens · Exemples

-algie — *Origine :* gr. *algos*, douleur ; *Sens :* douleur ; *Exemples :* gastralgie, arthralgie, myalgie, névralgie

-blaste — *Origine :* gr. *blastos*, germe ; *Sens :* cellule jeune, en formation ; *Exemples :* ostéoblaste, fibroblaste, érythroblaste

-centèse — *Origine :* gr. *kentêsis*, piqûre ; *Sens :* ponction ; *Exemples :* paracentèse, amniocentèse, thoracentèse

-cide — *Origine :* lat. *caedere*, tuer ; *Sens :* qui tue ; *Exemples :* bactéricide, fongicide, insecticide

-claste — *Origine :* gr. *klastos*, brisé ; *Sens :* qui détruit, qui brise ; *Exemples :* ostéoclaste

-cyte — *Origine :* gr. *kutos*, cavité, cellule ; *Sens :* cellule ; *Exemples :* érythrocyte, leucocyte, adipocyte, hépatocyte

-dipsie — *Origine :* gr. *dipsa*, soif ; *Sens :* soif ; *Exemples :* polydipsie, adipsie

-ectasie — *Origine :* gr. *ektasis*, extension ; *Sens :* dilatation ; *Exemples :* bronchectasie, télangiectasie

-ectomie — *Origine :* gr. *ek*, hors de, et *tomê*, section ; *Sens :* ablation chirurgicale ; *Exemples :* gastrectomie, cholécystectomie, appendicectomie

-émèse — *Origine :* gr. *emesis*, vomissement ; *Sens :* vomissement ; *Exemples :* hématémèse, hyperémèse gravidique

-émie — *Origine :* gr. *haima*, sang ; *Sens :* présence dans le sang ; concentration sanguine ; *Exemples :* glycémie, urémie, kaliémie, natrémie

-esthésie — *Origine :* gr. *aisthêsis*, sensation ; *Sens :* sensibilité ; *Exemples :* anesthésie, paresthésie, hyperesthésie

-gène — *Origine :* gr. *-genês*, né de, qui engendre ; *Sens :* qui produit ; qui est produit par ; *Exemples :* pathogène, cancérogène, iatrogène, endogène

-genèse — *Origine :* gr. *genesis*, naissance ; *Sens :* formation, production ; *Exemples :* lipogenèse, néoglucogenèse, cancérogenèse

-gramme — *Origine :* gr. *gramma*, lettre, tracé ; *Sens :* document enregistré, résultat écrit ; *Exemples :* électrocardiogramme, ionogramme, hémogramme

-graphie — *Origine :* gr. *graphein*, écrire ; *Sens :* technique d'enregistrement ou d'imagerie ; *Exemples :* radiographie, échographie, mammographie

-ite — *Origine :* gr. *-itis* ; *Sens :* inflammation ; *Exemples :* hépatite, gastrite, pancréatite, colite

-logie — *Origine :* gr. *logos*, discours, science ; *Sens :* étude, science ; *Exemples :* cardiologie, sémiologie, physiopathologie

-lyse — *Origine :* gr. *lusis*, dissolution ; *Sens :* destruction, dégradation, dissolution ; *Exemples :* lipolyse, glycolyse, hémolyse, dialyse

-mégalie — *Origine :* gr. *megas, megalou*, grand ; *Sens :* augmentation de volume ; *Exemples :* hépatomégalie, splénomégalie, acromégalie

-mnésie — *Origine :* gr. *mnêsis*, mémoire ; *Sens :* mémoire ; *Exemples :* amnésie, anamnèse

-ome — *Origine :* gr. *-ôma* ; *Sens :* tumeur, masse ; parfois collection ; *Exemples :* adénome, lipome, carcinome ; hématome

-ose — *Origine :* gr. *-ôsis* ; *Sens :* état, maladie non inflammatoire ; excès de cellules ; *Exemples :* arthrose, cirrhose, stéatose ; leucocytose

-pare — *Origine :* lat. *parere*, enfanter ; *Sens :* qui a accouché ; *Exemples :* nullipare, primipare, multipare

-parésie — *Origine :* gr. *paresis*, relâchement ; *Sens :* paralysie partielle ; *Exemples :* gastroparésie, hémiparésie

-pathie — *Origine :* gr. *pathos*, souffrance ; *Sens :* maladie (sens général) ; *Exemples :* néphropathie, cardiopathie, neuropathie

-pénie — *Origine :* gr. *penia*, pauvreté ; *Sens :* diminution, manque ; *Exemples :* thrombopénie, leucopénie, sarcopénie, ostéopénie

-pepsie — *Origine :* gr. *pepsis*, cuisson, digestion ; *Sens :* digestion ; *Exemples :* dyspepsie

-pexie — *Origine :* gr. *pêxis*, fixation ; *Sens :* fixation chirurgicale ; *Exemples :* rectopexie, néphropexie, gastropexie

-phasie — *Origine :* gr. *phasis*, parole ; *Sens :* parole, langage ; *Exemples :* aphasie, dysphasie

-phile — *Origine :* gr. *philos*, ami ; *Sens :* qui a de l'affinité pour ; *Exemples :* hydrophile, éosinophile, neutrophile

-phobie — *Origine :* gr. *phobos*, peur ; *Sens :* peur, aversion ; *Exemples :* néophobie alimentaire, hydrophobe, claustrophobie

-plasie — *Origine :* gr. *plasis*, formation ; *Sens :* formation, développement d'un tissu ; *Exemples :* hyperplasie, dysplasie, aplasie, néoplasie

-plastie — *Origine :* gr. *plassein*, modeler ; *Sens :* réparation, remodelage chirurgical ; *Exemples :* angioplastie, pyloroplastie, rhinoplastie

-plégie — *Origine :* gr. *plêgê*, coup ; *Sens :* paralysie (complète) ; *Exemples :* hémiplégie, paraplégie, tétraplégie

-poïèse — *Origine :* gr. *poiêsis*, fabrication ; *Sens :* production de cellules ; *Exemples :* hématopoïèse, érythropoïèse

-rèse — *Origine :* gr. *ourêsis*, action d'uriner ; *hairesis*, action d'enlever ; *Sens :* -urèse : excrétion urinaire ; -érèse : retrait ; *Exemples :* diurèse, natriurèse ; exérèse, aphérèse

-rragie — *Origine :* gr. *rhêgnunai*, briser, jaillir ; *Sens :* écoulement abondant de sang ; *Exemples :* hémorragie, ménorragie, rectorragie

-rraphie — *Origine :* gr. *rhaphê*, couture ; *Sens :* suture chirurgicale ; *Exemples :* herniorraphie, périnéorraphie

-rrhée — *Origine :* gr. *rhein*, couler ; *Sens :* écoulement (d'un liquide autre que le sang) ; *Exemples :* diarrhée, stéatorrhée, rhinorrhée, aménorrhée

-scopie — *Origine :* gr. *skopein*, examiner ; *Sens :* examen visuel, observation ; *Exemples :* endoscopie, gastroscopie, coloscopie

-stase — *Origine :* gr. *stasis*, arrêt, position ; *Sens :* arrêt, stagnation ; stabilité ; *Exemples :* cholestase, hémostase ; homéostasie

-stomie — *Origine :* gr. *stoma*, bouche ; *Sens :* abouchement d'un organe creux à la peau ou à un autre organe ; *Exemples :* colostomie, gastrostomie, iléostomie, trachéostomie

-thérapie — *Origine :* gr. *therapeia*, soin ; *Sens :* traitement ; *Exemples :* chimiothérapie, radiothérapie, insulinothérapie

-tocie — *Origine :* gr. *tokos*, accouchement ; *Sens :* accouchement ; *Exemples :* dystocie, eutocie

-tomie — *Origine :* gr. *tomê*, coupure ; *Sens :* incision, section ; *Exemples :* laparotomie, trachéotomie, sphinctérotomie

-trophie — *Origine :* gr. *trophê*, nourriture ; *Sens :* nutrition, croissance d'un tissu ou d'un organe ; *Exemples :* atrophie, hypertrophie, dystrophie

-ule — *Origine :* lat. *-ulus*, diminutif ; *Sens :* petit ; *Exemples :* veinule, lobule, ovule, globule

-urie — *Origine :* gr. *ouron*, urine ; *Sens :* présence dans l'urine ; émission d'urine ; *Exemples :* glycosurie, protéinurie, hématurie ; polyurie

29.3.4 Les racines, appareil par appareil

Module · *Guide 2025 p. 99-100 : 135 racines · CNED : 3-2023 M1 S1 §1 et §2*

Les **racines** sont les éléments les plus nombreux : la liste du guide en compte 135, et il en existe bien d'autres. Pour les retenir, le plus efficace est de les apprendre **organe par organe**, en même temps que l'anatomie. C'est pourquoi les planches de cette partie reprennent les schémas réalistes des chapitres d'organes du volume 1 (chapitres 12 à 18), dont les légendes ont été remplacées par « **organe – racine(s)** » : chaque fois que vous révisez un organe, vous révisez aussi son vocabulaire. Pour chaque appareil, un tableau donne ensuite les racines, leur sens et les termes qu'elles forment avec les préfixes et suffixes des parties précédentes. Les versions muettes des planches sont proposées en 29.11.1 pour l'entraînement.

Méthode

Apprendre les racines. 1) Situer l'organe sur la planche et dire sa fonction (renvoi au chapitre d'organe). 2) Associer la racine grecque et, s'il existe, l'adjectif latin. 3) Construire mentalement quatre mots : une maladie (-ite, -ose, -pathie), un signe (-algie, -mégalie), un examen (-scopie, -graphie), un acte (-ectomie, -stomie). 4) Vérifier sur le tableau. Exemple : **hépat(o)-** → hépatite, hépatomégalie, échographie hépatique, hépatectomie.

L'appareil digestif

L'appareil digestif (chapitre 17) fournit le plus grand nombre de termes au diététicien : chaque segment du tube digestif et chaque glande annexe a sa racine, et presque toutes les pathologies des chapitres 32 et 33 se nomment avec elles.

Comprendre le schéma – figure 29.15

La planche suit le trajet des aliments. **Bouche** : **stomat(o)-** (gr. *stoma* : stomatite, inflammation de la muqueuse buccale), **bucc(o)-**, **or(o)-** (lat. : buccal, oral, *per os*). **Glandes salivaires** : **sial(o)-** (gr. *sialon*, salive : sialorrhée, hypersalivation) ; la **parotide** est « à côté de l'oreille » (par- + ot-) et la glande **sublinguale** « sous la langue » (sub- + lingu-). **Pharynx** : pharyng(o)- ; **œsophage** : œsophag(o)- (gr. *oisophagos*, « qui porte ce qu'on mange »). **Diaphragme** : phrén(o)- (gr. *phrên* : nerf phrénique). **Estomac** : gastr(o)- (gr. *gastêr*) ; **pylore** : pylor(o)- (gr. *pulôros*, portier : il « garde » la sortie de l'estomac). **Duodénum** : duodén(o)- (lat. *duodeni*, douze : sa longueur est d'environ douze travers de doigt) ; **jéjunum** : jéjun(o)- (lat. *jejunus*, à jeun : on le trouvait vide lors des dissections) ; **iléon** : ilé(o)- ; l'intestin grêle dans son ensemble : **entér(o)-** (gr. *enteron*). **Cæcum** : cæc(o)- (lat. *caecus*, aveugle : c'est un cul-de-sac) ; **appendice** : appendic(o)- ; **côlon** : col(o)-, colon(o)- ; **côlon sigmoïde** : sigmoïd(o)- (en forme de sigma, la lettre grecque σ) ; **rectum** : rect(o)- (lat.) et **proct(o)-** (gr. *prôktos*) ; **anus** : an(o)- (lat.) et proct(o)-. **Glandes annexes** : **foie** : hépat(o)- (gr. *hêpar, hêpatos*) ; **vésicule biliaire** : cholécyst(o)- (*kholê*, bile, et *kustis*, vessie) ; **pancréas** : pancréat(o)- (gr. *pan*, tout, et *kreas*, chair) ; **rate**, organe lymphoïde voisin : splén(o)-.

Le rappel du bas distingue le **tube digestif** (rose et beige) des **glandes annexes** (salivaires, foie, pancréas).

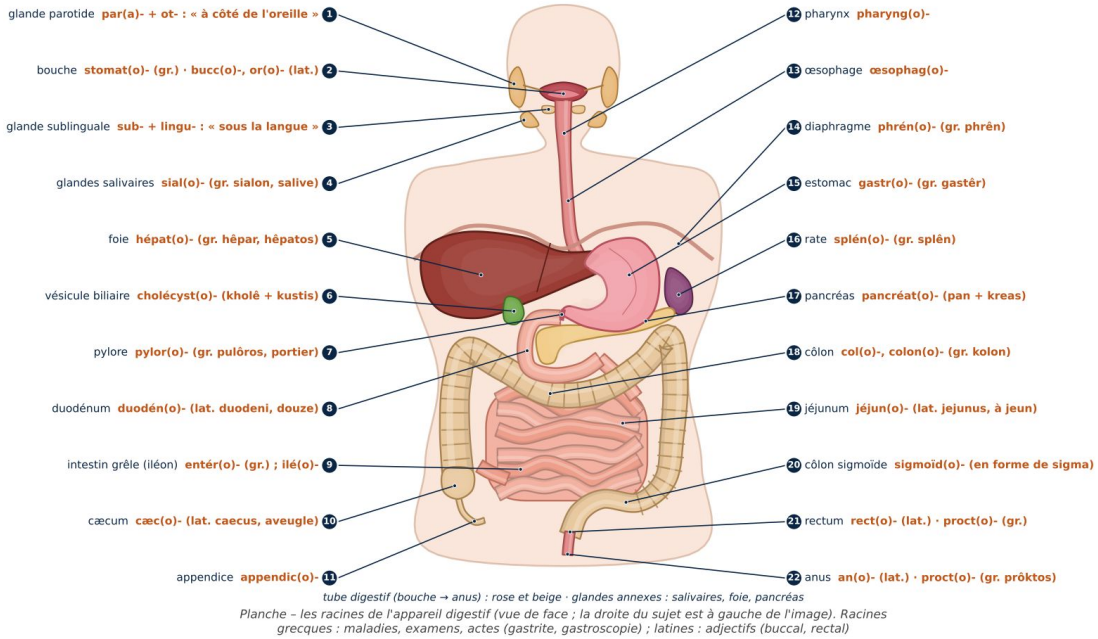


Fig. 29.15. Planche – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image) ; racines grecques : maladies, examens, actes ; latines : adjectifs

Organe · Racines · Termes formés (maladie, signe, examen, acte)

bouche — *Racines :* stomat(o)-, bucc(o)-, or(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* stomatite, stomatologie ; soins bucco-dentaires ; voie orale (*per os*)

langue — *Racines :* gloss(o)-, lingu- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* glossite (langue rouge et lisse des carences en B9, B12, fer) ; sublingual

dent, gencive — *Racines :* odont(o)-, dent- ; gingiv(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* odontologie, orthodontie, édenté ; gingivite, gingivorragie

salive — *Racines :* sial(o)-, ptyal- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* sialorrhée, hyposialie, asialie (sécheresse : xérostomie), sialadénite

pharynx — *Racines :* pharyng(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* pharyngite, oropharynx, rhinopharynx

œsophage — *Racines :* œsophag(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* œsophagite, œsophagectomie, mégaœsophage, FOGD

estomac — *Racines :* gastr(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* gastrite, gastralgie, gastroparésie, gastroscopie, gastrectomie, gastrostomie

pylore — *Racines :* pylor(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* sténose du pylore, pyloroplastie

duodénum — *Racines :* duodén(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* duodénite, ulcère duodénal, biopsies duodénales (maladie cœliaque)

jéjunum, iléon — *Racines :* jéjun(o)-, ilé(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* jéjunostomie ; iléite (maladie de Crohn), iléostomie, résection iléale

intestin — *Racines :* entér(o)-, intestin- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* entérite, entéropathie, entérocyte, nutrition entérale, gastro-entérologie

côlon — *Racines :* col(o)-, colon(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* colite, colectomie, colostomie, coloscopie, colopathie fonctionnelle

sigmoïde — *Racines :* sigmoïd(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* sigmoïdite (complication d'une diverticulose)

rectum, anus — *Racines :* rect(o)-, proct(o)-, an(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* rectite, rectorragie, rectoscopie ; proctologie ; fissure anale

foie — *Racines :* hépat(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* hépatite, hépatomégalie, hépatocyte, hépatectomie, hépatotoxique

bile, voies biliaires — *Racines :* chol(é)-, cholang(i)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* cholestase, cholangite, cholédoque (canal biliaire principal), cholurie

vésicule biliaire — *Racines :* cholécyst(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* cholécystite, cholécystectomie, lithiase vésiculaire

pancréas — *Racines :* pancréat(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* pancréatite, pancréatectomie, extraits pancréatiques

péritoine, abdomen — *Racines :* périton- ; lapar(o)-, cœli(o)- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* péritonite ; laparotomie, cœlioscopie ; ascite (gr. *askos*, outre)

selles — *Racines :* copr(o)-, féc- ; *Termes formés (maladie, signe, examen, acte) :* coproculture, fécalome, incontinence fécale

Lien avec la diététique

Lire un compte rendu de gastro-entérologie. « FOGD : œsophagite peptique de grade A, hernie hiatale, gastrite antrale ; biopsies duodénales normales. Coloscopie : diverticulose sigmoïdienne non compliquée, polype de 6 mm réséqué. » Le diététicien en déduit : une inflammation de l'œsophage par le reflux acide (conseils hygiéno-diététiques du reflux), une portion d'estomac passée au-dessus du diaphragme par l'orifice œsophagien (hiatus), une inflammation de l'antre gastrique, l'absence d'atrophie villositaire (pas d'argument pour une maladie cœliaque), des diverticules du côlon sigmoïde sans inflammation (pas de régime pauvre en fibres en dehors des poussées) et l'ablation d'un polype (surveillance).

L'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire (chapitre 16) fournit les racines des voies aériennes, du poumon et de la plèvre, et un suffixe très fréquent, **-pnée** (respiration). Le diététicien les rencontre en pneumologie (BPCO, mucoviscidose), en réanimation (ventilation, trachéotomie) et chez le patient dysphagique (risque de **pneumopathie d'inhalation** quand les aliments passent dans les voies aériennes : la « fausse route »).

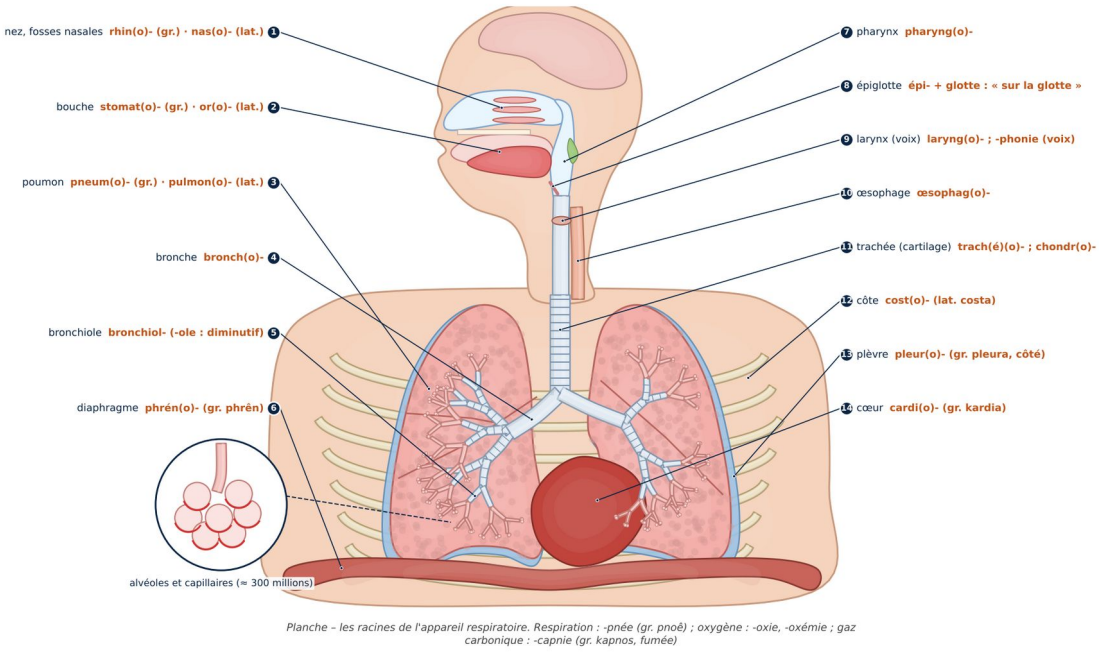


Planche – les racines de l'appareil respiratoire. Respiration : -pnée (gr. pnoê) ; oxygène : -oxie, -oxémie ; gaz carbonique : -capnie (gr. kapnos, fumée)

Fig. 29.16. Planche – les racines de l'appareil respiratoire ; respiration : -pnée ; oxygène : -oxie, -oxémie ; gaz carbonique : -capnie

Comprendre le schéma – figure 29.16

De haut en bas : **nez, fosses nasales** : rhin(o)- (gr. *rhis, rhinos* : rhinite, rhinopharynx) et nas(o)- (lat. : sonde **naso**gastrique) ; **bouche** : stomat(o)-, or(o)- ; **pharynx** : pharyng(o)-, carrefour des voies aériennes et digestives ; **épiglotte** : « sur la glotte » (épi- + glotte), le clapet qui ferme le larynx pendant la déglutition ; **larynx** : laryng(o)- (laryngite, laryngectomie) ; la voix : **-phonie** (dysphonie) ; **œsophage**, placé en arrière de la trachée ; **trachée** : trach(é)(o)- (trachéotomie, trachéostomie) ; ses anneaux de **cartilage** : chondr(o)- ; **bronche** : bronch(o)- (bronchite, bronchoscopie, bronchectasie) ; **bronchiole** : -ole, diminutif ; **poumon** : pneum(o)-, pneumon(o)- (gr.) et pulmon(o)- (lat.) ; **plèvre** : pleur(o)- (gr. *pleura*, côté : pleurésie, épanchement pleural) ; **côte** : cost(o)- (lat. *costa* : intercostal) ; **diaphragme** : phrén(o)- ; **cœur** : cardi(o)-. Le médaillon montre les **alvéoles** entourées de capillaires, lieu de l'hématose.

La légende du bas donne trois suffixes clés : **-pnée** (gr. *pnoê*, respiration : dyspnée, apnée, tachypnée, orthopnée), **-oxie**, **-oxémie** (oxygène dans les tissus, dans le sang : hypoxie, hypoxémie), **-capnie** (gr. *kapnos*, fumée, d'où le dioxyde de carbone : hypercapnie, excès de CO_2 dans le sang artériel au cours de l'insuffisance respiratoire).

Racine ou suffixe · Sens · Termes formés

rhin(o)-, nas(o)- — *Sens :* nez ; *Termes formés :* rhinite, rhinorrhée, rhinopharyngite ; sonde nasogastrique (SNG), nasojéjunale

pharyng(o)-, laryng(o)- — *Sens :* pharynx, larynx ; *Termes formés :* pharyngite, laryngite, laryngectomie (le patient respire par un orifice trachéal)

trach(é)(o)- — *Sens :* trachée ; *Termes formés :* trachéite, trachéotomie, trachéostomie (canule de trachéotomie et alimentation)

bronch(o)-, bronchiol- — *Sens :* bronche, bronchiole ; *Termes formés :* bronchite, bronchiolite (du nourrisson), bronchoscopie, bronchodilatateur, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

pneum(o)-, pneumon(o)-, pulmon(o)- — *Sens :* poumon ; air ; *Termes formés :* pneumonie, pneumopathie (d'inhalation), pneumothorax (air dans la plèvre), pneumologie ; embolie pulmonaire

pleur(o)- — *Sens :* plèvre ; *Termes formés :* pleurésie, pleurodynie, épanchement pleural

thorac(o)- — *Sens :* thorax ; *Termes formés :* thoracique, thoracotomie, thoracentèse

-pnée, spir(o)- — *Sens :* respiration ; *Termes formés :* dyspnée, apnée (du sommeil), polypnée ; spirométrie, inspiration, expiration

-oxie, -oxémie ; -capnie — *Sens :* oxygène ; CO_2 ; *Termes formés :* hypoxie, hypoxémie, oxygénothérapie ; hypercapnie, hypocapnie

ptys- — *Sens :* crachat ; *Termes formés :* hémoptysie ; expectoration (crachats)

tuss- — *Sens :* toux (lat. *tussis*) ; *Termes formés :* antitussif

Attention

pneum(o)- a deux sens : « poumon » (pneumonie, pneumopathie) et « air » (gr. *pneuma*, souffle : **pneumothorax**, présence d'air dans la cavité pleurale ; **pneumopéritoine**, air dans le péritoine, insufflé volontairement en cœlioscopie ou signe de perforation digestive). Le contexte permet de choisir.

L'appareil cardiovasculaire

L'appareil cardiovasculaire (chapitre 15) et le sang (chapitre 12) fournissent le vocabulaire des pathologies du chapitre 35 (athérosclérose, infarctus, hypertension, insuffisance cardiaque) et celui de l'hématologie (anémies, hémorragies, thromboses).

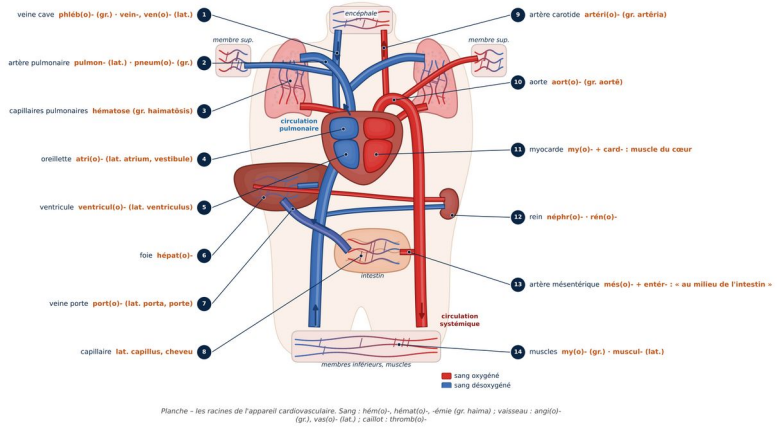


Planche – les racines de l'appareil cardiovasculaire. Sang : hém(o)-, hémat(o)-, -émie (gr. haima) ; vaisseau : angi(o)- (gr.), vas(o)- (lat.) ; caillot : thromb(o)-

Fig. 29.17. Planche – les racines de l'appareil cardiovasculaire ; sang : hém(o)-, hémat(o)-, -émie ; vaisseau : angi(o)- (gr.), vas(o)- (lat.) ; caillot : thromb(o)-

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.17

La planche représente la double circulation (sang oxygéné en rouge, désoxygéné en bleu). **Veine cave** : **phléb(o)-** (gr. *phleps* : phlébite, phlébotomie) et vein-, ven(o)- (lat. : intraveineux, retour veineux) ; **artère pulmonaire** : pulmon- (lat.), pneum(o)- (gr.) ; **capillaires pulmonaires** : siège de l'**hématose** (gr. *haimatôsis*, transformation en sang, c'est-à-dire l'oxygénation du sang) ; **oreillette** : atri(o)- (lat. *atrium*, vestibule) et auricul(o)- (auriculo-ventriculaire) ; **ventricule** : ventricul(o)- (lat. *ventriculus*, petit ventre) ; **foie** et **veine porte** : port(o)- (lat. *porta*, porte : le sang de l'intestin « entre » dans le foie par la porte du hile) ; **capillaire** : lat. *capillus*, cheveu (vaisseau fin comme un cheveu) ; **artère carotide** : artéri(o)- (gr. *artêria*) ; **aorte** : aort(o)- ; **myocarde** : my(o)- + card- : le **muscle** du cœur ; **rein** : néphr(o)-, rén(o)- ; **artère mésentérique** : més(o)- + entér- : « au milieu de l'intestin » (le mésentère porte les vaisseaux de l'intestin) ; **muscles** : my(o)- (gr.), muscul- (lat.).

La légende du bas ajoute les racines du **sang** (hém(o)-, hémat(o)-, -émie), du **vaisseau** (angi(o)- en grec : angiographie, angioplastie ; vas(o)-, vascul(o)- en latin : vasodilatation, cardiovasculaire) et du **caillot** (thromb(o)- : thrombose, thrombolyse).

Racine · Sens · Termes formés

cardi(o)-, card- — *Sens :* cœur ; *Termes formés :* cardiopathie, cardiomégalie, cardiologie, tachycardie, bradycardie, myocarde, endocarde, péricarde, péricardite

coronar(o)- — *Sens :* artères coronaires (en couronne autour du cœur) ; *Termes formés :* coronarographie, insuffisance coronarienne, syndrome coronarien aigu

valvul(o)- — *Sens :* valve du cœur ; *Termes formés :* valvulopathie, valvuloplastie ; rétrécissement aortique, insuffisance mitrale

angi(o)- — *Sens :* vaisseau ; *Termes formés :* angiographie, angioplastie, angiome, angiopathie (diabétique)

artéri(o)- — *Sens :* artère ; *Termes formés :* artériosclérose, artérite, artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), artériole

phléb(o)-, vein-, ven(o)- — *Sens :* veine ; *Termes formés :* phlébite (thrombose veineuse), phlébotomie, veinule, insuffisance veineuse

vas(o)-, vascul(o)- — *Sens :* vaisseau ; *Termes formés :* vasodilatation, vasoconstriction, vascularite, accident vasculaire cérébral

athér(o)- — *Sens :* dépôt lipidique (« bouillie ») ; *Termes formés :* athérome, athérosclérose, athérogène (qui favorise l'athérome : LDL)

thromb(o)- — *Sens :* caillot ; plaquette ; *Termes formés :* thrombose, thrombus, thrombolyse, thrombocyte, thrombopénie

embol- — *Sens :* corps obstruant un vaisseau (gr. *embolos*, coin) ; *Termes formés :* embolie pulmonaire, embole

isch- — *Sens :* arrêt (gr. *iskhein*, retenir) ; *Termes formés :* ischémie (apport sanguin insuffisant à un tissu), cardiopathie ischémique

infarct- — *Sens :* lat. *infarcire*, farcir, bourrer ; *Termes formés :* infarctus (nécrose d'un tissu privé de sang : infarctus du myocarde, infarctus mésentérique)

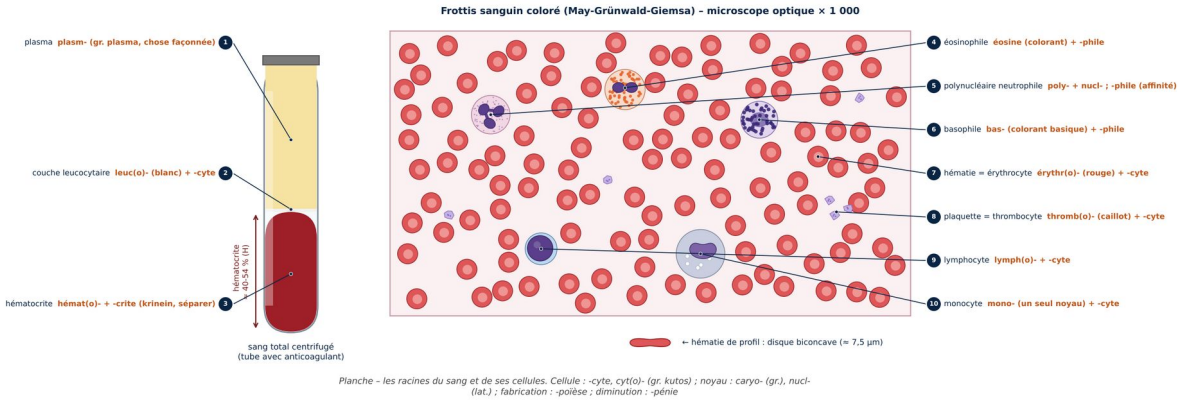


Fig. 29.18. Planche – les racines du sang et de ses cellules ; cellule : -cyte, cyt(o)- ; noyau : caryo- (gr.), nucl- (lat.) ; fabrication : -poïèse ; diminution : -pénie

-tension, -tonie — *Sens :* pression ; tonus ; *Termes formés :* hypertension artérielle (HTA), hypotension orthostatique ; hypertonie, hypotonie

-systole, -diastole — *Sens :* contraction ; relâchement (gr.) ; *Termes formés :* pression systolique et diastolique ; extrasystole

-rythmie — *Sens :* rythme ; *Termes formés :* arythmie (fibrillation auriculaire), tachyarythmie

œdém- — *Sens :* gonflement (gr. *oidêma*) ; *Termes formés :* œdème (des membres inférieurs, pulmonaire), lymphœdème

Le sang et ses cellules

Le **sang** et ses cellules ont un vocabulaire très régulier, construit avec **-cyte** (cellule), **-émie** (dans le sang), **-pénie** (manque), **-cytose** (excès ou anomalie de taille), **-poïèse** (production) et des racines de couleur.

Comprendre le schéma – figure 29.18

À gauche, un tube de sang total **centrifugé** : en haut le **plasma** (gr. *plasma*, chose façonnée), environ 55 % du volume ; au milieu une fine **couche leucocytaire** (leuc(o)-, blanc, + -cyte) qui contient aussi les plaquettes ; en bas les hématies, dont le pourcentage du volume total est l'**hématocrite** (hémat(o)- + -crite, du grec *krinein*, séparer), environ 40 à 54 % chez l'homme (37 à 47 % chez la femme). À droite, un **frottis** coloré au May-Grünwald-Giemsa : **éosinophile** (granulations colorées par l'éosine, un colorant acide : -phile, affinité), **polynucléaire neutrophile** (noyau à plusieurs lobes : poly- + nucl- ; granulations « neutres »), **basophile** (granulations colorées par un colorant basique), **hématie** ou **érythrocyte** (érythr(o)-, rouge), **plaquette** ou **thrombocyte** (thromb(o)-, caillot), **lymphocyte** (lymph(o)-), **monocyte** (mono-, un seul noyau, volumineux). L'hématie vue de profil est un **disque biconcave** d'environ 7,5 µm de diamètre.

Terme · Décomposition · Définition

anémie — *Décomposition :* an- + -émie ; *Définition :* diminution du taux d'hémoglobine (< 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme, < 11 g/dL chez la femme enceinte, selon l'OMS)

microcytose / macrocytose — *Décomposition :* micro- / macro- + cyt- + -ose ; *Définition :* hématies trop petites (VGM < 80 fL : carence en fer) / trop grandes (VGM > 100 fL : carence en B9 ou B12, alcool)

hypochromie — *Décomposition :* hypo- + chrom- (couleur) + -ie ; *Définition :* hématies pauvres en hémoglobine (TCMH ou CCMH basses : carence en fer)

leucopénie, neutropénie — *Décomposition :* leuc- / neutro- + -pénie ; *Définition :* baisse des leucocytes, des polynucléaires neutrophiles (risque infectieux, chimiothérapie)

hyperleucocytose — *Décomposition :* hyper- + leuc- + cyt- + -ose ; *Définition :* excès de leucocytes (infection, inflammation)

thrombopénie / thrombocytose — *Décomposition :* thromb- + -pénie / -cytose ; *Définition :* baisse / excès des plaquettes

pancytopénie — *Décomposition :* pan- + cyt- + -pénie ; *Définition :* baisse des trois lignées (aplasie médullaire)

hémolyse — *Décomposition :* hém- + -lyse ; *Définition :* destruction des hématies

hémostase — *Décomposition :* hém- + -stase ; *Définition :* ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement

hématopoïèse, érythropoïèse — *Décomposition :* hémat- / érythr- + -poïèse ; *Définition :* production des cellules sanguines, des hématies (moelle osseuse)

sidéropénie — *Décomposition :* sidér- (fer) + -pénie ; *Définition :* carence en fer (ferritine basse)

hémochromatose — *Décomposition :* hémo- + chrom- + -ose ; *Définition :* surcharge en fer d'origine génétique, qui atteint surtout le foie

septicémie — *Décomposition :* gr. *sêptikos*, qui putréfie, + -émie ; *Définition :* infection généralisée avec des bactéries dans le sang (on dit aujourd'hui « sepsis »)

S'entraîner – application

Décomposez et définissez : **a)** cholangite ; **b)** cardiomégalie ; **c)** phlébite ; **d)** hypercapnie ; **e)** sialorrhée ; **f)** proctologie ; **g)** thrombolyse ; **h)** macrocytose.

Corrigé

a) cholang- (voies biliaires) + -ite : **inflammation (souvent infectieuse) des voies biliaires**. **b)** cardi- + o + -mégalie : **augmentation du volume du cœur**. **c)** phléb- + -ite : **inflammation d'une veine**, le plus souvent associée à un caillot (thrombose veineuse profonde). **d)** hyper- + -capnie : **excès de dioxyde de carbone dans le sang artériel**.

e) sial- (salive) + o + -rrhée : **écoulement excessif de salive** hors de la bouche (fréquent dans les maladies neurologiques avec troubles de la déglutition). **f)** proct- (anus, rectum) + o + -logie : **spécialité médicale de l'anus et du rectum**. **g)** thromb- + o + -lyse : **dissolution d'un caillot** par un médicament (thrombolytique). **h)** macro- + cyt- + -ose : **hématies de volume trop grand** (VGM > 100 fL).

L'appareil urinaire

L'appareil urinaire (chapitre 18) fournit les racines des pathologies rénales du chapitre 34 (maladie rénale chronique, dialyse, lithiase, syndrome néphrotique) et les très nombreux termes en **-urie** qui décrivent l'urine.

Comprendre le schéma – figure 29.19

Rein : **néphr(o)-** (gr. *nephros* : néphrite, néphropathie, néphrectomie, néphron) et **rén(o)-** (lat. *ren* : rénal) ; **surrénale** : sur- + rén- (« au-dessus du rein ») et **adrén(o)-** (lat. *ad*, près de, et *ren* : adrénaline) ; **bassinet** : **pyél(o)-** (gr. *puelos*, cuve : pyélonéphrite, infection du bassinet et du rein) ; **uretère** : urétér(o)- (conduit du rein à la vessie) ; **vessie** : **cyst(o)-** (gr. *kustis* : cystite, cystoscopie) et vésic(o)- (lat. *vesica* : vésical) ; **urètre** : urétr(o)- (conduit de la vessie vers l'extérieur) ; **cortex** : cortic(o)- (lat. *cortex*, écorce : la partie périphérique) ; **médullaire** : médull(o)- (lat. *medulla*, moelle : la partie centrale, avec les

pyramides) ; **aorte**, **veine cave**, **artère rénale** : artéri(o)- + rén- ; **os iliaque** : ili(o)- (≠ ilé(o)-, l'iléon) et osté(o)- ; **vertèbre lombaire** : spondyl(o)- (gr.) et vertébr- (lat.).

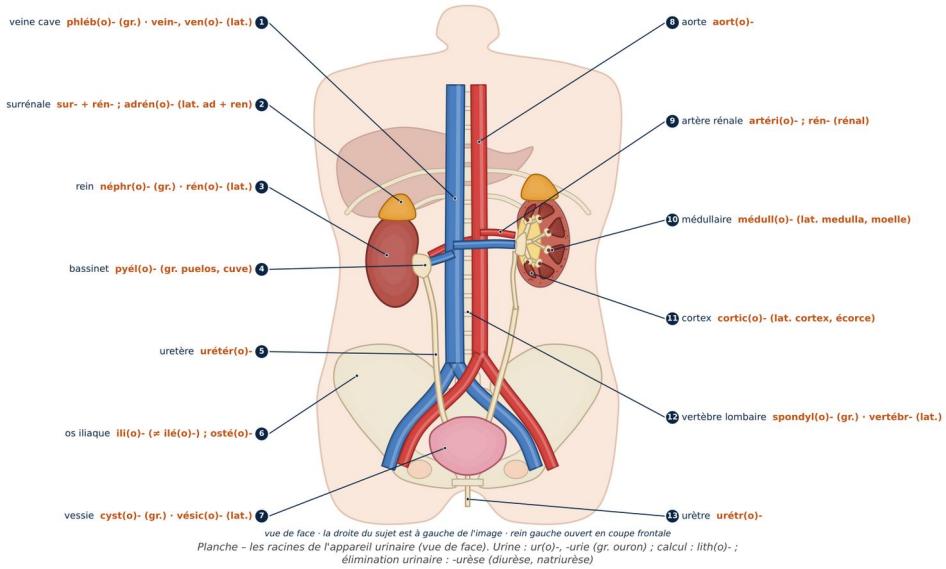


Fig. 29.19. Planche – les racines de l'appareil urinaire (vue de face) ; urine : ur(o)-, -urie ; calcul : lith(o)- ; élimination urinaire : -urèse

La légende du bas donne les éléments de l'**urine** (ur(o)-, -urie : gr. *ouron*), du **calcul** (lith(o)- : lithiase, lithotritie) et de l'**élimination urinaire** (-urèse : diurèse, volume d'urine émis ; natriurèse, kaliurèse : élimination urinaire du sodium, du potassium).

Terme · Décomposition · Définition

polyurie / oligurie / anurie — *Décomposition :* poly- / oligo- / an- + -urie ; *Définition :* diurèse > 3 L / < 500 mL / < 100 mL par 24 h (adulte)

pollakiurie — *Décomposition :* pollaki- + -urie ; *Définition :* mictions trop fréquentes (cystite, grossesse)

dysurie — *Décomposition :* dys- + -urie ; *Définition :* difficulté à uriner (obstacle prostatique)

nycturie — *Décomposition :* nyct- (nuit) + -urie ; *Définition :* mictions nocturnes

hématurie, pyurie — *Décomposition :* hémat- / py- + -urie ; *Définition :* sang / pus (leucocytes) dans les urines

glycosurie, cétonurie — *Décomposition :* glycos- / céton- + -urie ; *Définition :* glucose / corps cétoniques dans les urines (diabète déséquilibré, jeûne)

protéinurie, albuminurie — *Décomposition :* protéin- / albumin- + -urie ; *Définition :* protéines / albumine dans les urines ; microalbuminurie (30 à 300 mg/24 h) : signe précoce de néphropathie diabétique

azotémie, urémie — *Décomposition :* azot- / ur- + -émie ; *Définition :* concentration sanguine des déchets azotés, de l'urée (insuffisance rénale)

néphrolithiase — *Décomposition :* néphr- + lith- + -iase ; *Définition :* calculs du rein ; la colique néphrétique est la douleur aiguë qu'ils provoquent

glomérulonéphrite — *Décomposition :* glomérul- + néphr- + -ite ; *Définition :* inflammation des glomérules du rein

néphropathie — *Décomposition :* néphr- + -pathie ; *Définition :* maladie du rein (diabétique, hypertensive)

hémodialyse, dialyse péritonéale — *Décomposition :* hémo- + dia- (à travers) + -lyse ; *Définition :* épuration du sang à travers une membrane artificielle / à travers le péritoine (chapitre 34)

natriurèse, kaliurèse — *Décomposition :* natri- / kali- + -urèse ; *Définition :* quantité de sodium, de potassium éliminée dans les urines (mmol/24 h)

énurésie — *Décomposition :* en- + ourêsis ; *Définition :* émission involontaire d'urine, notamment nocturne chez l'enfant

Le système endocrinien

Le système endocrinien (chapitre 13) et le métabolisme (chapitres 20 et 21) fournissent le vocabulaire des pathologies endocriniennes et métaboliques du chapitre 36 (diabètes, dyslipidémies, obésité, hyperuricémie). Les glandes ont des racines souvent **descriptives** (forme, position) ; les hormones et les substances ont des noms formés de leur **source** ou de leur **effet**.

Comprendre le schéma – figure 29.20

Hypothalamus : hypo- + thalamus, « sous le thalamus » ; **hypophyse** : hypo- + *phusis*, « pousse en dessous » (elle est appendue sous le cerveau) ; **épiphyse** : épi- + *phusis*, « pousse au-dessus » (glande pinéale, mélatonine) ; **thyroïde** : thyr(o)-, thyré(o)- (gr. *thureos*, grand bouclier, + -oïde, en

forme de) ; **parathyroïdes** : para-, « à côté de » la thyroïde ; **thymus** : thym(o)- ; **îlots du pancréas** : l'**insuline** tient son nom des îlots (lat. *insula*, île) de Langerhans ; **surrénale** : adrén(o)-, cortic(o)- (cortex : cortisol, corticoïdes) et médull(o)- (médullosurrénale : adrénaline) ; **gonades** : gon(o)- (gr. *gonê*, semence), orchi(d)(o)- (testicule), ovari(o)- (ovaire). Le cœur, l'estomac, le rein et l'intestin sont aussi des glandes endocrines : **peptide natriurétique** (natri-, sodium + -urèse : il augmente l'élimination urinaire du sodium), **gastrine** (gastr- + -ine), **érythropoïétine** (érythr(o)- + -poïèse : elle stimule la production des hématies), **entérohormones** (entér(o)- : CCK, sécrétine, GLP-1).

La légende du bas rappelle que **-crine** vient du grec *krinein*, séparer, d'où sécréter (endocrine, exocrine), que **hormone** vient de *hormân*, exciter, et que **-trope** signifie « qui agit sur » (hormones gonadotropes, corticotrope, thyréotrope).

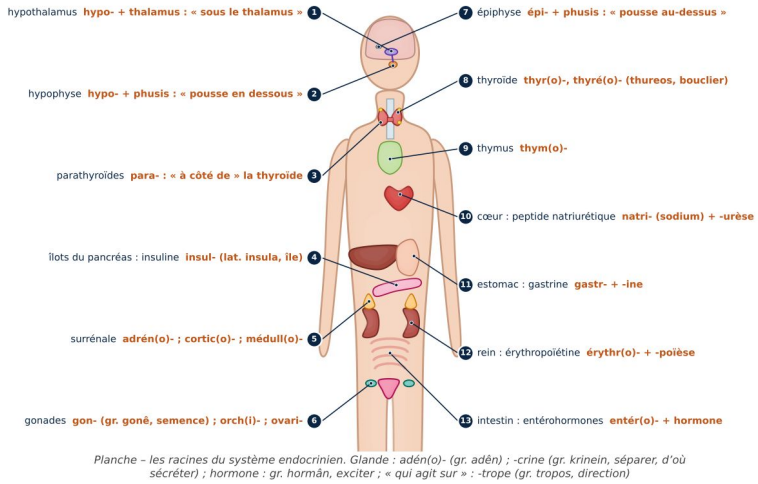


Fig. 29.20. Planche – les racines du système endocrinien ; glande : adén(o)- ; -crine : sécréter ; hormone : gr. hormân, exciter ; « qui agit sur » : -trope

Racine · Sens · Termes formés

adén(o)- — *Sens :* glande ; ganglion lymphatique ; *Termes formés :* adénome (hypophysaire, thyroïdien), adénocarcinome, adénopathie (ganglion augmenté de volume)

thyr(o)-, thyré(o)- — *Sens :* thyroïde ; *Termes formés :* hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdectomie, thyréotrope (TSH), thyroxine

gluc(o)-, glyc(o)- — *Sens :* sucre, glucose ; *Termes formés :* glycémie, glycosurie, glucagon, glycogène, néoglucogenèse, glycolyse, hémoglobine glyquée (HbA1c)

insulin(o)- — *Sens :* insuline ; *Termes formés :* insulinothérapie, insulinorésistance, insulinopénie, insulinome (tumeur sécrétant de l'insuline)

lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)- — *Sens :* graisse ; *Termes formés :* lipémie, dyslipidémie, lipolyse, lipome ; adipocyte, adiposité ; stéatose, stéatorrhée

cholestérol- — *Sens :* cholestérol (*kholê* + *stereos*, solide) ; *Termes formés :* hypercholestérolémie, hypocholestérolémiant

triglycérid- — *Sens :* triglycérides ; *Termes formés :* hypertriglycéridémie

prot(é)-, protid- — *Sens :* protéines ; *Termes formés :* protéinurie, protidémie, hypoprotidémie, protéolyse

album- — *Sens :* albumine (lat. *albus*, blanc : le blanc d'œuf) ; *Termes formés :* albuminémie, hypoalbuminémie, albuminurie

azot(o)-, ur(é)- — *Sens :* azote, urée ; *Termes formés :* azotémie, urémie, hyperuricémie (acide urique : goutte)

céton- — *Sens :* corps cétoniques ; *Termes formés :* cétose, cétonémie, cétonurie, acidocétose diabétique, cétogène

natri-, kali-, calc-, phosph-, magnés- — *Sens :* sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium ; *Termes formés :* natrémie, kaliémie, calcémie, phosphatémie, magnésémie ; hyperkaliémie de l'insuffisance rénale

sidér(o)-, ferr- — *Sens :* fer ; *Termes formés :* sidérémie, sidéropénie ; ferritine, ferriprive

hydr(o)- — *Sens :* eau ; *Termes formés :* déshydratation, hyperhydratation, hydrique

osm- — *Sens :* pression osmotique ; *Termes formés :* osmolarité, osmorécepteur, hyperosmolaire

-trophine, -trope — *Sens :* qui agit sur ; *Termes formés :* gonadotrophine, corticotrophine (ACTH), thyréotrope

-crine — *Sens :* sécrétion ; *Termes formés :* endocrine, exocrine, paracrine, endocrinologie

Le système nerveux et les organes des sens

Le système nerveux (chapitre 14) et les organes des sens fournissent le vocabulaire du chapitre 37 (AVC, maladies neuroévolutives, épilepsie, maladies du neurone moteur) et de nombreux signes qui retentissent sur l'alimentation : **dysphagie**, **aphasie**, **hémiplégie**, **troubles cognitifs**, **agueusie** (perte du goût), **anosmie** (perte de l'odorat).

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 29.21

La coupe **sagittale** (dans le plan antéro-postérieur médian, voir 29.3.6) montre : le **cortex cérébral** : cérébr(o)- (lat. *cerebrum*) et cortic(o)- (écorce) ; un **ventricule** cérébral, cavité contenant le liquide cérébrospinal (son excès est une **hydrocéphalie** : hydr- + céphal-) ; l'**hypothalamus** (hypo- + thalam-) ; le **chiasma optique** (opt-, vision ; *chiasma*, croisement en forme de X) ; l'**hypophyse** ; le **bulbe rachidien** (rach(i)-, colonne vertébrale), qui contient les centres de la déglutition et de la respiration ; la **moelle épinière** : **myél(o)-** (gr. *muelos*, moelle : myélite) ; le **lobe pariétal** (lat. *paries*, paroi) et le **lobe occipital** (lat. *occiput*, derrière de la tête) ; le **thalamus** (gr. *thalamos*, chambre) ; l'**épiphyse** ; le **mésencéphale** (més(o)- + encéphal-, « encéphale du milieu ») ; le **cervelet** (lat. *cerebellum*, petit cerveau : cérébelleux).

La légende du bas ajoute **encéphal(o)-** (en-, dans, + *kephalê*, tête : l'encéphale est « ce qui est dans la tête » : encéphalite, encéphalopathie), **céphal(o)-** (céphalée), **neur(o)-** et **méning(o)-** (les méninges, enveloppes du système nerveux central : méningite).

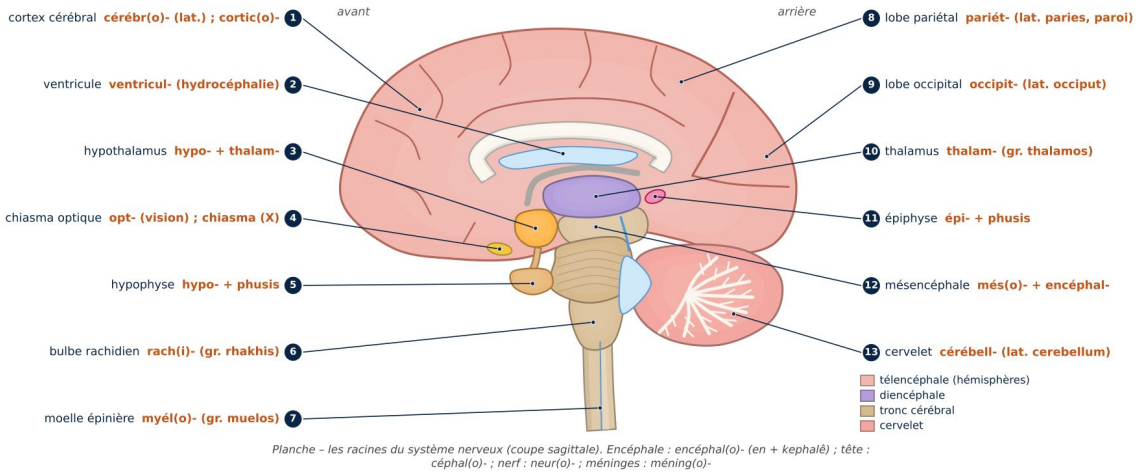


Planche – les racines du système nerveux (coupe sagittale). Encéphale : encéphal(o)- (en + kephalê) ; tête : céphal(o)- ; nerf : neur(o)- ; méninges : méning(o)-

Fig. 29.21. Planche – les racines du système nerveux (coupe sagittale) ; encéphale : encéphal(o)- ; tête : céphal(o)- ; nerf : neur(o)- ; méninges : méning(o)-

Racine ou suffixe · Sens · Termes formés

neur(o)-, névr(o)- — *Sens :* nerf, système nerveux ; *Termes formés :* neurologie, neurone, neuropathie (diabétique, alcoolique), névralgie, névrite

encéphal(o)-, cérébr(o)- — *Sens :* encéphale, cerveau ; *Termes formés :* encéphalopathie (hépatique, de Gayet-Wernicke), électroencéphalogramme ; accident vasculaire cérébral (AVC)

myél(o)- — *Sens :* moelle épinière (et osseuse) ; *Termes formés :* myélite, myéline (gaine des fibres nerveuses), démyélinisation

méning(o)- — *Sens :* méninges ; *Termes formés :* méningite

psych(o)- — *Sens :* esprit ; *Termes formés :* psychiatrie, psychologie, psychotrope, psychomoteur

-plégie, -parésie — *Sens :* paralysie complète, partielle ; *Termes formés :* hémiplégie (une moitié du corps), paraplégie (membres inférieurs), tétraplégie (quatre membres), hémiparésie

-phasie — *Sens :* langage ; *Termes formés :* aphasie (perte du langage par lésion cérébrale), dysphasie

-arthrie — *Sens :* articulation des mots (gr. *arthron*) ; *Termes formés :* dysarthrie (difficulté à articuler, par atteinte motrice)

-praxie, -gnosie — *Sens :* action ; reconnaissance ; *Termes formés :* apraxie (incapacité à réaliser un geste) ; agnosie (incapacité à reconnaître un objet, un visage)

-mnésie — *Sens :* mémoire ; *Termes formés :* amnésie, troubles mnésiques (maladie d'Alzheimer)

kinés(i)- — *Sens :* mouvement ; *Termes formés :* bradykinésie, dyskinésie, akinésie (maladie de Parkinson)

-esthésie — *Sens :* sensibilité ; *Termes formés :* anesthésie, paresthésie, hypoesthésie

ophtalm(o)-, ocul-, opt- — *Sens :* œil, vision ; *Termes formés :* ophtalmologie, xérophtalmie (sécheresse de l'œil, carence en vitamine A), rétinopathie diabétique

ot(o)-, audi(o)- — *Sens :* oreille, audition ; *Termes formés :* otite, oto-rhino-laryngologie (ORL), audiogramme

olfact(o)-, -osmie — *Sens :* odorat ; *Termes formés :* olfactif ; anosmie (perte de l'odorat, qui diminue le plaisir alimentaire)

-geusie — *Sens :* goût (gr. *geusis*) ; *Termes formés :* agueusie, dysgueusie (goût métallique sous chimiothérapie)

La peau et les phanères

La peau (chapitre 11) fournit le vocabulaire des signes cutanés de carence et de dénutrition (peau sèche, ongles cassants, cheveux fins, escarres, retard de cicatrisation) et celui des allergies (urticaire, eczéma, œdème de Quincke).

Comprendre le schéma – figure 29.22

La coupe montre les trois couches de la peau : **épiderme** (épi- + derme, « sur le derme »), **derme** et **hypoderme** (« sous le derme », riche en **adipocytes** : adip(o)- en latin, lip(o)- en grec). Légendes : **couche cornée** : kérat(o)- (gr. *keras*, corne : kératine, kératinocyte, hyperkératose) ; **mélanocyte** : mélan(o)- (noir) + -cyte ; jonction épiderme-derme ; **fibroblaste** : fibr(o)- (fibre) + -blaste (cellule qui forme : il synthétise le collagène) ; **veinule** et **artériole** (-ule, -ole, diminutifs) ; **poil** : trich(o)- (gr.), pil(o)- (lat.) ; **corpuscule sensitif** : -esthésie (sensibilité) ; **glande sébacée** : séb(o)- (lat. *sebum*, suif) ; **muscle lisse** horripilateur : my(o)- et léio- (lisse : léiomyome) ; **nerf** : neur(o)-, névr(o)- ; **glande sudoripare** : sudor- (lat.), hidr(o)- (gr. : anhidrose, absence de sueur).

Terme · Décomposition ou origine · Définition
dermatologie, dermite (dermatite) — *Décomposition ou origine :* dermat- + -logie, -ite ; *Définition :* spécialité de la peau ; inflammation de la peau
érythème — *Décomposition ou origine :* gr. *eruthros*, rouge ; *Définition :* rougeur de la peau qui s'efface à la pression
prurit — *Décomposition ou origine :* lat. *prurire*, démanger ; *Définition :* démangeaison (cholestase, insuffisance rénale, allergie)

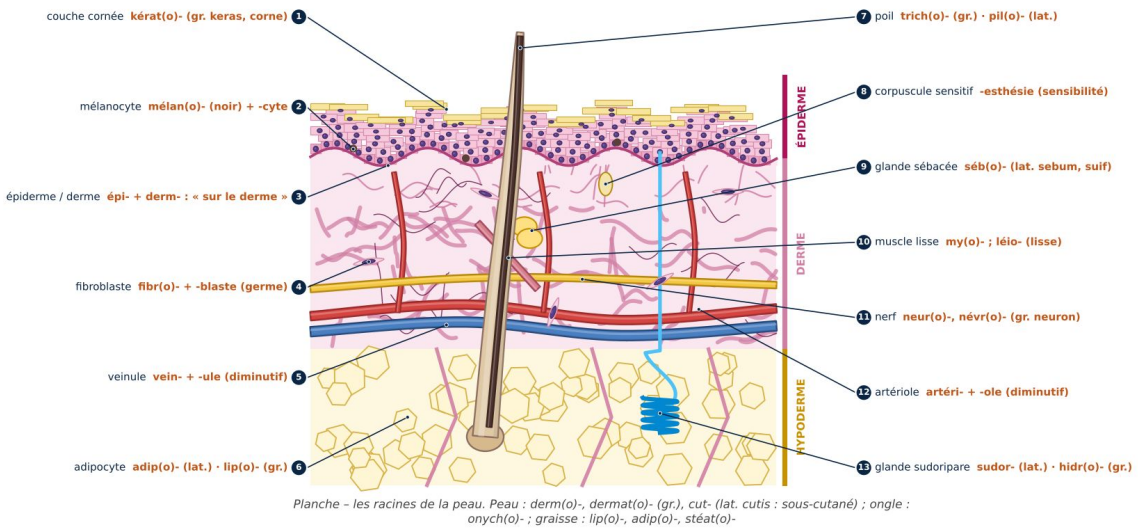


Planche – les racines de la peau. Peau : derm(o)-, dermat(o)- (gr.), cut- (lat. cutis : sous-cutané) ; ongle : onych(o)- ; graisse : lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-

Fig. 29.22. Planche – les racines de la peau ; peau : derm(o)-, dermat(o)- (gr.), cut- (lat.) ; ongle : onych(o)- ; graisse : lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-

urticaire — *Décomposition ou origine :* lat. *urtica*, ortie ; *Définition :* éruption de plaques rouges et gonflées qui démangent (allergie alimentaire possible)

œdème de Quincke — *Décomposition ou origine :* éponyme ; *oidêma*, gonflement ; *Définition :* gonflement brutal de la face et des muqueuses (allergie grave)

escarre — *Décomposition ou origine :* gr. *eskhara*, croûte ; *Définition :* plaie par nécrose de la peau et des tissus comprimés (alitement) ; la dénutrition en favorise l'apparition et retarde la cicatrisation

xérose — *Décomposition ou origine :* gr. *xêros*, sec, + -ose ; *Définition :* sécheresse de la peau

onychopathie — *Décomposition ou origine :* onych- (ongle) + -pathie ; *Définition :* maladie des ongles ; koïlonychie : ongles en cuillère de la carence en fer

alopécie — *Décomposition ou origine :* gr. *alôpex*, renard (qui perd ses poils) ; *Définition :* chute des cheveux (chimiothérapie, carence en fer ou en zinc, dénutrition)

cyanose — *Décomposition ou origine :* cyan- + -ose ; *Définition :* coloration bleutée de la peau et des muqueuses

ictère, subictère — *Décomposition ou origine :* gr. *ikteros* ; *Définition :* coloration jaune de la peau et des muqueuses (bilirubine) ; jaune visible seulement aux conjonctives

pâleur — *Décomposition ou origine :* — ; *Définition :* décoloration de la peau et des muqueuses (anémie)

sous-cutané (SC), transcutané — *Décomposition ou origine :* sous- / trans- + cut- ; *Définition :* sous la peau (injection d'insuline) ; à travers la peau

L'appareil locomoteur

L'appareil **locomoteur** (os, articulations, cartilages, muscles, tendons) et les **membres** ont des racines que le guide inclut dans sa liste : arthr(o)-, chondr(o)-, osté(o)-, my(o)-, sarc(o)-, tendin(o)-, spondyl(o)-, rach(i)-, disc(o)-, crâni(o)-,

céphal(o)-, brachi(al), chir(o)-, dactyl(o)-, cox(o)-, pod(o)-, pédi-, cost(o)-, kinés-, sthén(o)-. Elles intéressent le diététicien en gériatrie (ostéoporose, sarcopénie, chutes), en rhumatologie (goutte, polyarthrite) et en rééducation.

Comprendre le schéma – figure 29.23

Dix cartes regroupent les racines par structure. **Os** : osté(o)- (gr. *osteon* : ostéoporose, ostéomalacie, ostéite, ostéodensitométrie ; ostéoblaste, ostéoclaste). **Articulation** : arthr(o)- (arthrite, arthrose, arthralgie, arthroscopie, polyarthrite). **Cartilage** : chondr(o)- (chondrocyte, chondrocalcinose, chondrome). **Muscle** : my(o)- (myalgie, myopathie, myocarde) et sarc(o)- (gr. *sarx*, chair : **sarcopénie**, la perte de masse et de force musculaires du sujet âgé ; sarcome ; sarcomère, l'unité contractile). **Tendon** : tendin(o)-, tén(o)- (tendinite, ténotomie). **Colonne** : spondyl(o)- (vertèbre : spondylarthrite), rach(i)- (rachis, rachialgie) et disc(o)- (discopathie, hernie discale). **Tête** : crâni(o)-, céphal(o)- (craniopharyngiome, céphalée, hydrocéphalie). **Membre supérieur** : brachi- (lat. *brachium*, bras : artère brachiale), chir(o)- (gr. *kheir*, main : **chirurgie**, « travail de la main »), dactyl(o)- (doigt : polydactylie). **Membre inférieur** : cox(o)- (lat. *coxa*, hanche : coxarthrose), pod(o)- (gr. *pous*, pied : podologue), pédi- (lat. *pes, pedis* : artère pédieuse). **Mouvement et force** : kinés- (kinésithérapie, dyskinésie) et sthén(o)- (gr. *sthenos*, force : **asthénie**, fatigue ; **myasthénie**, faiblesse musculaire d'origine auto-immune).

La ligne rouge du bas signale un piège : **pédi-** a deux origines, le latin *pes* (pied : pédicure) et le grec *pais, paidos* (enfant : **pédiatrie**).

L'appareil génital et la reproduction

L'appareil **génital** et la **reproduction** concernent le diététicien en périnatalité (chapitre 27 : grossesse, allaitement), en cancérologie (cancers du sein, de l'utérus, de l'ovaire, de la prostate) et en endocrinologie (ménopause, syndrome des ovaires polykystiques). Les racines du guide concernées sont andr(o)-, gynéc(o)-, hystér(o)-, métr(o)-, colp(o)-, vagin(o)-, salping(o)-, ovari(o)-, orchid(o)-, sperm(o)-, gon(o)-, mamm(o)-, mast(o)-, mén(o)-, térat(o)-, et les suffixes -tocie et -pare.

Comprendre le schéma – figure 29.24

Femme : gynéc(o)- (gr. *gunê* : gynécologie ; gynécomastie, développement des seins chez l'homme ; obésité **gynoïde**, de répartition féminine, sur les hanches et les cuisses). **Homme** : andr(o)- (gr. *anêr, andros* : andrologie, androgène ; obésité **androïde**, abdominale, plus liée au risque cardiométabolique). **Utérus** : hystér(o)- (hystérectomie, hystéroscopie) et métr(o)- (gr. *mêtra* : **métrorragie**, endomètre, endométriose). **Vagin, trompe** : colp(o)- (colposcopie), vagin(o)- (lat. *vagina*, gaine) ; salping(o)- (gr. *salpinx*, trompette : salpingite). **Ovaire, testicule** : ovari(o)- (ovariectomie), orchi(d)(o)- (orchite, orchidectomie). **Sein** : mast(o)- (gr. : mastite, mastectomie) et mamm(o)- (lat. : mammaire, mammographie). **Règles** : mén(o)- (gr. *mên*, mois : ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie). **Accouchement** : -tocie (gr. *tokos* : dystocie, accouchement difficile ; eutocie ; **ocytocine**, l'hormone qui accélère l'accouchement et l'éjection du lait, de *ôkus*, rapide) et -pare (lat. *parere*, enfanter : nullipare, primipare, multipare). **Semence, germe** : sperm(o)- (spermatozoïde, oligospermie) et gon(o)- (gonade, gonadotrophine). **Développement** : -genèse (ovogenèse, spermatogenèse) et térat(o)- (gr. *teras*, monstre : **tératogène**, qui provoque des malformations : alcool, isotrétinoïne, excès de vitamine A).

La ligne rouge du bas distingue **métr(o)-** (utérus : métrorragie) et **-métrie** (mesure : densitométrie).

Terme · Définition · Intérêt diététique

primipare, multipare, nullipare — *Définition :* femme qui accouche pour la première fois, qui a déjà accouché plusieurs fois, qui n'a jamais accouché ; *Intérêt diététique :* parité et risque de carence en fer, de diabète gestationnel

gravide, primigeste — *Définition :* enceinte ; enceinte pour la première fois (lat. *gravidus*, *gestare*) ; *Intérêt diététique :* hyperémèse gravidique, diabète gestationnel

aménorrhée — *Définition :* absence de règles ; *Intérêt diététique :* aménorrhée de l'anorexie mentale ou de l'athlète (déficit énergétique)

dysménorrhée, ménorragie — *Définition :* règles douloureuses ; trop abondantes ; *Intérêt diététique :* ménorragies : carence en fer

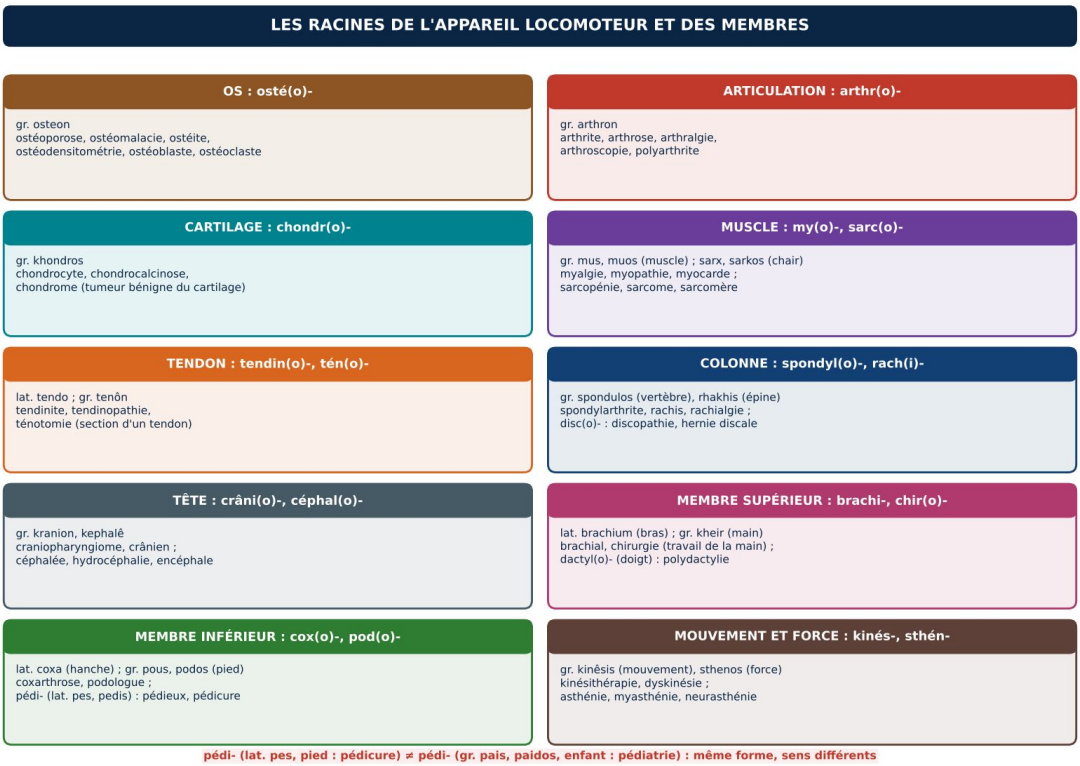


Fig. 29.23. Les racines de l'appareil locomoteur et des membres : chaque racine se combine aux suffixes des maladies (-ite, -ose, -algie), des examens (-scopie) et des actes (-tomie)

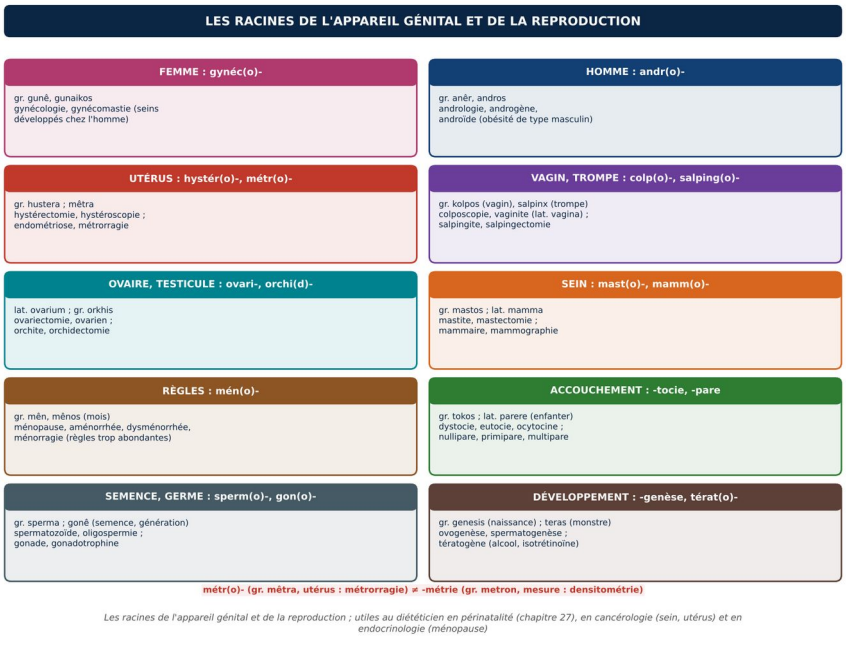


Fig. 29.24. Les racines de l'appareil génital et de la reproduction ; utiles au diététicien en périnatalité (chapitre 27), en cancérologie (sein, utérus) et en endocrinologie (ménopause)

ménopause — *Définition :* arrêt définitif des règles ; *Intérêt diététique :* ostéoporose, prise de poids abdominale, prévention cardiovasculaire

mastectomie, tumorectomie — *Définition :* ablation du sein ; ablation de la seule tumeur ; *Intérêt diététique :* prise en charge nutritionnelle du cancer du sein

tératogène — *Définition :* qui provoque des malformations chez l'embryon ; *Intérêt diététique :* zéro alcool ; pas d'excès de vitamine A (foie) pendant la grossesse

eutocie, dystocie — *Définition :* accouchement normal ; difficile ; *Intérêt diététique :* macrosomie fœtale du diabète gestationnel : risque de dystocie

post-partum — *Définition :* période qui suit l'accouchement ; *Intérêt diététique :* allaitement, retour au poids antérieur

Les racines générales : substances, états, fonctions

Un dernier groupe de racines ne désigne pas un organe mais une **cellule**, un **tissu**, un **processus pathologique**, un **agent** (microbe, chaleur, rayonnement) ou une **notion générale** de médecine. On les retrouve dans tous les chapitres de physiopathologie.

Racine · Sens · Termes formés

cyt(o)-, -cyte — *Sens :* cellule ; *Termes formés :* cytologie (étude des cellules), cytoplasme, cytotoxique, cytolyse hépatique (élévation des transaminases)

caryo-, nuclé(o)- — *Sens :* noyau ; *Termes formés :* caryotype, polynucléaire, nucléotide

hist(o)- — *Sens :* tissu ; *Termes formés :* histologie, histopathologie (examen d'un tissu au microscope : chapitre 30)

nécr(o)- — *Sens :* mort ; *Termes formés :* nécrose (mort cellulaire non programmée, avec inflammation), nécropsie (autopsie)

onc(o)-, carcin(o)-, cancér(o)-, tumor(o)- — *Sens :* tumeur, cancer ; *Termes formés :* oncologie, oncogène, carcinome, cancérogène, cancérologie, tumorectomie

-plasie, néo- — *Sens :* formation ; nouveau ; *Termes formés :* néoplasie, dysplasie, métaplasie, hyperplasie

scléro-, fibr(o)- — *Sens :* dur ; fibre ; *Termes formés :* sclérose, fibrose (hépatique, pulmonaire), fibroscopie

py(o)- — *Sens :* pus ; *Termes formés :* pyurie, pyogène (germe qui produit du pus), empyème

pyr(o)-, pyrét(o)- — *Sens :* feu, fièvre ; *Termes formés :* pyrexie (fièvre), apyrexie, antipyrétique

myc(o)- — *Sens :* champignon ; *Termes formés :* mycose, mycotoxine, antimycosique (antifongique)

bactéri-, vir-, parasit- — *Sens :* bactérie, virus, parasite ; *Termes formés :* bactériémie, virémie, parasitose, bactéricide

sér(o)- — *Sens :* sérum ; séreuse ; *Termes formés :* sérologie (recherche d'anticorps), séropositif, séreuse (plèvre, péritoine)

lymph(o)- — *Sens :* lymphe ; *Termes formés :* lymphocyte, lymphome, lymphœdème, adénopathie

immun(o)- — *Sens :* immunité (lat. *immunis*, exempt) ; *Termes formés :* immunodépression, immunothérapie, immunoglobuline, auto-immunité

all(o)-, -ergie — *Sens :* autre ; réaction (gr. *ergon*, action) ; *Termes formés :* allergie, allergène, anergie (chapitre 39)

nos(o)- — *Sens :* maladie ; *Termes formés :* nosocomial (infection contractée à l'hôpital, gr. *nosokomeion*), nosologie

iatr(o)- — *Sens :* médecin ; *Termes formés :* iatrogène, pédiatrie, gériatrie

chimi(o)-, radi(o)- — *Sens :* substances chimiques ; rayonnement ; *Termes formés :* chimiothérapie, radiothérapie, radiographie, radiologie

bar(o)- — *Sens :* poids, pression ; *Termes formés :* chirurgie bariatrique (de l'obésité), barorécepteur (pression artérielle)

oxy- — *Sens :* oxygène ; aigu, acide ; *Termes formés :* hypoxie, oxymétrie de pouls (saturation en O_2 : SpO_2) ; cellules oxyntiques (acide de l'estomac)

therm(o)- — *Sens :* chaleur ; *Termes formés :* hypothermie, hyperthermie, thermogenèse

psych(o)-, -somat- — *Sens :* esprit ; corps ; *Termes formés :* psychosomatique, somatique

térat(o)- — *Sens :* malformation ; *Termes formés :* tératogène

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Décomposez et définissez : **a)** pyélonéphrite ; **b)** cystoscopie ; **c)** hypoalbuminémie ; **d)** acidocétose ; **e)** hémiparésie ; **f)** agueusie ; **g)** coxarthrose ; **h)** sarcopénie ; **i)** métrorragie ; **j)** histopathologie.

CORRIGÉ

a) pyél- (bassinet) + o + néphr- (rein) + -ite : **infection du bassinet et du rein** (complication d'une infection urinaire). **b)** cyst- (vessie) + o + -scopie : **examen visuel de l'intérieur de la vessie**. **c)** hypo- + albumin- + -émie : **concentration d'albumine trop basse dans le sang** (< 35 g/L). **d)** acido- + cét- + -ose : **acidose due à une accumulation de corps cétoniques** (diabète de type 1 en carence d'insuline). **e)** hémi- + -parésie : **paralysie partielle d'une moitié du corps**.

f) a- + -geusie (goût) : **perte du goût**. **g)** cox- (hanche) + arthr- + -ose : **arthrose de la hanche**. **h)** sarc- (chair, muscle) + o + -pénie : **diminution de la masse et de la force musculaires** (European Working Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP2, 2019). **i)** métr- (utérus) + o + -rragie : **saignement de l'utérus en dehors des règles**. **j)** hist- (tissu) + o + path- + -logie : **étude des lésions des tissus au microscope** (anatomopathologie).

Tableau complet des racines du guide

Le tableau suivant reprend, dans l'ordre alphabétique, les **135 racines** de la liste indicative du guide d'accompagnement 2025 (la liste écrit « natrri » pour natri-), avec leur origine, leur sens et des exemples. Les formes entre parenthèses indiquent la voyelle de liaison ou une variante (hém(o)-, hémat(o)-). C'est le tableau de référence des révisions ; les mêmes racines figurent, classées par appareil, dans les planches et les tableaux précédents.

Racine · Origine · Sens · Exemples

adén(o)- — *Origine :* gr. *adên*, glande ; *Sens :* glande ; ganglion ; *Exemples :* adénome, adénocarcinome, adénopathie

adip(o)- — *Origine :* lat. *adeps, adipis*, graisse ; *Sens :* graisse ; *Exemples :* adipocyte, adipeux, adiposité

andr(o)- — *Origine :* gr. *anêr, andros*, homme ; *Sens :* homme, masculin ; *Exemples :* androgène, andropause, androïde

angi(o)- — *Origine :* gr. *angeion*, vase ; *Sens :* vaisseau ; *Exemples :* angiographie, angioplastie, angiome

appendic(o)- — *Origine :* lat. *appendix* ; *Sens :* appendice ; *Exemples :* appendicite, appendicectomie

artéri(o)- — *Origine :* gr. *artêria* ; *Sens :* artère ; *Exemples :* artériosclérose, artériopathie, artériographie

arthr(o)- — *Origine :* gr. *arthron*, articulation ; *Sens :* articulation ; *Exemples :* arthrite, arthrose, arthroscopie

athér(o)- — *Origine :* gr. *athêra*, bouillie ; *Sens :* dépôt lipidique de la paroi artérielle ; *Exemples :* athérome, athérosclérose

audi(o)- — *Origine :* lat. *audire*, entendre ; *Sens :* audition ; *Exemples :* audiogramme, audiométrie

auricul(o)- — *Origine :* lat. *auricula*, petite oreille ; *Sens :* oreille ; oreillette du cœur ; *Exemples :* auriculaire, auriculo-ventriculaire

azot(o)- — *Origine :* fr. azote (gr. *a-* et *zôê*, sans vie) ; *Sens :* azote, déchets azotés (urée) ; *Exemples :* azotémie, azoturie

bar(o)- — *Origine :* gr. *baros*, poids ; *Sens :* poids ; pression ; *Exemples :* bariatrique ; barorécepteur

brachi(al) — *Origine :* lat. *brachium*, bras ; *Sens :* bras ; *Exemples :* artère brachiale, plexus brachial

bronch(o)- — *Origine :* gr. *bronkhos*, gorge ; *Sens :* bronche ; *Exemples :* bronchite, bronchoscopie, bronchectasie

bucc(o)- — *Origine :* lat. *bucca*, joue ; *Sens :* bouche, joue ; *Exemples :* buccal, bucco-dentaire

cancér(o)- — *Origine :* lat. *cancer*, crabe ; *Sens :* cancer ; *Exemples :* cancérologie, cancérogène

carcin(o)- — *Origine :* gr. *karkinos*, crabe ; *Sens :* cancer (d'origine épithéliale) ; *Exemples :* carcinome, adénocarcinome

cardi(o)- — *Origine :* gr. *kardia*, cœur ; *Sens :* cœur ; cardia (orifice supérieur de l'estomac) ; *Exemples :* cardiologie, cardiopathie, tachycardie

céphal(o)- — *Origine :* gr. *kephalê*, tête ; *Sens :* tête ; *Exemples :* céphalée, hydrocéphalie, encéphale

cérébr(o)- — *Origine :* lat. *cerebrum*, cerveau ; *Sens :* cerveau ; *Exemples :* cérébral, accident vasculaire cérébral

cervic(o)- — *Origine :* lat. *cervix, cervicis*, cou ; *Sens :* cou ; col de l'utérus ; *Exemples :* cervicalgie, cancer du col (cervical)

chimi(o)- — *Origine :* gr. *khêmeia*, arabe *al-kîmiyâ* ; *Sens :* substances chimiques ; *Exemples :* chimiothérapie, chimiorécepteur

chir(o)- — *Origine :* gr. *kheir*, main ; *Sens :* main ; *Exemples :* chirurgie (travail de la main)

chol(é)- — *Origine :* gr. *kholê*, bile ; *Sens :* bile ; *Exemples :* cholestase, cholestérol, cholangite

cholécyst(o)- — *Origine :* gr. *kholê*, bile, et *kustis*, vessie ; *Sens :* vésicule biliaire ; *Exemples :* cholécystite, cholécystectomie

chondr(o)- — *Origine :* gr. *khondros*, cartilage ; *Sens :* cartilage ; *Exemples :* chondrocyte, chondrocalcinose

cœli(o)- — *Origine :* gr. *koilia*, ventre ; *Sens :* cavité abdominale ; *Exemples :* cœlioscopie, tronc cœliaque, maladie cœliaque

col(o)- — *Origine :* gr. *kolon* ; *Sens :* côlon ; *Exemples :* colite, colectomie, colostomie, coloscopie

colp(o)- — *Origine :* gr. *kolpos*, creux, vagin ; *Sens :* vagin ; *Exemples :* colposcopie

coronar(o)- — *Origine :* lat. *corona*, couronne ; *Sens :* artères coronaires ; *Exemples :* coronarographie, coronarien

cost(o)- — *Origine :* lat. *costa*, côte ; *Sens :* côte ; *Exemples :* intercostal, costal

cox(o)- — *Origine :* lat. *coxa*, hanche ; *Sens :* hanche ; *Exemples :* coxarthrose, coxalgie

crâni(o)- — *Origine :* gr. *kranion*, crâne ; *Sens :* crâne ; *Exemples :* crânien, craniopharyngiome

cyst(o)- — *Origine :* gr. *kustis*, vessie, poche ; *Sens :* vessie ; poche ; *Exemples :* cystite, cystoscopie ; kyste

cyt(o)- — *Origine :* gr. *kutos*, cavité, cellule ; *Sens :* cellule ; *Exemples :* cytologie, cytoplasme, cytotoxique

dactyl(o)- — *Origine :* gr. *daktulos*, doigt ; *Sens :* doigt ; *Exemples :* polydactylie, syndactylie

derm(o)-, dermat(o)- — *Origine :* gr. *derma, dermatos*, peau ; *Sens :* peau ; *Exemples :* dermatologie, dermite, épiderme

disc(o)- — *Origine :* gr. *diskos*, disque ; *Sens :* disque intervertébral ; *Exemples :* discopathie, hernie discale

duodén(o)- — *Origine :* lat. *duodeni*, douze ; *Sens :* duodénum ; *Exemples :* duodénite, ulcère duodénal

entér(o)- — *Origine :* gr. *enteron*, intestin ; *Sens :* intestin ; *Exemples :* entérite, entérocyte, nutrition entérale

érythr(o)- — *Origine :* gr. *eruthros*, rouge ; *Sens :* rouge ; *Exemples :* érythrocyte, érythème, érythropoïétine

gastr(o)- — *Origine :* gr. *gastêr, gastros*, ventre ; *Sens :* estomac ; *Exemples :* gastrite, gastrectomie, gastroscopie

gingiv(o)- — *Origine :* lat. *gingiva* ; *Sens :* gencive ; *Exemples :* gingivite, gingivorragie

glomérul(o)- — *Origine :* lat. *glomus*, pelote ; *Sens :* glomérule du rein ; *Exemples :* glomérulonéphrite, débit de filtration glomérulaire

gloss(o)- — *Origine :* gr. *glôssa*, langue ; *Sens :* langue ; *Exemples :* glossite, hypoglosse

gon(o)- — *Origine :* gr. *gonos*, semence, génération ; *Sens :* semence ; glandes sexuelles ; *Exemples :* gonade, gonadotrophine, gonocoque

gynéc(o)- — *Origine :* gr. *gunê, gunaikos*, femme ; *Sens :* femme ; *Exemples :* gynécologie, gynécomastie, gynoïde

hém(o)-, hémat(o)- — *Origine :* gr. *haima, haimatos*, sang ; *Sens :* sang ; *Exemples :* hémorragie, hémoglobine, hématome, hémodialyse

hépat(o)- — *Origine :* gr. *hêpar, hêpatos*, foie ; *Sens :* foie ; *Exemples :* hépatite, hépatocyte, hépatomégalie

hist(o)- — *Origine :* gr. *histos*, toile, tissu ; *Sens :* tissu ; *Exemples :* histologie, histopathologie

hystér(o)- — *Origine :* gr. *hustera*, utérus ; *Sens :* utérus ; *Exemples :* hystérectomie, hystéroscopie

ilé(o)- — *Origine :* lat. *ileum* ; *Sens :* iléon ; *Exemples :* iléite, iléostomie, valvule iléocæcale

inguinal — *Origine :* lat. *inguen, inguinis*, aine ; *Sens :* aine ; *Exemples :* hernie inguinale, région inguinale

insulin(o)- — *Origine :* lat. *insula*, île (îlots de Langerhans) ; *Sens :* insuline ; *Exemples :* insulinothérapie, insulinorésistance, insulinome

jéjun(o)- — *Origine :* lat. *jejunus*, à jeun ; *Sens :* jéjunum ; *Exemples :* jéjunostomie

kali- — *Origine :* lat. sc. *kalium* (arabe *al-qalî*, cendre de plantes) ; *Sens :* potassium ; *Exemples :* kaliémie, hypokaliémie, kaliurèse

kinés(i)- — *Origine :* gr. *kinêsis*, mouvement ; *Sens :* mouvement ; *Exemples :* kinésithérapie, dyskinésie

lapar(o)- — *Origine :* gr. *lapara*, flanc ; *Sens :* paroi abdominale ; *Exemples :* laparotomie, laparoscopie

laryng(o)- — *Origine :* gr. *larunx* ; *Sens :* larynx ; *Exemples :* laryngite, laryngectomie

leuc(o)- — *Origine :* gr. *leukos*, blanc ; *Sens :* blanc ; *Exemples :* leucocyte, leucopénie, leucémie

lymph(o)- — *Origine :* lat. *lympha*, eau claire ; *Sens :* lymphe, tissu lymphoïde ; *Exemples :* lymphocyte, lymphome, lymphœdème

mamm(o)- — *Origine :* lat. *mamma*, sein ; *Sens :* sein ; *Exemples :* mammographie, glande mammaire

mast(o)- — *Origine :* gr. *mastos*, sein ; *Sens :* sein ; *Exemples :* mastectomie, mastite, mastose

médull(o)- — *Origine :* lat. *medulla*, moelle ; *Sens :* moelle ; partie centrale d'un organe ; *Exemples :* médullosurrénale, médullaire

mélan(o)- — *Origine :* gr. *melas, melanos*, noir ; *Sens :* noir ; mélanine ; *Exemples :* mélanome, mélanocyte, méléna

mén(o)- — *Origine :* gr. *mên*, mois ; *Sens :* règles ; *Exemples :* ménopause, ménorragie

métr(o)- — *Origine :* gr. *mêtra*, utérus ; *Sens :* utérus ; *Exemples :* métrorragie, endomètre, endométriose

myc(o)- — *Origine :* gr. *mukês*, champignon ; *Sens :* champignon microscopique ; *Exemples :* mycose, mycotoxine

myél(o)- — *Origine :* gr. *muelos*, moelle ; *Sens :* moelle épinière ou osseuse ; *Exemples :* myélite, myélome, myélogramme

my(o)- — *Origine :* gr. *mus, muos*, muscle ; *Sens :* muscle ; *Exemples :* myalgie, myocarde, myopathie

nas(o)- — *Origine :* lat. *nasus*, nez ; *Sens :* nez ; *Exemples :* sonde nasogastrique, nasal

natri- (« natrri » dans la liste) — *Origine :* lat. sc. *natrium* (de *natron*) ; *Sens :* sodium ; *Exemples :* natrémie, hyponatrémie, natriurèse

nécr(o)- — *Origine :* gr. *nekros*, mort ; *Sens :* mort cellulaire ou tissulaire ; *Exemples :* nécrose, nécropsie

néphr(o)- — *Origine :* gr. *nephros*, rein ; *Sens :* rein ; *Exemples :* néphrite, néphropathie, néphrectomie, néphron

névr(o)- — *Origine :* gr. *neuron*, nerf ; *Sens :* nerf ; *Exemples :* névralgie, névrite

nos(o)- — *Origine :* gr. *nosos*, maladie ; *Sens :* maladie ; *Exemples :* nosocomial, nosologie

neur(o)- — *Origine :* gr. *neuron*, nerf ; *Sens :* nerf, système nerveux ; *Exemples :* neurologie, neuropathie, neurone

nuclé(o)- — *Origine :* lat. *nucleus*, noyau ; *Sens :* noyau ; *Exemples :* nucléotide, polynucléaire

odont(o)- — *Origine :* gr. *odous, odontos*, dent ; *Sens :* dent ; *Exemples :* odontologie, orthodontie

œsophag(o)- — *Origine :* gr. *oisophagos*, qui porte ce qu'on mange ; *Sens :* œsophage ; *Exemples :* œsophagite, œsophagectomie

olfact(o)- — *Origine :* lat. *olfacere*, sentir ; *Sens :* odorat ; *Exemples :* olfactif, olfaction

onc(o)- — *Origine :* gr. *onkos*, masse ; *Sens :* tumeur ; *Exemples :* oncologie, oncogène

ophtalm(o)- — *Origine :* gr. *ophthalmos*, œil ; *Sens :* œil ; *Exemples :* ophtalmologie, xérophtalmie

orchi(d)(o)- — *Origine :* gr. *orkhis, orkhidos*, testicule ; *Sens :* testicule ; *Exemples :* orchite, orchidectomie

ostéo(o)- — *Origine :* gr. *osteon*, os ; *Sens :* os ; *Exemples :* ostéoporose, ostéomalacie, ostéoblaste

ot(o)- — *Origine :* gr. *ous, ôtos*, oreille ; *Sens :* oreille ; *Exemples :* otite, otorragie, oto-rhino-laryngologie

ovari(o)- — *Origine :* lat. *ovarium* ; *Sens :* ovaire ; *Exemples :* ovariectomie, insuffisance ovarienne

oxy- — *Origine :* gr. *oxus*, aigu, acide (d'où oxygène) ; *Sens :* oxygène ; acide ; *Exemples :* hypoxie, hypoxémie, oxymétrie ; cellules oxyntiques

pédi- — *Origine :* gr. *pais, paidos*, enfant ; lat. *pes, pedis*, pied ; *Sens :* enfant ; pied ; *Exemples :* pédiatrie ; pédicure, artère pédieuse

phag(o)- — *Origine :* gr. *phagein*, manger ; *Sens :* manger, avaler ; *Exemples :* phagocyte, dysphagie, aphagie

pharyng(o)- — *Origine :* gr. *pharunx*, gorge ; *Sens :* pharynx ; *Exemples :* pharyngite, rhinopharynx

phléb(o)- — *Origine :* gr. *phleps, phlebos*, veine ; *Sens :* veine ; *Exemples :* phlébite, phlébotomie

phrén(o)- — *Origine :* gr. *phrên*, diaphragme, esprit ; *Sens :* diaphragme ; esprit ; *Exemples :* nerf phrénique ; schizophrénie

phon(o)- — *Origine :* gr. *phônê*, voix ; *Sens :* voix, son ; *Exemples :* aphonie, dysphonie, orthophonie

pleur(o)- — *Origine :* gr. *pleura*, côté ; *Sens :* plèvre ; *Exemples :* pleurésie, épanchement pleural

-pnée — *Origine :* gr. *pnoê*, souffle ; *Sens :* respiration (élément placé par le guide parmi les racines, mais employé comme suffixe) ; *Exemples :* dyspnée, apnée, tachypnée, orthopnée

pneum(o)-, pneumon(o)- — *Origine :* gr. *pneuma*, souffle ; *pneumôn*, poumon ; *Sens :* air ; poumon ; *Exemples :* pneumothorax ; pneumonie, pneumopathie

pod(o)- — *Origine :* gr. *pous, podos*, pied ; *Sens :* pied ; *Exemples :* podologue, podologie

proct(o)- — *Origine :* gr. *prôktos*, anus ; *Sens :* anus, rectum ; *Exemples :* proctologie, proctite

psych(o)- — *Origine :* gr. *psukhê*, âme ; *Sens :* esprit, psychisme ; *Exemples :* psychologie, psychiatrie, psychotrope

pulm(o)-, pulmon- — *Origine :* lat. *pulmo, pulmonis*, poumon ; *Sens :* poumon ; *Exemples :* pulmonaire, embolie pulmonaire

pyél(o)- — *Origine :* gr. *puelos*, cuve ; *Sens :* bassinet du rein ; *Exemples :* pyélonéphrite, pyélographie

py(o)- — *Origine :* gr. *puon*, pus ; *Sens :* pus ; *Exemples :* pyurie, pyogène

pyr(o)-, pyrét(o)- — *Origine :* gr. *pur*, feu ; *puretos*, fièvre ; *Sens :* feu, fièvre ; *Exemples :* antipyrétique, apyrexie, pyrexie

rach(i)- — *Origine :* gr. *rhakhis*, épine dorsale ; *Sens :* colonne vertébrale ; *Exemples :* rachis, rachianesthésie, rachitisme

rachid(o)- — *Origine :* idem ; *Sens :* colonne vertébrale (adjectif) ; *Exemples :* bulbe rachidien, canal rachidien

radi(o)- — *Origine :* lat. *radius*, rayon ; *Sens :* rayonnement ; *Exemples :* radiographie, radiothérapie, radiologie

rect(o)- — *Origine :* lat. *rectum (intestinum)*, intestin droit ; *Sens :* rectum ; *Exemples :* rectorragie, rectite, rectoscopie

rhin(o)- — *Origine :* gr. *rhis, rhinos*, nez ; *Sens :* nez ; *Exemples :* rhinite, rhinorrhée, rhinopharynx

sagittal — *Origine :* lat. *sagitta*, flèche ; *Sens :* plan de coupe antéro-postérieur ; *Exemples :* coupe sagittale (IRM, scanner)

salping(o)- — *Origine :* gr. *salpinx*, trompette ; *Sens :* trompe (utérine ou auditive) ; *Exemples :* salpingite, salpingectomie

sarc(o)- — *Origine :* gr. *sarx, sarkos*, chair ; *Sens :* chair, muscle ; tissu conjonctif ; *Exemples :* sarcopénie, sarcomère ; sarcome

sclér(o)- — *Origine :* gr. *sklêros*, dur ; *Sens :* durcissement ; *Exemples :* sclérose, athérosclérose

sér(o)- — *Origine :* lat. *serum*, petit-lait ; *Sens :* sérum ; séreuse ; *Exemples :* sérologie, séropositif, séreuse

sial(o)- — *Origine :* gr. *sialon*, salive ; *Sens :* salive ; *Exemples :* sialorrhée, sialadénite

sidér(o)- — *Origine :* gr. *sidêros*, fer ; *Sens :* fer ; *Exemples :* sidérémie, sidéropénie

sperm(o)-, spermat(o)- — *Origine :* gr. *sperma*, semence ; *Sens :* sperme ; *Exemples :* spermatozoïde, oligospermie

spir(o)- — *Origine :* lat. *spirare*, souffler, respirer ; *Sens :* respiration ; *Exemples :* spirométrie

splén(o)- — *Origine :* gr. *splên*, rate ; *Sens :* rate ; *Exemples :* splénomégalie, splénectomie

spondyl(o)- — *Origine :* gr. *spondulos*, vertèbre ; *Sens :* vertèbre ; *Exemples :* spondylarthrite, spondylodiscite

sténo)- — *Origine :* gr. *stenos*, étroit ; *Sens :* rétrécissement ; *Exemples :* sténose, sténose aortique

sthén(o)- — *Origine :* gr. *sthenos*, force ; *Sens :* force ; *Exemples :* asthénie, myasthénie

stéat(o)- — *Origine :* gr. *stear, steatos*, suif, graisse ; *Sens :* graisse ; *Exemples :* stéatose, stéatorrhée

stomat(o)- — *Origine :* gr. *stoma, stomatos*, bouche ; *Sens :* bouche ; *Exemples :* stomatite, stomatologie

tendin(o)- — *Origine :* lat. *tendo, tendinis* ; *Sens :* tendon ; *Exemples :* tendinite, tendinopathie

térat(o)- — *Origine :* gr. *teras, teratos*, monstre ; *Sens :* malformation ; *Exemples :* tératogène, tératologie

thorac(o)- — *Origine :* gr. *thôrax*, cuirasse ; *Sens :* thorax ; *Exemples :* thoracique, thoracotomie

thromb(o)- — *Origine :* gr. *thrombos*, caillot ; *Sens :* caillot ; plaquette ; *Exemples :* thrombose, thrombocyte, thrombopénie

thym(o)- — *Origine :* gr. *thumos* ; *Sens :* thymus ; humeur ; *Exemples :* thymome ; dysthymie

trachéo- — *Origine :* gr. *trakheia (artêria)*, conduit rugueux ; *Sens :* trachée ; *Exemples :* trachéotomie, trachéite

tumor(o)- — *Origine :* lat. *tumor*, gonflement ; *Sens :* tumeur ; *Exemples :* tumoral, tumorectomie

vagin(o)- — *Origine :* lat. *vagina*, gaine ; *Sens :* vagin ; *Exemples :* vaginite, vaginal

valvul(o)- — *Origine :* lat. *valvula*, petit battant de porte ; *Sens :* valve du cœur ; *Exemples :* valvulopathie, valvuloplastie

vas(o)- — *Origine :* lat. *vas*, vase, récipient ; *Sens :* vaisseau ; *Exemples :* vasodilatation, vasoconstriction

vascul(o)- — *Origine :* lat. *vasculum*, petit vase ; *Sens :* vaisseau ; *Exemples :* vascularite, cardiovasculaire

29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique

Module · *Guide 2025 p. 99-100 et p. 18 (démarche d'étude des pathologies) · CNED : 3-2023 M1 S1 §2 (définitions)*

Santé, maladie et démarche d'étude d'une pathologie

Le guide d'accompagnement 2025 recommande d'étudier chaque pathologie selon une démarche fixe : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie** et facteurs de risque, **mécanismes physiopathologiques**, **diagnostic** et examens complémentaires, **conséquences** et complications, **traitements** et conséquences des traitements. Chaque étape a son vocabulaire, que le CNED présente au début du cours de physiopathologie (« Quelques définitions à bien connaître »). Ces mots, construits avec les éléments des parties précédentes, structurent toutes les réponses d'examen sur une pathologie.

Définitions

Santé : « état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (préambule de la Constitution de l'OMS, 1946).

Maladie : altération de l'état de santé qui se traduit par des symptômes et des signes, due à une cause (connue ou non) et évoluant selon un mode propre.

Pathologie (gr. *pathos*, souffrance, + -logie) : au sens strict, **étude** des maladies ; dans l'usage courant, synonyme de maladie (« une pathologie cardiaque »).

Physiopathologie : étude des **mécanismes** par lesquels une cause perturbe le fonctionnement normal (la physiologie) et produit les signes de la maladie ; c'est le cœur du bloc BPADN.

Étiologie (étio-, cause, + -logie) : étude des **causes** d'une maladie ; par extension, la cause elle-même (« l'étiologie de cette cirrhose est alcoolique »).

Pathogénie (pathogenèse) : mécanisme d'apparition et de développement d'une maladie ; **étiopathogénie** : étude conjointe des causes et des mécanismes.

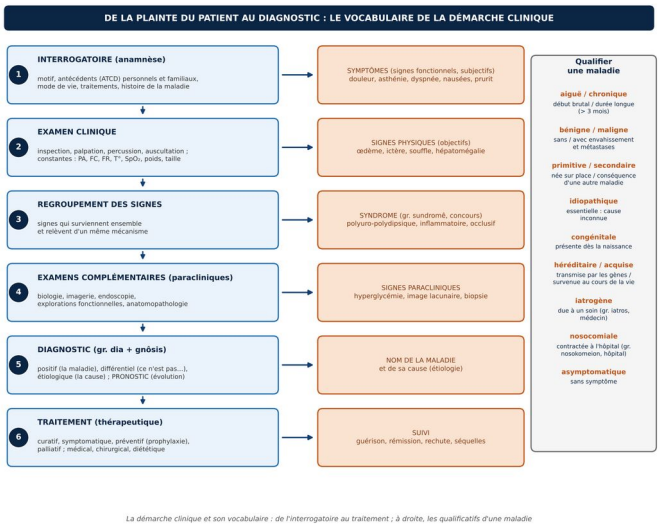
Sémiologie (gr. *sêmeion*, signe, + -logie) : étude des **signes** des maladies et de la façon de les rechercher et de les interpréter.

Épidémiologie (gr. *epi*, sur, *dêmos*, peuple, + -logie) : étude de la **fréquence** et de la **répartition** des maladies dans les populations et des **facteurs** qui les influencent.

Nosologie (nos(o)-, maladie) : classification des maladies.

Du symptôme au diagnostic

La démarche clinique va de la **plainte** du patient au **traitement**. Elle commence toujours par l'**interrogatoire**, appelé **anamnèse** (gr. *anamnêsis*, souvenir : ana-, en remontant, et -mnèse, mémoire) : le médecin recueille l'identité et le mode de vie, le **motif** de consultation ou d'hospitalisation, les **antécédents** (ATCD) **personnels** (maladies, interventions, allergies, traitements) et **familiaux** ou hérédo-collatéraux (maladies des parents, frères et sœurs, enfants : cancers, diabète, maladies cardiovasculaires précoces), puis l'**histoire de la maladie** (date de début, circonstances, évolution des symptômes). L'**examen clinique** proprement dit utilise les sens du médecin : **inspection** (regarder), **palpation** (toucher), **percussion** (frapper le thorax ou l'abdomen avec les doigts pour en apprécier la sonorité) et **auscultation** (écouter le cœur, les poumons, l'abdomen avec un stéthoscope) ; il comprend la mesure des **constantes** (pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire, température, saturation en oxygène, poids, taille). Seule l'évaluation de l'**état général** et des données anthropométriques fait partie du travail du diététicien ; il doit comprendre et savoir interpréter le reste.



La démarche clinique et son vocabulaire : de l'interrogatoire au traitement ; à droite, les qualificatifs d'une maladie

Fig. 29.25. La démarche clinique et son vocabulaire : de l'interrogatoire au traitement ; à droite, les qualificatifs d'une maladie

Comprendre le schéma – figure 29.25

La colonne de gauche suit les six étapes de la démarche ; la colonne du milieu indique ce que chaque étape met en évidence. **1. Interrogatoire** (anamnèse : motif, antécédents personnels et familiaux, mode de vie, traitements, histoire de la maladie) → **symptômes**, ou signes fonctionnels, **subjectifs**, rapportés par le patient (douleur, asthénie, dyspnée, nausées, prurit). **2. Examen clinique** (inspection, palpation, percussion, auscultation ; constantes : PA, FC, FR, température, SpO_2, poids, taille) → **signes physiques**, **objectifs**, constatés par le soignant (œdème, ictère, souffle cardiaque, hépatomégalie). **3. Regroupement des signes** qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme → **syndrome** (gr. *sundromê*, concours, réunion : syndrome polyuro-polydipsique, inflammatoire, occlusif). **4. Examens complémentaires** ou paracliniques (biologie, imagerie, endoscopie, explorations fonctionnelles, anatomopathologie) → **signes paracliniques**

(hyperglycémie, image lacunaire, lésion à la biopsie). **5. Diagnostic** (gr. *dia*, à travers, et *gnôsis*, connaissance) **positif** (la maladie est identifiée), **différentiel** (on écarte les maladies qui donnent des signes voisins), **étiologique** (on en trouve la cause) ; **pronostic** (pro-, avant : prévision de l'évolution) → le **nom de la maladie** et sa cause. **6. Traitement** (thérapeutique) curatif, symptomatique, préventif (prophylaxie), palliatif ; médical, chirurgical, diététique → **suivi** (guérison, rémission, rechute, séquelles).

La colonne de droite donne les **qualificatifs** d'une maladie : aiguë (début brutal, évolution courte) / chronique (évolution prolongée, en général plus de 3 mois) ; bénigne (sans envahissement ni métastases) / maligne (avec envahissement et métastases, ou de mauvais pronostic) ; primitive (née dans l'organe) / secondaire (conséquence d'une autre maladie, ou métastase) ; idiopathique ou essentielle (cause inconnue : hypertension essentielle) ; congénitale (présente dès la naissance) ; héréditaire (transmise par les gènes) / acquise (survenue au cours de la vie) ; iatrogène (due à un soin, gr. *iatros,* médecin) ; nosocomiale (contractée dans un établissement de soins) ; asymptomatique (sans symptôme).

Terme · Définition · Exemple

symptôme (signe fonctionnel) — *Définition :* manifestation **ressentie** et rapportée par le patient (subjective) ; *Exemple :* douleur, nausée, asthénie, prurit, dysphagie, dyspnée

signe physique — *Définition :* anomalie **constatée** par le soignant à l'examen (objective) ; *Exemple :* œdème, ictère, hépatomégalie, souffle, pli cutané

signe général — *Définition :* signe non spécifique d'un organe, commun à de nombreuses maladies ; *Exemple :* fièvre, amaigrissement, asthénie, anorexie

signe paraclinique — *Définition :* anomalie mise en évidence par un examen complémentaire ; *Exemple :* hyperglycémie, anémie, opacité radiologique

syndrome — *Définition :* ensemble de signes et de symptômes qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme, quelle que soit la cause ; *Exemple :* syndrome néphrotique, syndrome de malabsorption, syndrome inflammatoire, syndrome métabolique, syndrome de renutrition inappropriée

AEG (altération de l'état général) — *Définition :* association d'une asthénie, d'une anorexie et d'un amaigrissement (« les trois A ») ; *Exemple :* cancer, infection chronique, dénutrition

prodrome — *Définition :* signe avant-coureur d'une maladie (pro-, avant, + *dromos*, course) ; *Exemple :* fatigue et courbatures avant une hépatite virale

complication — *Définition :* événement nouveau qui aggrave l'évolution d'une maladie ; *Exemple :* acidocétose au cours d'un diabète de type 1

décompensation — *Définition :* aggravation brutale d'une maladie chronique jusque-là équilibrée ; *Exemple :* décompensation œdémato-ascitique d'une cirrhose

séquelle — *Définition :* lésion ou trouble qui persiste après la guérison ; *Exemple :* hémiplégie séquellaire d'un AVC

rémission / rechute / récidive — *Définition :* diminution ou disparition des signes / réapparition au cours de la même maladie / réapparition après guérison ; *Exemple :* MICI en rémission ; récidive d'un cancer

poussée — *Définition :* aggravation temporaire d'une maladie chronique ; *Exemple :* poussée de maladie de Crohn, de goutte

facteur de risque — *Définition :* caractéristique associée à une probabilité plus élevée de maladie ; *Exemple :* tabac, HTA, LDL élevé, sédentarité pour l'athérosclérose

facteur déclenchant — *Définition :* événement qui provoque l'apparition d'une crise ; *Exemple :* excès alimentaire et alcool pour une crise de goutte

diagnostic différentiel — *Définition :* maladies à éliminer car elles donnent des signes voisins ; *Exemple :* hyperglycémie de stress ou diabète

indication / contre-indication — *Définition :* situation qui justifie / interdit un traitement ou un examen ; *Exemple :* contre-indication de la nutrition entérale : occlusion intestinale

effet indésirable — *Définition :* effet nocif non recherché d'un traitement ; *Exemple :* mucite de la chimiothérapie, prise de poids sous corticoïdes

observance (adhésion) — *Définition :* degré de suivi d'un traitement ou d'un régime par le patient ; *Exemple :* observance du régime sans gluten

Attention

Fonctionnel a deux sens. Un « signe fonctionnel » est un **symptôme** (rapporté par le patient). Un « trouble fonctionnel » (colopathie fonctionnelle, dyspepsie fonctionnelle) est un trouble **sans lésion organique** décelable : il s'oppose à « organique ». Le sens se déduit du contexte.

Chronique ne veut pas dire grave, ni **aigu** « intense » : ces termes décrivent la **durée** et le mode d'évolution. Une pancréatite aiguë peut être bénigne ou mortelle ; une hypertension chronique peut rester longtemps asymptomatique.

Traitement, prévention et épidémiologie

Le vocabulaire des traitements et de la prévention est indispensable au bloc 3 (santé publique). Un traitement **curatif** vise la guérison (antibiotique, chirurgie d'exérèse d'un cancer localisé, régime sans gluten de la maladie cœliaque, qui fait disparaître les lésions) ; un traitement **symptomatique** soulage un symptôme sans agir sur la cause (antalgique, antiémétique, épaississement des liquides) ; un traitement

préventif ou **prophylactique** (gr. *prophulaxis*, précaution) évite l'apparition d'une maladie ou d'une complication ; un traitement **palliatif** améliore le confort et la qualité de vie quand la guérison n'est plus possible (alimentation plaisir en soins palliatifs). La **prévention** est classiquement **primaire** (éviter l'apparition de la maladie : réduire la consommation de sel dans la population), **secondaire** (la dépister tôt pour en limiter la gravité : dépistage du diabète, du cancer colorectal) ou **tertiaire** (limiter ses complications et ses récidives : éducation thérapeutique du patient diabétique).

Le vocabulaire de l'épidémiologie permet de lire les données de santé publique. La **prévalence** est la proportion de personnes **atteintes** d'une maladie dans une population à un moment donné (cas existants / population) ; l'**incidence** est le nombre de **nouveaux cas** apparus pendant une période (souvent un an), rapporté à la population à risque ; la **morbidité** désigne l'ensemble des maladies dans une population (« la morbidité cardiovasculaire ») ; la **mortalité** est le nombre de **décès** rapporté à la population totale pendant une période ; la **létalité** est la proportion de décès parmi les **malades** (gravité d'une maladie). Une **endémie** est la présence habituelle d'une maladie dans une région ; une **épidémie** son augmentation inhabituelle (épi-, sur, et *dêmos*, peuple) ; une **pandémie** une épidémie qui touche plusieurs continents (pan-, tout).

Exemple chiffré

Dans une ville de **200 000 habitants**, on recense au 1er janvier **12 000** personnes diabétiques traitées ; pendant l'année, **900** nouveaux cas sont diagnostiqués et **300** diabétiques décèdent (toutes causes).

Prévalence au 1er janvier = 12 000 / 200 000 = **0,06**, soit **6 %**. **Incidence annuelle** (population à risque : les non-diabétiques, 200 000 − 12 000 = 188 000) = 900 / 188 000 ≈ **0,0048**, soit **4,8 cas pour 1 000** personnes à risque et par an (≈ 4,5 pour 1 000 habitants si l'on rapporte, par approximation, à la population totale). **Mortalité** des diabétiques dans l'année = 300 / 12 000 = **2,5 %** (ce n'est pas une létalité « du diabète », car les décès ont toutes les causes).

Une prévalence **augmente** quand l'incidence augmente **ou** quand la durée de la maladie s'allonge (meilleure survie grâce aux traitements) : une prévalence en hausse n'est donc pas forcément une mauvaise nouvelle.

Se repérer sur le corps

Les comptes rendus situent les lésions, les douleurs et les cicatrices avec un vocabulaire **topographique** précis. Toutes les descriptions se font en **position anatomique de référence** : sujet debout, face à l'observateur, bras le long du corps, paumes tournées vers l'avant. Conséquence importante pour la lecture des schémas et des images : **la droite du patient est à gauche de l'image**.

Comprendre le schéma – figure 29.26

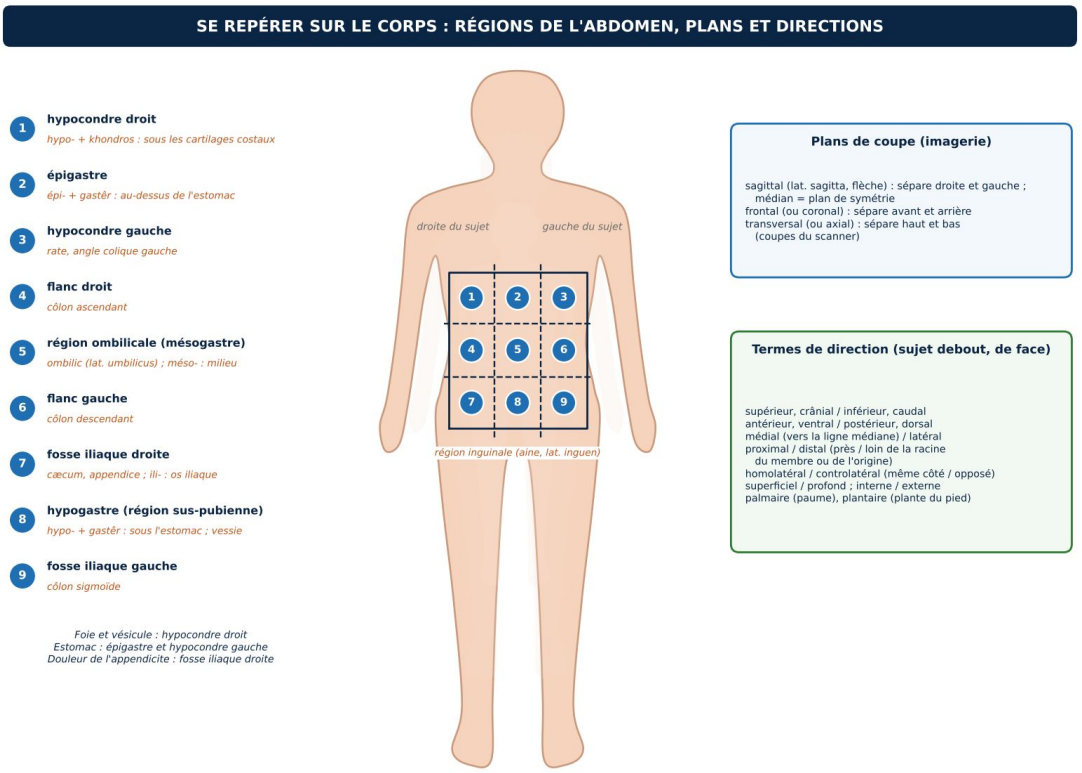
Deux lignes verticales (passant par le milieu des clavicules) et deux lignes horizontales (sous les côtes et au niveau des crêtes iliaques) divisent l'abdomen en **neuf régions**. Rangée supérieure : **1. hypocondre droit** (hypo- + *khondros*, « sous les cartilages » des côtes : foie, vésicule biliaire ; la douleur de la colique hépatique y siège) ; **2. épigastre** (« au-dessus de l'estomac » : estomac, pancréas ; épigastralgie de l'ulcère) ; **3. hypocondre gauche** (rate, angle colique gauche, une partie de l'estomac). Rangée moyenne : **4. flanc droit** (côlon ascendant) ; **5. région ombilicale** ou mésogastre (intestin grêle) ; **6. flanc gauche** (côlon descendant). Rangée inférieure : **7. fosse iliaque droite** (cæcum, appendice : douleur de l'appendicite) ; **8. hypogastre** (« sous l'estomac », région sus-pubienne : vessie, utérus) ; **9. fosse iliaque gauche** (côlon sigmoïde : douleur de la sigmoïdite diverticulaire). Sous l'abdomen, la région **inguinale** (lat. *inguen*, aine) est le siège des hernies inguinales.

Le cadre bleu donne les **plans de coupe** de l'imagerie : **sagittal** (lat. *sagitta*, flèche, comme une flèche qui frapperait le sujet de face) : il sépare la droite et la gauche ; le plan sagittal **médian** est le plan de symétrie ; **frontal** ou **coronal** : il sépare l'avant et l'arrière ; **transversal** ou **axial** : il sépare le haut et le bas (coupes habituelles du scanner). Le cadre vert donne les **termes de direction** : supérieur ou crânial / inférieur ou caudal ; antérieur ou ventral / postérieur ou dorsal ; médial (vers la ligne médiane) / latéral ; proximal / distal (près / loin de la racine d'un membre ou de l'origine d'un conduit : l'œsophage distal est sa partie basse, près

de l'estomac) ; homolatéral / controlatéral (du même côté / du côté opposé : un AVC de l'hémisphère gauche donne une hémiplégie **controlatérale**, droite) ; superficiel / profond ; palmaire / plantaire.

Terme · Définition

décubitus dorsal, latéral, ventral — position couchée sur le dos, sur le côté, sur le ventre (lat. *decumbere*, se coucher) ; le décubitus prolongé expose aux escarres



Se repérer sur le corps : les neuf régions de l'abdomen (la droite du sujet est à gauche de l'image), les plans de coupe et les termes de direction employés dans les comptes rendus

Fig. 29.26. Se repérer sur le corps : les neuf régions de l'abdomen (la droite du sujet est à gauche de l'image), les plans de coupe et les termes de direction employés dans les comptes rendus

position demi-assise — tête et thorax relevés à 30-45° : recommandée pendant et après une alimentation par sonde pour limiter le reflux et l'inhalation

orthostatisme, orthostatique — position debout ; hypotension orthostatique : baisse de la pression artérielle au passage à la position debout (risque de chute chez la personne âgée déshydratée)

bilatéral, unilatéral — des deux côtés, d'un seul côté (œdèmes bilatéraux des membres inférieurs)

sus-, sous- (topographie) — au-dessus, au-dessous d'un repère : sus-ombilical, sous-costal, sous-mandibulaire

axillaire, inguinal, cervical, lombaire — de l'aisselle (lat. *axilla*), de l'aine, du cou, des lombes (bas du dos)

membre supérieur, inférieur — bras et avant-bras ; cuisse et jambe (en anatomie, la « jambe » est la partie entre genou et cheville)

29.3.6 Le vocabulaire des documents médicaux et de la nutrition clinique

Module · *Guide 2025 p. 99-100 et p. 18 (diagnostic diététique) · CNED : 3-2023 M1 S2 et S5 · HAS 2019 et 2021 (dénutrition)*

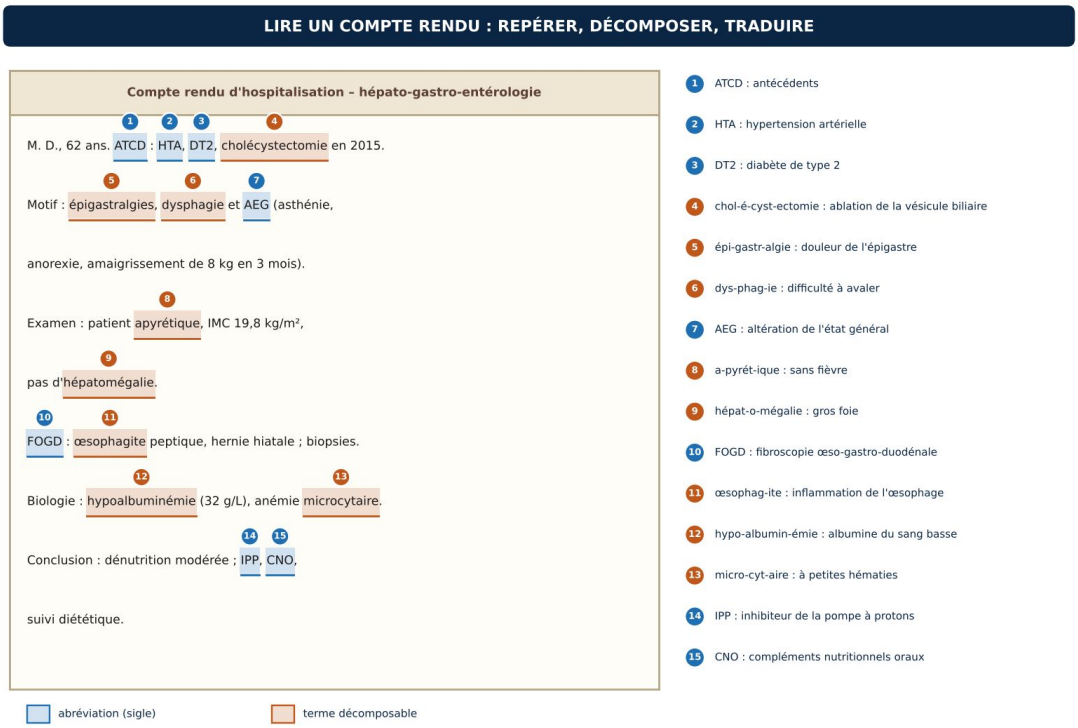
Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles

Le **compte rendu d'hospitalisation** (CRH), la **lettre de liaison** à la sortie et le **dossier patient** informatisé sont les documents que le diététicien lit le plus souvent. Ils suivent un plan constant : identité et service ; **motif** d'hospitalisation ; **antécédents** médicaux, chirurgicaux, familiaux ; **allergies** ; **mode de vie** (profession, entourage, autonomie, tabac, alcool) ; **traitement habituel** ; **histoire de la maladie** ; **examen clinique** d'entrée ; **examens complémentaires** (biologie, imagerie, endoscopie, anatomopathologie) ; **évolution** pendant le séjour ; **conclusion** (diagnostics retenus) ; **traitement de sortie** et suivi. Ils mêlent termes composés et **abréviations** ; la méthode consiste à **repérer**, **décomposer**, **traduire**, puis **sélectionner** ce qui est utile à la prise en charge nutritionnelle.

Comprendre le schéma – figure 29.27

Le cadre de gauche reproduit un extrait de compte rendu de **gastro-entérologie** (cas fictif) ; les **abréviations** sont surlignées en bleu, les **termes décomposables** en orange, et chacun est numéroté. La colonne de droite les traduit : **1. ATCD** : antécédents ; **2. HTA** : hypertension artérielle ; **3. DT2** : diabète de type 2 ; **4. cholécystectomie** (chol-é-cyst-ectomie) : ablation de la vésicule biliaire ; **5. épigastralgies** (épi-gastr-algie) : douleurs de l'épigastre ; **6. dysphagie** (dys-phag-ie) : difficulté à avaler ; **7. AEG** : altération de l'état général, précisée entre parenthèses (asthénie, anorexie, amaigrissement de 8 kg en 3 mois) ; **8. apyrétique** (a-pyrét-ique) : sans fièvre ; **9. hépatomégalie** : gros foie (absente ici) ; **10. FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale ; **11. œsophagite** (œsophag-ite) : inflammation de l'œsophage (« peptique » : due à l'acide gastrique) ; la **hernie hiatale** est le passage d'une partie de l'estomac dans le thorax par l'orifice œsophagien du diaphragme ; **12. hypoalbuminémie** (hypo-albumin-émie) : albumine du sang basse (32 g/L) ; **13. microcytaire** (micro-cyt-aire) : à petites hématies, évocatrice d'une carence en fer ; **14. IPP** : inhibiteur de la pompe à protons (médicament qui réduit l'acidité gastrique) ; **15. CNO** : compléments nutritionnels oraux.

Ce que le diététicien retient : un homme de 62 ans **dénutri** (perte de 8 kg en 3 mois, apports réduits par la dysphagie), diabétique et hypertendu, avec une œsophagite et une anémie microcytaire : objectifs de renutrition avec des **textures adaptées** à la dysphagie, des **CNO** compatibles avec le diabète, un apport de fer, une surveillance du poids. Selon la HAS (2019), l'albuminémie n'est pas un critère **diagnostique** de dénutrition chez l'adulte mais un critère de **sévérité** (dénutrition sévère si ≤ 30 g/L) : à 32 g/L, elle reste compatible avec une dénutrition modérée.



Un compte rendu d'hospitalisation annoté : les abréviations sont développées, les termes composés sont décomposés puis traduits (cas fictif)

Fig. 29.27. Un compte rendu d'hospitalisation annoté : les abréviations sont développées, les termes composés sont décomposés puis traduits (cas fictif)

Sigle · Signification · Sigle · Signification

ATCD — *Signification :* antécédents ; *Sigle :* NFS ; *Signification :* numération formule sanguine (hémogramme)

AEG — *Signification :* altération de l'état général ; *Sigle :* VGM ; *Signification :* volume globulaire moyen

HTA — *Signification :* hypertension artérielle ; *Sigle :* CRP ; *Signification :* protéine C réactive (inflammation)

DT1, DT2 — *Signification :* diabète de type 1, de type 2 ; *Sigle :* HbA1c ; *Signification :* hémoglobine glyquée

IMC — *Signification :* indice de masse corporelle (kg/m²) ; *Sigle :* DFG ; *Signification :* débit de filtration glomérulaire

AVC, AIT — *Signification :* accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire ; *Sigle :* ASAT, ALAT ; *Signification :* transaminases (enzymes hépatiques)

IDM, SCA — *Signification :* infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu ; *Sigle :* GGT ; *Signification :* gamma-glutamyl-transférase

IC, ICC — *Signification :* insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque congestive ; *Sigle :* TSH ; *Signification :* hormone thyréotrope

FA — *Signification :* fibrillation auriculaire ; *Sigle :* BU ; *Signification :* bandelette urinaire

BPCO — *Signification :* bronchopneumopathie chronique obstructive ; *Sigle :* ECBU ; *Signification :* examen cytobactériologique des urines

IRC, MRC — *Signification :* insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique ; *Sigle :* ECG ; *Signification :* électrocardiogramme

IRA — *Signification :* insuffisance rénale aiguë ; *Sigle :* TDM ; *Signification :* tomodensitométrie (scanner)

MICI — *Signification :* maladie inflammatoire chronique de l'intestin ; *Sigle :* IRM ; *Signification :* imagerie par résonance magnétique

RGO — *Signification :* reflux gastro-œsophagien ; *Sigle :* TEP ; *Signification :* tomographie par émission de positons

SII — *Signification :* syndrome de l'intestin irritable ; *Sigle :* FOGD ; *Signification :* fibroscopie œso-gastro-duodénale

NASH, MASH — *Signification :* stéatohépatite non alcoolique, stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique ; *Sigle :* PA, FC, FR ; *Signification :* pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire

SAOS — *Signification :* syndrome d'apnées obstructives du sommeil ; *Sigle :* SpO_2 ; *Signification :* saturation pulsée en oxygène

TCA — *Signification :* troubles des conduites (ou du comportement) alimentaires ; *Sigle :* PO, *per os* ; *Signification :* par la bouche

DPE — *Signification :* dénutrition protéino-énergétique ; *Sigle :* IV, IM, SC ; *Signification :* intraveineux, intramusculaire, sous-cutané

SRI — *Signification :* syndrome de renutrition inappropriée ; *Sigle :* NE, NP ; *Signification :* nutrition entérale, nutrition parentérale

CNO — *Signification :* compléments nutritionnels oraux ; *Sigle :* SNG ; *Signification :* sonde nasogastrique

ETP — *Signification :* éducation thérapeutique du patient ; *Sigle :* GPE ; *Signification :* gastrostomie percutanée endoscopique

EHPAD — *Signification :* établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; *Sigle :* PICC ; *Signification :* cathéter central inséré par voie périphérique

SSR, SMR — *Signification :* soins de suite et de réadaptation (aujourd'hui soins médicaux et de réadaptation) ; *Sigle :* RCP ; *Signification :* réunion de concertation pluridisciplinaire

HAD — *Signification :* hospitalisation à domicile ; *Sigle :* ALD ; *Signification :* affection de longue durée

Attention

Une abréviation peut avoir plusieurs sens : **IC** = insuffisance cardiaque ou insuffisance coronarienne ; **PA** = pression artérielle ou phosphatases alcalines ; **AG** = anesthésie générale ou acides gras ; **IR** = insuffisance rénale ou insuffisance respiratoire ; **PL** = ponction lombaire. Le contexte (service, autres données) permet de trancher ; en cas de doute, on **demande** au prescripteur. Dans ses propres écrits, le diététicien n'emploie que des abréviations **usuelles**, et développe les autres à la première occurrence.

Le vocabulaire de la nutrition clinique

Le diététicien emploie lui-même un vocabulaire technique pour désigner les **voies d'alimentation**, les **textures** et les **modalités** de la nutrition clinique. Ce vocabulaire est celui des recommandations de la HAS, de la SFNCM (Société francophone nutrition clinique et métabolisme) et de l'ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Comprendre le schéma – figure 29.28

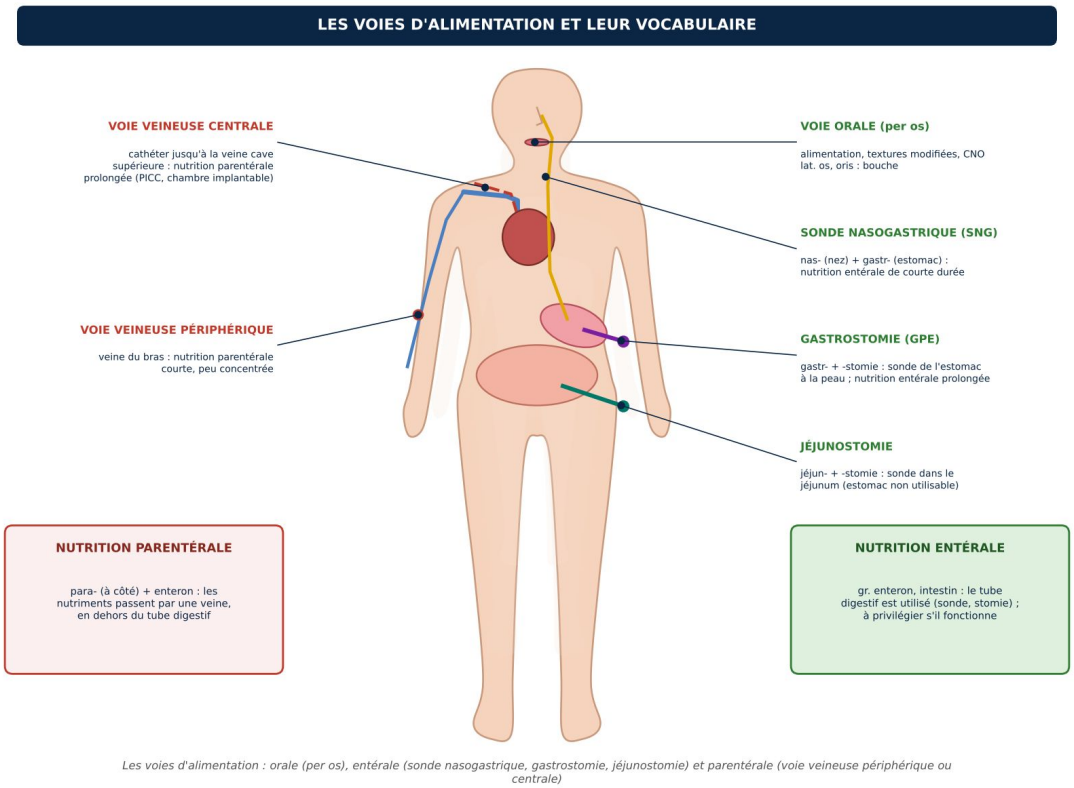
À droite, en vert, les voies qui utilisent le **tube digestif**. **Voie orale** (*per os*, lat. *os, oris*, bouche) : alimentation normale, textures modifiées, compléments nutritionnels oraux (CNO). **Sonde nasogastrique** (SNG : nas-, nez, + gastr-, estomac), en jaune : sonde introduite par le nez jusqu'à l'estomac, pour une **nutrition entérale de courte durée** (moins de 4 à 6 semaines). **Gastrostomie** (gastr- + -stomie), en violet : sonde qui relie l'estomac à la peau, posée le plus souvent par voie endoscopique (GPE), pour une nutrition entérale **prolongée**. **Jéjunostomie** (jéjun- + -stomie), en vert foncé : sonde placée dans le jéjunum quand l'estomac n'est pas utilisable. Le cadre vert rappelle que l'**entérale** (gr. *enteron*, intestin) utilise le tube digestif et doit être **privilégiée** dès qu'il fonctionne.

À gauche, en rouge, les voies **veineuses** de la nutrition **parentérale** (par(a)-, à côté, + *enteron* : « en dehors de l'intestin »). **Voie veineuse périphérique** : une veine du bras, pour une nutrition parentérale courte et peu concentrée (les solutions concentrées irritent les petites veines). **Voie veineuse centrale** : un cathéter dont l'extrémité atteint la **veine cave supérieure**, à gros débit sanguin, pour une nutrition parentérale prolongée ou concentrée ; il est posé par une veine du cou ou sous la clavicule (cathéter tunnelisé, **chambre implantable**) ou par une veine du bras (**PICC**, *peripherally inserted central catheter*).

Terme · Définition
nutrition orale, alimentation enrichie — alimentation par la bouche, éventuellement enrichie (poudre de lait, œufs, fromage, crème) pour augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume

CNO (compléments nutritionnels oraux) — mélanges nutritifs complets, hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques, pris en plus des repas

nutrition entérale (NE) — apport de nutriments par une sonde dans le tube digestif (gastrique ou jéjunale) ; administration continue (pompe) ou discontinue



Les voies d'alimentation : orale (per os), entérale (sonde nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie) et parentérale (voie veineuse périphérique ou centrale)

Fig. 29.28. Les voies d'alimentation : orale (per os), entérale (sonde nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie) et parentérale (voie veineuse périphérique ou centrale)

nutrition parentérale (NP) — apport de nutriments par voie veineuse ; réservée aux situations où le tube digestif est inutilisable ou insuffisant

jeûne, mise à jeun, « à jeun strict » — absence de tout apport par la bouche (aliments et boissons), avant une intervention ou un examen

réalimentation, renutrition — reprise de l'alimentation après un jeûne ; correction progressive d'une dénutrition

iso-, hyperénergétique ; iso-, hyperprotidique — apport égal à / supérieur aux besoins habituels en énergie, en protéines

hyposodé, désodé — pauvre en sodium (régime à 4 à 6 g de sel par jour, selon les recommandations) / sans sel ajouté et pauvre en sodium (strict, rare aujourd'hui)

textures modifiées — aliments transformés (hachés, moulinés, mixés) pour les patients ayant des troubles de la mastication ou de la déglutition

liquides épaissis, eau gélifiée — boissons rendues plus épaisses (poudre épaississante) pour ralentir leur passage et limiter les fausses routes en cas de dysphagie

fausse route — passage d'aliments ou de liquide dans les voies aériennes (trachée) au lieu de l'œsophage ; risque de pneumopathie d'inhalation

IDDSI — *International Dysphagia Diet Standardisation Initiative* : cadre international en 8 niveaux (0 à 7) qui décrit les textures des boissons (0 fluide à 4 très épais) et des aliments (3 liquéfié à 7 normal), adopté en France depuis la fin des années 2010

Définition et exemple

Diagnostic diététique (format PES) : énoncé rédigé par le diététicien qui identifie un **Problème** nutritionnel, son **Étiologie** (cause relevant de la diététique) et les **Signes et/ou Symptômes** qui le mettent en évidence et serviront d'indicateurs de suivi. Il emploie la **TIDN** (Terminologie internationale de diététique et de nutrition, traduction française de la terminologie du processus de soin nutritionnel de l'Academy of Nutrition and Dietetics), qui classe les problèmes en trois **domaines** : **apports** (consommation), **clinique**, **comportement et environnement**. Le guide 2025 précise que le diagnostic diététique doit rester dans le **champ de la diététique** et non du médical.

Exemple : « Apport oral insuffisant (**P**) lié à une dysphagie aux solides et à une perte d'appétit (**E**), mis en évidence par une perte de poids de 11 % en 3 mois et des apports estimés à 55 % des besoins énergétiques (**S**). » Le diagnostic **médical** (« œsophagite peptique », « dénutrition modérée ») n'est pas du ressort du diététicien, mais il en utilise les termes pour comprendre la situation.

S'entraîner – application

Traduisez en langage courant, pour un patient, les phrases suivantes : **a)** « Vous allez bénéficier d'une nutrition entérale par SNG. » **b)** « Votre bilan montre une hypokaliémie. » **c)** « La FOGD a montré une gastrite. » **d)** « Il faut éviter le décubitus dorsal strict après les repas. » **e)** « Vous avez une hypercholestérolémie. »

Corrigé

a) « Pendant quelques jours, vous serez nourri par un petit tuyau souple qui passe par le nez et descend jusqu'à l'estomac ; on y fait couler un aliment liquide complet. » **b)** « Votre prise de sang montre que vous manquez un peu de potassium dans le sang. » **c)** « L'examen par caméra de votre estomac a montré que sa paroi est irritée, enflammée. » **d)** « Après les repas, ne vous allongez pas complètement à plat sur le dos : restez assis ou demi-assis. » **e)** « Vous avez trop de cholestérol dans le sang. » Chaque reformulation reste **exacte** : on simplifie les mots, pas le sens.

Exercice de synthèse – la lithiase biliaire en chirurgie digestive

Exercice type examen 29.1

Un dossier de chirurgie digestive : la lithiase biliaire – 20 points · durée conseillée : 45 min

Mme L., 47 ans, est hospitalisée en chirurgie viscérale. Le diététicien du service doit préparer sa sortie. Il lit l'extrait du compte rendu d'hospitalisation ci-dessous (cas fictif).

Document 1

Motif : douleur de l'**hypochondre droit** évoluant depuis 48 h, **fébrile** à 38,9 °C, **nausées** et **vomissements**. **ATCD** : **appendicectomie** à 12 ans ; **hystérectomie** à 44 ans ; surpoids (IMC 29 kg/m²).

Examen : signe de Murphy positif (douleur qui bloque l'inspiration profonde à la palpation de l'hypochondre droit) ; pas d'**ictère**. **Biologie** : **hyperleucocytose** à 14,2 G/L, CRP 98 mg/L, bilan hépatique normal. **Échographie** abdominale : vésicule à paroi épaissie, multiples **lithiases** ; voie biliaire principale non dilatée.

Conclusion : **cholécystite aiguë lithiasique**. **Cholécystectomie** par **cœlioscopie** à J2 ; suites simples. **Anatomopathologie** : cholécystite aiguë, pas de lésion **tumorale**.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez les termes suivants : hypochondre, appendicectomie, hystérectomie, hyperleucocytose, cholécystite, lithiasique, cholécystectomie, cœlioscopie. *(8 pts)*

2. Distinguez un **signe** et un **symptôme** à l'aide de deux exemples tirés du document. *(2 pts)*

3. Expliquez les termes « fébrile », « ictère » et « anatomopathologie ». Pourquoi le médecin précise-t-il l'absence d'ictère ? *(4 pts)*

4. Proposez deux termes médicaux construits sur la racine chol(é)- qui désignent d'autres atteintes des voies biliaires et définissez-les. *(2 pts)*

5. Après l'ablation de la vésicule, Mme L. demande si elle devra « supprimer toutes les graisses à vie ». Répondez en reformulant sans jargon le rôle de la vésicule biliaire. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.1

Question 1

Hypochondre : hypo- (sous) + chondr- (cartilage) : région de l'abdomen située **sous les cartilages costaux** ; l'hypochondre droit contient le foie et la vésicule biliaire.

Appendicectomie : appendic- (appendice) + -ectomie (ablation) : ablation chirurgicale de l'appendice. **Hystérectomie** : hystér- (gr. *hustera*, utérus) + -ectomie : ablation de l'utérus.

Hyperleucocytose : hyper- (excès) + leuc(o)- (blanc) + cyt- (cellule) + -ose (état) : nombre de globules blancs **supérieur à la normale** (au-delà de 10 G/L) ; signe d'infection ou d'inflammation.

Cholécystite : chol(é)- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ite (inflammation) : inflammation de la vésicule biliaire. **Lithiasique** : lith- (pierre) + -iase (état pathologique) + -ique (relatif à) : due à des **calculs** (« pierres »).

Cholécystectomie : ablation de la vésicule biliaire. **Cœlioscopie** : cœli(o)- (gr. *koilia*, ventre, cavité) + -scopie (examen visuel) : technique qui permet de voir et d'opérer dans la cavité abdominale à l'aide d'une caméra introduite par de petites incisions, sans ouvrir largement la paroi (par opposition à la **laparotomie**).

Question 2

Le **symptôme** est ce que le patient **ressent** et rapporte : la **douleur**, les **nausées**. Le **signe** est ce que le soignant **constate** ou mesure : la **fièvre** à 38,9 °C, le signe de Murphy, l'hyperleucocytose.

Question 3

Fébrile (lat. *febris*, fièvre) : qui a de la fièvre (température centrale supérieure à 38 °C) ; le contraire est **apyrétique**. **Ictère** (gr. *ikteros*, jaunisse) : coloration jaune de la peau et des muqueuses due à l'accumulation de **bilirubine** dans le sang. **Anatomopathologie** : ana- (de bas en haut, à travers) + tom- (couper) + path- (maladie) + -logie (étude) : étude des **lésions** des tissus prélevés (ici, la vésicule).

Un ictère ferait craindre un **calcul migré dans la voie biliaire principale** (cholédoque) qui bloquerait l'écoulement de la bile : son absence, avec un bilan hépatique normal et une voie biliaire non dilatée, rend cette complication peu probable.

Question 4

Exemples : **cholédocholithiase** (cholédoque + lith- + -iase) : présence d'un calcul dans le canal cholédoque ; **cholangite** (chol- + angi-, vaisseau, canal, + -ite) : inflammation infectieuse des voies biliaires ; **cholestase** (chol- + -stase, arrêt) : diminution ou arrêt de l'écoulement de la bile ; **lithiase vésiculaire** ou **cholélithiase** : calculs dans la vésicule.

Question 5

Réponse type : « La vésicule n'est qu'un **réservoir** : elle stocke la bile fabriquée par le **foie** et la vide dans l'intestin au moment des repas gras. Sans vésicule, le foie continue de fabriquer la bile, qui coule en petite quantité et en continu dans l'intestin. Vous pourrez donc manger **normalement**, graisses comprises, **sans régime particulier à vie**. Dans les premières semaines, certaines personnes digèrent moins bien un repas très gras ou ont les selles plus molles : fractionnez alors les repas, évitez les plats très gras et réintroduisez-les progressivement selon votre tolérance. » On profitera de la consultation pour aborder le **surpoids** (IMC 29) si la patiente le souhaite.

Exercice de synthèse – lire le bilan biologique d'un résident déshydraté

Exercice type examen 29.2

Lire un bilan biologique : un résident déshydraté – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. P., 78 ans, vit en EHPAD. Depuis cinq jours, il boit peu, mange la moitié de ses repas et paraît confus. Le médecin prescrit un bilan sanguin. Le diététicien doit en extraire les informations utiles et nommer chaque anomalie avec le terme médical exact.

Document 1

Ionogramme sanguin : sodium (natrémie) **151 mmol/L** (135 à 145) ; potassium (kaliémie) **3,2 mmol/L** (3,5 à 5,0) ; urée **14,6 mmol/L** (2,5 à 7,5) ; créatinine **142 µmol/L** (60 à 110). Glycémie (prélèvement non à jeun) **1,32 g/L**.

Hémogramme (NFS) : hémoglobine **11,8 g/dL** (13 à 17 chez l'homme) ; VGM **104 fL** (80 à 100) ; leucocytes **12,5 G/L** (4 à 10) ; plaquettes 260 G/L (150 à 400). **Protéines** : albumine **29 g/L** (35 à 50) ; CRP **45 mg/L** (< 5).

Poids : 58 kg (poids habituel 63 kg il y a 3 mois) ; taille 1,72 m.

Travail à faire

1. Nommez chaque anomalie du ionogramme, de l'hémogramme et du dosage de l'albumine par un terme construit (préfixe + racine + suffixe) et décomposez-le. *(6 pts)*

2. Expliquez ce qu'indiquent l'hypernatrémie et l'élévation de l'urée chez ce patient. *(3 pts)*

3. La glycémie de 1,32 g/L permet-elle de diagnostiquer un diabète ? Justifiez avec les seuils et convertissez-la en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L). *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids, puis indiquez si les critères de la HAS (2021) pour la personne de 70 ans et plus permettent de retenir une dénutrition, et sa sévérité. *(5 pts)*

5. Pourquoi l'albuminémie doit-elle être interprétée avec prudence ici ? *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.2

Question 1

Hypernatrémie : hyper- (excès) + natr- (sodium, lat. *natrium*) + -émie (dans le sang) : sodium sanguin supérieur à 145 mmol/L. **Hypokaliémie** :

hypo- (insuffisance) + kali- (potassium, lat. *kalium*) + -émie : potassium sanguin inférieur à 3,5 mmol/L. **Hyperurémie** (ou urée élevée) et **hypercréatininémie** : taux sanguins d'urée et de créatinine augmentés.

Anémie : an- (privatif) + -émie : hémoglobine insuffisante (11,8 g/dL < 13 g/dL chez l'homme). **Macrocytose** : macro- (grand) + cyt- (cellule) + -ose : globules rouges trop gros (VGM > 100 fL) : on parle d'**anémie macrocytaire**. **Hyperleucocytose** : hyper- + leuc(o)- (blanc) + cyt- + -ose : globules blancs en excès. **Hypoalbuminémie** : hypo- + albumin- + -émie : albumine sanguine inférieure à 35 g/L.

Question 2

L'**hypernatrémie** traduit un **manque d'eau** par rapport au sodium : c'est le signe biologique d'une **déshydratation intracellulaire** (l'eau quitte les cellules, ce qui explique la confusion). L'**urée** augmente davantage que la créatinine car la baisse du volume sanguin réduit la filtration rénale et augmente la réabsorption de l'urée : c'est une **insuffisance rénale fonctionnelle** (dite prérénale), qui doit régresser avec la réhydratation.

Question 3

Non. Le diabète se diagnostique par une glycémie **à jeun** ≥ 1,26 g/L à **deux reprises**, ou par une glycémie ≥ 2,00 g/L à n'importe quel moment de la journée associée à des signes cliniques (polyurie, polydipsie, amaigrissement). Ici le prélèvement n'est pas à jeun et il existe une **infection** (stress), qui élève la glycémie : on parle d'**hyperglycémie** modérée, à contrôler à jeun. Conversion : 1,32 × 5,55 = **7,3 mmol/L**.

Question 4

IMC = 58 / 1,72² = 58 / 2,958 = **19,6 kg/m²**. Perte de poids : (63 − 58) / 63 = 5 / 63 = **7,9 %** en 3 mois.

HAS 2021 (70 ans et plus) : le diagnostic exige **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**. Critères phénotypiques : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois (ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie) ; **IMC < 22 kg/m²** ; sarcopénie confirmée. Ici, **IMC 19,6 < 22** : critère phénotypique présent (la perte de 7,9 % en 3 mois n'atteint pas les seuils). Critères étiologiques : **réduction des apports** (moitié des repas) et **situation d'agression** (infection, CRP 45 mg/L) : présents. La **dénutrition est donc retenue**. Sévérité : **IMC < 20** : critère de **dénutrition sévère** (un seul critère de sévérité suffit).

Question 5

L'albumine est une protéine **de phase aiguë négative** : sa synthèse hépatique **diminue** lors de l'**inflammation** (CRP élevée) ; de plus, la déshydratation concentre le sang et peut la surestimer. Elle n'est **pas un critère diagnostique** de la dénutrition selon la HAS ; elle sert à apprécier la **sévérité** (sévère si < 30 g/L chez la personne âgée) et doit toujours être lue avec la CRP et l'état d'hydratation. On recontrôlera le bilan après réhydratation et guérison de l'infection.

Exercice de synthèse – un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann

Exercice type examen 29.3

Un compte rendu opératoire : l'intervention de Hartmann – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 64 ans, a été opéré en urgence. Il est transféré en chirurgie viscérale avec une poche collée sur l'abdomen. Le diététicien est appelé pour la reprise alimentaire. Il lit le compte rendu opératoire (extrait, cas fictif).

Document 1

Indication : **péritonite stercorale** sur perforation d'une **sigmoïdite diverticulaire**. ATCD : **diverticulose** colique connue depuis une **coloscopie** réalisée à 58 ans.

Intervention : **laparotomie** médiane ; lavage abondant de la cavité péritonéale ; **sigmoïdectomie** emportant la perforation ; fermeture du **moignon** rectal ; **colostomie** terminale en fosse iliaque gauche (intervention de Hartmann). Pas d'**anastomose** en milieu septique. Rétablissement de la continuité digestive envisagé à 3 à 6 mois.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : péritonite, sigmoïdite, diverticulose, coloscopie, laparotomie, sigmoïdectomie, colostomie, anastomose. *(8 pts)*

2. Distinguez à l'aide de trois exemples les suffixes -tomie, -ectomie et -stomie. *(3 pts)*

3. Expliquez la différence entre diverticulose et diverticulite, et pourquoi le chirurgien n'a pas réalisé d'anastomose immédiate. *(3 pts)*

4. « Stercoral » vient du latin *stercus, stercoris*. Proposez un sens et expliquez la gravité de cette péritonite. *(2 pts)*

5. Comparez les conséquences alimentaires d'une colostomie gauche et d'une iléostomie, puis donnez deux conseils à M. D. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.3

Question 1

Péritonite : périton- (péritoine, gr. *peritonaion*, « tendu autour ») + -ite : inflammation, ici infectieuse, du péritoine. **Sigmoïdite** : inflammation du côlon sigmoïde (en forme de sigma, ς). **Diverticulose** : diverticul- (lat. *diverticulum*, chemin détourné) + -ose (état non inflammatoire) : présence de multiples **diverticules**, petites hernies de la muqueuse à travers la paroi du côlon.

Coloscopie : col(o)- (côlon) + -scopie (examen visuel) : exploration endoscopique du côlon. **Laparotomie** : lapar(o)- (gr. *lapara*, flanc, abdomen) + -tomie (incision) : ouverture chirurgicale de la paroi abdominale. **Sigmoïdectomie** : ablation du côlon sigmoïde.

Colostomie : col(o)- + -stomie (gr. *stoma*, bouche) : abouchement du côlon à la peau, créant un **anus artificiel**. **Anastomose** (gr. *anastomôsis*, ouverture, abouchement) : raccordement chirurgical de deux conduits (ici, côlon et rectum) pour rétablir la continuité.

Question 2

-tomie = incision, ouverture (laparotomie, trachéotomie : ouverture de la trachée) ; **-ectomie** = ablation (sigmoïdectomie, gastrectomie) ; **-stomie** = abouchement d'un organe creux à la peau ou à un autre organe, créant un orifice durable (colostomie, gastrostomie, iléostomie).

Question 3

La **diverticulose** est la simple présence de diverticules, souvent sans symptôme (-ose : état) ; la **diverticulite** est leur **inflammation** ou infection (-ite), avec douleur de la fosse iliaque gauche et fièvre, compliquée ici de **perforation**. En milieu **septique** (infecté, gr. *sêptikos*, qui putréfie), une suture entre deux segments du côlon risquerait de **lâcher** (fistule) : le chirurgien préfère une stomie temporaire et différer l'anastomose.

Question 4

Stercus signifie **excrément** : la péritonite stercorale est due à l'issue de **matières fécales** dans la cavité péritonéale. Les bactéries du côlon y provoquent une infection massive, avec un risque de choc septique : c'est une urgence chirurgicale vitale.

Question 5

Une **colostomie gauche** évacue des selles **moulées** : l'eau et les électrolytes ont déjà été réabsorbés par la plus grande partie du côlon ; l'alimentation est **normale**, sans régime restrictif. Une **iléostomie** (abouchement de l'iléon) évacue des selles **liquides** et abondantes (souvent 0,5 à 1 L/j, parfois plus) : risque de **déshydratation**, de perte de **sodium** et de potassium ; il faut boire suffisamment, saler et surveiller la diurèse.

Conseils à M. D. : 1) reprendre une **alimentation variée et normale** dès que le chirurgien l'autorise, en mangeant lentement et en mastiquant bien ; 2) repérer et limiter **selon la tolérance** les aliments qui donnent beaucoup de **gaz** ou d'odeurs (choux, légumes secs, boissons gazeuses), sans les supprimer d'emblée ; boire 1,5 L par jour pour éviter la constipation.

Exercice de synthèse – une décompensation cardiaque

Exercice type examen 29.4

Une décompensation cardiaque : traduire et agir – 20 points · durée conseillée : 45 min

Mme G., 81 ans, est hospitalisée en cardiologie. Le diététicien doit lui expliquer son régime avant la sortie. Il lit l'observation médicale (extrait, cas fictif).

Document 1

Motif : **dyspnée** d'aggravation progressive depuis 10 jours, devenue présente au moindre effort, puis **orthopnée** (trois oreillers). Prise de poids de 4 kg en une semaine.

Examen : FC 112/min, irrégulière (**tachyarythmie** par **FA**) ; PA 145/85 mmHg ; **œdèmes** des membres inférieurs bilatéraux prenant le godet ; crépitants aux deux bases pulmonaires. **Radiographie**

thoracique : **cardiomégalie**, **épanchement pleural** droit. **Biologie** : NT-proBNP très élevé ; natrémie 131 mmol/L.

Conclusion : **insuffisance cardiaque** gauche **décompensée**. Traitement : **diurétique** de l'anse (furosémide), anticoagulant ; **régime hyposodé** ; restriction hydrique à 1 L/j tant que la natrémie est basse.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : dyspnée, orthopnée, tachyarythmie, cardiomégalie, hyponatrémie, diurétique. *(6 pts)*

2. Expliquez le terme « œdème » et ce que signifie l'expression « prenant le godet ». *(2 pts)*

3. Expliquez la relation entre la prise de poids de 4 kg, les œdèmes et le sel, puis l'intérêt d'une pesée quotidienne après le retour à domicile. *(4 pts)*

4. Traduisez « restriction hydrique à 1 L/j » et indiquez ce qui est compté dans ce litre. *(3 pts)*

5. Rédigez en langage courant trois conseils pour le régime hyposodé de Mme G., en précisant la quantité de sel visée. *(5 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.4

Question 1

Dyspnée : dys- (difficulté) + -pnée (respiration) : gêne respiratoire, essoufflement. **Orthopnée** : orth(o)- (droit) + -pnée : dyspnée en position couchée, soulagée par la position assise ou demi-assise (d'où les oreillers). **Tachyarythmie** : tachy- (rapide) + a- (privatif) + rythm- + -ie : rythme cardiaque rapide et irrégulier.

Cardiomégalie : cardi(o)- (cœur) + -mégalie (augmentation de volume) : cœur augmenté de volume à la radiographie. **Hyponatrémie** : sodium sanguin inférieur à 135 mmol/L. **Diurétique** : dia- (à travers) + our- (urine) + -ique : médicament qui augmente l'élimination de l'eau et du sodium par les urines.

Question 2

Œdème (gr. *oidêma*, gonflement) : accumulation de liquide dans le tissu interstitiel. « Prenant le godet » : la pression du doigt laisse une **dépression** (un « godet ») qui persiste quelques secondes, ce qui confirme qu'il s'agit d'eau infiltrée dans les tissus.

Question 3

Le cœur pompe mal ; le rein, mal perfusé, **retient le sodium**, et l'eau le suit : le volume extracellulaire augmente, ce qui se traduit par des œdèmes, un épanchement pleural et une **prise de poids** (1 L d'eau retenue ≈ 1 kg). Les 4 kg pris en une semaine correspondent donc surtout à de l'eau. Une **pesée quotidienne**, le matin à jeun, dans les mêmes conditions, permet de détecter une **rétention** débutante : une prise de poids rapide (de l'ordre de 2 kg en 3 jours) doit faire **appeler le médecin** avant l'apparition de la dyspnée.

Question 4

« Restriction hydrique » : limitation des **apports d'eau** (gr. *hudôr*, eau) à 1 litre par 24 heures. Ce litre comprend **toutes les boissons** (eau, café, thé, lait, jus, bouillon) et les aliments **liquides** ou très riches en eau servis comme boissons (potage, laitages liquides, eau gélifiée, compléments buvables) ; l'eau contenue dans les aliments solides n'est habituellement pas comptée.

Question 5

Objectif usuel : **environ 5 à 6 g de sel par jour** (régime hyposodé « modéré »), sans tomber dans un régime trop strict chez une personne âgée, qui risquerait de faire chuter les apports et de favoriser la dénutrition.

1) « Ne resalez pas à table et salez peu en cuisine ; relevez le goût avec des herbes, des épices, de l'ail, du citron. » 2) « Limitez les aliments très salés : charcuteries, fromages à pâte dure, plats préparés, soupes industrielles, biscuits apéritifs, et certaines eaux gazeuses riches en sodium ; lisez la ligne "sel" des étiquettes. » 3) « Le pain contient du sel : gardez-en une quantité habituelle mais raisonnable, et préférez les produits frais cuisinés à la maison. » On veillera à maintenir un apport énergétique et protéique suffisant.

Exercice de synthèse – une maladie rénale chronique d'origine diabétique

Exercice type examen 29.5

Une maladie rénale chronique d'origine diabétique – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. K., 59 ans, diabétique de type 2 depuis 18 ans, est suivi en néphrologie. Il consulte le diététicien avec le dernier courrier du néphrologue (extrait, cas fictif).

Document 1

« Je revois M. K. pour sa **néphropathie** diabétique, compliquée d'une **maladie rénale chronique** de stade 4 (DFG estimé à **22 mL/min/1,73 m²**). **Protéinurie** à 1,8 g/24 h. On note une **hyperkaliémie** à 5,8 mmol/L, une **hyperphosphatémie** à 1,90 mmol/L (0,80 à 1,45) et une **anémie normocytaire** à 10,4 g/dL, d'origine rénale, qui justifie un traitement par **érythropoïétine**. Il existe également une **rétinopathie** et une **neuropathie** périphérique. Nous préparons une **hémodialyse** : création d'une **fistule artérioveineuse** au bras gauche. »

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : néphropathie, protéinurie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie, normocytaire, érythropoïétine, hémodialyse. *(7 pts)*

2. Les termes « rétinopathie » et « neuropathie » complètent « néphropathie ». Expliquez ce qu'ont en commun ces trois complications du diabète et nommez la quatrième famille de complications, de nature vasculaire. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'insuffisance rénale chronique provoque une anémie, en vous appuyant sur l'étymologie d'« érythropoïétine ». *(3 pts)*

4. Expliquez ce qu'est une fistule artérioveineuse et pourquoi on la crée avant la dialyse. *(2 pts)*

5. Indiquez, pour chacune des anomalies biologiques (kaliémie, phosphatémie), une orientation diététique ; précisez comment évolue l'apport protéique conseillé quand le patient passe en hémodialyse. *(5 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.5

Question 1

Néphropathie : néphr(o)- (rein, gr. *nephros*) + -pathie (maladie) : maladie du rein. **Protéinurie** : protéin- + -urie (dans l'urine) : présence de protéines dans l'urine (normale < 0,15 g/24 h). **Hyperkaliémie** : potassium sanguin supérieur à 5,0 mmol/L. **Hyperphosphatémie** : phosphate sanguin supérieur à la normale (1,90 > 1,45 mmol/L).

Normocytaire : norm(o)- (normal) + cyt- (cellule) + -aire : globules rouges de taille normale (VGM 80 à 100 fL). **Érythropoïétine** : érythr(o)- (rouge) + -poïèse (gr. *poiêsis*, fabrication) + -ine : hormone qui stimule la **fabrication des globules rouges**. **Hémodialyse** : hém(o)- (sang) + dia- (à travers) + -lyse (gr. *lusis*, séparation) : épuration du sang à travers une membrane semi-perméable, dans un circuit extracorporel.

Question 2

Le suffixe **-pathie** (maladie, sans préjuger du mécanisme) : rétinopathie (rétine), neuropathie (nerfs), néphropathie (rein). Ces trois atteintes sont des complications **microangiopathiques** (micr(o)- + angi(o)- + -pathie : maladie des **petits vaisseaux**) dues à l'hyperglycémie chronique. La quatrième famille est la **macroangiopathie** (gros vaisseaux : coronaropathie, AVC, artériopathie des membres inférieurs).

Question 3

L'**érythropoïétine** (EPO), littéralement « ce qui fabrique le rouge », est une hormone **sécrétée par le rein** en réponse au manque d'oxygène. Lorsque la masse rénale fonctionnelle diminue, la sécrétion d'EPO baisse : la moelle osseuse produit moins de globules rouges, d'où une anémie **normocytaire** (globules de taille normale, mais en nombre insuffisant), traitée par EPO de synthèse.

Question 4

Une **fistule** (lat. *fistula*, tuyau) est une communication anormale entre deux cavités ; la fistule **artérioveineuse** est créée chirurgicalement entre une artère et une veine du bras : la veine, soumise à un fort débit, se dilate et s'épaissit, ce qui permet de la **ponctionner** facilement à chaque séance et d'obtenir le débit sanguin nécessaire à la dialyse. Elle doit être créée plusieurs semaines à l'avance pour avoir le temps de se développer.

Question 5

Hyperkaliémie : limiter les aliments les plus riches en potassium (fruits secs et oléagineux, chocolat, légumes secs, certains fruits comme la banane), utiliser des modes de cuisson qui en éliminent une partie (épluchage, découpe, cuisson à grande eau en jetant l'eau), éviter les sels de régime à base de potassium. **Hyperphosphatémie** : limiter les aliments riches en phosphore **ajouté** (additifs phosphatés des charcuteries, fromages fondus, sodas de type cola), modérer les fromages ; les chélateurs du phosphore, s'ils sont prescrits, se prennent au cours des repas.

Protéines : avant la dialyse, apport **modéré**, de l'ordre de **0,6 à 0,8 g/kg/j** chez le diabétique, avec un apport énergétique suffisant ; en **hémodialyse**,

les besoins **augmentent** (pertes d'acides aminés dans le dialysat, catabolisme) : environ **1,0 à 1,2 g/kg/j**. Toute restriction doit éviter la dénutrition, fréquente chez le dialysé.

Exercice de synthèse – la découverte d'un diabète de type 1

Exercice type examen 29.6

La découverte d'un diabète de type 1 chez un adolescent – 20 points · durée conseillée : 45 min

Lucas, 15 ans, est hospitalisé en pédiatrie. Le diététicien le rencontre avec ses parents pour l'éducation thérapeutique. Le dossier mentionne les éléments suivants (cas fictif).

Document 1

Histoire : depuis trois semaines, **polyurie** avec **nycturie**, **polydipsie** (5 L/j), **polyphagie** et pourtant **amaigrissement** de 5 kg ; **asthénie** croissante. Admis pour douleurs abdominales et **vomissements**.

Biologie : glycémie **4,2 g/L** ; **glycosurie** et **cétonurie** à la bandelette ; pH sanguin 7,21 (7,38 à 7,42) : **acidocétose** diabétique. HbA1c 11,5 %.

Traitement : réhydratation, **insulinothérapie** intraveineuse puis schéma **basal-bolus** sous-cutané ; éducation à la prévention de l'**hypoglycémie**.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : polyurie, nycturie, polydipsie, polyphagie, glycosurie, cétonurie, hypoglycémie. *(7 pts)*

2. Convertissez la glycémie de Lucas en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L) et comparez-la aux valeurs de référence à jeun. *(2 pts)*

3. Expliquez l'enchaînement hyperglycémie → glycosurie → polyurie → polydipsie. *(4 pts)*

4. Expliquez le terme « acidocétose » et pourquoi Lucas a maigri malgré la polyphagie. *(4 pts)*

5. Définissez « HbA1c » et « insulinothérapie basal-bolus » en des mots accessibles à un adolescent. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.6

Question 1

Polyurie : poly- (nombreux, abondant) + -urie : urines abondantes (plus de 2,5 à 3 L/24 h chez l'adulte). **Nycturie** : nyct- (gr. *nux, nuktos*, nuit) + -urie : mictions nocturnes. **Polydipsie** : poly- + dips- (soif) + -ie : soif intense et besoin de boire beaucoup. **Polyphagie** : poly- + phag- (manger) + -ie : faim excessive.

Glycosurie : glyc(o)- (sucre) + -urie : présence de glucose dans l'urine. **Cétonurie** : présence de **corps cétoniques** dans l'urine. **Hypoglycémie** : hypo- (insuffisance) + glyc- + -émie : glycémie trop basse, inférieure à **0,70 g/L** (3,9 mmol/L) chez le diabétique traité.

Question 2

4,2 × 5,55 = **23,3 mmol/L**. Glycémie normale à jeun : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; seuil du diabète à jeun : 1,26 g/L (7,0 mmol/L). La glycémie de Lucas est près de **quatre fois** la limite supérieure de la normale.

Question 3

Au-delà d'environ **1,8 g/L** (seuil rénal), les transporteurs du tubule rénal sont saturés et ne réabsorbent plus tout le glucose filtré : il apparaît dans l'urine (**glycosurie**). Le glucose attire l'eau par effet **osmotique** : le volume urinaire augmente (**polyurie**, **diurèse osmotique**). La perte d'eau entraîne une déshydratation qui déclenche la **soif** (**polydipsie**).

Question 4

Acidocétose : acid- (acide) + cét- (corps cétoniques) + -ose (état) : accumulation de corps cétoniques acides dans le sang, qui fait baisser le **pH** (7,21 < 7,38). Sans insuline, le glucose n'entre plus dans les cellules musculaires et adipeuses : l'organisme se comporte comme s'il jeûnait. Il **dégrade ses graisses** (lipolyse) et ses **protéines musculaires** ; le foie transforme les acides gras en corps cétoniques. Le sucre mangé est perdu dans les urines : d'où l'**amaigrissement** malgré une alimentation abondante.

Question 5

HbA1c (hémoglobine glyquée) : part de l'hémoglobine des globules rouges qui a fixé du sucre ; comme un globule rouge vit environ **120 jours**, elle reflète la **moyenne des glycémies des 2 à 3 derniers mois** (11,5 % : très élevée ; objectif habituel < 7 % chez l'enfant et l'adolescent selon l'ISPAD (2022), à individualiser). **Basal-bolus** : une

insuline **lente** (« basale ») couvre les besoins de fond sur 24 h, et des doses d'insuline **rapide** (« bolus ») sont injectées à chaque repas, adaptées à la quantité de **glucides** consommée.

Exercice de synthèse – construire et décomposer vingt termes

Exercice type examen 29.7

Construire et décomposer : vingt termes en miroir – 20 points · durée conseillée : 40 min

Cet exercice entraîne les deux sens du travail terminologique : **construire** un terme à partir de sa définition, puis **décomposer** un terme pour en retrouver le sens. Chaque réponse exacte rapporte 1 point (orthographe comprise).

Travail à faire

1. Construisez le terme qui correspond à chaque définition : a) inflammation de l'estomac ; b) ablation de la rate ; c) douleur musculaire ; d) ouverture chirurgicale de la trachée ; e) présence de sang dans l'urine ; f) vomissement de sang ; g) augmentation du volume du foie ; h) peur de manger ; i) examen visuel de l'intérieur des bronches ; j) étude des tissus. *(10 pts)*

2. Décomposez et définissez : a) ostéoporose ; b) hémiplégie ; c) bradycardie ; d) polynévrite ; e) leucopénie ; f) gastrectomie ; g) adénome ; h) hydrocéphalie ; i) arthrose ; j) aménorrhée. *(10 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.7

Question 1

a) **gastrite** (gastr- + -ite) ; b) **splénectomie** (splén- + -ectomie) ; c) **myalgie** (my(o)- + -algie) ; d) **trachéotomie** (trachéo- + -tomie) ; e) **hématurie** (hémat- + -urie) ; f) **hématémèse** (hémat- + gr. *emesis*, vomissement) ; g) **hépatomégalie** (hépat(o)- + -mégalie) ; h) **sitiophobie** ou **cibophobie** (sitio-, gr. *sition*, nourriture, ou lat. *cibus*, + -phobie) ; i) **bronchoscopie** (bronch(o)- + -scopie) ; j) **histologie** (hist(o)- + -logie).

Question 2

a) **ostéoporose** : osté(o)- (os) + gr. *poros* (pore, passage) + -ose : raréfaction et fragilisation du tissu osseux. b) **hémiplégie** : hémi- (moitié) + -plégie (paralysie) : paralysie d'une moitié (droite ou gauche) du corps. c) **bradycardie** : brady- (lent) + card- + -ie : fréquence cardiaque inférieure à 60/min. d) **polynévrite** : poly- + névr- (nerf) + -ite : atteinte de plusieurs nerfs, souvent symétrique (le terme **polyneuropathie** est préféré quand il n'y a pas d'inflammation). e) **leucopénie** : leuc(o)- (blanc) + -pénie (manque) : diminution du nombre de globules blancs.

f) **gastrectomie** : ablation de tout ou partie de l'estomac. g) **adénome** : adén(o)- (glande) + -ome (tumeur) : tumeur **bénigne** d'une glande ou d'un épithélium glandulaire. h) **hydrocéphalie** : hydr(o)- (eau) + céphal- (tête) + -ie : accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans les cavités du cerveau. i) **arthrose** : arthr- (articulation) + -ose : usure dégénérative, non inflammatoire, du cartilage articulaire (à distinguer de l'**arthrite**, inflammatoire). j) **aménorrhée** : a- (privatif) + mén- (mois, règles) + -rrhée (écoulement) : absence de règles.

Exercice de synthèse – les pièges de la terminologie

Exercice type examen 29.8

Les pièges de la terminologie : paronymes et faux amis – 20 points · durée conseillée : 40 min

Une stagiaire diététicienne a rédigé des transmissions dans le dossier de soins. Sa tutrice relève dix erreurs de vocabulaire. Retrouvez-les.

Document 1

1. « Patient opéré d'une **iléostomie** de la hanche. » 2. « Présente une **hémoptysie** : vomissements de sang rouge. » 3. « **Hypoglycémie** à 2,10 g/L ce matin. » 4. « Glycosurie positive : présence de sucre dans le sang. » 5. « Selles noires et goudronneuses : **mélanome** probable. »

6. « Patiente **anurique** : urines peu abondantes, 600 mL/24 h. » 7. « Douleur à la miction (**pollakiurie**). » 8. « **Gastrotomie** posée par voie endoscopique pour la nutrition entérale. » 9. « Patient **apyrétique** à 38,7 °C. » 10. « **Dysphagie** : ne ressent plus la faim. »

Travail à faire

1. Pour chaque transmission, identifiez le terme erroné, proposez le terme exact et justifiez par l'étymologie. *(15 pts)*

2. Classez les quatre termes suivants selon le volume urinaire de 24 h : polyurie, anurie, oligurie, diurèse normale ; donnez les seuils usuels chez l'adulte. *(3 pts)*

3. Proposez une règle de prudence pour écrire dans un dossier patient. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.8

Question 1

1. **Iléostomie** (abouchement de l'**iléon**, intestin grêle) est confondu avec l'**os iliaque** (ili(o)-, lat. *ilium*, flanc) ; la hanche ne fait pas l'objet d'une stomie : il s'agit sans doute d'une **arthroplastie** (prothèse) de hanche. 2. L'**hémoptysie** (gr. *ptusis*, crachement) est un **crachat** de sang venu des voies respiratoires ; le vomissement de sang est une **hématémèse**. 3. 2,10 g/L est une **hyperglycémie** (hyper-, excès) ; l'hypoglycémie est < 0,70 g/L.

4. **-urie** = dans l'urine : la glycosurie est le sucre dans l'**urine** ; dans le sang, on parle de **glycémie** (-émie). 5. Les selles noires sont un **méléna** (gr. *melas*, noir) : sang digéré venu du haut du tube digestif ; le **mélanome** (mélan- + -ome) est une tumeur maligne des mélanocytes. Les deux termes partagent la racine « noir » mais n'ont aucun rapport clinique. 6. **Anurie** (an- privatif) = absence ou quasi-absence d'urine (< 100 mL/24 h) ; 600 mL/24 h ne relève pas de l'anurie ni même de l'oligurie (< 500 mL/24 h) : on écrira « **diurèse faible**, 600 mL/24 h ».

7. **Pollakiurie** (gr. *pollakis*, souvent) = mictions **fréquentes** ; la douleur à la miction est une **brûlure mictionnelle** ou une **dysurie** si la miction est difficile. 8. **Gastrotomie** (-tomie) = simple **incision** de l'estomac ; le dispositif d'alimentation est une **gastrostomie** (-stomie) percutanée endoscopique (GPE). 9. **Apyrétique** (a- + gr. *puretos*, fièvre) = **sans** fièvre ; à 38,7 °C le patient est **fébrile** (pyrétique). 10. **Dysphagie** (dys- + -phagie) = **difficulté à avaler** ; l'absence de faim est une **anorexie** (an- + gr. *orexis*, appétit).

Question 2

Anurie < 100 mL/24 h < **oligurie** < 500 mL/24 h ≤ **diurèse normale** (environ 0,5 à 2,5 L/24 h, selon les apports) < **polyurie** au-delà de 2,5 à 3 L/24 h.

Question 3

N'écrire un terme médical que si l'on est **certain** de son sens ; sinon, **décrire** ce que l'on observe en langage simple et mesuré (« a vomi du sang rouge à 10 h, environ un verre ») ; vérifier le préfixe (hypo-/hyper-) et le suffixe (-émie/-urie ; -tomie/-ectomie/-stomie) ; n'utiliser que des abréviations usuelles ; signer et dater.

Exercice de synthèse – une BPCO et une dénutrition

Exercice type examen 29.9

Une BPCO et une dénutrition : reformuler pour le patient – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. A., 70 ans, ancien fumeur (45 paquets-années), est hospitalisé en pneumologie. Le diététicien doit **expliquer au patient**, avec des mots simples, ce que contient son dossier, puis rédiger une **transmission** pour l'équipe (extrait du dossier, cas fictif).

Document 1

« **Exacerbation** de **BPCO** de stade sévère. **Polypnée** à 28/min, **cyanose** des lèvres, **SpO₂** 86 % en air ambiant. Gaz du sang : **hypoxémie** et **hypercapnie**. **Oxygénothérapie** à 2 L/min. **Antibiothérapie** et **corticothérapie** par voie orale. »

« Poids 52 kg (58,5 kg il y a 6 mois), taille 1,71 m. Fonte musculaire importante, force de préhension diminuée : **sarcopénie** probable. Apports estimés à la moitié des besoins, **dyspnée** à l'effort au cours des repas. Aspect **cachectique**. »

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : exacerbation, polypnée, cyanose, hypoxémie, hypercapnie, oxygénothérapie, sarcopénie, cachectique. *(8 pts)*

2. Développez les sigles BPCO et SpO_2. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids en pourcentage ; concluez sur la dénutrition selon la HAS (2021) et sur sa sévérité. *(4 pts)*

4. Reformulez pour M. A., en trois ou quatre phrases sans jargon, ce qui lui arrive sur le plan respiratoire et nutritionnel. *(3 pts)*

5. Rédigez une transmission ciblée (cible, données, actions, résultats attendus) destinée à l'équipe soignante. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.9

Question 1

Exacerbation (lat. *ex-* + *acerbus*, aigre, âpre) : aggravation aiguë des symptômes d'une maladie chronique. **Polypnée** : poly- + -pnée : respiration rapide (au-delà de 20/min chez l'adulte). **Cyanose** (gr. *kuanos*, bleu sombre, + -ose) : coloration bleutée de la peau et des muqueuses due au manque d'oxygène du sang. **Hypoxémie** : hyp(o)- + ox- (oxygène) + -émie : oxygène insuffisant dans le sang artériel.

Hypercapnie : hyper- + capn- (gr. *kapnos*, fumée, ici gaz carbonique) + -ie : excès de CO_2 dans le sang. **Oxygénothérapie** : apport d'oxygène à visée thérapeutique (-thérapie, traitement). **Sarcopénie** : sarc(o)- (chair, muscle) + -pénie (manque) : perte de masse **et** de force musculaires. **Cachectique** : en état de **cachexie** (gr. *kakos*, mauvais, + *hexis*, état) : amaigrissement extrême avec fonte musculaire, liée à une maladie chronique.

Question 2

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive. **SpO_2** : saturation **pulsée** en oxygène (mesurée au doigt par un oxymètre de pouls), normale ≥ 95 % chez l'adulte sain.

Question 3

IMC = 52 / 1,71² = 52 / 2,924 = **17,8 kg/m²**. Perte = (58,5 − 52) / 58,5 = 6,5 / 58,5 = **11,1 %** en 6 mois.

HAS 2021 (70 ans et plus) : critères phénotypiques présents (**perte ≥ 10 % en 6 mois**, **IMC < 22**, **sarcopénie**) ; critères étiologiques présents (**apports réduits** de moitié, **maladie chronique** inflammatoire en exacerbation). **Dénutrition** retenue. Sévérité : **IMC < 20** : dénutrition **sévère** (la perte de 11,1 % en 6 mois, inférieure à 15 %, relèverait seulement de la forme modérée, mais un seul critère de sévérité suffit).

Question 4

Exemple : « Vos bronches sont abîmées par le tabac, et une infection a aggravé votre souffle : votre sang manque d'oxygène et garde trop de gaz carbonique, c'est pourquoi on vous donne de l'oxygène. Respirer vous demande beaucoup d'énergie, et vous mangez moins parce que vous êtes essoufflé à table : vous avez perdu 6,5 kg et surtout du muscle. Nous allons vous proposer des repas plus petits, plus nombreux et plus riches, pour retrouver des forces. »

Question 5

Cible : dénutrition sévère. **Données** : IMC 17,8 kg/m² ; perte de 11,1 % en 6 mois ; apports ≈ 50 % des besoins ; dyspnée au cours des repas ; sarcopénie probable. **Actions** : alimentation **enrichie** et **fractionnée** (6 prises/j), textures faciles à mâcher, **CNO** hyperénergétiques et hyperprotidiques (2 par jour, entre les repas), oxygène maintenu pendant les repas si prescrit, pesée hebdomadaire, relevé des ingesta sur 3 jours. **Résultats attendus** : apports ≥ 75 % des besoins en une semaine ; stabilisation puis reprise de poids ; réévaluation en lien avec le kinésithérapeute (activité physique adaptée).

29.4 APPROFONDISSEMENTS

29.4.1 Lire et rédiger dans le dossier patient

Module • *Bloc 3 du référentiel (communiquer, assurer la traçabilité) · guide 2025 p. 18 (diagnostic diététique) · TIDN*

Le diététicien **lit** les écrits des autres professionnels (comptes rendus, prescriptions, observations infirmières) et **écrit** lui-même dans le dossier patient : bilan diététique, diagnostic diététique, transmissions, courriers de liaison, comptes rendus de consultation. Le référentiel (bloc 3) lui demande de « communiquer avec les autres professionnels » et d'« assurer la traçabilité » de ses interventions. Ces écrits ont une valeur **médico-légale** : ils engagent leur auteur et doivent être **exacts**, **datés**, **signés** et compréhensibles par tous les soignants.

Les règles de rédaction dans le dossier patient

Méthode – six règles pour écrire dans le dossier

1. Être exact : n'employer un terme médical que si l'on est sûr de son sens ; distinguer ce qui est **observé** (« a mangé la moitié du plat ») de ce qui est **interprété** (« apports insuffisants ») et de ce qui est **rapporté** par le patient (« dit ne plus avoir d'appétit »).

2. Être précis et mesurable : chiffres, unités et dates plutôt qu'adjectifs vagues : « perte de 4 kg en 2 mois (6,5 %) » plutôt que « a beaucoup maigri » ; « apports estimés à 1 100 kcal et 40 g de protéines par jour » plutôt que « mange peu ».

3. Être concis : phrases courtes, style nominal accepté ; pas de répétition de ce qui figure déjà dans le dossier, sauf pour justifier une action.

4. Limiter les abréviations aux sigles **usuels** de l'établissement ; développer les autres à la première occurrence ; ne jamais inventer d'abréviation.

5. Rester dans son champ de compétence : le diététicien formule un **diagnostic diététique**, pas un diagnostic médical ; il **signale** une anomalie (« glycémies capillaires supérieures à 2,5 g/L à trois reprises ») au médecin, sans conclure à une maladie.

6. Respecter la personne : pas de jugement (« patient non compliant », « refuse de faire des efforts ») mais des faits (« n'a pas pris les compléments proposés ; dit ne pas en aimer le goût »).

Les transmissions ciblées

Les **transmissions ciblées** organisent l'information autour d'une **cible** (préoccupation, problème, événement, changement d'état) suivie de trois rubriques : **D**onnées (ce qui est observé, mesuré, rapporté), **A**ctions (ce qui a été fait ou proposé), **R**ésultats (effet obtenu ou attendu, évaluation). On parle de transmissions **DAR**. Elles complètent le **diagramme de soins** (actes répétitifs) et le **plan de soins**.

Rubrique · Contenu · Exemple (patient âgé dysphagique)

Cible — *Contenu :* un mot ou une courte expression : problème, réaction, risque ; *Exemple (patient âgé dysphagique) :* Troubles de la déglutition

Données — *Contenu :* observations objectives, mesures, paroles du patient entre guillemets ; *Exemple (patient âgé dysphagique) :* toux à chaque gorgée d'eau ; voix « mouillée » après le repas ; a mangé 1/3 du plateau ; poids 61 kg (64 kg il y a 1 mois)

Actions — *Contenu :* interventions réalisées ou prévues, personnes informées ; *Exemple (patient âgé dysphagique) :* texture mixée lisse (IDDSI 4) et boissons modérément épaisses (IDDSI 3) mises en place ; installation assise à 90° ; avis de l'orthophoniste demandé ; médecin informé

Résultats — *Contenu :* évaluation, avec un délai ; *Exemple (patient âgé dysphagique) :* plus de toux au repas du soir ; consommation de 2/3 du plateau ; réévaluation des textures après le bilan orthophonique ; pesée dans 7 jours

Du diagnostic diététique à la rédaction

Le **diagnostic diététique** (format PES, terminologie TIDN : voir 29.3.6) se rédige en une phrase normalisée. Les trois **domaines** de la terminologie permettent de choisir le bon intitulé du **problème** : le domaine **apports** décrit une consommation (insuffisante, excessive, inadaptée en un nutriment) ; le domaine **clinique** décrit un état fonctionnel, biochimique ou pondéral lié à la nutrition (difficulté de déglutition, perte de poids involontaire, interaction aliment-médicament) ; le domaine **comportement et environnement** décrit les connaissances, les croyances, l'accès aux aliments ou l'activité physique.

Domaine · Problème (P) · Étiologie (E) · Signes et symptômes (S)

Apports — *Problème (P) :* apport insuffisant en protéines ; *Étiologie (E) :* dégoût de la viande et difficultés de mastication (prothèse dentaire inadaptée) ; *Signes et symptômes (S) :* apports estimés à 0,7 g/kg/j pour un besoin d'environ 1,0 à 1,2 g/kg/j ; perte de poids de 5 % en 1 mois

Clinique — *Problème (P) :* difficulté de déglutition ; *Étiologie (E) :* séquelles d'AVC (paralysie de la moitié droite du visage) ; *Signes et symptômes (S) :* toux au cours des repas, stase buccale, repas de plus de 45 min

Comportement et environnement — *Problème (P) :* déficit de connaissances en lien avec l'alimentation et la nutrition ; *Étiologie (E) :* diabète de type 2 découvert récemment ; aucune information antérieure ; *Signes et symptômes (S) :* ne sait pas identifier les aliments riches en glucides ; boit 1 L de jus de fruits par jour en pensant « faire du bien »

Attention

Ne pas confondre l'étiologie diététique et la cause médicale. Dans « difficulté de déglutition liée à des séquelles d'AVC », l'AVC est la cause médicale ; elle peut figurer dans l'étiologie si elle explique **directement** le problème nutritionnel, mais le diététicien ne la « diagnostique » pas : il la **reprend** du dossier. De même, « dénutrition » est un diagnostic **médical** codé par le médecin (CIM-10) ; le diététicien rédige un problème du type « apport énergétique insuffisant » ou « perte de poids involontaire », qu'il argumente.

Reformuler pour le patient

Le patient a le droit d'être informé sur son état de santé (Code de la santé publique, article L. 1111-2), par une information **claire, loyale et appropriée**. Reformuler n'est pas « simplifier le sens » : c'est remplacer un mot savant par sa **traduction exacte**, en vérifiant la compréhension (« Pouvez-vous me redire avec vos mots ce que vous allez changer ? » : technique du **reformuler-vérifier**, ou *teach-back*). La décomposition étymologique fournit souvent la reformulation.

Terme médical · Reformulation exacte · Terme médical · Reformulation exacte

hypertension artérielle — *Reformulation exacte :* pression du sang trop élevée dans les artères ; *Terme médical :* hypoglycémie ; *Reformulation exacte :* manque de sucre dans le sang

insuffisance rénale — *Reformulation exacte :* les reins filtrent moins bien le sang ; *Terme médical :* hypercholestérolémie ; *Reformulation exacte :* trop de cholestérol dans le sang

dyslipidémie — *Reformulation exacte :* anomalie des graisses du sang ; *Terme médical :* stéatose hépatique ; *Reformulation exacte :* accumulation de graisse dans le foie

dysphagie — *Reformulation exacte :* difficulté à avaler ; *Terme médical :* fausse route ; *Reformulation exacte :* aliment ou boisson qui passe « de travers », vers les poumons

gastrostomie — *Reformulation exacte :* petit tuyau qui traverse la peau du ventre et entre dans l'estomac ; *Terme médical :* nutrition entérale ; *Reformulation exacte :* alimentation liquide par un tuyau qui va dans le tube digestif

œdème — *Reformulation exacte :* gonflement dû à l'eau retenue dans les tissus ; *Terme médical :* diurétique ; *Reformulation exacte :* médicament qui fait uriner davantage

anémie — *Reformulation exacte :* manque de globules rouges ou d'hémoglobine ; *Terme médical :* carence martiale ; *Reformulation exacte :* manque de fer

ostéoporose — *Reformulation exacte :* os devenus moins denses et plus fragiles ; *Terme médical :* sarcopénie ; *Reformulation exacte :* perte de muscle et de force

asymptomatique — *Reformulation exacte :* qui ne donne aucun signe ressenti ; *Terme médical :* chronique ; *Reformulation exacte :* qui dure longtemps (pas forcément grave)

néphrolithiase — *Reformulation exacte :* calculs (« pierres ») dans les reins ; *Terme médical :* cholécystectomie ; *Reformulation exacte :* opération qui enlève la vésicule biliaire

S'entraîner – application

Rédigez le diagnostic diététique au format PES de la situation suivante : Mme T., 55 ans, a une obésité (IMC 36 kg/m²) ; elle saute le petit déjeuner et le déjeuner, puis grignote des biscuits et des chips de 17 h à 23 h devant la télévision (relevé alimentaire sur 3 jours : environ 2 900 kcal par jour, dont 45 % sous forme de produits gras et sucrés en dehors des repas). Elle dit : « je n'ai pas faim le matin et je n'ai pas le temps à midi ».

Corrigé

Exemple : « **Rythme alimentaire inadapté** (P) lié à une absence de repas structurés dans la journée pour des raisons d'organisation et d'absence de faim matinale (E), mis en évidence par 0 repas avant 17 h, une prise alimentaire continue de 17 h à 23 h et des apports estimés à 2 900 kcal/j dont 45 % issus de produits gras et sucrés consommés hors repas (S). » On peut aussi retenir « apport énergétique excessif » (domaine apports). Le terme « **obésité** » appartient au diagnostic médical ; il figure dans le dossier mais n'est pas le problème diététique formulé.

29.4.2 La terminologie de la nutrition clinique

Module · *HAS 2019 (adulte) et 2021 (70 ans et plus) · GLIM 2019 · EWGSOP2 2019 · IDDSI*

Les termes de la nutrition clinique ont des **définitions consensuelles**, fixées par des recommandations nationales (HAS) et internationales (GLIM, ESPEN, EWGSOP). Les employer « à peu près » conduit à des erreurs de prise en charge et de **codage** (la dénutrition codée dans le dossier modifie la valorisation du séjour hospitalier). Ce paragraphe donne les définitions de référence ; la prise en charge détaillée relève des chapitres de diététique thérapeutique.

Définitions de référence

Dénutrition : état d'un organisme en **déséquilibre nutritionnel**, caractérisé par un **bilan énergétique et/ou protéique négatif**, qui entraîne des effets délétères sur les tissus (changements mesurables des fonctions et de la composition corporelle) et une aggravation du pronostic des maladies (HAS-FFN 2019 pour l'adulte ; HAS-FFN 2021 pour la personne de 70 ans et plus).

Malnutrition : terme plus large (OMS) qui recouvre la **dénutrition**, les **carences** en micronutriments, le **surpoids** et l'**obésité**. En anglais, *malnutrition* désigne souvent la seule dénutrition : attention aux traductions.

Carence : apport ou statut insuffisant en **un** nutriment (carence en fer, carence en vitamine B12) ; **déficit** : manque mesuré par rapport à une norme ; **subcarence** : statut bas sans signe clinique.

Cachexie (gr. *kakos*, mauvais, + *hexis*, état) : syndrome métabolique complexe associé à une maladie chronique (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale), caractérisé par une **perte de masse musculaire**, avec ou sans perte de masse grasse, qui ne peut pas être entièrement corrigée par la seule renutrition (consensus d'Evans, 2008).

Sarcopénie (gr. *sarx, sarkos*, chair, + *penia*, manque ; terme proposé par I. Rosenberg en

1989) : maladie musculaire caractérisée par une **diminution de la force** musculaire, confirmée par une **diminution de la masse** ou de la qualité musculaire, et dite **sévère** si la **performance physique** est aussi diminuée (EWGSOP2, 2019).

Fragilité : syndrome gériatrique de réduction des réserves physiologiques qui augmente la vulnérabilité à un stress ; phénotype de Fried (2001) : perte de poids involontaire, épuisement, faiblesse (force de préhension), lenteur de la marche, faible activité physique ; **fragile** si 3 critères ou plus, **préfragile** si 1 ou 2.

Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : ensemble des troubles hydroélectrolytiques et métaboliques (surtout **hypophosphatémie**, hypokaliémie, hypomagnésémie, carence en **thiamine**, rétention hydrosodée) qui surviennent lors de la **reprise d'une alimentation** chez un patient sévèrement dénutri ou à jeun prolongé ; en anglais *refeeding syndrome*.

Les critères de la dénutrition selon la HAS

Les recommandations de la HAS reprennent la démarche internationale **GLIM** (*Global Leadership Initiative on Malnutrition*, 2019) : le diagnostic associe **au moins un critère phénotypique** (ce que l'on mesure sur le corps) et **au moins un critère étiologique** (ce qui explique la dénutrition). La sévérité est ensuite graduée. Les seuils diffèrent entre l'adulte (moins de 70 ans) et la personne âgée (70 ans et plus).

Critère · Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) · Personne de 70 ans et plus (HAS 2021)
Phénotypique : perte de poids — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* identique
Phénotypique : IMC — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* < 18,5 kg/m² ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* < 22 kg/m²
Phénotypique : muscle — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* sarcopénie confirmée (force et masse ou qualité musculaires réduites)
Étiologique — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines) ou absorption réduite ; situation d'agression (aiguë ou chronique) ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* identique
Sévérité : dénutrition sévère — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L
Sévérité : dénutrition modérée — *Adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) :* 17 < IMC < 18,5 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; 30 < albuminémie < 35 g/L ; *Personne de 70 ans et plus (HAS 2021) :* 20 ≤ IMC < 22 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; 30 ≤ albuminémie < 35 g/L

À RETENIR

Le diagnostic repose sur la **clinique** (poids, taille, histoire pondérale, apports, muscle) ; la **biologie** n'intervient que pour la sévérité. Un seul critère de sévérité suffit pour classer la dénutrition comme **sévère**. L'albuminémie, abaissée par l'inflammation, s'interprète avec la CRP. Chez l'adulte en **obésité**, la dénutrition est possible (critères de perte de poids et de muscle) : l'IMC élevé ne protège pas.

Les critères de la sarcopénie (EWGSOP2, 2019)

Étape · Mesure · Seuil (homme / femme)
1. Sarcopénie probable **: force basse** — *Mesure :* force de préhension (dynamomètre) ou test du lever de chaise (5 levers) ; *Seuil (homme / femme) :* < 27 kg / < 16 kg ; lever de chaise > 15 s
2. Sarcopénie confirmée **: masse basse** — *Mesure :* masse musculaire squelettique appendiculaire (DEXA, impédancemétrie) ; *Seuil (homme / femme) :* < 20 kg / < 15 kg (ou < 7,0 / < 5,5 kg/m²)
3. Sarcopénie sévère **: performance basse** — *Mesure :* vitesse de marche, SPPB, *timed up and go* (TUG) ; *Seuil (homme / femme) :* vitesse ≤ 0,8 m/s ; SPPB ≤ 8 ; TUG ≥ 20 s

Les autres termes de la nutrition clinique

Terme · Définition et précisions
bilan énergétique — différence entre les apports et les dépenses d'énergie ; négatif : perte de poids ; positif : prise de poids
bilan azoté — différence entre l'azote ingéré et l'azote excrété (surtout urinaire) ; négatif dans l'agression et la dénutrition (catabolisme protéique)
hypercatabolisme — hyper- + catabolisme (gr. *katabolê*, action de jeter en bas) : dégradation accrue des réserves, notamment protéiques, au cours de l'agression (infection, chirurgie, brûlure, cancer)
anabolisme — ensemble des synthèses (gr. *anabolê*, action de monter) ; la renutrition vise à restaurer un état anabolique
agression — réponse inflammatoire et hormonale de l'organisme à une maladie aiguë ou chronique, qui augmente les besoins et favorise le catabolisme
ingesta — lat. « choses ingérées » : ensemble des aliments et boissons effectivement consommés ; relevé des ingesta : évaluation quantitative sur 1 à 3 jours

MNA, NRS 2002, SGA — outils de dépistage ou d'évaluation : *Mini Nutritional Assessment* (personne âgée), *Nutritional Risk Screening* 2002 (hôpital), *Subjective Global Assessment*

impédancemétrie — impédance (opposition d'un milieu au passage d'un courant alternatif) + -métrie : estimation de l'eau totale, de la masse maigre et de la masse grasse

DEXA — absorptiométrie biphotonique à rayons X (*dual-energy X-ray absorptiometry*) : mesure de la densité osseuse et de la composition corporelle

obésité sarcopénique — association d'un excès de masse grasse et d'une sarcopénie (consensus ESPEN-EASO, 2022) ; masquée par un poids normal ou élevé

IMC (classes OMS) — maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (classe I : 30 à 34,9 ; classe II : 35 à 39,9 ; classe III : ≥ 40) ; ces seuils concernent l'adulte de moins de 70 ans

dysphagie oropharyngée, œsophagienne — difficulté de déglutition au moment de la propulsion du bol de la bouche vers le pharynx (toux, fausses routes) / au cours de la traversée de l'œsophage (blocage rétrosternal)

Les niveaux de texture IDDSI

Le cadre **IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*), élaboré par un groupe international entre 2013 et 2016, remplace les nombreuses appellations locales (« mouliné », « haché fin », « mixé », « eau gazeuse épaissie »…) par **huit niveaux numérotés de 0 à 7**, testés par des méthodes simples (écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s pour les boissons ; test de la fourchette et de la cuillère pour les aliments). Les intitulés français sont ceux de la traduction officielle.

Niveau · Boissons · Aliments · Exemples

0 — *Boissons :* fluide (*thin*) ; *Aliments :* – ; *Exemples :* eau, thé, café

1 — *Boissons :* très légèrement épais (*slightly thick*) ; *Aliments :* – ; *Exemples :* lait infantile épaissi, certains laits

2 — *Boissons :* légèrement épais (*mildly thick*) ; *Aliments :* – ; *Exemples :* nectar de fruits peu épais

3 — *Boissons :* modérément épais (*moderately thick*) ; *Aliments :* liquéfié (*liquidised*) ; *Exemples :* boisson épaissie se buvant à la tasse ; potage lisse

4 — *Boissons :* très épais (*extremely thick*) ; *Aliments :* purée (*pureed*) ; *Exemples :* eau gélifiée ; purée lisse, mixé lisse sans grumeaux

5 — *Boissons :* – ; *Aliments :* haché et humide (*minced and moist*) ; *Exemples :* viande hachée fine en sauce, morceaux ≤ 4 mm chez l'adulte

6 — *Boissons :* – ; *Aliments :* tendre et en petits morceaux (*soft and bite-sized*) ; *Exemples :* morceaux tendres ≤ 1,5 cm, écrasables à la fourchette

7 — *Boissons :* – ; *Aliments :* normal (*regular*) ; variante « facile à mâcher » (*easy to chew*) ; *Exemples :* alimentation courante

29.4.3 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche

Module · *Lien avec le bloc 4 (veille scientifique) et les chapitres de santé publique*

Le diététicien lit des **articles scientifiques**, des **recommandations** et des **rapports de santé publique**, et participe parfois à des études. Il doit comprendre leur vocabulaire méthodologique, issu lui aussi du grec et du latin : **épidémiologie** (gr. *epi*, sur, *dêmos*, peuple, *logos*), **étiologie** (gr. *aitia*, cause), **cohorte** (lat. *cohors*, unité de l'armée romaine), **placebo** (lat. « je plairai »).

Type d'étude · Principe · Ce qu'elle permet de conclure

étude descriptive (transversale) — *Principe :* photographie d'une population à un instant donné (enquête INCA, Esteban) ; *Ce qu'elle permet de conclure :* mesure une **prévalence**, décrit des consommations ; ne prouve pas de causalité

étude cas-témoins — *Principe :* on compare l'exposition passée de malades (cas) et de non-malades (témoins) ; *Ce qu'elle permet de conclure :* calcule un **odds ratio** (OR) ; rapide pour les maladies rares ; biais de mémoire

étude de cohorte (prospective) — *Principe :* on suit dans le temps des sujets exposés et non exposés, initialement indemnes ; *Ce qu'elle permet de conclure :* mesure une **incidence** et un **risque relatif** (RR) ; forte présomption, pas de preuve absolue

essai contrôlé randomisé — *Principe :* l'investigateur attribue l'intervention par **tirage au sort** ; groupe contrôle (placebo ou référence) ; idéalement en **double aveugle** ; *Ce qu'elle permet de conclure :* preuve de **causalité** la plus forte pour une intervention

revue systématique, méta-analyse — *Principe :* synthèse de toutes les études publiées sur une question, avec combinaison statistique des résultats (méta-analyse) ; *Ce qu'elle permet de conclure :* niveau de preuve le plus élevé si les études incluses sont de bonne qualité

Terme · Définition

biais — erreur systématique qui fausse le résultat (biais de sélection, de mesure, de mémoire)

facteur de confusion — facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée une association trompeuse (le tabac pour l'association café-cancer du poumon)

risque relatif (RR) — incidence chez les exposés / incidence chez les non-exposés ; RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur

intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) — fourchette qui contient la vraie valeur avec une confiance de 95 % ; si l'IC d'un RR contient 1, l'association n'est pas significative

p (valeur p) — probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si l'hypothèse nulle est vraie ; p < 0,05 : résultat dit « statistiquement significatif »

sensibilité (Se) — proportion de malades que le test classe positifs : VP / (VP + FN)

spécificité (Sp) — proportion de non-malades que le test classe négatifs : VN / (VN + FP)

valeur prédictive positive (VPP) — proportion de malades parmi les sujets positifs au test : VP / (VP + FP) ; dépend de la prévalence

valeur prédictive négative (VPN) — proportion de non-malades parmi les sujets négatifs : VN / (VN + FN)

dépistage, diagnostic — dépistage : repérer dans une population les personnes à risque (test simple, sensible) ; diagnostic : confirmer la maladie chez un individu (examen spécifique)

grade des recommandations (HAS) — A : preuve scientifique établie ; B : présomption scientifique ; C : faible niveau de preuve ; AE : accord d'experts

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On teste un outil de dépistage de la dénutrition chez 200 patients hospitalisés ; 50 sont dénutris selon les critères de la HAS. L'outil est positif chez 40 des 50 patients dénutris et chez 15 des 150 patients non dénutris. Calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN, et commentez.

CORRIGÉ

Tableau : VP = 40, FN = 50 − 40 = 10 ; FP = 15, VN = 150 − 15 = 135. **Sensibilité** = 40 / 50 = **80 %** ; **spécificité** = 135 / 150 = **90 %** ; **VPP** = 40 / (40 + 15) = 40 / 55 ≈ **72,7 %** ; **VPN** = 135 / (135 + 10) = 135 / 145 ≈ **93,1 %**.

Commentaire : un test de **dépistage** doit être avant tout **sensible** (ne pas « rater » de malades) ; ici, 1 patient dénutri sur 5 n'est pas repéré, ce qui est insuffisant. Un test positif doit être suivi d'une **évaluation complète** (critères HAS), car plus d'un positif sur quatre n'est pas dénutri.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Dans une cohorte, 30 cas de diabète de type 2 apparaissent en 10 ans parmi 1 000 personnes buvant au moins une boisson sucrée par jour, et 20 cas parmi 2 000 personnes n'en buvant pas. Calculez les incidences cumulées et le risque relatif. Peut-on conclure que les boissons sucrées causent le diabète ?

CORRIGÉ

Incidence chez les exposés : 30 / 1 000 = **3 %** ; chez les non-exposés : 20 / 2 000 = **1 %** ; **RR = 3 / 1 = 3** : le risque est triplé chez les buveurs de boissons sucrées.

Une cohorte montre une **association**, pas une preuve de causalité : il faut vérifier l'**intervalle de confiance** et l'ajustement sur les **facteurs de confusion** (corpulence, activité physique, alimentation globale, niveau socio-économique). La cohérence avec d'autres études, la relation dose-effet et un mécanisme plausible renforcent l'hypothèse causale (critères de Bradford Hill).

29.4.4 Sens courant et sens médical

Module · *Communication avec le patient, éducation thérapeutique*

Beaucoup de mots médicaux sont passés dans la langue courante avec un **sens différent**. Ces glissements sont source de **malentendus** entre soignants et patients. Le diététicien doit connaître le sens médical exact et repérer le sens que lui donne son interlocuteur.

Mot · Sens courant (souvent erroné) · Sens médical exact

aigu — *Sens courant (souvent erroné) :* très douloureux, intense ; *Sens médical exact :* d'apparition **rapide** et d'évolution courte (lat. *acutus*, pointu) ; une maladie aiguë peut être bénigne

chronique — *Sens courant (souvent erroné) :* grave, incurable ; *Sens médical exact :* qui **dure** (gr. *khronos*, temps), en pratique plus de 3 à 6 mois ; souvent contrôlable

positif / négatif — *Sens courant (souvent erroné) :* bon / mauvais résultat ; *Sens médical exact :* test **positif** : le signe recherché est **présent** (souvent une mauvaise nouvelle) ; **négatif** : absent

régime — *Sens courant (souvent erroné) :* privation pour maigrir ; *Sens médical exact :* mode d'alimentation adapté à une situation (régime hyposodé, régime sans gluten), pas forcément restrictif ; du gr. *diaita*, mode de vie, viennent « diète » et « diététique »

diète — *Sens courant (souvent erroné) :* jeûne (« être à la diète ») ; *Sens médical exact :* en diététique, synonyme de régime ; « diète hydrique » : seulement des liquides

tension — *Sens courant (souvent erroné) :* nervosité, stress ; « avoir de la tension » ; *Sens médical exact :* pression artérielle ; « avoir de la tension » = hypertension

anémie — *Sens courant (souvent erroné) :* fatigue, « être anémié » ; *Sens médical exact :* diminution de l'hémoglobine du sang (chiffrée) ; la fatigue n'en est qu'un symptôme possible

crise de foie — *Sens courant (souvent erroné) :* indigestion, nausées après un repas copieux ; *Sens médical exact :* expression sans équivalent médical ; le foie n'est souvent pas en cause (estomac, vésicule)

allergie — *Sens courant (souvent erroné) :* toute réaction désagréable à un aliment ; *Sens médical exact :* réaction **immunologique** (souvent IgE) ; à distinguer de l'**intolérance** (ex. lactose : déficit enzymatique)

bénin — *Sens courant (souvent erroné) :* sans importance ; *Sens médical exact :* non cancéreux (tumeur bénigne), mais parfois gênant ou à surveiller

infection / inflammation — *Sens courant (souvent erroné) :* synonymes ; *Sens médical exact :* infection : présence d'un micro-organisme pathogène ; inflammation : réaction de défense (-ite), infectieuse ou non

sucres — *Sens courant (souvent erroné) :* le sucre blanc ; *Sens médical exact :* en nutrition, « glucides » ; « sucres » (mono- et disaccharides) s'opposent aux glucides complexes (amidon)

cholestérol (« bon », « mauvais ») — *Sens courant (souvent erroné) :* deux sortes de cholestérol ; *Sens médical exact :* une seule molécule, transportée par les **HDL** (« bon ») ou les **LDL** (« mauvais ») : ce sont les transporteurs qui diffèrent

dépression — *Sens courant (souvent erroné) :* tristesse passagère ; *Sens médical exact :* maladie psychiatrique définie par des critères (durée d'au moins 2 semaines, retentissement)

syndrome — *Sens courant (souvent erroné) :* maladie grave ; *Sens médical exact :* ensemble de signes et symptômes qui vont ensemble, quelle qu'en soit la cause (gr. *sundromê*, concours)

Lien avec la diététique

Un langage respectueux. Les recommandations actuelles invitent à parler de la **personne** avant sa maladie : « une personne vivant avec une obésité » plutôt que « un obèse », « une personne diabétique » ou « vivant avec un diabète » plutôt que « un diabétique ». Le terme « **compliance** » (anglicisme) cède la place à **observance**, puis à **adhésion** thérapeutique, qui reconnaît le rôle actif du patient. On évite les termes culpabilisants (« écarts », « tricher », « bons et mauvais aliments ») au profit d'une description neutre des consommations.

29.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

29.5.1 Classifications et terminologies normalisées : CIM, CCAM, SNOMED CT

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

La CIM (Classification internationale des maladies), publiée par l'**OMS**, attribue à chaque maladie un **code** alphanumérique. La **CIM-10** (adoptée en 1990, utilisée depuis 1994) sert en France au codage des séjours hospitaliers dans le **PMSI** (programme de médicalisation des systèmes d'information) et à la statistique des causes de décès. Exemples : **E10** à **E14** (diabètes ; E11 : diabète de type 2), **E40** à **E46** (malnutrition protéino-énergétique : E43 « grave » et E44 « modérée et légère » servent à coder la dénutrition sévère et modérée), **E66** (obésité), **I10** (hypertension essentielle), **I21** (infarctus aigu du myocarde), **K80** (lithiase biliaire). La **CIM-11**, adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2019, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 ; son déploiement en France est progressif. Le codage d'une dénutrition comme **diagnostic associé** modifie le niveau de sévérité du séjour : d'où l'importance de sa traçabilité par le diététicien.

Les autres terminologies normalisées. La **CCAM** (classification commune des actes médicaux, 2005) code les actes techniques (code de 4 lettres et 3 chiffres, dont les lettres décrivent l'organe, l'action et la voie d'abord). **SNOMED CT** est une terminologie clinique internationale très détaillée (plusieurs centaines de milliers de concepts reliés entre eux), utilisée dans les dossiers informatisés. **LOINC** code les examens de biologie, la classification **ATC** (anatomique, thérapeutique et chimique) code les médicaments. Le **MeSH** (*Medical Subject Headings*), thésaurus de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, indexe les articles de la base **PubMed** ; sa traduction française est tenue par l'Inserm. La terminologie du **processus de soin nutritionnel** (eNCPT, dont la TIDN est la version française) applique le même principe aux diagnostics diététiques.

29.5.2 La nomenclature anatomique internationale

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

Une nomenclature anatomique internationale. Pour mettre fin à la multiplicité des noms (plusieurs dizaines de milliers de termes pour environ 5 000 structures au XIXe siècle), les anatomistes ont adopté des listes officielles en latin : *Basle Nomina Anatomica* (Bâle, 1895), *Nomina Anatomica* de Paris (1955), puis **Terminologia Anatomica** (1998, révisée en 2019 sous le nom de TA2). Les éponymes y sont **supprimés** et remplacés par des noms descriptifs.

Conséquences en français : **péroné → fibula** ; **rotule → patella** ; **cubitus → ulna** ; **omoplate → scapula** ; **astragale → talus** ; **trompe de Fallope → trompe utérine** ; **trompe d'Eustache → trompe auditive** ; **canal de Wirsung → conduit pancréatique** ; **ampoule de Vater → ampoule hépato-pancréatique** ; **îlots de Langerhans → îlots pancréatiques**. Les deux nomenclatures coexistent dans les comptes rendus : il faut connaître les deux. L'adjectif dérive souvent du terme latin : « fibulaire », « ulnaire », « patellaire ».

29.5.3 Une brève histoire de la langue médicale

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

Une langue construite en strates. Les médecins grecs (le **Corpus hippocratique**, Ve et IVe siècles

avant notre ère ; **Galien**, IIe siècle) ont nommé les organes et les maladies : *nephros*, *gaster*, *diabêtês* (« qui traverse », d'après l'écoulement abondant des urines), *arthritis*. Rome a traduit ou latinisé ces termes (*ren*, *venter*) ; la médecine arabe (Avicenne, *Canon*, XIe siècle) a transmis le savoir grec, retraduit en latin au XIIe siècle. Le latin est resté la langue savante de la médecine jusqu'au XVIIIe siècle (Vésale, *De humani corporis fabrica*, 1543) ; Ambroise Paré, au XVIe siècle, écrit en français. Au XIXe siècle, l'essor de la clinique et des sciences crée des centaines de **néologismes savants** : **stéthoscope** (Laennec, publié en 1819 ; gr. *stêthos*, poitrine, + *skopein*, examiner), **leucémie** (Virchow, *Leukämie*, 1847), **hémoglobine**. Au XXe siècle, l'anglais devient la langue de publication : il fournit des sigles et des emprunts (*stent*, *bypass*, *burn-out*, *check-up*), auxquels la Commission d'enrichissement de la langue française propose des équivalents (**endoprothèse**, **pontage**, **épuisement professionnel**, **bilan de santé**).

29.5.4 La fabrique des néologismes

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

La fabrique des mots nouveaux. La médecine crée en permanence des termes par **composition savante** (deux bases grecques ou latines : *orthorexie*, proposé en 1997 pour l'obsession de manger « sain » ; *obésogène*), par **dérivation** (préfixe ou suffixe ajouté : *prédiabète*, *dénutrition*), par **sigles** (*ARFID*, trouble restrictif ou évitant de l'ingestion d'aliments, entré dans le DSM-5 en 2013) ou par **emprunt** (*flexitarien*, de l'anglais *flexitarian*). Les termes évoluent aussi quand la compréhension des maladies change : la **NAFLD** (stéatose hépatique non alcoolique) et la **NASH** ont été renommées en 2023 **MASLD** et **MASH** (maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique), pour décrire la cause plutôt que l'absence d'alcool et éviter un terme jugé stigmatisant ; le **microbiote** a remplacé la « flore intestinale » (les bactéries ne sont pas des végétaux) ; le **diabète de type 1** et **de type 2** ont remplacé « insulinodépendant » et « non insulinodépendant » (1997), car un diabétique de type 2 peut être traité par insuline.

29.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Situation professionnelle · Notions du chapitre mobilisées · Action du diététicien

Service hospitalier : lecture du dossier d'un patient entrant — *Notions du chapitre mobilisées :* abréviations, termes composés, plan du compte rendu, biologie (-émie, -urie, -cytose) ; *Action du diététicien :* repérer les informations nutritionnelles utiles (poids, apports, troubles de déglutition, biologie), préparer le bilan diététique

Rédaction du bilan et du diagnostic diététiques — *Notions du chapitre mobilisées :* format PES, TIDN, critères HAS de la dénutrition, transmissions ciblées ; *Action du diététicien :* écrire un diagnostic exact, mesurable et dans le champ de la diététique ; tracer les actions et les résultats

Réunion pluridisciplinaire (staff, RCP) — *Notions du chapitre mobilisées :* vocabulaire des spécialités, sigles, termes de chirurgie et d'imagerie ; *Action du diététicien :* comprendre les décisions médicales (stomie, résection, nutrition artificielle) et y adapter le projet nutritionnel

Consultation : patient qui ne comprend pas son ordonnance de régime — *Notions du chapitre mobilisées :* reformulation, sens courant et sens médical, éducation thérapeutique ; *Action du diététicien :* traduire sans trahir (hyposodé, hypoglycémie, hyperkaliémie), vérifier la compréhension par reformulation

EHPAD : résident dysphagique — *Notions du chapitre mobilisées :* dysphagie, fausse route, IDDSI, textures modifiées ; *Action du diététicien :* prescrire les niveaux IDDSI adaptés, former l'équipe aux tests et aux appellations normalisées

Service de chirurgie digestive — *Notions du chapitre mobilisées :* -tomie, -ectomie, -stomie, -anastomose, iléostomie, colostomie, gastrectomie ; *Action du diététicien :* adapter l'alimentation au montage chirurgical (pertes hydro-électrolytiques, fractionnement, dumping syndrome)

Dialyse, néphrologie — *Notions du chapitre mobilisées :* néphropathie, -kaliémie, -phosphatémie, protéinurie, hémodialyse ; *Action du diététicien :* interpréter le bilan, ajuster potassium, phosphore, protéines et liquides

Industrie, rédaction d'étiquetage ou de communication — *Notions du chapitre mobilisées :* allégations, termes réglementés, sens courant et sens médical ; *Action du diététicien :* éviter les termes médicaux trompeurs (« détox », « anti-cholestérol ») et respecter le règlement sur les allégations

Veille scientifique, santé publique — *Notions du chapitre mobilisées :* vocabulaire de l'épidémiologie et de la recherche (RR, IC, cohorte, méta-analyse) ; *Action du diététicien :* lire et hiérarchiser les études, distinguer association et causalité avant de diffuser une information

29.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'essentiel

Un terme médical se construit : [préfixe] + **racine**(s) + [voyelle de liaison, souvent -o-] + **suffixe**. Le **suffixe** donne la **nature** (maladie, signe, examen, acte), la **racine** l'**organe** ou la

substance, le **préfixe** la **position**, la **quantité**, le **temps** ou la **négation**. On lit le sens **de la fin vers le début** : gastr-o-entér-ite = inflammation (-ite) de l'estomac et de l'intestin.

Méthode en cinq étapes : repérer le suffixe ; repérer le ou les préfixes ; isoler la ou les racines ; traduire chaque élément ; reformuler en une phrase exacte, puis vérifier la cohérence avec le contexte. Les mots **non décomposables** (éponymes, sigles, termes historiques comme ictère ou diabète) s'apprennent tels quels.

Doublets : la racine **grecque** forme surtout les noms de **maladies, d'examens et d'actes** (néphrite, gastroscopie, hépatectomie) ; la racine **latine** forme surtout les **adjectifs anatomiques** (**rénal**, **buccal**, **pulmonaire**, **vésical**, **cutané**, **oculaire**), même si certains adjectifs courants viennent du grec (gastrique, hépatique). Rein : néphr(o)- / rén- ; poumon : pneum(o)- / pulmon- ; peau : derm(at)- / cut- ; bouche : stomat(o)- / bucc-, or- ; vessie : cyst(o)- / vésic- ; œil : ophtalm(o)- / ocul-.

Préfixes (53 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.2) : position (endo-, ecto-, exo-, extra-, épi-, hypo-, sub-, supra-, péri-, para-, rétro-, trans-, inter-, intra-) ; quantité (hypo- / hyper-, oligo- / poly-, micro- / macro-, méga-, mono-, multi-, hémi-, tétra-, pan-) ; temps (anté-, post-, néo-) ; négation et anomalie (a-, an-, dys-, mal-, anti-) ; vitesse (brady- / tachy-, pollaki-) ; qualité et relation (eu-, iso-, hétéro-, homo-, ortho-, auto-, allo-, xéno-). Hors liste du guide, mais fréquents : pré-, sus-, sous-, normo-, contra-.

Suffixes (49 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.3) : maladies (-ite inflammation ≠ infection ; -ose état non inflammatoire ou dégénératif ; -ome tumeur ; -pathie maladie ; -ectasie dilatation ; -plasie formation de tissu ; -trophie nutrition, développement) ; signes (-algie douleur ; -mégalie gros ; -rragie, -rrhée écoulement ; -émie sang ; -urie urine ; -émèse vomissement ; -pénie manque ; -cyte cellule ; -plégie, -parésie paralysie ; -phasie, -mnésie, -pepsie, -dipsie, -esthésie) ; examens (-scopie voir ; -graphie enregistrer, -gramme le document ; -centèse ponction) ; actes (-tomie inciser ; -ectomie enlever ; -stomie aboucher ; -plastie réparer ; -pexie fixer ; -rraphie suturer ; -lyse détruire) ; traitements (-thérapie, -cide). Hors liste des suffixes du guide, mais fréquents : -iase, -isme, -dynie, -métrie ; -pnée et phag(o)- figurent dans la liste des racines.

Racines (135 dans la liste du guide, tableau complet en 29.3.4) : organes (cardi-, gastr-, entér-, hépat-, néphr-, pneum-, cérébr-, my-, osté-, arthr-, derm-), sang et cellules (hém-, hémat-, cyt-, érythr-, leuc-, thromb-, lymph-), substances (chol(é)-, natri-, kali-, azot-, adip-, stéat-, sidér-), états et maladies (nécr-, sclér-, sién-, py-, pyrét-, onc-, carcin-), fonctions (-pnée, phag-, kinés-, phon-). Hors liste du guide, mais fréquents : glyc-, lip-, calc-, ur-, encéphal-.

Démarche clinique : **symptôme** (ressenti, rapporté par le patient) ≠ **signe** (constaté par le soignant) ; **syndrome** (ensemble de signes et symptômes) ; **étiologie** (cause) ; **pathogénie** (mécanisme) ; **diagnostic** (identifier) ; **pronostic** (prévoir l'évolution) ; **prévalence** (cas existants / population, à un instant) ≠ **incidence** (nouveaux cas / population à risque, sur une période). Maladie **aiguë** (rapide), **chronique** (qui dure) ; **bénigne** / **maligne** ; **iatrogène** (due aux soins) ; **idiopathique** (sans cause connue) ; **nosocomiale** (acquise à l'hôpital).

Documents : le compte rendu suit un plan fixe (motif, antécédents, mode de vie, traitement, histoire, examen, examens complémentaires, évolution, conclusion, traitement de sortie) ; décoder les **sigles** usuels (ATCD, AEG, HTA, DT2, IMC, NFS, CRP, HbA1c, DFG, FOGD, SNG, GPE, CNO) et se méfier des sigles ambigus (IC, PA, IR).

Nutrition clinique : **dénutrition** (HAS 2019 adulte ; HAS 2021 personne de 70 ans et plus) = au moins 1 critère **phénotypique** (perte de poids, IMC bas : < 18,5 ou < 22 selon l'âge, muscle) + au moins 1 critère **étiologique** (apports ou absorption réduits, agression) ; **sarcopénie** (EWGSOP2 2019 : force, masse, performance) ; **cachexie** ; **SRI** ; voies **orale** (*per os*), **entérale** (SNG, gastrostomie, jéjunostomie), **parentérale** (voie veineuse) ; textures **IDDSI** 0 à 7 ; diagnostic diététique au format **PES** (problème, étiologie, signes et symptômes) en terminologie **TIDN**.

Pièges : ilé- (iléon) ≠ ili- (os iliaque) ; -tomie ≠ -ectomie ≠ -stomie ; -émie (sang) ≠ -urie (urine) ; hémoptysie (crachat) ≠ hématémèse (vomissement) ; méléna (selles noires) ≠ mélanome (tumeur) ; arthrite (inflammatoire) ≠ arthrose (dégénérative) ; dysphagie (avaler) ≠ dysphasie (parler) ; hémi- (moitié) ≠ hém(o)- (sang) ; -graphie (technique) ≠ -gramme (document obtenu).

29.8 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiche 1 – Les suffixes indispensables

Famille · Suffixe · Sens · Exemple

Maladies — *Suffixe :* -ite ; *Sens :* inflammation ; *Exemple :* gastrite, hépatite, arthrite

— *Suffixe :* -ose ; *Sens :* état non inflammatoire, dégénératif ou accumulation ; *Exemple :* arthrose, stéatose, fibrose

— *Suffixe :* -ome ; *Sens :* tumeur (bénigne ou maligne) ; *Exemple :* adénome, lipome, carcinome

— *Suffixe :* -pathie ; *Sens :* maladie (sans préciser le mécanisme) ; *Exemple :* néphropathie, cardiopathie

Signes — *Suffixe :* -algie, -dynie ; *Sens :* douleur ; *Exemple :* gastralgie, myalgie, glossodynie

— *Suffixe :* -mégalie ; *Sens :* augmentation de volume ; *Exemple :* hépatomégalie, splénomégalie

— *Suffixe :* -émie / -urie ; *Sens :* dans le sang / dans l'urine ; *Exemple :* glycémie / glycosurie

— *Suffixe :* -rragie / -rrhée ; *Sens :* écoulement de sang / écoulement ; *Exemple :* hémorragie, rectorragie / diarrhée, stéatorrhée

— *Suffixe :* -pénie / -cytose ; *Sens :* manque / excès de cellules ; *Exemple :* leucopénie / hyperleucocytose

Examens — *Suffixe :* -scopie ; *Sens :* examen visuel (endoscope) ; *Exemple :* coloscopie, cœlioscopie

— *Suffixe :* -graphie / -gramme ; *Sens :* technique d'enregistrement / document obtenu ; *Exemple :* échographie / électrocardiogramme

— *Suffixe :* -métrie ; *Sens :* mesure ; *Exemple :* impédancemétrie, spirométrie

Actes — *Suffixe :* -tomie ; *Sens :* incision, ouverture ; *Exemple :* laparotomie, trachéotomie

— *Suffixe :* -ectomie ; *Sens :* ablation ; *Exemple :* gastrectomie, cholécystectomie

— *Suffixe :* -stomie ; *Sens :* abouchement (orifice) ; *Exemple :* colostomie, gastrostomie

— *Suffixe :* -plastie / -pexie / -rraphie ; *Sens :* réparer / fixer / suturer ; *Exemple :* angioplastie / gastropexie / herniorraphie

Fiche 2 – Les préfixes contraires

Préfixe · Sens · Contraire · Sens · Exemples

hypo- — *Sens :* sous, insuffisant ; *Contraire :* hyper- ; *Sens :* au-dessus, excès ; *Exemples :* hypoglycémie / hyperglycémie

oligo- — *Sens :* peu ; *Contraire :* poly- ; *Sens :* beaucoup ; *Exemples :* oligurie / polyurie

micro- — *Sens :* petit ; *Contraire :* macro- ; *Sens :* grand ; *Exemples :* microcytose / macrocytose

brady- — *Sens :* lent ; *Contraire :* tachy- ; *Sens :* rapide ; *Exemples :* bradycardie / tachycardie

endo- — *Sens :* dedans ; *Contraire :* exo- ; *Sens :* dehors ; *Exemples :* endocrine / exocrine

pré-, anté- — *Sens :* avant ; *Contraire :* post- ; *Sens :* après ; *Exemples :* préopératoire / postopératoire

homo- — *Sens :* semblable ; *Contraire :* hétéro- ; *Sens :* différent ; *Exemples :* homozygote / hétérozygote

eu- — *Sens :* bien, normal ; *Contraire :* dys- ; *Sens :* difficulté, anomalie ; *Exemples :* eupnée / dyspnée

sus-, épi- — *Sens :* au-dessus ; *Contraire :* sous-, hypo- ; *Sens :* au-dessous ; *Exemples :* sus-ombilical / sous-ombilical ; épigastre / hypogastre

Fiche 3 – Les doublets grec et latin des organes

Organe · Grec · Latin · Organe · Grec · Latin

rein — *Grec :* néphr(o)- ; *Latin :* rén- ; *Organe :* bouche ; *Grec :* stomat(o)- ; *Latin :* bucc-, or-

poumon — *Grec :* pneum(o)- ; *Latin :* pulmon- ; *Organe :* langue ; *Grec :* gloss(o)- ; *Latin :* lingu-

peau — *Grec :* derm(at)(o)- ; *Latin :* cut- ; *Organe :* œil ; *Grec :* ophtalm(o)- ; *Latin :* ocul-

vessie — *Grec :* cyst(o)- ; *Latin :* vésic- ; *Organe :* os ; *Grec :* osté(o)- ; *Latin :* oss-

veine — *Grec :* phléb(o)- ; *Latin :* vein-, ven(o)- ; *Organe :* sein ; *Grec :* mast(o)- ; *Latin :* mamm-

utérus — *Grec :* hystér(o)-, métr(o)- ; *Latin :* utér- ; *Organe :* nez ; *Grec :* rhin(o)- ; *Latin :* nas-

oreille — *Grec :* ot(o)- ; *Latin :* auricul- ; *Organe :* lait ; *Grec :* galact(o)- ; *Latin :* lact-

rectum, anus — *Grec :* proct(o)- ; *Latin :* rect-, an- ; *Organe :* muscle ; *Grec :* my(o)- ; *Latin :* muscul-

Fiche 4 – Les sigles des comptes rendus à connaître

ATCD (antécédents) · AEG (altération de l'état général) · HTA · DT1, DT2 · IMC · IDM · AVC · IC · FA · BPCO · IRC, MRC · MICI · RGO · NFS · VGM · CRP · HbA1c · DFG · ASAT, ALAT · TSH · ECG · TDM · IRM · FOGD · SNG · GPE · NE, NP · CNO · SRI · ETP · SSR (SMR) · EHPAD · *per os* (PO).

29.9 VALEURS DE RÉFÉRENCE ET CONVERSIONS À ASSOCIER AUX TERMES

Un terme construit sur hypo- ou hyper- n'a de sens que par rapport à une **valeur de référence**. Les valeurs ci-dessous sont les repères usuels chez l'adulte ; elles varient légèrement selon les laboratoires, qui indiquent toujours leurs propres normes sur le compte rendu.

Paramètre · Valeur de référence · Termes associés

glycémie à jeun — *Valeur de référence :* 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; diabète si ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ; *Termes associés :* hypoglycémie < 0,70 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun de 1,10 à 1,25 g/L

HbA1c — *Valeur de référence :* objectif usuel ≤ 7 % chez le diabétique de type 2 (HAS 2013, à individualiser) ; *Termes associés :* équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois

natrémie — *Valeur de référence :* 135 à 145 mmol/L ; *Termes associés :* hyponatrémie, hypernatrémie

kaliémie — *Valeur de référence :* 3,5 à 5,0 mmol/L ; *Termes associés :* hypokaliémie, hyperkaliémie

calcémie — *Valeur de référence :* 2,20 à 2,60 mmol/L ; *Termes associés :* hypocalcémie, hypercalcémie

phosphatémie — *Valeur de référence :* 0,80 à 1,45 mmol/L ; *Termes associés :* hypophosphatémie (syndrome de renutrition), hyperphosphatémie (insuffisance rénale)

urée, créatinine — *Valeur de référence :* urée 2,5 à 7,5 mmol/L ; créatinine ≈ 60 à 110 µmol/L (homme), 45 à 90 µmol/L (femme) ; *Termes associés :* hypercréatininémie, insuffisance rénale

DFG — *Valeur de référence :* ≥ 90 mL/min/1,73 m² ; stades de la MRC : 60 à 89 (2), 45 à 59 (3a), 30 à 44 (3b), 15 à 29 (4), < 15 (5) ; *Termes associés :* insuffisance rénale chronique

albuminurie — *Valeur de référence :* < 30 mg/24 h ; 30 à 300 mg/24 h : « microalbuminurie » ; > 300 mg/24 h : macroalbuminurie ; *Termes associés :* néphropathie diabétique

protéinurie — *Valeur de référence :* < 0,15 g/24 h ; *Termes associés :* protéinurie, syndrome néphrotique

hémoglobine — *Valeur de référence :* ≥ 13 g/dL (homme), ≥ 12 g/dL (femme), ≥ 11 g/dL (femme enceinte) (OMS) ; *Termes associés :* anémie

VGM — *Valeur de référence :* 80 à 100 fL ; *Termes associés :* microcytose (< 80), normocytose, macrocytose (> 100)

leucocytes — *Valeur de référence :* 4 à 10 G/L ; *Termes associés :* leucopénie, hyperleucocytose

plaquettes — *Valeur de référence :* 150 à 400 G/L ; *Termes associés :* thrombopénie, thrombocytose

albuminémie — *Valeur de référence :* 35 à 50 g/L ; *Termes associés :* hypoalbuminémie (critère de sévérité de la dénutrition)

CRP — *Valeur de référence :* < 5 mg/L ; *Termes associés :* syndrome inflammatoire

triglycérides — *Valeur de référence :* < 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ; *Termes associés :* hypertriglycéridémie

fréquence cardiaque — *Valeur de référence :* 60 à 100/min au repos ; *Termes associés :* bradycardie < 60, tachycardie > 100

fréquence respiratoire — *Valeur de référence :* 12 à 20/min ; *Termes associés :* bradypnée < 12, polypnée (tachypnée) > 20, apnée

pression artérielle — *Valeur de référence :* HTA si ≥ 140/90 mmHg en consultation (HAS 2016) ; *Termes associés :* hypertension, hypotension

température centrale — *Valeur de référence :* 36,5 à 37,5 °C ; fièvre ≥ 38 °C ; *Termes associés :* hypothermie < 35 °C, apyrexie, état fébrile

SpO_2 — *Valeur de référence :* ≥ 95 % chez l'adulte sain ; *Termes associés :* hypoxémie, désaturation

diurèse — *Valeur de référence :* ≈ 0,5 à 2,5 L/24 h selon les apports ; *Termes associés :* anurie < 100 mL, oligurie < 500 mL, polyurie > 3 L/24 h

IMC (adulte < 70 ans) — *Valeur de référence :* 18,5 à 24,9 kg/m² ; *Termes associés :* maigreur < 18,5 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30

Les conversions à savoir faire

Grandeur · Relation · Exemple

glucose — *Relation :* g/L × 5,55 = mmol/L (M = 180 g/mol) ; *Exemple :* 1,26 g/L × 5,55 = 7,0 mmol/L

cholestérol — *Relation :* g/L × 2,58 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol) ; *Exemple :* 2,00 g/L × 2,58 = 5,2 mmol/L

triglycérides — *Relation :* g/L × 1,14 = mmol/L ; *Exemple :* 1,50 g/L × 1,14 = 1,7 mmol/L

créatinine — *Relation :* mg/L × 8,84 = µmol/L (M = 113 g/mol) ; *Exemple :* 12 mg/L × 8,84 = 106 µmol/L

sodium et sel — *Relation :* 1 mmol de Na = 23 mg ; 1 g de sel (NaCl) = 393 mg de Na ≈ 17 mmol ; sel = Na × 2,54 ; *Exemple :* 6 g de sel ≈ 2,4 g de Na ≈ 103 mmol

potassium — *Relation :* 1 mmol de K = 39 mg ; *Exemple :* 3,5 g de K ≈ 90 mmol

pourcentage de perte de poids — *Relation :* (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100 ; *Exemple :* (70 − 63) / 70 × 100 = 10 %

IMC — *Relation :* poids (kg) / taille² (m²) ; *Exemple :* 63 / 1,68² = 63 / 2,822 = 22,3 kg/m²

29.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* Dans un terme médical, le suffixe indique souvent la nature du processus (inflammation, ablation, examen). ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* La racine indique l'organe ; le préfixe, la position, la quantité ou le temps.

2 — *Affirmation :* Le suffixe -ite signifie « infection ». ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il signifie **inflammation**, qui peut être infectieuse ou non (arthrite rhumatoïde, gastrite médicamenteuse).

3 — *Affirmation :* Une arthrose est une inflammation de l'articulation. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* -ose : processus **dégénératif** ; l'inflammation est l'**arthrite**.

4 — *Affirmation :* Le préfixe a- (ou an-) exprime l'absence ou la privation. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Anurie, aphagie, apnée, anémie.

5 — *Affirmation :* Le préfixe dys- signifie « deux ». ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Dys- = **difficulté, anomalie** ; « deux » = di- ou bi-.

6 — *Affirmation :* Une gastrostomie est l'ablation de l'estomac. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est un **abouchement** de l'estomac à la peau ; l'ablation est une **gastrectomie**.

7 — *Affirmation :* La glycosurie désigne la présence de glucose dans l'urine. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* -urie : dans l'urine ; -émie : dans le sang.

8 — *Affirmation :* L'hémoptysie est un vomissement de sang. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est un **crachat** de sang d'origine respiratoire ; le vomissement de sang est l'**hématémèse**.

9 — *Affirmation :* Le méléna est une émission de selles noires contenant du sang digéré. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Gr. *melas*, noir ; saignement du haut du tube digestif.

10 — *Affirmation :* Néphr(o)- et rén- désignent tous deux le rein. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Doublet grec et latin : néphrite, rénal.

11 — *Affirmation :* La racine latine forme plus souvent les noms de maladies que la racine grecque. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est l'inverse : le **grec** forme surtout les maladies et les actes, le **latin** les adjectifs anatomiques.

12 — *Affirmation :* Un symptôme est constaté par le médecin lors de l'examen. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il est **ressenti** et rapporté par le patient ; le **signe** est constaté.

13 — *Affirmation :* La prévalence mesure les nouveaux cas apparus pendant une période. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est l'**incidence** ; la prévalence compte tous les cas présents à un instant.

14 — *Affirmation :* Une maladie chronique est forcément grave. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Chronique = qui **dure** ; la gravité est une autre notion.

15 — *Affirmation :* Une affection iatrogène est provoquée par un acte ou un traitement médical. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Gr. *iatros*, médecin, + *-genês*, engendré.

16 — *Affirmation :* Une bradycardie est une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Brady- = **lent** : < 60/min ; > 100/min = tachycardie.

17 — *Affirmation :* L'oligurie correspond à une diurèse inférieure à 500 mL/24 h. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Anurie : < 100 mL/24 h.

18 — *Affirmation :* Une échographie utilise des rayons X. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle utilise des **ultrasons** (écho) ; le scanner (TDM) utilise des rayons X.

19 — *Affirmation :* La coloscopie et la cœlioscopie explorent le même organe. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Coloscopie : intérieur du **côlon** ; cœlioscopie : **cavité abdominale** (péritonéale).

20 — *Affirmation :* Un électrocardiogramme est le tracé obtenu lors de l'électrocardiographie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* -gramme : document ; -graphie : technique.

21 — *Affirmation :* Ilé(o)- et ili(o)- sont deux orthographes de la même racine. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ilé(o)- : **iléon** (intestin grêle) ; ili(o)- : **os iliaque**.

22 — *Affirmation :* La dysphagie est une difficulté à avaler. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* La **dysphasie** est un trouble du langage.

23 — *Affirmation :* La nutrition parentérale passe par une sonde gastrique. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle passe par une **voie veineuse** (para- + *enteron* : en dehors de l'intestin).

24 — *Affirmation :* Selon la HAS (2021), un IMC < 22 kg/m² est un critère phénotypique de dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Chez l'adulte plus jeune (HAS 2019), le seuil est 18,5 kg/m².

25 — *Affirmation :* L'albuminémie est un critère indispensable au diagnostic de dénutrition. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle ne sert qu'à apprécier la **sévérité** (et dépend de l'inflammation).

26 — *Affirmation :* La sarcopénie associe une diminution de la force et de la masse musculaires. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* EWGSOP2 (2019) ; sévère si la performance physique est aussi réduite.

27 — *Affirmation :* Le niveau IDDSI 4 correspond aux aliments en purée lisse et aux boissons très épaisses. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.

28 — *Affirmation :* Hypocalcémie et hypercalciurie sont des termes contraires. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ils portent sur deux milieux différents (sang et urine) : le contraire d'hypocalcémie est **hypercalcémie**.

29 — *Affirmation :* Une tumeur bénigne peut nécessiter une intervention chirurgicale. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Bénin = non cancéreux, pas forcément sans conséquence (compression, sécrétion hormonale).

30 — *Affirmation :* Le terme « diabète » vient du grec et évoque l'écoulement abondant des urines. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Gr. *diabainein*, traverser.

29.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – réussir les questions de terminologie

1. Décomposer un terme : écrire le terme en séparant ses éléments par des traits (hépat-o-mégal-ie) ; donner le sens de **chaque** élément avec son origine (gr. ou lat.) ; rédiger une **définition** en une phrase qui commence par la nature (« inflammation de… », « ablation de… », « examen visuel de… »). Une définition sans décomposition, ou une décomposition sans définition, ne rapporte que la moitié des points.

2. Construire un terme : partir de la nature (suffixe), puis de l'organe (racine, en général grecque pour une maladie, un examen ou un acte), ajouter le préfixe éventuel ; vérifier la **voyelle de liaison** (supprimée devant une voyelle) et l'**orthographe** (h, y, doubles consonnes : hémorragie, diarrhée, rhinite, dyspnée).

3. Lire un compte rendu : repérer le plan ; surligner sigles et termes composés ; les traduire dans la marge ; puis **trier** : ce qui concerne l'état nutritionnel (poids, apports, troubles digestifs, déglutition), ce qui modifie les besoins (agression, chirurgie, fièvre), ce qui impose une adaptation (stomie, insuffisance d'organe, biologie), ce qui conditionne l'éducation (contexte social, autonomie).

4. Interpréter une valeur : comparer à la **valeur de référence** donnée (ou connue) ; nommer l'anomalie par le terme exact (hypo-/hyper- + racine + -émie ou -urie) ; préciser l'unité ; ne conclure à une maladie que si les critères diagnostiques sont réunis (« à jeun », « à deux reprises »).

5. Reformuler : remplacer chaque terme savant par sa traduction **exacte**, en phrases courtes ; garder les chiffres utiles ; vérifier la compréhension par le patient (reformuler-vérifier).

6. Rédiger dans le dossier : employer le terme juste, chiffrer, dater, signer ; au format PES pour le diagnostic diététique ; en transmissions ciblées (cible, données, actions, résultats) pour le suivi.

29.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chaque élément numéroté, écrivez le **nom de la structure** et la ou les **racines** correspondantes (grecque et latine), puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen,

chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

Corrigé des schémas à légender

Appareil digestif : 1. glande parotide : par(a)- + ot- : « à côté de l'oreille » ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · bucc(o)-, or(o)- (lat.) ; 3. glande sublinguale : sub- + lingu- : « sous la langue » ; 4. glandes salivaires : sial(o)- (gr. sialon, salive) ; 5. foie : hépat(o)- (gr. hêpar, hêpatos) ; 6. vésicule biliaire : cholécyst(o)- (kholê + kustis) ; 7. pylore : pylor(o)- (gr. pulôros, portier) ; 8. duodénum : duodén(o)- (lat. duodeni, douze) ; 9. intestin grêle (iléon) : entér(o)- (gr.) ; ilé(o)- ; 10. cæcum : cæc(o)- (lat. caecus, aveugle) ; 11. appendice : appendic(o)- ; 12. pharynx : pharyng(o)- ; 13. œsophage : œsophag(o)- ; 14. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 15. estomac : gastr(o)- (gr. gastêr) ; 16. rate : splén(o)- (gr. splên) ; 17. pancréas : pancréat(o)- (pan + kreas) ; 18. côlon : col(o)-, colon(o)- (gr. kolon) ; 19. jéjunum : jéjun(o)- (lat. jejunus, à jeun) ; 20. côlon sigmoïde : sigmoïd(o)- (en forme de sigma) ; 21. rectum : rect(o)- (lat.) · proct(o)- (gr.) ; 22. anus : an(o)- (lat.) · proct(o)- (gr. prôktos).

Appareil respiratoire : 1. nez, fosses nasales : rhin(o)- (gr.) · nas(o)- (lat.) ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · or(o)- (lat.) ; 3. poumon : pneum(o)- (gr.) · pulmon(o)- (lat.) ; 4. bronche : bronch(o)- ; 5. bronchiole : bronchiol- (-ole : diminutif) ; 6. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 7. pharynx : pharyng(o)- ; 8. épiglotte : épi- + glotte : « sur la glotte » ; 9. larynx (voix) : laryng(o)- ; -phonie (voix) ; 10. œsophage : œsophag(o)- ; 11. trachée (cartilage) : trach(é)(o)- ; chondr(o)- ; 12. côte : cost(o)- (lat. costa) ; 13. plèvre : pleur(o)- (gr. pleura, côté) ; 14. cœur : cardi(o)- (gr. kardia).

Appareil cardiovasculaire : 1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. artère pulmonaire : pulmon- (lat.) · pneum(o)- (gr.) ; 3. capillaires pulmonaires : hématose (gr. haimatôsis) ; 4. oreillette : atri(o)- (lat. atrium, vestibule) ; 5. ventricule : ventricul(o)- (lat. ventriculus) ; 6. foie : hépat(o)- ; 7. veine porte : port(o)- (lat. porta, porte) ; 8. capillaire : lat. capillus, cheveu ; 9. artère carotide : artéri(o)- (gr. artêria) ; 10. aorte : aort(o)- (gr. aortê) ; 11. myocarde : my(o)- + card- : muscle du cœur ; 12. rein : néphr(o)- · rén(o)- ; 13. artère mésentérique : més(o)- + entér- : « au milieu de l'intestin » ; 14. muscles : my(o)- (gr.) · muscul- (lat.).

Sang : 1. plasma : plasm- (gr. plasma, chose façonnée) ; 2. couche leucocytaire : leuc(o)- (blanc) + -cyte ; 3. hématocrite : hémat(o)- + -crite (krinein, séparer) ; 4. éosinophile : éosine (colorant) + -phile ; 5. polynucléaire neutrophile : poly- + nucl- ; -phile (affinité) ; 6. basophile : bas- (colorant basique) + -phile ; 7. hématie = érythrocyte : érythr(o)- (rouge) + -cyte ; 8. plaquette = thrombocyte : thromb(o)- (caillot) + -cyte ; 9. lymphocyte : lymph(o)- + -cyte ; 10. monocyte : mono- (un seul noyau) + -cyte.

Appareil urinaire : 1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. surrénale : sur- + rén- ; adrén(o)- (lat. ad + ren) ; 3. rein : néphr(o)- (gr.) · rén(o)- (lat.) ; 4. bassinet : pyél(o)- (gr. puelos, cuve) ; 5. uretère : urétér(o)- ; 6. os iliaque : ili(o)- (≠ ilé(o)-) ; osté(o)- ; 7. vessie : cyst(o)- (gr.) · vésic(o)- (lat.) ; 8. aorte : aort(o)- ; 9. artère rénale : artéri(o)- ; rén- (rénal) ; 10. médullaire : médull(o)- (lat. medulla, moelle) ; 11. cortex : cortic(o)- (lat. cortex, écorce) ; 12. vertèbre lombaire : spondyl(o)- (gr.) · vertébr- (lat.) ; 13. urètre : urétr(o)-.

Système endocrinien : 1. hypothalamus : hypo- + thalamus : « sous le thalamus » ; 2. hypophyse : hypo- + phusis : « pousse en dessous » ; 3. parathyroïdes : para- : « à côté de » la thyroïde ; 4. îlots du pancréas : insuline : insul- (lat. insula, île) ; 5. surrénale : adrén(o)- ; cortic(o)- ; médull(o)- ; 6. gonades : gon- (gr. gonê, semence) ; orch(i)- ; ovari- ; 7. épiphyse : épi- + phusis : « pousse au-dessus » ; 8. thyroïde : thyr(o)-, thyré(o)- (thureos, bouclier) ; 9. thymus : thym(o)- ; 10. cœur : peptide natriurétique : natri- (sodium) + -urèse ; 11. estomac : gastrine : gastr- + -ine ; 12. rein : érythropoïétine : érythr(o)- + -poïèse ; 13. intestin : entérohormones : entér(o)- + hormone.

Système nerveux : 1. cortex cérébral : cérébr(o)- (lat.) ; cortic(o)- ; 2. ventricule : ventricul- (hydrocéphalie) ; 3. hypothalamus : hypo- + thalam- ; 4. chiasma optique : opt- (vision) ; chiasma (X) ; 5. hypophyse : hypo- + phusis ; 6. bulbe rachidien : rach(i)- (gr. rhakhis) ; 7. moelle épinière : myél(o)- (gr. muelos) ; 8. lobe pariétal : pariét- (lat. paries, paroi) ; 9. lobe occipital : occipit- (lat. occiput) ; 10. thalamus : thalam- (gr. thalamos) ; 11. épiphyse : épi- + phusis ; 12. mésencéphale : més(o)- + encéphal- ; 13. cervelet : cérébell- (lat. cerebellum).

Peau : 1. couche cornée : kérat(o)- (gr. keras, corne) ; 2. mélanocyte : mélan(o)- (noir) + -cyte ; 3. épiderme / derme : épi- + derm- : « sur le derme » ; 4. fibroblaste : fibr(o)- + -blaste (germe) ; 5. veinule : vein- + -ule (diminutif) ; 6. adipocyte : adip(o)- (lat.) · lip(o)- (gr.) ; 7. poil : trich(o)- (gr.) · pil(o)- (lat.) ; 8. corpuscule sensitif : -esthésie (sensibilité) ; 9. glande sébacée : séb(o)- (lat. sebum, suif) ; 10. muscle lisse : my(o)- ; léio- (lisse) ;

11. nerf : neur(o)-, névr(o)- (gr. neuron) ; 12. artériole : artéri- + -ole (diminutif) ; 13. glande sudoripare : sudor- (lat.) · hidr(o)- (gr.).

Gestes chirurgicaux : 1. -tomie : section, incision (gr. tomê) ; 2. -ectomie : ablation (ek + tomê) ; 3. anastomose : abouchement de deux conduits ; 4. -stomie : abouchement à la peau (stoma, bouche) ; 5. -rraphie : suture (gr. rhaphê) ; 6. -pexie : fixation (gr. pêxis) ; 7. -plastie : remodelage, réparation (gr. plassein) ; 8. -centèse : ponction (gr. kentêsis).

Hémorragies : 1. otorragie : saignement par l'oreille (ot- + -rragie) ; 2. épistaxis : saignement de nez (gr. epistazein, couler goutte à goutte) ; 3. hématémèse : vomissement de sang (hémat- + -émèse) ; 4. méléna : selles noires (sang digéré) : saignement digestif haut, ici l'estomac (gr. melaina, noire) ; 5. hématurie : sang dans les urines (hémat- + -urie) ; 6. purpura, pétéchies : petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression ; 7. gingivorragie : saignement des gencives (lat. gingiva) ; 8. hémoptysie : crachat de sang venant des voies respiratoires (gr. ptusis) ; 9. hématome, ecchymose : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau ; 10. ménorragie / métrorragie : règles trop abondantes / saignement utérin en dehors des règles ; 11. rectorragie : sang rouge émis par l'anus : saignement digestif bas.

Méthode – schémas à savoir réaliser

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez l'anatomie d'un mot médical à partir de l'exemple « hépatomégalie » puis « gastro-entérologie ». *Attendus : cases distinctes pour le préfixe (absent ici), la ou les racines (hépat- ; gastr-, entér-), la voyelle de liaison (-o-) et le suffixe (-mégalie ; -logie) ; sens de chaque élément ; flèche indiquant le sens de lecture (du suffixe vers la racine) ; définition finale.*

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Dessinez un tube digestif simplifié et placez-y les termes : œsophagite, gastrectomie, gastrostomie, jéjunostomie, iléostomie, colostomie, coloscopie, FOGD. *Attendus : organes nommés dans l'ordre (œsophage, estomac, duodénum, jéjunum, iléon, côlon, rectum) ; distinction visuelle entre une ablation (segment barré), une stomie (orifice relié à la peau) et un examen endoscopique (flèche d'entrée de l'endoscope par la bouche ou par l'anus).*

Schéma 13 – à réaliser sans modèle. Représentez sur un axe gradué de la glycémie (en g/L) les termes hypoglycémie, normoglycémie, hyperglycémie modérée à jeun et diabète. *Attendus : axe orienté avec unité ; seuils 0,70, 1,10 et 1,26 g/L ; équivalents en mmol/L (3,9 ; 6,1 ; 7,0) ; mention « à jeun » et « à deux reprises ».*

29.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'entraîner – application

Application 1. Décomposez et définissez : gastro-entérite, hépatite, cholécystectomie, splénomégalie.

Corrigé

Gastro-entérite : gastr- (estomac) + entér- (intestin) + -ite : inflammation de l'estomac et de l'intestin. **Hépatite** : hépat- (foie) + -ite : inflammation du foie. **Cholécystectomie** : chol(é)- (bile) + cyst- (vessie, poche) + -ectomie : ablation de la vésicule biliaire. **Splénomégalie** : splén- (rate) + -mégalie : augmentation de volume de la rate.

S'entraîner – application

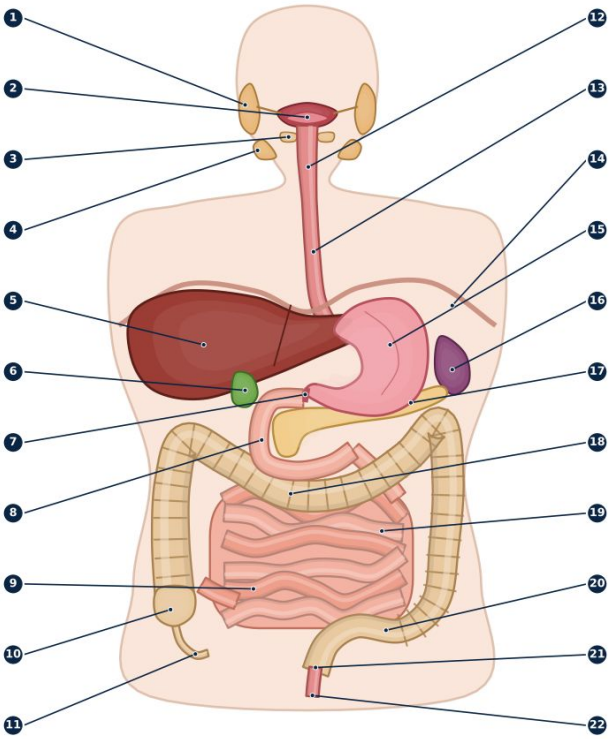
Application 2. Construisez les termes : inflammation de la muqueuse buccale ; ablation d'un rein ; incision de la paroi abdominale ; diminution du nombre de plaquettes ; écoulement de graisse dans les selles.

Corrigé

Stomatite (stomat-, bouche) ; **néphrectomie** ; **laparotomie** ; **thrombopénie** (thromb(o)-, caillot, plaquette, + -pénie) ; **stéatorrhée** (stéat-, graisse, + -rrhée).

S'entraîner – application

Application 3. Donnez le terme contraire et le sens de chacun : hypoglycémie, oligurie, bradycardie, microcytose, endocrine.



tube digestif (bouche → anus) : rose et beige · glandes annexes : salivaires, foie, pancréas
Planche muette – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Fig. 29.29. Schéma à légender – l'appareil digestif et ses racines (22 légendes)

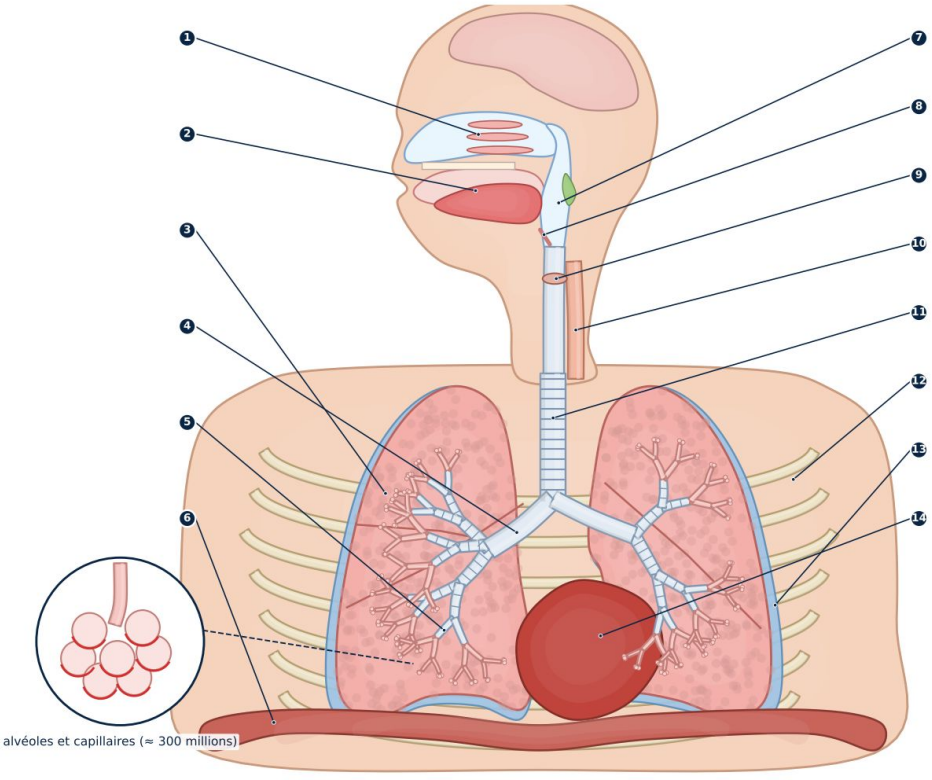


Planche muette – les racines de l'appareil respiratoire

Fig. 29.30. Schéma à légender – l'appareil respiratoire et ses racines (14 légendes)

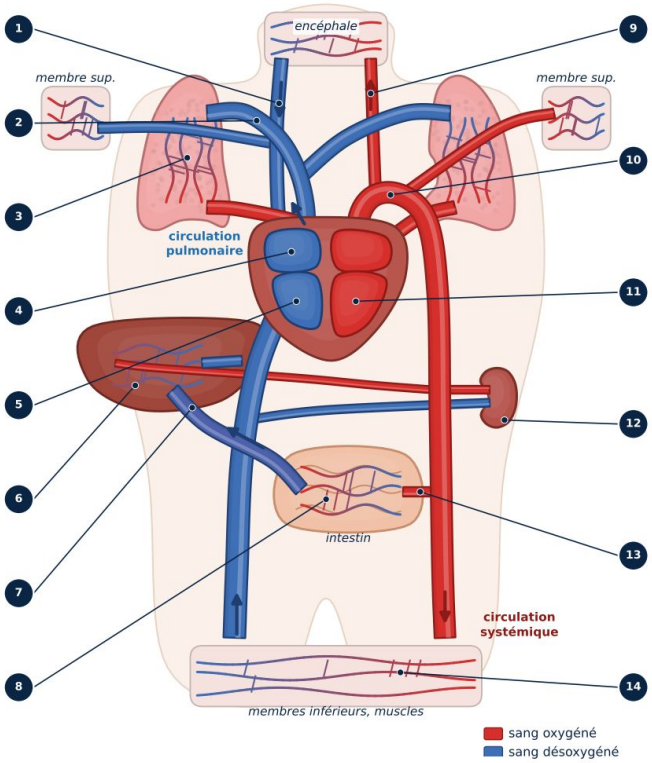


Planche muette – les racines de l'appareil cardiovasculaire

Fig. 29.31. Schéma à légender – l'appareil cardiovasculaire et ses racines (14 légendes)

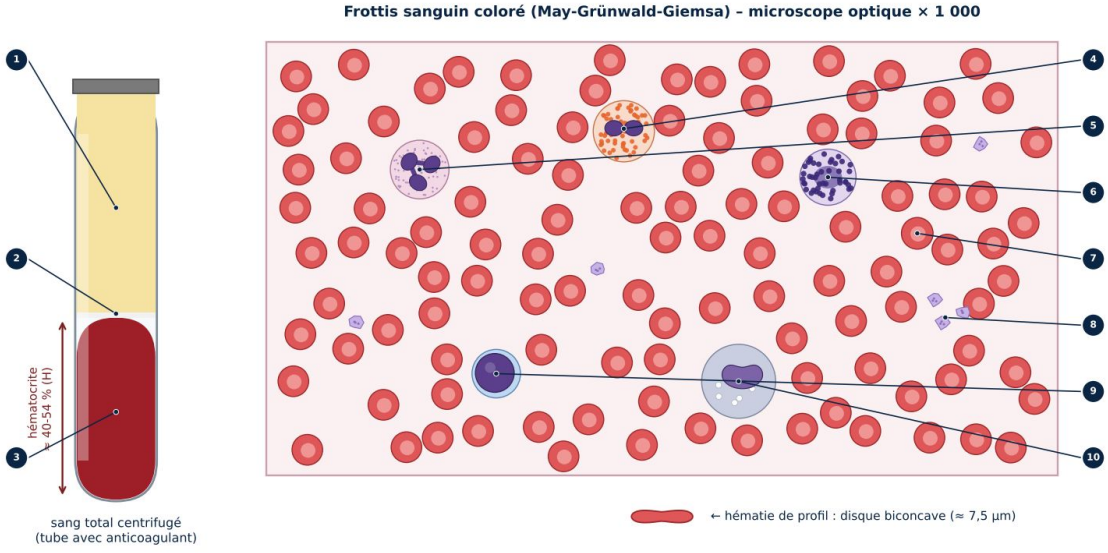


Planche muette – les racines du sang et de ses cellules

Fig. 29.32. Schéma à légender – le sang et ses cellules (10 légendes)

Corrigé

Hyperglycémie (excès de glucose sanguin) ; **polyurie** (urines abondantes) ; **tachycardie** (cœur rapide, > 100/min) ; **macrocytose** (globules rouges trop gros) ; **exocrine** (sécrétion vers l'extérieur ou dans une cavité : glandes salivaires, pancréas exocrine).

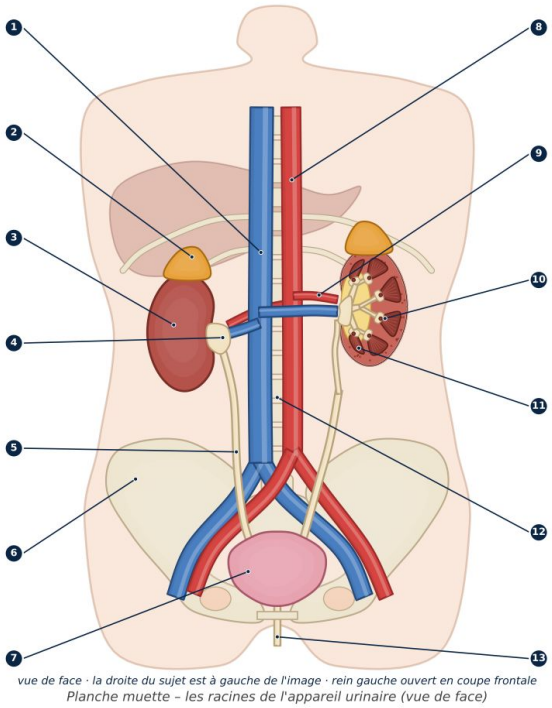


Fig. 29.33. Schéma à légender – l'appareil urinaire et ses racines (13 légendes)

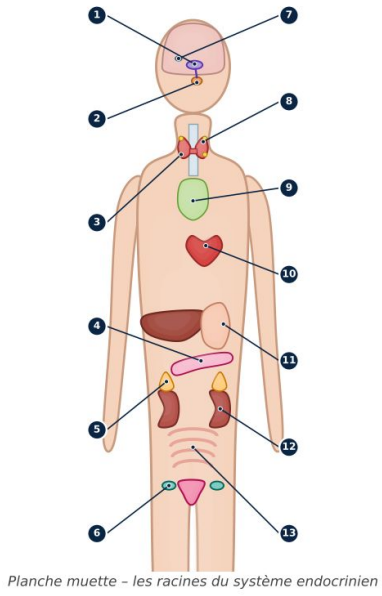


Fig. 29.34. Schéma à légender – le système endocrinien et ses racines (13 légendes)

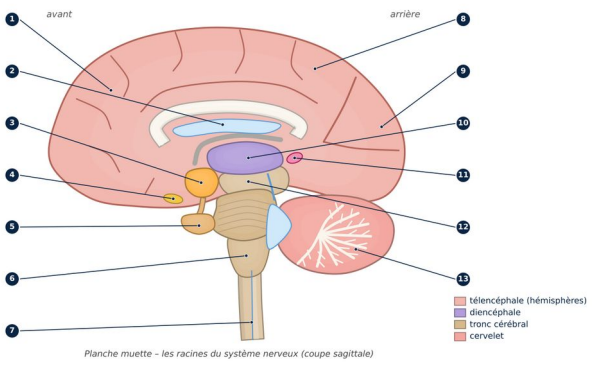


Fig. 29.35. Schéma à légender – le système nerveux et ses racines (13 légendes)

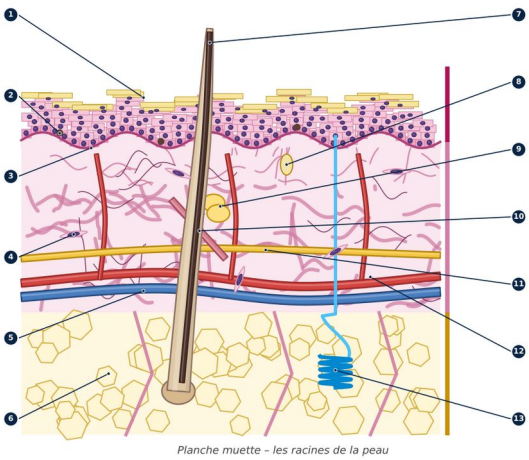


Planche muette – les racines de la peau

Fig. 29.36. Schéma à légender – la peau et ses racines (13 légendes)

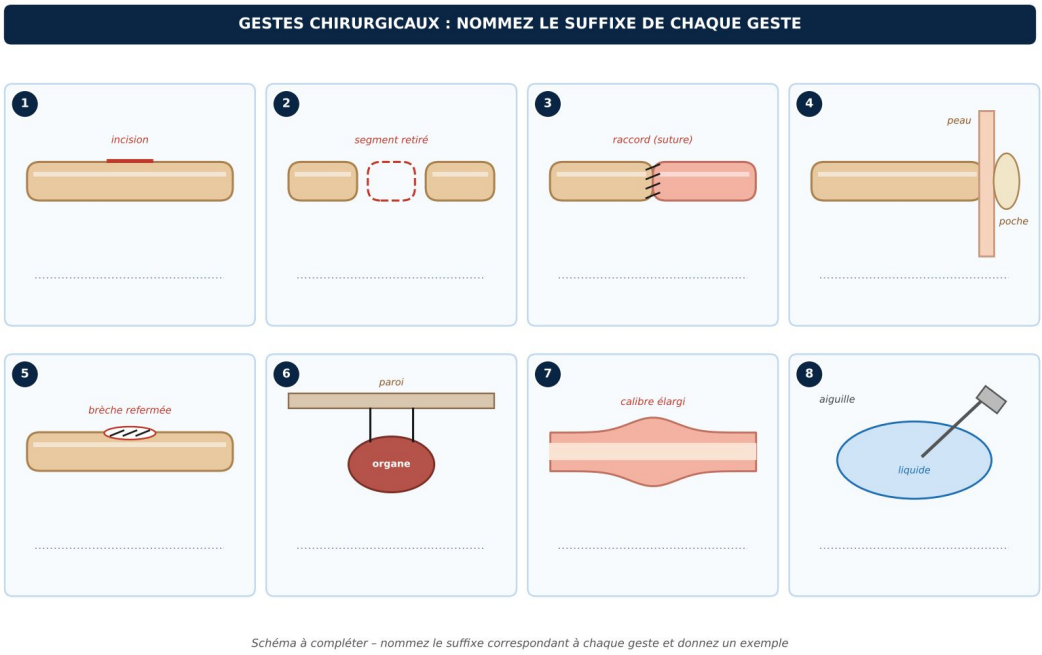


Schéma à compléter – nommez le suffixe correspondant à chaque geste et donnez un exemple

Fig. 29.37. Schéma à légender – les gestes chirurgicaux et leurs suffixes (8 légendes)

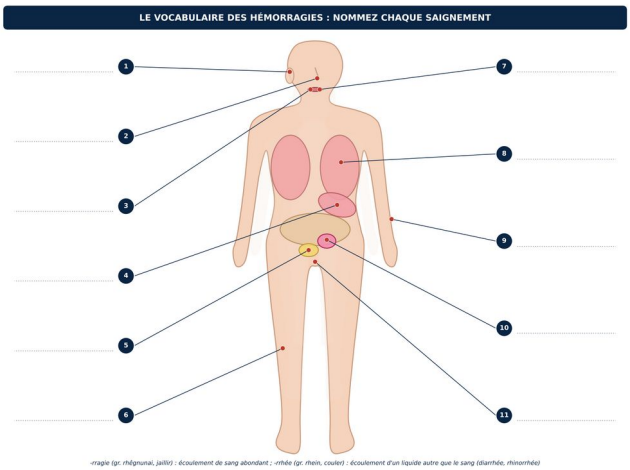


Fig. 29.38. Schéma à légender – le vocabulaire des hémorragies (11 légendes)

S'entraîner – application

Application 4. Donnez la racine grecque et la racine latine, puis un terme formé sur chacune : rein, poumon, peau, bouche, vessie.

Corrigé

Rein : **néphr-** (néphropathie) / **rén-** (rénal). Poumon : **pneum-** (pneumonie) / **pulmon-** (pulmonaire). Peau : **derm-, dermat-** (dermatose) / **cut-** (sous-cutané). Bouche : **stomat-** (stomatite) / **bucc-, or-** (buccal, oral). Vessie : **cyst-** (cystite) / **vésic-** (vésical).

S'entraîner – application

Application 5. Un patient a une natrémie de 128 mmol/L, une kaliémie de 5,6 mmol/L et une glycémie à jeun de 0,62 g/L. Nommez les trois anomalies et convertissez la glycémie en mmol/L.

Corrigé

Hyponatrémie (< 135 mmol/L) ; **hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L) ; **hypoglycémie** (< 0,70 g/L) : 0,62 × 5,55 = **3,4 mmol/L**.

S'entraîner – application

Application 6. Classez ces termes en examens, actes et maladies : coloscopie, colectomie, colite, colostomie, colopathie, coloscanner.

Corrigé

Examens : coloscopie (endoscopie), coloscanner (scanner du côlon). **Actes** : colectomie (ablation), colostomie (abouchement). **Maladies** : colite (inflammation), colopathie (maladie du côlon, sans précision).

S'entraîner – application

Application 7. Expliquez la différence entre : a) hématurie et hématémèse ; b) arthrite et arthrose ; c) dysphagie et dysphasie ; d) iléon et ilion.

Corrigé

a) **Hématurie** : sang dans l'urine ; **hématémèse** : vomissement de sang. b) **Arthrite** : inflammation articulaire ; **arthrose** : dégénérescence du cartilage. c) **Dysphagie** : difficulté à avaler ; **dysphasie** : trouble du langage. d) **Iléon** : dernière partie de l'intestin grêle (ilé-) ; **ilion** (ou ilium) : partie supérieure de l'os iliaque (ili-).

S'entraîner – application

Application 8. Développez les sigles : AEG, DT2, FOGD, CNO, SNG, GPE, NFS, DFG.

Corrigé

AEG : altération de l'état général (asthénie, anorexie, amaigrissement) ; **DT2** : diabète de type 2 ; **FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale ; **CNO** : compléments nutritionnels oraux ; **SNG** : sonde nasogastrique ; **GPE** : gastrostomie percutanée endoscopique ; **NFS** : numération formule sanguine ; **DFG** : débit de filtration glomérulaire.

S'entraîner – application

Application 9. Une femme de 74 ans pesait 60 kg il y a 6 mois et pèse aujourd'hui 52,5 kg pour 1,60 m. Calculez l'IMC et la perte de poids ; quels critères de la HAS (2021) sont présents ?

Corrigé

IMC = 52,5 / 1,60² = 52,5 / 2,56 = **20,5 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique). Perte = (60 − 52,5) / 60 = 7,5 / 60 = **12,5 %** en 6 mois (≥ 10 % : critère phénotypique). Il faut au moins un **critère étiologique** (apports réduits, malabsorption, agression) pour poser le diagnostic. Sévérité : IMC entre 20 et 22 et perte de 10 à 15 % en 6 mois : **modérée** (sauf albuminémie < 30 g/L).

S'entraîner – application

Application 10. Une maladie touche 1 500 personnes dans une ville de 60 000 habitants au 1er janvier ; 240 nouveaux cas apparaissent dans l'année. Calculez la prévalence au 1er janvier et l'incidence annuelle.

Corrigé

Prévalence = 1 500 / 60 000 = **2,5 %**. **Incidence** = 240 nouveaux cas / population à risque (60 000 − 1 500 = 58 500) = **0,41 %** par an, soit environ **4,1 ‰** (4,0 ‰ si l'on rapporte, de façon approchée, à toute la population).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Traduisez pour un patient : « Vous présentez une stéatose hépatique et une hypertriglycéridémie ; nous allons rechercher une insulinorésistance. »

CORRIGÉ

« Votre foie contient trop de graisse, et votre sang contient trop de triglycérides, un type de graisse. Nous allons vérifier si votre insuline, l'hormone qui fait baisser le sucre dans le sang, agit moins bien que la normale. »

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Donnez le terme qui désigne : a) une alimentation par la bouche ; b) une alimentation par sonde dans le tube digestif ; c) une alimentation par voie veineuse ; d) un orifice de l'intestin grêle à la peau ; e) un aliment transformé en purée lisse pour un patient dysphagique (niveau IDDSI).

CORRIGÉ

a) **Alimentation orale**, *per os* ; b) **nutrition entérale** ; c) **nutrition parentérale** ; d) **iléostomie** (ou jéjunostomie selon le segment) ; e) **purée**, niveau **IDDSI 4** (mixé lisse).

29.11.3 QCM

Q1. Dans le terme « gastrectomie », le suffixe signifie :

A. incision B. ablation C. abouchement D. examen

Q2. Le suffixe -ite signifie :

A. infection B. inflammation C. tumeur D. douleur

Q3. Le suffixe -ome désigne :

A. une tumeur B. une inflammation C. un état dégénératif D. une ablation

Q4. La racine néphr(o)- désigne :

A. le nerf B. le rein C. le foie D. le nez

Q5. La racine latine correspondant à néphr(o)- est :

A. vésic- B. rén- C. cut- D. ocul-

Q6. « Dys- » signifie :

A. deux B. difficulté, anomalie C. absence D. au-dessous

Q7. Une oligurie correspond à une diurèse :

A. nulle B. inférieure à 500 mL/24 h C. supérieure à 3 L/24 h D. normale

Q8. Une hématémèse est :

A. un crachat de sang B. un vomissement de sang C. du sang dans les urines D. un saignement du nez

Q9. Le méléna correspond à :

A. des selles noires contenant du sang digéré B. du sang rouge dans les selles C. une tumeur de la peau D. un saignement des gencives

Q10. La -scopie est :

A. un enregistrement graphique B. un examen visuel de l'intérieur d'un organe ou d'une cavité C. une mesure D. une ponction

Q11. Une colostomie est :

A. l'ablation du côlon B. l'incision du côlon C. l'abouchement du côlon à la peau D. l'examen du côlon

Q12. La tachycardie est une fréquence cardiaque :

A. inférieure à 60/min B. comprise entre 60 et 100/min C. supérieure à 100/min D. irrégulière

Q13. Le préfixe péri- signifie :

A. à travers B. autour C. au-dessus D. dedans

Q14. La polydipsie est :

A. une faim excessive B. une soif excessive C. des urines abondantes D. des selles nombreuses

Q15. Un symptôme est :

A. constaté par le médecin B. ressenti par le patient C. mesuré par un examen biologique D. visible à l'imagerie

Q16. L'étiologie est :

A. l'étude des causes B. l'étude des signes C. la prévision de l'évolution D. le mécanisme de la maladie

Q17. Une affection nosocomiale est :

A. héréditaire B. contractée dans un établissement de soins C. sans cause connue D. due à un médicament

Q18. La prévalence est :

A. le nombre de nouveaux cas B. le nombre de cas présents rapporté à la population C. le nombre de décès D. la durée moyenne de la maladie

Q19. L'hépatomégalie désigne :

A. une inflammation du foie B. une augmentation de volume du foie C. une tumeur du foie D. une ablation du foie

Q20. « Anurie » signifie :

A. absence ou quasi-absence d'urine B. urines douloureuses C. urines fréquentes D. urines abondantes

Q21. La dysphagie est :

A. une difficulté à parler B. une difficulté à avaler C. une absence d'appétit D. une douleur gastrique

Q22. La nutrition parentérale utilise :

A. une sonde nasogastrique B. une gastrostomie C. une voie veineuse D. la voie orale

Q23. Selon la HAS (2019), le seuil d'IMC définissant un critère phénotypique de dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans est :

A. < 17 kg/m² B. < 18,5 kg/m² C. < 21 kg/m² D. < 22 kg/m²

Q24. La sarcopénie est :

A. une tumeur du muscle B. une diminution de la force et de la masse musculaires C. une inflammation du muscle D. une douleur musculaire

Q25. La leucopénie est :

A. un excès de globules blancs B. une diminution du nombre de globules blancs C. une diminution des plaquettes D. une anémie

Q26. Le terme « iatrogène » signifie :

A. sans cause connue B. provoqué par les soins C. héréditaire D. contagieux

Q27. Dans le format PES du diagnostic diététique, la lettre E signifie :

A. évaluation B. étiologie C. éducation D. examen

Q28. « Ilé(o)- » désigne :

A. l'os iliaque B. l'iléon C. le flanc D. l'ilion

Q29. Une hypokaliémie correspond à :

A. un excès de potassium dans le sang B. un manque de potassium dans le sang C. un manque de sodium dans le sang D. du potassium dans l'urine

Q30. Le niveau IDDSI 7 correspond :

A. à l'eau fluide B. à la purée lisse C. à l'alimentation normale D. au haché humide

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse

Q1 — *Réponse :* **B** – ablation ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* **C** – l'abouchement du côlon à la peau ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* **B** – une difficulté à avaler

Q2 — *Réponse :* **B** – inflammation ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* **C** – supérieure à 100/min ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* **C** – une voie veineuse

Q3 — *Réponse :* **A** – une tumeur ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* **B** – autour ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* **B** – < 18,5 kg/m²

Q4 — *Réponse :* **B** – le rein ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* **B** – une soif excessive ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* **B** – une diminution de la force et de la masse musculaires

Q5 — *Réponse :* **B** – rén- ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* **B** – ressenti par le patient ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* **B** – une diminution du nombre de globules blancs

Q6 — *Réponse :* **B** – difficulté, anomalie ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* **A** – l'étude des causes ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* **B** – provoqué par les soins

Q7 — *Réponse :* **B** – inférieure à 500 mL/24 h ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* **B** – contractée dans un établissement de soins ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* **B** – étiologie

Q8 — *Réponse :* **B** – un vomissement de sang ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* **B** – le nombre de cas présents rapporté à la population ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* **B** – l'iléon

Q9 — *Réponse :* **A** – des selles noires contenant du sang digéré ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* **B** – une augmentation de volume du foie ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* **B** – un manque de potassium dans le sang

Q10 — *Réponse :* **B** – un examen visuel de l'intérieur d'un organe ou d'une cavité ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* **A** – absence ou quasi-absence d'urine ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* **C** – à l'alimentation normale

29.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la connaissance d'une centaine d'éléments permet-elle de comprendre plusieurs milliers de termes médicaux ?

Corrigé

Parce que la terminologie médicale est **combinatoire** : chaque élément garde un sens stable et se combine aux autres. Avec 10 racines d'organes et 10 suffixes, on peut lire jusqu'à 100 termes (gastrite, gastralgie, gastrectomie, gastroscopie, néphrite, néphralgie…) ; avec les préfixes, le nombre se multiplie encore. La liste du guide (53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines) couvre ainsi l'essentiel du vocabulaire rencontré par le diététicien. Les exceptions (éponymes, sigles, mots historiques) s'apprennent à part.

Question 2. Pourquoi le diététicien doit-il distinguer le diagnostic médical et le diagnostic diététique ?

Corrigé

Le **diagnostic médical** (maladie : « cirrhose », « dénutrition sévère ») relève de la compétence du médecin, qui le pose et le **code**. Le **diagnostic diététique** identifie un **problème nutritionnel** que le diététicien peut traiter par une intervention diététique (apport insuffisant, déficit de connaissances, difficulté de déglutition). Les confondre expose à sortir de son champ de compétence (responsabilité juridique) et à formuler des objectifs non mesurables. Le diagnostic diététique est aussi l'outil qui permet d'**évaluer** l'intervention, grâce aux signes et symptômes (S) choisis comme indicateurs.

Question 3. Pourquoi l'albuminémie n'est-elle plus un critère diagnostique de la dénutrition ?

Corrigé

L'albumine a une **demi-vie longue** (environ 20 jours) et sa concentration dépend surtout de l'**inflammation** (sa synthèse baisse lors de l'agression), de l'**hydratation** (dilution ou concentration), des pertes (rein, intestin, brûlures) et de la fonction **hépatique**. Une hypoalbuminémie peut donc exister sans dénutrition, et une dénutrition sans hypoalbuminémie (anorexie mentale). La HAS fonde le diagnostic sur des critères **cliniques** (poids, IMC, muscle) et étiologiques, et réserve l'albumine à l'appréciation de la **sévérité**.

Question 4. Pourquoi les termes « -tomie », « -ectomie » et « -stomie » doivent-ils être parfaitement distingués par le diététicien ?

Corrigé

Ils décrivent des situations nutritionnelles très différentes : une **-tomie** est une simple ouverture, sans conséquence durable sur la digestion ; une **-ectomie** retire un organe ou un segment (gastrectomie : petit volume gastrique, dumping, carences en fer et en vitamine B12 ; iléectomie : malabsorption de la B12 et des sels biliaires) ; une **-stomie** crée un orifice (iléostomie : pertes d'eau et de sel ; gastrostomie : voie d'alimentation). Une confusion dans la lecture du dossier entraîne des conseils inadaptés.

Question 5. Pourquoi l'usage des abréviations est-il encadré dans les établissements de santé ?

Corrigé

Une abréviation peut avoir **plusieurs sens** (IC, PA, IR), varier d'un service à l'autre ou être inconnue d'un professionnel : la mauvaise interprétation d'une prescription ou d'une transmission est une cause reconnue d'**événements indésirables**. Les établissements établissent donc des **listes d'abréviations autorisées** et interdisent certaines abréviations dangereuses (par exemple « U » pour « unités » d'insuline, confondu avec un 0). Le diététicien n'utilise que les sigles usuels et développe les autres.

Question 6. En quoi la connaissance de l'étymologie aide-t-elle à éduquer un patient ?

Corrigé

Elle fournit une **explication concrète et mémorisable** : « dys-phagie », c'est « avaler avec difficulté » ; « hyper-kali-émie », « trop de potassium dans le sang ». Le patient comprend que le mot décrit un phénomène et non une fatalité, ce qui favorise son **adhésion**. Elle permet aussi de **reformuler sans erreur** et de repérer les contresens du langage courant (chronique ≠ grave ; positif ≠ bon).

29.11.5 Étude de cas – Mme R., 45 ans, une chirurgie bariatrique

Mme R., 45 ans, 1,64 m, 112 kg, vit avec une **obésité** de classe III, une **HTA**, un **DT2** traité par metformine et un **SAOS** appareillé. Après une préparation pluridisciplinaire de 8 mois, elle bénéficie d'une **gastrectomie longitudinale** (*sleeve gastrectomy*) par **cœlioscopie**. Le compte rendu de sortie mentionne : « suites simples ; **réalimentation** progressive : liquide (J1-J7), mixé (J8-J21), mouliné puis haché, puis normal ; supplémentation **vitaminique** et **martiale** ; consultation diététique à 1 mois ». À 1 mois, elle se plaint de **nausées**, d'une sensation de **plénitude** rapide et d'une **asthénie** ; elle pèse 101 kg.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC avant l'intervention et classez-le ; calculez la perte de poids à 1 mois en kg et en pourcentage.

2. Décomposez et définissez : gastrectomie, cœlioscopie, réalimentation, asthénie, martiale (supplémentation martiale).

3. Expliquez le principe de la gastrectomie longitudinale et ce qui la distingue d'un **court-circuit gastrique** (*bypass*).

4. Développez les sigles HTA, DT2, SAOS, et expliquez pourquoi ces maladies sont appelées des **comorbidités** de l'obésité.

5. Proposez quatre conseils pour limiter les nausées et la plénitude, et justifiez la supplémentation.

Corrigé

1. IMC = 112 / 1,64² = 112 / 2,690 = **41,6 kg/m²** : **obésité de classe III** (≥ 40). Perte : 112 − 101 = **11 kg**, soit 11 / 112 = **9,8 %** en 1 mois (perte rapide attendue après chirurgie bariatrique, qui doit préserver la masse musculaire).

2. Gastrectomie : gastr- + -ectomie : ablation (ici partielle) de l'estomac. **Cœlioscopie** : cœli(o)- (cavité abdominale) + -scopie : chirurgie sous contrôle d'une caméra par de petites incisions. **Réalimentation** : ré- (de nouveau) + alimentation : reprise progressive de l'alimentation. **Asthénie** : a- (privatif) + gr. *sthenos* (force) : fatigue, manque de force. **Martiale** : relative au **fer** (lat. *Mars*, dieu de la guerre, associé au fer des armes) : supplémentation en fer.

3. La **gastrectomie longitudinale** retire **entre les deux tiers et les trois quarts** de l'estomac, le long de sa grande courbure, en laissant un **tube gastrique** étroit : c'est une technique **restrictive** (petit volume, satiété rapide ; diminution de la sécrétion de ghréline, hormone orexigène). Le **court-circuit gastrique** (*bypass* en Y) crée une petite poche gastrique reliée directement au **jéjunum** : il est à la fois **restrictif** et **malabsorptif** (le duodénum et le début du jéjunum sont court-circuités), d'où un risque plus élevé de carences et de **dumping syndrome**.

4. HTA : hypertension artérielle ; **DT2** : diabète de type 2 ; **SAOS** : syndrome d'apnées obstructives du sommeil. Une **comorbidité** (co- + morbidité, lat. *morbus*, maladie) est une maladie **associée** à la maladie principale ; ces trois maladies sont favorisées par l'excès de tissu adipeux (insulinorésistance, compression des voies aériennes, activation du système rénine-angiotensine) et s'améliorent souvent après la perte de poids.

5. 1) **Fractionner** : 5 à 6 petites prises par jour, dans de petites assiettes ; 2) **manger lentement** (20 à 30 min) et **mastiquer** longuement ; s'arrêter dès la première sensation de satiété ; 3) **boire en dehors des repas** (attendre 30 min avant et après) pour ne pas remplir le petit estomac ; 4) privilégier les **protéines** en début de repas (laitages, œufs, poisson) pour préserver la masse musculaire, et suivre la progression des textures. La supplémentation est indispensable à vie : apports réduits et, selon la technique, absorption diminuée (fer, vitamine B12, folates, calcium, vitamine D, autres vitamines et oligoéléments) ; l'asthénie doit faire rechercher une **anémie**.

29.11.6 Étude de cas – M. F., 68 ans, une cirrhose décompensée

M. F., 68 ans, ancien buveur excessif, est hospitalisé en hépato-gastro-entérologie. Le compte rendu indique : « **cirrhose** alcoolique Child-Pugh C ; **ascite** de grande abondance traitée par **ponction** évacuatrice ; **varices œsophagiennes** de grade 2 découvertes à la **FOGD** après une **hématémèse** ; épisode d'**encéphalopathie hépatique** (confusion, **astérixis**) ; **ictère** ; **hypoalbuminémie** à 24 g/L ; **thrombopénie** à 72 G/L. Poids 74 kg pour 1,78 m, avec ascite. Fonte musculaire importante. » L'équipe demande au

diététicien de prévenir l'aggravation de la dénutrition.

Travail à faire

1. Décomposez ou expliquez : cirrhose, ascite, hématémèse, encéphalopathie, ictère, hypoalbuminémie, thrombopénie.

2. Expliquez le terme « varices œsophagiennes » et le lien avec l'**hypertension portale**.

3. Pourquoi le poids et l'IMC sont-ils difficiles à interpréter chez ce patient ? Quel paramètre peut-on lui préférer ?

4. Une idée répandue veut qu'on « supprime les protéines » en cas d'encéphalopathie hépatique. Que recommandent aujourd'hui les sociétés savantes ?

5. Proposez trois conseils diététiques adaptés à ce patient.

Corrigé

1. Cirrhose : du gr. *kirrhos*, roux, jaune orangé (couleur du foie cirrhotique décrite par Laennec) + -ose : maladie chronique du foie où le tissu normal est remplacé par de la **fibrose** et des nodules. **Ascite** (gr. *askos*, outre) : épanchement de liquide dans la cavité péritonéale. **Hématémèse** : vomissement de sang. **Encéphalopathie** : encéphal(o)- + -pathie : atteinte du cerveau, ici due à l'accumulation de toxiques (ammoniac) que le foie n'épure plus. **Ictère** : coloration jaune (bilirubine). **Hypoalbuminémie** : albumine sanguine < 35 g/L (ici 24 g/L : défaut de synthèse hépatique). **Thrombopénie** : plaquettes < 150 G/L (séquestration dans une rate augmentée de volume).

2. Une **varice** (lat. *varix*) est une veine dilatée et tortueuse. Dans la cirrhose, le sang de la **veine porte** traverse difficilement le foie fibreux : la pression portale augmente (**hypertension portale**) et le sang emprunte des voies de dérivation, notamment les veines de l'**œsophage**, qui se dilatent et peuvent se rompre (hématémèse). L'**astérixis** (gr. *a-* + *stêrixis*, appui : « absence de maintien ») est un tremblement de battement des mains, signe d'encéphalopathie.

3. L'**ascite** et les **œdèmes** ajoutent plusieurs kilos d'eau : le poids **surestime** la masse corporelle et masque la fonte musculaire (IMC apparent : 74 / $1{,}78^2$ = 74 / 3,168 = 23,4 kg/m²). On peut utiliser un **poids sec** estimé (poids après ponction, ou poids diminué selon l'importance de l'ascite), et surtout évaluer le **muscle** : force de préhension, circonférence du bras, mesure de la masse musculaire au scanner (sarcopénie).

4. La restriction protéique est **abandonnée** : elle aggrave la fonte musculaire, alors que le muscle participe à l'épuration de l'ammoniac. Les recommandations (ESPEN 2019, EASL 2019) conseillent **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** et 35 kcal/kg/j, réparties dans la journée, éventuellement avec des protéines végétales et laitières mieux tolérées ; l'encéphalopathie est traitée par les médicaments (lactulose, rifaximine).

5. 1) **Fractionner** en 4 à 6 prises et ajouter une **collation tardive** riche en glucides complexes et en protéines (le foie cirrhotique stocke peu de glycogène : le jeûne nocturne accélère le catabolisme musculaire) ; 2) **régime modérément hyposodé** (environ 5 g de sel par jour), sans restriction excessive qui réduirait les apports ; 3) **abstinence alcoolique** totale, apport de **thiamine** (vitamine B1) et correction des carences ; textures adaptées après la ligature des varices si nécessaire, CNO si les apports restent insuffisants.

29.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée

Exercice type examen 29.10

Sujet de synthèse 1 – Une maladie de Crohn opérée – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Thomas, 24 ans, étudiant, a une **maladie de Crohn** diagnostiquée à 19 ans. Il est hospitalisé pour un syndrome **occlusif**. Le diététicien du service de chirurgie digestive le prend en charge (cas fictif).

Document 1

Extrait du compte rendu : « MICI de type Crohn, **iléite** terminale **sténosante** et **fistulisante**. Depuis 2 mois : douleurs de la fosse iliaque droite postprandiales, **diarrhée** à 5 selles par jour, **amaigrissement** de 7 kg (poids actuel 56 kg, taille 1,80 m). **Coloscopie** : **sténose** iléale infranchissable. **Entéro-IRM** : sténose de 25 cm et **fistule** iléo-cæcale. **Biologie** : CRP 62 mg/L ; **hypoalbuminémie** à 31 g/L ; **anémie** à 10,9 g/dL, **microcytaire** (VGM 74 fL) ; ferritine basse ; vitamine B12 basse. Calprotectine fécale très élevée. »

« **Intervention** : **laparotomie** ; **résection iléo-cæcale** de 40 cm avec **anastomose** iléo-colique. Suites : reprise du **transit** à J3 ; diarrhée persistante. »

Document 2

Données : l'iléon terminal absorbe la vitamine B12 (liée au facteur intrinsèque) et réabsorbe les **sels biliaires** (cycle entéro-hépatique). Après une résection iléale de moins de 100 cm, les sels biliaires non réabsorbés arrivent dans le côlon et provoquent une **diarrhée** dite cholérétique ; au-delà de 100 cm, la perte des sels biliaires dépasse la capacité de synthèse du foie et une **stéatorrhée** apparaît.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : iléite, sténosante, fistulisante, coloscopie, laparotomie, anastomose, stéatorrhée, postprandial. *(4 pts)*

2. Développez MICI et expliquez pourquoi la maladie de Crohn est un éponyme. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids ; indiquez si les critères de la HAS (2019) permettent de retenir une dénutrition et précisez sa sévérité. *(4 pts)*

4. Nommez par leur terme exact les anomalies de l'hémogramme ; expliquez leurs deux causes probables chez Thomas. *(3 pts)*

5. Expliquez la diarrhée postopératoire à l'aide du document 2 et proposez une adaptation alimentaire. *(4 pts)*

6. Rédigez un diagnostic diététique au format PES et deux conseils pour le retour à domicile. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.10

Question 1

Iléite : ilé- (iléon) + -ite : inflammation de l'iléon. **Sténosante** : qui provoque une **sténose** (gr. *stenôsis*, rétrécissement) : rétrécissement du calibre de l'intestin. **Fistulisante** : qui crée des **fistules** (communications anormales entre deux organes ou avec la peau). **Coloscopie** : examen endoscopique du côlon. **Laparotomie** : ouverture de la paroi abdominale. **Anastomose** : raccordement chirurgical de deux segments digestifs (ici iléon et côlon). **Stéatorrhée** : stéat- (graisse) + -rrhée : graisse en excès dans les selles. **Postprandial** : post- (après) + lat. *prandium* (repas) : après les repas.

Question 2

MICI : maladie inflammatoire chronique de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique). La maladie porte le nom du médecin américain **Burrill B. Crohn**, qui l'a décrite avec ses collègues en 1932 (iléite régionale) : c'est un **éponyme**, non décomposable, qu'il faut apprendre.

Question 3

IMC = 56 / 1,80² = 56 / 3,24 = **17,3 kg/m²**. Poids antérieur : 56 + 7 = 63 kg ; perte = 7 / 63 = **11,1 %** en 2 mois.

HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : critères **phénotypiques** : IMC < 18,5 et perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères **étiologiques** : **malabsorption** (iléite, diarrhée), **réduction des apports** (douleurs postprandiales) et **agression** (inflammation chronique, CRP élevée). **Dénutrition** retenue. Sévérité : IMC 17,3 (> 17) et perte de 11,1 % (< 15 % en 6 mois ; non connue sur 1 mois) : critères de **dénutrition modérée** ; albuminémie à 31 g/L (> 30) : modérée. Conclusion : **dénutrition modérée**, à réévaluer.

Question 4

Anémie (Hb 10,9 g/dL < 13) **microcytaire** (VGM 74 < 80 fL) avec **ferritine basse** : **carence martiale** due aux **pertes** sanguines digestives (lésions inflammatoires) et à la diminution des apports. La **vitamine B12** basse s'explique par l'atteinte de l'**iléon terminal**, seul site d'absorption du complexe B12-facteur intrinsèque ; cette carence donne en principe une macrocytose, masquée ici par la carence en fer (anémie mixte).

Question 5

La résection de 40 cm (< 100 cm) retire une partie de la zone de réabsorption des **sels biliaires** : ceux-ci passent dans le côlon, où ils stimulent la sécrétion d'eau et d'électrolytes : **diarrhée cholérétique** (« diarrhée par les sels biliaires »). Elle se traite surtout par un **chélateur des sels biliaires** (cholestyramine) prescrit par le médecin ; la restriction des graisses n'est pas nécessaire (elle n'est utile qu'en cas de stéatorrhée, après de longues résections). Diététique : **fractionner** les repas, boire suffisamment (eau, bouillons salés) pour compenser les pertes, réintroduire progressivement les **fibres** selon la tolérance

(après une sténose, éviter temporairement les fibres dures et les peaux).

Question 6

PES : « Apport énergétique et protéique insuffisant (P) lié à des douleurs abdominales après les repas et à une restriction volontaire de l'alimentation par crainte des symptômes (E), mis en évidence par une perte de poids de 11,1 % en 2 mois, un IMC de 17,3 kg/m² et des apports estimés à 60 % des besoins (S). » **Conseils** : 1) une alimentation **variée, enrichie** et **fractionnée**, sans éviction inutile (pas de régime « sans résidus » prolongé hors sténose) ; CNO si les apports restent insuffisants ; 2) poursuivre la supplémentation prescrite (fer, vitamine B12 en injections) et se peser chaque semaine ; **arrêt du tabac** s'il fume (facteur aggravant de la maladie de Crohn).

29.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage

Exercice type examen 29.11

Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

M. V., 63 ans, ancien fumeur et buveur, consulte pour une **dysphagie** progressive. Le diététicien le suit tout au long de son traitement en oncologie (cas fictif).

Document 1

Compte rendu de consultation : « **Dysphagie** aux solides depuis 3 mois, puis aux liquides épais ; **odynophagie** ; **hypersialorrhée** ; **amaigrissement** de 12 kg (poids habituel 78 kg, taille 1,76 m). **FOGD** : lésion **ulcéro-bourgeonnante** du tiers moyen de l'œsophage ; **biopsies** : **carcinome épidermoïde**. **TDM** thoraco-abdomino-pelvien : pas de **métastase**. RCP : **radiochimiothérapie** puis **œsophagectomie** ; pose d'une **jéjunostomie** d'alimentation. »

Document 2

Effets secondaires prévisibles : **œsophagite radique**, **mucite**, **nausées**, **anorexie**, **dysgueusie** ; après l'œsophagectomie, l'estomac est remonté dans le thorax (« **gastroplastie** » ou tube gastrique) : risque de **reflux**, de **dumping syndrome** et de **satiété précoce**.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : dysphagie, odynophagie, hypersialorrhée, biopsie, carcinome, métastase, œsophagectomie, jéjunostomie. *(4 pts)*

2. Expliquez la différence entre un carcinome et un adénocarcinome, et ce que signifie « épidermoïde ». *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids et l'IMC ; concluez sur l'état nutritionnel (HAS 2019). *(3 pts)*

4. Développez FOGD, TDM et RCP ; expliquez le rôle de la RCP. *(3 pts)*

5. Décomposez et expliquez : radiochimiothérapie, mucite, dysgueusie, gastroplastie ; proposez une adaptation pour chacun des trois effets secondaires mucite, dysgueusie et satiété précoce. *(5 pts)*

6. Justifiez le choix d'une jéjunostomie plutôt que d'une gastrostomie chez ce patient. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.11

Question 1

Dysphagie : difficulté à avaler. **Odynophagie** : gr. *odunê* (douleur) + -phagie : déglutition douloureuse. **Hypersialorrhée** : hyper- + sial- (salive) + -rrhée : excès de salive (en réalité souvent salive qui ne peut être avalée). **Biopsie** : bio- (vie, vivant) + -opsie (vue) : prélèvement d'un fragment de tissu sur le vivant pour examen au microscope. **Carcinome** : carcin- (gr. *karkinos*, crabe, cancer) + -ome : tumeur maligne d'origine **épithéliale**. **Métastase** : gr. *meta* (au-delà, changement) + *stasis* (position) : foyer cancéreux secondaire, à distance de la tumeur primitive. **Œsophagectomie** : ablation de l'œsophage. **Jéjunostomie** : abouchement du jéjunum à la peau (ici, sonde d'alimentation).

Question 2

Un **carcinome** est un cancer d'un **épithélium** ; l'**adénocarcinome** (adén-, glande) se développe à partir d'un épithélium **glandulaire** (bas œsophage, souvent sur un endobrachyœsophage), tandis que le carcinome **épidermoïde** ressemble à l'**épiderme** (épithélium **malpighien** pavimenteux stratifié, qui tapisse normalement l'œsophage) ; il est favorisé par le tabac et l'alcool.

Question 3

Perte : 12 / 78 = **15,4 %** en 3 mois ; poids actuel 66 kg ; IMC = 66 / 1,76² = 66 / 3,098 = **21,3 kg/m²**.

Critères HAS 2019 : perte ≥ 10 % en 6 mois (phénotypique) ; apports réduits (dysphagie) et maladie cancéreuse (étiologiques) : **dénutrition**. Perte ≥ 15 % en 6 mois : **dénutrition sévère**, malgré un IMC normal.

Question 4

FOGD : fibroscopie œso-gastro-duodénale. **TDM** : tomodensitométrie (scanner). **RCP** : réunion de concertation pluridisciplinaire. La RCP réunit au moins trois spécialistes (chirurgien, oncologue, radiothérapeute, radiologue, anatomopathologiste…) qui décident ensemble du **traitement** de chaque patient atteint de cancer, selon les référentiels ; elle est obligatoire en France pour tout nouveau cas de cancer.

Question 5

Radiochimiothérapie : association de la **radiothérapie** (rayons) et de la **chimiothérapie** (médicaments anticancéreux). **Mucite** : lat. *mucus* + -ite : inflammation des muqueuses (bouche, œsophage) : textures **lisses**, aliments tièdes ou froids, non acides, non épicés ; soins de bouche. **Dysgueusie** : dys- + gr. *geusis* (goût) : altération du goût (goût métallique) : couverts en plastique, assaisonnements (herbes, citron si pas de mucite), viandes marinées ou remplacées par œufs, laitages, poisson. **Gastroplastie** : gastr- + -plastie (reconstruction) : estomac remodelé en tube pour remplacer l'œsophage. **Satiété précoce** : repas **fractionnés** (6 à 8 petites prises), aliments **enrichis**, boissons en dehors des repas, position assise après le repas (reflux).

Question 6

L'estomac va servir à **remplacer l'œsophage** lors de l'œsophagectomie : il ne doit pas être perforé par une gastrostomie. La **jéjunostomie**, posée en aval, permet une **nutrition entérale** pendant la radiochimiothérapie et la période postopératoire, en utilisant le tube digestif (voie à privilégier sur la parentérale), sans gêner la reconstruction.

29.11.9 Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition

Exercice type examen 29.12

Sujet de synthèse 3 – L'anorexie mentale et la renutrition – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Inès, 17 ans, est hospitalisée en service de nutrition pour une **anorexie mentale** restrictive. Le diététicien participe à la renutrition (cas fictif).

Document 1

Observation d'entrée : « Restriction alimentaire depuis 14 mois, **hyperactivité** physique, **aménorrhée** secondaire depuis 8 mois. Poids **37,5 kg**, taille **1,65 m** (poids il y a 1 an : 52 kg). **Bradycardie** à 42/min, **hypotension** à 85/50 mmHg, **hypothermie** à 35,6 °C, **acrocyanose**, **lanugo**. **Biologie** : **hypophosphatémie** limite à 0,82 mmol/L, **hypokaliémie** à 3,3 mmol/L, **hypoglycémie** à 0,58 g/L, **leucopénie** à 2,9 G/L. **Ostéodensitométrie** : **ostéopénie**. »

Document 2

Données : DSM-5 (2013), sévérité de l'anorexie mentale chez l'adulte selon l'IMC : légère ≥ 17 ; modérée 16 à 16,99 ; sévère 15 à 15,99 ; extrême < 15 kg/m² (chez l'adolescent, on utilise les courbes de corpulence). Le **syndrome de renutrition inappropriée** survient surtout dans les premiers jours de la renutrition ; l'**hypophosphatémie** en est le marqueur principal.

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : anorexie, aménorrhée, bradycardie, hypothermie, acrocyanose, leucopénie, ostéopénie, hypophosphatémie. *(4 pts)*

2. « Lanugo » vient du latin *lana*, laine. Proposez une définition. Expliquez pourquoi le terme « anorexie » est trompeur dans l'anorexie mentale. *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC et la perte de poids en pourcentage ; situez l'IMC sur l'échelle du DSM-5. *(3 pts)*

4. Expliquez la bradycardie, l'hypothermie et l'hypoglycémie par l'adaptation de l'organisme au jeûne. *(4 pts)*

5. Définissez le syndrome de renutrition inappropriée, expliquez le rôle du phosphore et indiquez les précautions à prendre. *(4 pts)*

6. Rédigez une transmission ciblée pour le premier jour de la renutrition. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 29.12

Question 1

Anorexie : an- (privatif) + gr. *orexis* (appétit) : perte de l'appétit. **Aménorrhée** : a- + mén- (règles) + -rrhée : absence de règles ; secondaire : chez une jeune fille déjà réglée. **Bradycardie** : fréquence cardiaque < 60/min. **Hypothermie** : température centrale < 35 °C (35,6 °C : température basse, proche de l'hypothermie). **Acrocyanose** : acr(o)- (extrémités) + cyan- (bleu) + -ose : coloration bleutée et froide des mains et des pieds. **Leucopénie** : globules blancs diminués (< 4 G/L). **Ostéopénie** : osté(o)- + -pénie : diminution de la densité osseuse, moins marquée que l'ostéoporose. **Hypophosphatémie** : phosphate sanguin bas (< 0,80 mmol/L ; 0,82 mmol/L est à la limite inférieure).

Question 2

Lanugo : duvet fin et laineux qui recouvre le corps (comme chez le fœtus), réaction de l'organisme pour lutter contre le froid. Le terme **anorexie** est trompeur car la patiente n'a **pas perdu la faim** : elle la ressent mais **restreint volontairement** son alimentation par peur de prendre du poids ; il s'agit d'un trouble des conduites alimentaires (TCA), d'origine psychique.

Question 3

IMC = 37,5 / 1,65² = 37,5 / 2,7225 = **13,8 kg/m²** : < 15 : **extrême** selon l'échelle adulte du DSM-5 (chez une adolescente de 17 ans, on la reporterait sur les courbes de corpulence, où elle est très en dessous du 3e percentile). Perte = (52 − 37,5) / 52 = 14,5 / 52 = **27,9 %** en un an.

Question 4

Face au jeûne prolongé, l'organisme **économise l'énergie** : la diminution de l'hormone thyroïdienne active (T3) et du tonus sympathique réduit la **fréquence cardiaque** et la **production de chaleur** (bradycardie, hypothermie, acrocyanose par vasoconstriction périphérique). Le **glycogène** est épuisé, la **néoglucogenèse** est limitée par la fonte des réserves protéiques : la glycémie baisse (**hypoglycémie**, ici 0,58 g/L), ce qui expose au malaise et justifie une surveillance rapprochée.

Question 5

SRI : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques déclenchés par la reprise de l'alimentation chez un patient dénutri. L'apport de **glucides** stimule l'**insuline**, qui fait entrer dans les cellules le glucose, le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** (synthèse d'ATP, de glycogène, de protéines) : leurs taux sanguins **chutent** brutalement. L'**hypophosphatémie** prive les cellules d'ATP (faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire et cardiaque, troubles neurologiques) ; la **thiamine** est consommée par le métabolisme des glucides. **Précautions** : apports énergétiques initiaux **prudents et progressifs**, fixés par le protocole médical (5 à 10 kcal/kg/j chez les patients à très haut risque selon le NICE, 2006 ; des protocoles plus récents débutent plus haut sous surveillance étroite), puis augmentés sur plusieurs jours, **supplémentation** en phosphore, potassium, magnésium et **thiamine** dès le début, **dosages** quotidiens du phosphore et de la kaliémie les premiers jours, surveillance clinique (œdèmes, fréquence cardiaque).

Question 6

Cible : risque de syndrome de renutrition inappropriée. **Données** : IMC 13,8 kg/m² ; perte de 27,9 % en 1 an ; phosphatémie 0,82 mmol/L ; kaliémie 3,3 mmol/L ; bradycardie 42/min. **Actions** : apport initial réduit et progressif selon la prescription médicale, fractionné en 3 repas et 2 collations ; supplémentation en phosphore, potassium, magnésium et thiamine prescrite ; relevé des ingesta à chaque repas ; information de l'équipe sur les signes d'alerte (œdèmes, dyspnée, confusion, faiblesse). **Résultats attendus** : phosphatémie ≥ 0,80 mmol/L au contrôle de J2 ; absence d'œdème et de trouble du rythme ; consommation de la totalité des repas prescrits ; augmentation des apports selon le protocole.

29.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

acronyme — sigle qui se prononce comme un mot (SIDA, PICC) ; un sigle se prononce lettre par lettre (HTA)

aigu — d'apparition brutale et d'évolution rapide (lat. *acutus*)

anastomose — raccordement chirurgical (ou naturel) de deux conduits

antécédents (ATCD) — maladies, interventions et événements de santé passés du patient ou de sa famille

bénin — non cancéreux, sans invasion ni métastase

cachexie — amaigrissement extrême avec fonte musculaire, au cours d'une maladie chronique

chronique — qui évolue lentement et dure (en pratique plus de 3 à 6 mois)

comorbidité — maladie associée à la maladie principale

diagnostic — identification d'une maladie à partir des signes, des symptômes et des examens

diagnostic diététique — énoncé PES rédigé par le diététicien : problème nutritionnel, étiologie, signes et symptômes

doublet — deux racines, grecque et latine, de même sens (néphr- / rén-)

épidémiologie — étude de la fréquence, de la répartition et des déterminants des maladies dans les populations

éponyme — terme formé sur un nom propre (maladie de Crohn)

étiologie — étude des causes ; par extension, la cause d'une maladie

étymologie — origine et histoire d'un mot

iatrogène — provoqué par un acte médical ou un médicament

idiopathique — qui n'a pas de cause connue

incidence — nombre de nouveaux cas pendant une période, rapporté à la population à risque

malin — cancéreux, capable d'envahir et de métastaser

nosocomial — acquis au cours d'un séjour dans un établissement de santé

pathogénie — mécanisme par lequel une cause provoque une maladie

préfixe — élément placé avant la racine, qui en modifie le sens (position, quantité, temps, négation)

prévalence — nombre de cas présents à un instant donné, rapporté à la population

pronostic — prévision de l'évolution d'une maladie

racine — élément porteur du sens principal d'un mot (organe, substance, fonction)

sarcopénie — diminution de la force, de la masse et de la qualité musculaires

sémiologie — étude des signes et des symptômes des maladies

signe — manifestation d'une maladie constatée par le soignant (fièvre, hépatomégalie)

sigle — abréviation formée des initiales d'un groupe de mots (IMC, NFS)

suffixe — élément placé après la racine, qui indique la nature (maladie, signe, examen, acte)

symptôme — manifestation ressentie et rapportée par le patient (douleur, nausée)

syndrome — ensemble de signes et de symptômes qui vont ensemble

TIDN — terminologie internationale de diététique et de nutrition, utilisée pour le diagnostic diététique

voyelle de liaison — voyelle (souvent o, parfois i) qui relie deux éléments (gastr-o-logie) ; supprimée devant une voyelle (gastr-algie)

29.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté de 2024) ; Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition, 2025 (liste indicative des préfixes, suffixes et racines, p. 99 et 100 ; format du diagnostic diététique, p. 18).

CNED. Bases physiopathologiques de la diététique, réf. 3-2023 : module 1, séquence 1 (examen clinique : étymologie et définitions), séquence 2 (examens complémentaires), séquence 5 (terminologie chirurgicale).

Académie nationale de médecine. Dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, édition en ligne régulièrement mise à jour (dictionnaire.academie-medecine.fr).

Garnier M., Delamare V., Delamare J. et al. Dictionnaire illustré des termes de médecine (« Garnier-Delamare »). Paris : Maloine, dernière édition.

Bailly A. Dictionnaire grec-français. Paris : Hachette ; 1894 (édition revue par Séchan L. et Chantraine P., 1950) ; Gaffiot F. Dictionnaire latin-français. Paris : Hachette ; 1934.

Organisation mondiale de la santé. Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (préambule). New York ; 1946 ; Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision (CIM-10) ; 11e révision (CIM-11), en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Federative International Programme for Anatomical Terminology (FIPAT). Terminologia Anatomica. 2e éd. 2019.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical Nutrition. 2019;38(1):1-9.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31 ; Rosenberg I.H. Summary comments. American Journal of Clinical Nutrition. 1989;50(5):1231-1233.

Evans W.J., Morley J.E., Argilés J. et al. Cachexia: a new definition. Clinical Nutrition. 2008;27(6):793-

799 ; Fried L.P., Tangen C.M., Walston J. et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. Journal of Gerontology: Medical Sciences. 2001;56(3):M146-M156.

Donini L.M., Busetto L., Bischoff S.C. et al. Definition and diagnostic criteria for sarcopenic obesity: ESPEN and EASO consensus statement. Clinical Nutrition. 2022;41(4):990-1000.

National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (CG32). Londres : NICE ; 2006 ; da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutrition in Clinical Practice. 2020;35(2):178-195.

Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework. Dysphagia. 2017;32(2):293-314 ; IDDSI. Complete IDDSI Framework, detailed definitions 2.0. 2019.

Writing Group of the Nutrition Care Process/Standardized Language Committee. Nutrition care process and model part I: the 2008 update. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(7):1113-1117 ; Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). Terminologie internationale de diététique et de nutrition (TIDN).

Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. Journal of Hepatology. 2023;79(6):1542-1556.

Haute Autorité de santé. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Saint-Denis : HAS ; 2013 ; Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte (fiche mémo). HAS ; 2016.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1):1-150 ; KDOQI. Clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 suppl. 1):S1-S107.